

منظمة أرض البشر - بعثة الأردن

تقييم سريع للاحتياجات المجتمعية المرتكزة على المجتمع في مجال حماية
الطفل والفئات الأقل حظاً

كانون الأول / ديسمبر 2025

4	1. الشكر والتقدير
5	2. قائمة الاختصارات
6	3. الملخص التنفيذي
7	4. التفاصيل الفنية للتحليل
7	4.1 الخلفية
7	4.2 نطاق وأهداف ومخرجات المهمة
8	4.3 المنهجية
9	4.3.1 النهج العام والأطر النظرية
10	4.3.2 أساليب جمع البيانات واستراتيجية العينة
11	4.3.3 عينة التقييم
13	4.3.4 تحليل البيانات والتعامل معها
13	4.3.5 الاعتبارات الأخلاقية
14	5. بناء القدرات في جمع البيانات
14	6. ضبط الجودة
14	7. القيود والتحديات
15	8. نتائج البيانات الثانوية: مراجعة مكتبية
25	9. نتائج البيانات الأولية
25	1. عمّان
29	1.1 المخاطر الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل
32	1.2 الرفاه النفسي وآليات التكيف
34	1.3 الاستجابة المؤسسية ومعوقات الإبلاغ
34	1.4 مشاركة الأطفال واليافعين
35	2. إربد
40	2.1 المخاطر الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل
42	2.2 الرفاه النفسي وآليات التكيف
43	2.3 الاستجابة المؤسسية ومعوقات الإبلاغ
43	2.4 مشاركة الأطفال واليافعين
44	3. مادبا
44	3.1 المخاطر الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل
49	3.2 الرفاه النفسي وآليات التكيف
49	3.3 الاستجابة المؤسسية ومعوقات الإبلاغ
41	3.4 مشاركة الأطفال واليافعين
42	4. الكرك
50	4.1 المخاطر الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل
53	4.2 الرفاه النفسي وآليات التكيف
55	4.3 الاستجابة المؤسسية ومعوقات الإبلاغ
57	4.4 مشاركة الأطفال واليافعين
60	5. الزرقاء
60	5.1 المخاطر الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل

62	5.2 الرفاه النفسي وآليات التكيف
65	5.3 الاستجابة المؤسسية ومعوقات الإبلاغ
67	5.4 مشاركة الأطفال واليافعين
70	6. البقاء
70	6.1 المخاطر الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل
72	6.2 الرفاه النفسي وآليات التكيف
75	6.3 الاستجابة المؤسسية ومعوقات الإبلاغ
77	6.4 مشاركة الأطفال واليافعين
80	7. الأطفال والنظام القضائي
80	7.1 عوامل الخطورة والوساطة قبل المحاكمة
80	7.2 التفاعل مع النظام الرسمي
81	7.3 إعادة التأهيل
81	7.4 إعادة الاندماج والتصورات المجتمعية
83	8. أنماط الهشاشة والمخاطر المرتبطة بالنوع الاجتماعي
84	8.1 الأطفال ذوو الإعاقة
85	8.2 الفتيات اليافعات
85	8.3 الأطفال من اللاجئين والمتأثرون بالفقر
86	9. الاستنتاجات
87	10. التوصيات
92	11. المراجع
94	12. الملاحق

1. الشكر والتقدير

لم يكن لهذا التقييم السريع أن يرى النور لولا الرؤى القيّمة والتجارب الحسّاسة التي شارك بها أفراد المجتمع المحلي في كل من عمّان، والزرقاء، والبلقاء، وإربد، ومادبا، والكرك، إلى جانب إسهامات من دعموا إعداد هذا التقييم من داخل هذه المجتمعات نفسها. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لفرق عمل بعثة أرض البشر (Terre des Hommes – Tdh) في الأردن، وللمنظمات المجتمعية الشريكة، على ما قدموه من دعم تقني ولوجستي أساسي كان له الدور المحوري في إنجاز هذا التحليل.

وقد أُعدّ هذا التقرير من قبل مستشاري البحث أحمد عميرة وميرا أبو مغلي، وتُعبّر الأفكار والآراء الواردة فيه عن وجهات نظر المؤلفين، ولا تعكس بالضرورة آراء المنظمة. بل يهدف التقرير إلى أن يكون دعوة واضحة لاتخاذ إجراءات عملية من شأنها تعزيز استجابات حماية الطفل والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، من خلال موازنة البرامج المستقبلية، وحوارات السياسات، والتفاعل المؤسسي مع الواقع المعاش والاحتياجات المعبر عنها من قبل الأطفال ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية.

2. جدول الاختصارات

A2D	البدائل عن الاحتجاز
CBO	منظمة مجتمع محلي
CBORP	البحث التشاركي المبني على المجتمع
CP SWG	الفريق الفرعي لحماية الطفل
CRBA	المنهجية القائمة على حقوق الطفل
CRC	اتفاقية حقوق الطفل
FGD	المجموعة البؤرية المركزة
FPD	دائرة حماية الأسرة
GIZ	الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
ICT	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ILO	منظمة العمل الدولية
IPEC	البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال
KII	مقابلة أصحاب المصلحة الرئيسيين
MENA	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
MHPSS	الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي
MoSD	وزارة التنمية الاجتماعي
NCFA	المجلس الوطني لشؤون الأسرة
PSD	مديرية الأمن العام
PTSD	اضطراب ما بعد الصدمة
SOP	إجراءات التشغيل القياسية
Tdh	أرض البشر
UNHCR	المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
UNICEF	صندوق الأمم المتحدة للأطفال (يونييسف)
VAF	إطار تقييم الضعف

3. الملخص التنفيذي

تم إجراء هذا التقييم السريع لتعميق الفهم حول الاحتياجات الحالية لحماية الأطفال ومستويات الضعف بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في ست محافظات أردنية (عمّان، الزرقاء، البلقاء، إربد، مادبا، الكرك). تهدف النتائج إلى توجيه منظمة أرض البشر (Tdh) وشركائها في تعديل البرامج بشكل فوري ومتوسط الأمد، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد استراتيجية المنظمة وإطار برامجها لعام 2026. يركز هذا التقييم بشكل خاص على تحديد الثغرات في حماية الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي، وكشف الأولويات في مجال الحماية، وتحديد الفرص لتعزيز التدخلات الموجهة للشباب والأطفال ذوي الاحتياجات للحماية وأولياء الأمور. كما يهدف إلى إحداث تغييرات عملية في برمجة أرض البشر والمناصرة الخاصة بها من خلال إنتاج أدلة قائمة على واقع المجتمعات المتأثرة واحتياجاتها المعبر عنها.

اعتمد التقييم على تصميم مختلط، يجمع بين الاستبيانات الكمية على مستوى الأسر والمناقشات الجماعية البؤرية النوعية (FGDs) والمقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين (KIIs) التي نفذها فرق محلية مدربة من منظمات المجتمع المدني. أتم 1,201 من أولياء الأمور استبيانات منظمة عبر (KoboToolbox)، كما شارك 205 من أفراد المجتمع في 24 مجموعة نقاشية، إضافة إلى مقابلات مع العديد من القادة المحليين ومقدمي الخدمات. شمل التقييم المحافظات الست المذكورة، مع أخذ عينات من الأسر اللاجئة والمضيفة في أحياء محددة تم تصنيفها على أنها ذات مستويات عالية من الضعف. كانت العينات موزعة بشكل منهجي مع مراعاة الجنس، العمر، الجنسية، والإعاقة، كما ضمن الشركاء المحليون شمول الفئات صعبة الوصول. تم تطبيق إجراءات أخلاقية صارمة: حيث حصل الميسرون المدربون على موافقة مستنيرة (بما يشمل موافقة الأطفال)، وضمن السرية، وتهيئة بيئات صديقة للأطفال، وتطبيق بروتوكولات إحالة للحالات المجعدة. كما جرى إخفاء هوية البيانات وتخزينها بشكل آمن، مع اعتماد نهج "عدم الإضرار" طوال فترة العمل الميداني.

النتائج الرئيسية

أظهر التحليل عبر جميع المواقع مجموعة متسقة من أبرز المخاطر التي يواجهها الأطفال، ويمكن تلخيصها في أربع فئات رئيسية مترابطة:

1. العنف والإهمال داخل الأسرة:

يتعرض العديد من الأطفال للعقاب الجسدي أو الحرمان أو الإهمال داخل المنزل، حيث بلغت النسبة نحو 34% على مستوى المحافظات. ويُلاحظ أن مقدمي الرعاية غالبًا ما يقللون من خطورة هذه المخاطر أو لا يعترفون بحجمها الحقيقي.

2. العنف في المدارس:

شكّل التنمر والعنف بين الأقران الخطر الأبرز في البيئة المدرسية في جميع المواقع. وأظهرت الاستبيانات أن ما يقارب ثلث الأطفال تعرّضوا للتنمر في المدرسة، ما يجعله الخطر المدرسي الأول.

3. العنف في المجتمع والأماكن العامة:

تم الإبلاغ على نطاق واسع عن التحرش والعنف الجسدي في الأماكن العامة (مثل اعتداءات الغرباء والتحرش القائم على النوع الاجتماعي). وأفاد مقدمو الرعاية—لا سيما في الزرقاء وعمّان وإربد—بمستويات مرتفعة من العنف في الأحياء تؤثر على الأطفال (50%) فأكثر، مع مستويات أقل نسبيًا لكنها مستمرة في الكرك (45%) ومادبا (44%) والبلقاء (34%).

4. التهديدات الرقمية/عبر الإنترنت:

برز الإنترنت بوصفه “أكثر خطورة من الشارع”، إذ يتعرض الأطفال للتنمر الإلكتروني، ولمحتوى عنيف أو جنسي، وللاستغلال عبر الإنترنت. وأشار نحو 44% من مقدمي الرعاية إلى التعرض لمحتوى ضار عبر الإنترنت باعتباره الخطر الأبرز على الفضاء الرقمي (وهو الخطر المهيمن ضمن هذه الفئة).

تتكرر هذه الفئات الأربع من المخاطر في جميع المحافظات. ويُلاحظ أن العنف الجسدي (من المنزل إلى الفضاء العام) والتعرض للأذى (في المدارس وعبر الإنترنت) يتصدّران باستمرار ملف المخاطر في كل مجتمع. كما تظهر فجوة واضحة بين تصورات مقدمي الرعاية وتقارير الأطفال؛ إذ لا يزال معظم مقدمي الرعاية يقيمون المنازل والمدارس والمجتمعات على أنها “آمنة”، ما يشير إلى نقطة عمياء في إدراك التهديدات الفعلية. وتؤكد الطبيعة الإيكولوجية لهذه النتائج أن المخاطر في مجال واحد (مثل الإساءة داخل الأسرة) غالبًا ما تتفاقم وتتعاكس في مجالات أخرى (مثل السلوك العدواني في المدرسة أو اللجوء إلى الفضاء الرقمي بحثًا عن ملاذ).

الفروقات بين المحافظات

على الرغم من تشابه المخاطر العامة، إلا أن هناك اختلافات إقليمية مهمة لها آثار برمجية. على سبيل المثال، تميزت مادبا بضغط اقتصادي شديد؛ حيث واجه 39% من الأطفال حرمانًا ماديًا في المنزل، وهو أعلى خطر على مستوى الأسرة هناك، مقارنة بالعنف المباشر. في المقابل، أظهرت عمان وإربد (المناطق الحضرية الكبيرة وذات الكثافة العالية للاجئين) معدلات أعلى من العنف المباشر في المنزل (46% في عمان، 44% في إربد) والتنمر المدرسي (36% في عمان مقابل 43% في إربد). كما أبلغ نحو نصف أولياء الأمور في إربد عن تعرض الأطفال لمحتوى ضار على الإنترنت (48%)، مما يعكس الاتصال العالي وتواجد اللاجئين. أما الكرك، فقد بدا سكانها أكثر تفاؤلاً بشأن السلامة المدرسية (89% اعتبروا المدارس آمنة)، إلا أن الأطفال ما زالوا يواجهون العنف بين الأقران (39%) والمخاطر في الأماكن العامة (45%).

التوصيات ذات الأولوية

يقدم هذا التقييم ست توصيات عملية ذات أولوية، مقسمة بين التوصيات الفورية والمتوسطة المدى، ومرتبطة بالنتائج السابقة:

توسيع برامج تعليم الأبوة والدعم النفسي الاجتماعي:

ينبغي لأرض البشر والمنظمات المحلية تنفيذ برامج مستمرة لتعليم الآباء والأمهات أساليب الانضباط غير العنيفة، والتواصل العاطفي، والوعي بتطور الطفل. ونظرًا لأن نسبة أولياء الأمور الذين يلجأون للدعم الرسمي منخفضة جدًا (1-2% فقط)، يجب تقديم هذه البرامج في المجتمع عبر المنظمات المحلية والمدارس والمراكز الدينية. بالتوازي، ينبغي توسيع خدمات الدعم النفسي الاجتماعي المجتمعية: تدريب العاملين والمتطوعين المحليين على الإرشاد الأساسي، ودمج فحوصات الصحة النفسية للأهالي واستخدام المواد المخدرة. تعالج هذه الإجراءات عدة نتائج، بما في ذلك التصورات “المتفائلة” ولكن غير الدقيقة لأولياء الأمور حول الأمان، والارتباط بين ضغوط الوالدين (اقتصادية أو عاطفية) والعنف ضد الأطفال، من خلال تزويد الأسر بالمهارات والدعم للتكيف دون الإضرار بالطفل.

لماذا تعتبر هذه التوصيات مهمة الآن؟

1. التهجير طويل الأمد:

يوضح التقييم أن مخاطر حماية الطفل مرتبطة بفترات طويلة من التهجير، التي أثرت على كل من المجتمعات المضيفة واللاجئة. وتبرز النتائج أن فترات عدم الاستقرار المستمرة جعلت الأطفال والأسر يعتادون على الظروف المعيشية الصعبة، مع ضغوط اقتصادية وسكن مزدحم وصولاً محدود للخدمات. ويؤثر هذا على استراتيجيات التكيف للأطفال وأولياء الأمور، حيث تصبح المخاطر تراكمية وليست مؤقتة. كما يبين التقييم أن التهجير لم يعد يُنظر إليه كظرف مؤقت، مما له تأثيرات مباشرة على التخطيط الأسري، والأولويات التعليمية، وتفاعل الأسر مع نظم الدعم، وبالتالي تعريض الأطفال لمخاطر متعددة في المنزل والمدرسة والمجتمع.

2. تزايد الحاجة للحماية والدعم النفسي الاجتماعي:

يوضح التقييم العلاقة بين مخاطر حماية الطفل والضغوط النفسية والاجتماعية. يتعرض الأطفال للعنف والإهمال والتهم والبيئات غير الآمنة، ما يؤدي إلى ضغوط عاطفية، تغييرات سلوكية، وانخفاض الرفاهية. كما أبلغ أولياء الأمور عن مستويات عالية من التوتر المرتبط بالضغوط الاقتصادية وعدم اليقين. هناك فجوة كبيرة بين انتشار الاحتياجات النفسية الاجتماعية واستخدام الخدمات الرسمية، مما يشير إلى حواجز متعلقة بالوعي، الوصمة الاجتماعية، وإمكانية الوصول. وهذا يفاقم المخاطر، حيث تسهم ضغوط الوالدين وتوتر الأطفال في تبني آليات مواجهة ضارة وتقليل طلب المساعدة، ما يوضح الحاجة إلى استجابات متكاملة تشمل الحماية والدعم النفسي الاجتماعي بدلاً من تدخلات منفصلة.

3. قيود التمويل:

تستمر قيود التمويل في تشكيل نطاق وجودة واستدامة تدخلات حماية الطفل والدعم النفسي الاجتماعي، خاصة في سياقات الأزمات. عالميًا، لم تواكب التمويلات الإنسانية والتنمية حجم وطول فترات التهجير المتزايد، مع انخفاض الميزانيات هذا العام إلى أدنى مستوياتها خلال عقد، مما أجبر المنظمات على تقليص الخدمات الأساسية والعمليات. هذه القيود تحد من قدرة المنظمات على الاستثمار في نهج وقائي طويل الأمد، وغالبًا ما تُعطى الأولوية للخدمات الفورية على تعزيز النظام الكلي. كما تقلل صيغ التمويل قصيرة المدى من المرونة لتكييف البرامج مع تطور الاحتياجات، خاصة في ظل تزايد المخاطر والضغوط النفسية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، لا تقتصر تأثير فجوات التمويل على التغطية فقط، بل قد تقوض استمرارية الرعاية، والتنسيق بين الجهات، ودمج استجابات الحماية والدعم النفسي الاجتماعي الضرورية حيث الحاجة أكبر.

4. استراتيجية أرض البشر للفترة 2026-2028:

تعزز نتائج هذا التقييم بشكل مباشر استراتيجية تير دي زوم في الأردن للأعوام 2026-2028، والتي تُعطي أولوية للاستجابات الوقائية وعلى مستوى النظم، وقيادة محلية، في مجال حماية الطفل. إن الانتشار الموثق للعنف الأسري، والأذى بين الأقران وعلى مستوى المجتمع، والمخاطر الرقمية، إلى جانب الفجوة المستمرة بين التجارب المعيشة للأطفال وتصورات مقدمي الرعاية، يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز أنظمة حماية الطفل وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي، بحيث تعمل بصورة متكاملة عبر بيئات المنزل والمدرسة والمجتمع والفضاء الرقمي.

واستجابةً لذلك، تركز الاستراتيجية على تعزيز نهج التوطين من خلال تمكين الشركاء المحليين وبناء قدراتهم، وتعميق الانخراط مع منصات التنسيق الوطني وصنع السياسات، وبناء تحالف موحد لحماية الطفل بما يسهم في تحسين الاتساق وتعزيز المناصرة المستندة إلى الأدلة، إلى جانب إدماج الإعاقة كأولوية شاملة وعابرة لكافة محاور العمل.

وتسهم هذه التوجهات الاستراتيجية مجتمعة في ترجمة نتائج التقييم إلى توصيات عملية، من خلال تحويل الاستجابة من تدخلات مجزأة وتفاعلية إلى أنظمة منسقة، قائمة على الحقوق، وشاملة، قادرة على معالجة المخاطر التراكمية، وتعزيز مشاركة الأطفال، وتحقيق نتائج حماية أكثر استدامة للأطفال والشباب ومقدمي الرعاية في الأردن.

4. التفاصيل الفنية للتحليل

1.4 الخلفية

منظمة أرض البشر-الأردن تعمل بنشاط في مجال حماية الطفل وتعزيز الوصول إلى العدالة منذ عام 2007، حيث بدأت استجابتها لأزمة اللاجئين العراقيين، ولاحقًا وسعت نطاق عملها ليشمل أزمة اللاجئين السوريين. حاليًا، تعمل المنظمة في ست محافظات: عمان، الزرقاء، البلقاء، إربد، مادبا، والكرك. وتقدم المنظمة الدعم لكل من المجتمعات المضيفة واللاجئة، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والشباب، بما في ذلك الفئات المتورطة في نزاعات مع القانون.

4.2 نطاق وأهداف ونتائج التقييم

النطاق

يركز هذا التقييم بشكل أساسي على حماية الطفل والسياق الأوسع للدعم النفسي والاجتماعي والحماية للفئات المتأثرة في الأردن، مع استهداف المجتمعات المضيفة الضعيفة واللاجئين في المناطق الحضرية (السوريين وجنسيات أخرى) في ست محافظات: عمان، الزرقاء، البلقاء، إربد، مادبا، والكرك. تشمل المجالات الموضوعية للتقييم استكشاف فرص تعزيز برامج الشباب، وحماية الطفل، ودعم مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى إجراء تقييم للضعف لتحديد أولويات الحماية الأساسية. يغطي الإطار الزمني للتقييم العام 2025، ويهدف إلى تقديم رؤى للتعدلات البرمجية الفورية والمتوسطة المدى، كما سيرشد مباشرة استراتيجية المنظمة للفترة 2026-2028.

الأهداف

الهدف العام من هذا التقييم هو تعميق فهم الاحتياجات الحالية لحماية الطفل والفئات الضعيفة، بما يدعم تطوير إطار برامجي مرن ومستدام لمنظمة أرض البشر وشركائها المحليين. وتشمل أهداف التقييم ما يلي:

1. تقييم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) القائمة، من خلال تحليل الموارد، وتغطية الخدمات، وفعاليتها.
2. تحديد فرص تعزيز التدخلات الموجهة نحو الشباب، والأطفال ذوي احتياجات الحماية، ومقدمي الرعاية، لضمان استجابة البرامج للاحتياجات الفعلية.
3. إجراء تقييم شامل للضعف بين اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لتحديد أولويات الحماية التي يجب التركيز عليها في تصميم البرامج.
4. بناء قدرات الشركاء المحليين في منهجيات التقييم التشاركي، وجمع البيانات الأخلاقي، وتحليل المعلومات.

يُستند تقييم الاحتياجات المجتمعية إلى مجموعة من الأسئلة الأساسية المصممة لاستكشاف قضايا حماية الطفل، والوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والمشاركة في العدالة، ومدى شمول المجتمع للفئات المستهدفة، سواء في المجتمعات المضيفة أو بين اللاجئين في المحافظات الست المستهدفة: عمان، الزرقاء، البلقاء، إربد، مادبا، والكرك. وبناءً على ذلك، يوضح الجدول 2 أدناه الأسئلة الرئيسية والمقاطعة التي سعى التقييم للإجابة عليها. وللإطلاع على مصفوفة الأسئلة البحثية الكاملة، مع الأسئلة الفرعية، والمحاور، وأدوات جمع البيانات المستخدمة، يرجى الرجوع إلى الملحق 1.

#	السؤال البحثي	الأسئلة المقاطعة
1	ما هي أبرز قضايا حماية الطفل والمخاطر الوقائية السائدة التي يواجهها الأطفال (12-17 سنة) والشباب (18-24 سنة) في المجتمعات المستهدفة؟	ما هي نقاط الضعف المحددة (مثل المخاطر الوقائية، حالة النزوح، الفجوات في الاحتياجات الأساسية، إدماج ذوي الإعاقة، الوصول إلى العدالة) لدى اللاجئين (سوريين وجنسيات أخرى) وأعضاء المجتمعات المضيفة الضعيفة؟
2	ما هو الأثر والتأثير المتوقع للتدخلات الحالية في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب ومقدمي الرعاية؟ وما هي نقاط القوة، والفجوات، والمجالات التي يمكن تحسينها في تغطية الخدمات؟	ما هي الآليات الرئيسية للتكيف والموارد المجتمعية المستخدمة (مثل الأماكن الآمنة، الشبكات الاجتماعية، المعايير الإيجابية) للتعامل مع المخاطر الوقائية والتحديات النفسية والاجتماعية؟ كيف يمكن تعزيز التدخلات الحالية لتكون أكثر استجابة وملاءمة سياقياً وفعالية للشباب والأطفال ذوي احتياجات الحماية ومقدمي الرعاية؟
3	كيف يمكن تمكين أرض البشر وشركائها المحليين (مثل منظمات المجتمع المدني والمتطوعين) بفعالية في منهجيات التقييم التشاركي، وجمع البيانات الأخلاقية، والتحليل لدعم ملكية محلية مستدامة؟	ما هي العوائق الرئيسية التي تمنع الوصول إلى خدمات حماية الطفل، والدعم النفسي والاجتماعي، والعدالة للفئات الضعيفة-وما هي مصادر المساعدة الأكثر موثوقية ضمن هذه المجتمعات؟ -إلى أي مدى تؤثر المعتقدات الثقافية، الأعراف الجنسانية، وتوقعات الأسرة في سلوك طلب المساعدة النفسي والاجتماعي بين الأطفال والشباب ومقدمي الرعاية؟

الجدول 1: قائمة الأسئلة البحثية للتحليل

النتائج

1. التمويل والأدلة: إنشاء قاعدة بيانات شاملة مستمدة من هذا التقييم، لتعزيز قدرة المنظمة على التواصل مع المانحين وتأمين التمويل استنادًا إلى أدلة قوية.
2. تعزيز القدرات المحلية: تقوية قدرات المنظمات المجتمعية (CBOs) لتمكينها من إجراء تقييمات احتياجات مستقلة عبر مختلف القطاعات في المستقبل.
3. استراتيجيات برمجية قابلة للتنفيذ: استخدام التوصيات العملية للتقييم لتطوير تدخلات جديدة أو تعديل التدخلات الحالية لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات الأطفال والشباب والمقدمين للرعاية المستهدفين.

4.3 المنهجية

4.3.1 النهج العام والأطر النظرية

استند هذا التقييم إلى مجموعة من النظريات والأطر المفاهيمية التي أرست منهجية التحليل والرؤية التحليلية. تم اختيارها لملاءمتها لقضايا حماية الطفل، والتفاعل المجتمعي، وإجراء بحوث أخلاقية مع الفئات المهمشة.

#	النظرية/الإطار	الوصف
1	نظرية النظم البيئية (برونفنبرنر)	يقوم التحليل على مبدأ أن رفاهية الطفل تتشكل من خلال بيئات متعددة مترابطة. على سبيل المثال، يتم تصنيف المخاطر بشكل منهجي ضمن بيئات: المنزل، المجتمع/المدرسة/المكان العام، والفضاء الرقمي/الإنترنت في كل ملف فردي. يوفر هذا النهج صورة واضحة للطبيعة التراكمية لمخاطر الحماية ويتجاوز التركيز على العوامل الفردية فقط.
2	نهج قائم على حقوق الطفل (CRBA)	مستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، يركز هذا الإطار على اعتبار الأطفال أصحاب حقوق ويعزز المشاركة وعدم التمييز والمساءلة. وقد تجلّى ذلك في التحليل من خلال إبراز أصوات الأطفال والشباب، بدءًا من تقاريرهم الضعيفة في النتائج الأولية وصولًا إلى تأثيرهم على صياغة التوصيات.
3	إطار التقاطعية (Intersectionality)	كشف التحليل كيف أن الهويات المتداخلة تزيد من التعرض للمخاطر، مع تخصيص قسم كامل بعنوان "ملفات الضعف والمخاطر المرتبطة بالأنوع الاجتماعي".
4	البحث التشاركي المجتمعي (CBPR)	يدعو هذا الإطار إلى نهج بحثي يشارك فيه الباحثون والمنظمات وأعضاء المجتمع في جميع جوانب المشروع البحثي لتعزيز الملكية المحلية وتقوية المشاركة الحقيقية والفاعلة. وقد تجلّى ذلك في جميع جوانب هذا التحليل، من تصميم أدوات جمع البيانات إلى تنفيذ جمع البيانات، مع التركيز على أصوات المجتمع.
5	إطار البحث الأخلاقي	الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للبحث يشكل أساسًا لكامل المنهجية. ويظهر ذلك في جميع أجزاء هذا التقييم، حيث التزم الباحثون بالمبادئ الأساسية الموضحة في القسم "4.3.5 الاعتبارات الأخلاقية".

الجدول 2: النظريات والأطر المفاهيمية للتقييم

4.3.2 طرق جمع البيانات واستراتيجية العينة

استخدم الباحثون أساليب جمع البيانات الأولية والثانوية لتقديم صورة شاملة تتماشى مع نطاق وأهداف التقييم، كما هو موضح أدناه:

#	منهجية جمع البيانات	الوصف	الإرشادات
1	البحث المكتبي	طريقة جمع بيانات نوعية ثانوية تُستخدم لتجميع وتحليل الأدلة الموجودة حول حماية الطفل والهشاشة في المجتمعات المستهدفة. شمل الاستعراض السياسات الوطنية، الأطر القانونية، الاستراتيجيات القطاعية، وثائق برامج أرض البشر، تقارير الشركاء، التقييمات، والدراسات الحديثة لتوفير سياق لنتائج المجتمع المحلي، وتحديد المخاطر الرئيسية للفئات المحمية، وفجوات الخدمات، والمساهمة في تصميم وتفسير أدوات جمع البيانات الأولية.	إرشادات منظمة تحدد نطاق الوثائق المراجعة، معايير الإدراج والاستبعاد، المجالات الموضوعية الرئيسية، وطريقة قياسية لاستخراج البيانات وتجميعها لضمان الدقة والاتساق والملاءمة لأهداف التقييم.
2	مسح الأسر	أداة كمية لقياس المؤشرات الرئيسية والانطباعات المجتمعية. مقسم إلى المسح 1 (مركز على التدخل، اختيار عشوائي من قوائم CBO) والمسح 2 (تقييم احتياجات المجتمع، عينة حصة لمناطق التركيز).	نص مفصل للمُحصّين، تعليمات واضحة حول منطق التجاوز للأدوات الرقمية (KoboToolbox)، وإرشادات لتقديم الأسئلة دون تحيز.
3	مجموعات النقاش المركزة	أداة نوعية للنقاش المعمق مع مجموعات متجانسة (مثل الشباب، النساء، منظمات المجتمع المحلي).	دليل للميسر يحتوي على أسئلة استكشافية مقترحة، تقنيات لإدارة ديناميات المجموعة، ضمان سماع جميع الأصوات، وإدارة المواضيع الحساسة. تعليمات لتدوين الملاحظات والتسجيل الصوتي (مع الحصول على الموافقة).
4	مقابلات المصلحة الرئيسيين أصحاب	أداة نوعية للحصول على رؤى من الموظفين، مزوّدي الخدمات، وقادة المجتمع.	دليل مقابلة بأسئلة مفتوحة تهدف لاستخراج وجهات نظر مفصلة حول الأولويات، التحديات، والقضايا النظامية. إرشادات حول الاستماع النشط، الاستقصاء، والسرية.

الجدول 3: أدوات جمع البيانات والإرشادات

4.3.3 عينة التقييم

اعتمد نهج أخذ عينات مختلط لتحقيق التوازن بين الملاءمة السياقية والدقة المنهجية. ساعدت منظمات المجتمع المحلي الشريكة (CBOs) أولاً في اختيار ثلاث مجتمعات استناداً إلى مخاطر الحماية، وتنوع السكان، والفجوات في الخدمات. ضمن كل مجتمع، تم تحديد ثلاث أحياء تلبي معايير القابلية الضعف المحددة مسبقاً. تم تقسيم كل حي إلى كتل، وطبق جامعو البيانات طريقة الفاصل المنهجي، بدءاً من أول منزل على اليمين في كل كتلة، مع تخطي كل منزل خامس لتقليل تحيز الاختيار.

شملت المعايير العامة لاختيار جميع المشاركين ضمان التنوع في العمر والجنس والجنسية وحالة الإعاقة. كما استُبعد الأفراد الراضين للمشاركة والأشخاص ذوو المناصب العليا من مجموعات النقاش لمنع التحيز. تضمنت الضوابط الأخلاقية الحصول على موافقة الوالدين للقصر، وتيسير الجلسات بما يتناسب مع الجنس، واستخدام أدوات صديقة للطفل.

لضمان التمثيل وتقليل التحيز، استخدمت المنهجية التقسيم الطبقي حسب الخصائص الديموغرافية الأساسية. ساعدت المنظمات الشريكة في الوصول إلى المجموعات صعبة الوصول، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. كما جرى فصل مجموعات النقاش حسب العمر والجنس لضمان مساحة نقاش آمنة. وتلقى جامعي البيانات التدريب على الحيادية والمشاركة الأخلاقية. تقنية الفصل المنهجي منعت استخدام العينات بالراحة (convenience sampling).

تم توزيع العينة بما يتناسب مع حجم السكان، حيث تلقت المناطق الأكبر عددًا أكبر من الاستبيانات للتمثيل الإحصائي، بينما أظهرت مقابلات أصحاب المعرفة (KIIs) ومجموعات النقاش (FGDs) رؤى نوعية متنوعة عبر المناطق.

كما تم اعتماد معايير اختيار محددة لأصحاب المصلحة، والتي شملت لمجيبين استبيانات الأسر (الأوصياء) الإقامة في المجتمع المختار لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يكون عمرهم أكثر من 18 عامًا، وتضمين أعضاء من المجتمعات المستضيفة واللاجئة، مع إعطاء أولوية للأسر التي لديها أطفال وشباب. الرقم النهائي موضح في الجدول أدناه.

الموقع	الجنسية					المجموع
	أردني/ة	سوري	جنسيات أخرى (فلسطينيون، عراقيون، سودانيون، باكستانيون)	ذكر	أنثى	
عمان	118	44	34	79	117	196
الزرقاء	125	65	13	78	125	203
البلقاء	167	18	14	76	122	198
مادبا	120	66	12	68	130	198
إربد	128	81	0	129	80	209
الكرك	158	37	2	79	118	197
مجموع العينة: 1201						

الجدول 4: توزيع عينة المسح حسب الخصائص الديموغرافية

بالنسبة لمجموعات النقاش المركزة، كان من الضروري أن ينتمي المشاركون إلى الفئة الديموغرافية المعنية (مثل الأطفال من 10-14 سنة، الشباب من 15-24 سنة، وأولياء الأمور)، وأن يقيموا في الحي المحدد والمعروف لدى المنظمات المجتمعية المحلية (CBOs). الرقم النهائي للمشاركين موضح في الجدول أدناه.

الموقع	الفئة العمرية			الجنسية		الجنس		مجموع المشاركين	مجموع المشاركين في المجموعات النقاشية المركزة
	كبار (18+)	يافعين- 17) Jordanian	أطفال (12-14)	أردنيون	لاجئون	ذكر	أمثى		
عمان	4	9	8	18	3	8	13	21	3
الزرقاء	6	11	13	18	12	11	19	30	5
البلقاء	13	10	18	25	16	23	18	41	5
مادبا	8	24	17	20	29	41	8	49	5

3	30	23	7	14	16	1	5	24	إربد
5	34	20	14	20	14	7	2	25	الكرك
مجموع العينة: 205									

الجدول 5: توزيع عينة مجموعات النقاش المركزة (FGD) حسب الخصائص الديموغرافية

فيما يخص المقابلات المعمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين (KIIs)، فقد طُلب من المشاركين أن يمتلكوا معرفة وخبرة ذات صلة بحماية الطفل، أو أوضاع الهشاشة المجتمعية، أو تقديم الخدمات. وشمل ذلك ناشطين مجتمعيين، وممثلي وموظفي منظمات المجتمع المحلي، والسلطات المحلية، والمعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي وممثلي المنظمات غير الحكومية. وقد استند اختيار المشاركين إلى أدوارهم الوظيفية، ومعرفتهم المؤسسية، وخبرتهم المباشرة في العمل مع الفئات الأكثر هشاشة. ويُبين الجدول أدناه العدد النهائي للمقابلات التي تم تنفيذها، بما في ذلك عدد الأطفال المشمولين ببرامج البدائل عن الاحتجاز (A2D) الذين تمت مقابلتهم.

#	المحافظة	نوع المستجيب	عدد المقابلات المعمقة
1	عمان	ناشط/ة مجتمعي/ة	2
		معلم/ة	1
		ممثل/ة عن منظمة أرض البشر	1
		أطفال ضمن برامج البدائل عن الاحتجاز (A2D)	2
2	الزرقاء	ناشط/ة مجتمعي/ة	1
		معلم/ة	1
		ممثل/ة عن منظمة غير حكومية	1
		أطفال ضمن برامج البدائل عن الاحتجاز (A2D)	2
3	البلقاء	ناشط/ة مجتمعي/ة	1
4	إربد	ممثل/ة عن منظمة مجتمع محلي (CBO)	1
		معلم/ة	1
		أخصائي/ة اجتماعي/ة	1
		أطفال ضمن برامج البدائل عن الاحتجاز (A2D)	2
		ناشط/ة مجتمعي/ة	1
5	مادبا	ناشط/ة مجتمعي/ة	1

		ممثلة/ة عن منظمة غير حكومية	1
6	الكرك	معلم/ة	1
		ممثلة/ة عن منظمة مجتمع محلي (CBO)	1
		ممثلة/ة عن سلطة محلية	1

الجدول 6: توزيع عينة المقابلات الفردية المتعمقة (KIIs) حسب نوع المشارك/ة والمحافظة

4.3.4 تحليل البيانات ومعالجتها

- سيتم تحليل البيانات عملية منهجية وتكرارية، مع الاستفادة من التقنيات الكمية والنوعية لضمان التمثيل القوي للنتائج:
- تحليل البيانات الكمية: تم تنظيف وترميز بيانات الاستبيانات التي جُمعت عبر KoboToolbox وتحليلها باستخدام Excel و Tagutte لإنتاج إحصاءات وصفية. يشمل ذلك استخدام التكرارات، النسب المئوية، والمتوسطات لتحديد مدى انتشار المخاطر، الاحتياجات المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، الوصول إلى الخدمات، والفئات الأكثر ضعفًا.
 - تحليل البيانات النوعية: تم تفريغ تسجيلات مجموعات النقاش المركزة والمقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وإخفاء هويات المشاركين. طبق الباحثون التحليل الموضوعي لتحديد القضايا المتكررة، والمخاوف، والانطباعات، والتجارب المتعلقة بحماية الأطفال، وبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وآليات التكيف، والعوائق أمام الوصول إلى الخدمات، واستجابة المؤسسات، وتجارب النظام القضائي. كما تم تطوير أطر الترميز بشكل تكراري استنادًا إلى أسئلة التقييم والبيانات الناشئة.

الاعتبارات الأخلاقية

استند هذا التقييم إلى التزام قوي بالأخلاقيات، مع إعطاء الأولوية لسلامة وكرامة وحقوق المشاركين، وخاصة الأطفال والشباب الضعفاء. وبالنظر إلى حساسية مواضيع حماية الطفل والصحة النفسية والعدالة، اتبع الفريق إطارًا أخلاقيًا صارمًا في جميع مراحل العمل، مستندًا إلى مبدأ "عدم الإضرار"، مع تدابير تشمل:

- سياسة حماية الطفل ومدونة السلوك: الالتزام الصارم بسياسات أرض البشر لضمان السلامة والكرامة والسرية.
- الموافقة المستنيرة: الحصول على موافقة مقدمي الرعاية والأطفال (شفوية أو مكتوبة)، مع بروتوكولات محسنة للفئات الضعيفة.
- السرية وإخفاء الهوية: تم إخفاء هوية جميع البيانات وتخزينها بأمان (مشفر/مقفّل)، ووقع جميع أعضاء الفريق على اتفاقيات سرية.
- بيئة صديقة وآمنة للأطفال: أجريت المقابلات في مواقع آمنة بواسطة ميسرين مدربين باستخدام أدوات مصممة لتجنب التسبب بالضيق النفسي.
- بروتوكولات محددة للأطفال في النظام القضائي: تضمنت تدابير مسبقة مع الشركاء، موافقة/موافقة صريحة، وتجنب الأسئلة التي قد تضر الطفل أو تجرمه.

- **تخفيف المخاطر ومسارات الإحالة:** تم وضع مسارات إحالة واضحة لخدمات حماية الأطفال والدعم النفسي الاجتماعي التابعة لأرض البشر، مع تزويد المشاركين بمعلومات الدعم.
- **التدريب:** أتم جميع الباحثين والشركاء والمتطوعون تدريباً إلزامياً على الأخلاقيات وحماية الطفل.

1- بناء القدرات في جمع البيانات

نقذ الباحثون برنامجاً لبناء القدرات بهدف دعم أعضاء المنظمات المجتمعية لتمكينهم من قيادة تقييمات الاحتياجات والضعف المجتمعية بشكل فعال. وكجزء من تقرير الانطلاقة الأوسع، صُمم هذا البرنامج لتزويد المنظمات المجتمعية المختارة بالمعرفة والأدوات والإرشادات الأخلاقية اللازمة لإجراء تقييمات شاملة، تشاركية، ومتوافقة مع سياق كل مجتمع. ساهم التدريب في تحقيق الهدف العام للتقييم، وهو تعزيز نظم حماية الأطفال من خلال توليد أدلة محلية تعكس الاحتياجات والأولويات الحقيقية للأطفال والشباب والفئات الضعيفة. لمزيد من التفاصيل حول التدريب، بما في ذلك المواد المستخدمة والموضوعات المغطاة، يُرجع إلى الملحق الثاني. (Annex II)

2- ضبط الجودة

لضمان سلامة وموثوقية البيانات المجمعة، خضعت جميع أدوات البحث (الاستبيانات، وأدلة مجموعات النقاش، وأدلة مقابلات أصحاب المعلومات الرئيسيين) لاختبار تجريبي على شكل محاكاة خلال التدريب لأعضاء المنظمات المجتمعية المكلفين بجمع البيانات. فيما يخص التحليل، تم إزالة جميع المعلومات القابلة للتعريف من النصوص قبل التحليل، وتم تقييد الوصول إلى البيانات لأعضاء الفريق المصرح لهم فقط، وتم تخزين جميع الملفات بشكل آمن على محركات مشفرة ومحمية بكلمات مرور.

3- القيود والتحديات

1. أظهرت البيانات الأولية تناقضات بارزة، خاصة فيما يتعلق بتصورات السلامة. على سبيل المثال، أفاد الأطفال بتعرضهم لمعدلات عالية من العنف المباشر والتتمر بين الأقران، بينما ذكر مقدمو الرعاية بأغلبية ساحقة أن البيئة المنزلية والمدرسية آمنة. اضطر المستشارون لتفسير هذه التباينات الكمية والنوعية باعتبارها دليلاً بحد ذاته، مثل قلة الإبلاغ من قبل مقدمي الرعاية واختلاف فهم مفهوم السلامة.
2. واجه الباحثون تحدياً في تقديم نتائج نوعية حول كيفية تجربة الأطفال والشباب الذين يواجهون مستويات مختلفة من التهميش (سواء بسبب الجنس، الجنسية، أو القدرات البدنية) للموضوعات المستكشفة في التقييم. ويرجع ذلك إلى أن معظم البيانات المتعلقة بالمستجيبين جاءت منهم مباشرة (مقدمو الرعاية والأطفال والشباب)، ونظراً لأن هذه البيانات جُمعت عبر مجموعات النقاش، لم يتمكن جامعو البيانات من تمييز هوية كل متحدث بدقة، ما أدى إلى نتائج تفتقر للعدسة الداخلية. ومع ذلك، وبما أن البيانات الكمية جُمعت باستخدام هذه العدسة الداخلية، تمكن الباحثون من تعويض هذا النقص لاستنتاج الفئات ذات الهوية المحددة التي تواجه مخاطر أو عوائق أكبر.

النتائج المستخلصة من البيانات الثانوية: مراجعة المكتبية

1. السياق والخلفية

1.2 فهم سياق اللاجئين: العبء الاستثنائي على الأردن

يشكل موقع الأردن كدولة مضيقة رئيسية للاجئين عاملاً أساسياً في صياغة سياق برمجة حماية الطفل. حتى ديسمبر 2024، تستضيف المملكة حوالي 675,000 لاجئ مسجل وفق بيانات التسجيل الرسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع نسبة كبيرة تبلغ 90% من اللاجئين القادمين من سوريا.¹ ومع ذلك، تمثل هذه الأرقام اللاجئين المسجلين النشطين فقط لدى المفوضية، في حين يُقدّر العدد الفعلي للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن بأن يكون أعلى بكثير عند احتساب الأفراد غير المسجلين أو الذين فقدوا حالة التسجيل لأسباب إدارية متعددة. هذه الفئة من اللاجئين تمثل عبئاً استثنائياً لكل فرد على دولة متوسطة الدخل ذات موارد طبيعية محدودة، وإمدادات مياه محدودة، واقتصاد يعاني من البطالة ونمو اقتصادي بطيء حتى قبل استيعاب أعداد كبيرة من النازحين.

توضح التوزيعات الديموغرافية للاجئين عبر الأردن أنماطاً مهمة لبرمجة حماية الطفل. فبدلاً من الإقامة في المخيمات، يعيش 81% من اللاجئين السوريين المسجلين خارج المخيمات في مناطق حضرية وشبه حضرية، مندمجين في المجتمعات المستضيفة في جميع أنحاء المملكة. هذا الواقع الحضري للاجئين يوفر فرصاً وتحديات على حد سواء: فبينما يتمتع اللاجئون بحرية أكبر في التنقل والوصول إلى الخدمات الحضرية مقارنة بالمقيمين في المخيمات، فإنهم يواجهون مخاطر حماية متزايدة تشمل الاستغلال، عمل الأطفال، وسوء السكن. من الناحية الجغرافية، تتركز أعداد اللاجئين بشكل كبير في محافظات الشمال مثل إربد والمفرق والزرقاء، بالإضافة إلى العاصمة عمان. محافظة إربد وحدها تستضيف حوالي 128,000 لاجئ، وهو ثاني أكبر تجمع حضري للاجئين في الأردن بعد عمان. وتعكس هذه الأنماط التركيزية قربها من الحدود السورية وتوافر المساكن الإيجارية وفرص العيش في هذه المدن.

أدخلت التطورات السياسية الأخيرة ديناميكيات جديدة في سياق اللاجئين في الأردن. بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بدأ حوالي 58,000 لاجئ سوري بالعودة الطوعية إلى سوريا، في ظل آمال بتحقيق تغيير سياسي واستقرار.² ويمثل هذا نحو 8.6% من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن. ومع ذلك، اختار الغالبية العظمى البقاء في الأردن، مشيرين إلى استمرار المخاطر الأمنية في سوريا، وعدم توفر الخدمات الأساسية في مناطق العودة المحتملة، إضافة إلى أن العديد من الأطفال قضوا حياتهم كلها في النزوح ولديهم اتصال محدود بسوريا. إن قرار البقاء أو العودة يخلق ضغوطاً نفسية واجتماعية معقدة للعائلات اللاجئة، ما يزيد من مخاطر الحماية بسبب الضغوط الاقتصادية، وغموض المستقبل، والانفصال العائلي.

لا يمكن المبالغة في طول أمد النزوح في الأردن. فالأزمة السورية، التي أدت إلى أغلب تدفقات اللاجئين، بدأت في 2011، ما يعني أن العديد من الأطفال والمراهقين اللاجئين في الأردن اليوم قد قضوا حياتهم كلها في النزوح.³ الأطفال المولودون في السنوات الأولى للأزمة أصبحوا الآن مراهقين يواجهون تحولات تعليمية وتنموية حاسمة في ظل حالة عدم اليقين الممتدة. هذا النزوح طويل الأمد خلق تحديات متعددة الطبقات تؤثر على كل جانب من جوانب رفاه الطفل: حماية من العنف والاستغلال، الوصول إلى تعليم جيد، التنمية النفسية والاجتماعية والصحة العقلية، الضعف الاقتصادي الذي يدفع إلى آليات مواجهة سلبية مثل عمل الأطفال والزواج المبكر، وحالة عدم اليقين العميقة حول المستقبل التي تقوض تطلعات المراهقين وتنميتهم. وفهم هذه التحديات المترابطة يتطلب الاعتراف بأن النزوح بالنسبة للعديد من الأطفال في الأردن ليس مجرد اضطراب مؤقت، بل هو السياق المحدد لطفولتهم ومراهقتهم.

2. التحديات الرئيسية التي تؤثر على الأطفال في الأردن

2.1 عمالة الأطفال: تآكل الطفولة من خلال الاستغلال

¹ Unhcr, Dec 2024, External Statistical Report on UNHCR Registered Refugees and Asylum-Seekers Jordan as of 31 Dec 2024

² The Jordan Times, 75,500 Syrian refugees return home since Assad fall , UNHCR, 2025, link: <https://jordantimes.com/news/local/75500-syrian-refugees-return-home-since-assad-fall-unhcr>

³ UNCHR, Syria Refugee Crisis Explained, 2025, link: <https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/>

تمثل عمالة الأطفال واحدة من أخطر الانتهاكات المتعلقة بحماية الأطفال في الأردن، إذ تؤدي بشكل منهجي إلى تآكل الطفولة من خلال إجبار الأطفال على الانخراط في أنشطة اقتصادية تتداخل مع التعليم، وتؤثر سلباً على صحتهم وتطورهم، وتعمل على ترسيخ دائرة الفقر عبر الأجيال. وتعد دراسة المسح الوطني لعمالة الأطفال التي أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2016 أكثر البيانات شمولاً لفهم نطاق وخصائص عمالة الأطفال في الأردن، حيث أظهرت الدراسة، التي نفذها دائرة الإحصاءات العامة بدعم فني من منظمة العمل الدولية، أن 75,982 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاماً مشاركون في أنشطة اقتصادية، ما يمثل 1.89% من إجمالي الأطفال في هذه الفئة العمرية من أصل 4.03 مليون طفل.

ومع ذلك، ليس كل الأطفال العاملين يُصنفون ضمن "عمالة الأطفال" وفق التعريفات الدولية. فقد أظهرت الدراسة أن 69,661 من هؤلاء الأطفال، أي ما يعادل 91.7% من جميع الأطفال العاملين، يندرجون تحت تعريف عمالة الأطفال حسب الاتفاقيات الدولية، أي العمل الذي يضر بصحتهم أو سلامتهم أو تنميتهم الأخلاقية، أو يتداخل مع تعليمهم. والأمر الأكثر إثارة للقلق أن 44,917 طفلاً، أي 1.11% من إجمالي الأطفال و 64.5% من الأطفال العاملين، يعملون في أنشطة خطيرة، وهي أشد أشكال عمالة الأطفال التي تتضمن ظروفًا خطيرة، حمل أوزان ثقيلة، التعرض للمواد الكيميائية، أو العمل في بيئات ضارة.

ويبرز البعد الجنساني لعمالة الأطفال بشكل واضح في الأردن، حيث يمثل الأولاد 88.3% من الأطفال العاملين، بينما تمثل الفتيات 11.7% فقط، ما يعكس المعايير الاجتماعية المرتبطة بالعمل المناسب لكل جنس، بالإضافة إلى احتمالية أن يتم تقليل الإبلاغ عن العمل المنزلي للفتيات في المنازل ضمن منهجيات المسح.

كما يكشف بعد اللاجئين عن ضعف خاص وحاد. إذ يشارك الأطفال السوريون اللاجئون في عمالة الأطفال بمعدلات أعلى بكثير من الأطفال الأردنيين، حيث تبلغ نسبة الأطفال السوريين المشاركين 3.22% مقارنة بـ 1.57% للأطفال الأردنيين و 2.41% للأطفال من جنسيات أخرى.⁴ وتعكس هذه الفجوة التحديات المركبة التي تواجه العائلات اللاجئة، مثل الضغوط الاقتصادية الشديدة مع محدودية فرص العمل القانونية للمقدمي الرعاية، وغياب شبكات الحماية الاجتماعية، والانقطاع عن التعليم أثناء النزوح، وضعف تطبيق قوانين حماية العمل على اللاجئين.

تشير التقديرات الحديثة لعامي 2023-2024، رغم أنها ليست مستندة إلى مسوحات وطنية شاملة، إلى أن عمالة الأطفال لم تنخفض وربما ازدادت سوءاً. إذ تشير تقارير حماية الأطفال لدى اليونسيف الأردن لعام 2024 إلى أن أكثر من 75,000 طفل مشاركون حالياً في أنشطة اقتصادية، بينهم 45,000 طفل يعملون في أشكال خطيرة من العمل، وهي أرقام تتماشى مع نتائج مسح 2016 أو تتجاوزها قليلاً.

ومن الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص التقارير الصادرة عن الشركاء الميدانيين والمنظمات المجتمعية التي توثق حالات أطفال في سن الرابعة أو الخامسة يعملون. كما أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 حول حقوق الإنسان في الأردن، مستنداً إلى ملاحظات ميدانية لأرض البشر، إلى حالات أطفال صغار جداً يعملون، خاصة في المناطق الزراعية وبين اللاجئين اللبنانيين الذين يواجهون ضعفاً اقتصادياً أشد من اللاجئين السوريين.

وتشمل القطاعات التي يوظف فيها الأطفال في الأردن:

- الزراعة، حيث يعمل الأطفال في الحصاد والزراعة تحت ظروف قاسية؛
- الورش والمصانع الصغيرة، وخاصة في قطاع الملابس والتصنيع؛
- مواقع البناء، حيث يحمل الأطفال المواد ويساعدون العمال المهرة؛
- البيع المتجول والتسول في المراكز الحضرية؛
- العمل المنزلي، الذي يؤثر بشكل أكبر على الفتيات ويظل إلى حد كبير غير مرئي وغير منظم.

وتترتب على عمالة الأطفال عواقب عميقة وطويلة الأمد على نمو الأطفال ومستقبلهم. إذ يواجه الأطفال العاملون مخاطر جسدية مباشرة تشمل الإصابات، والتعرض للمواد الكيميائية والظروف الخطرة، والضرر التنموي الناجم عن الجهد البدني المبكر. كما يؤثر العمل على التعليم من خلال تقليل حضور المدرسة، وزيادة معدلات التسرب، أو إرهاق الأطفال بما يمنعهم من التعلم بفعالية، مما يساهم في استمرار دائرة الفقر عبر حُرمان الأطفال من التعليم اللازم لفرص مستقبلية أفضل.

⁴ ILO, Child labour doubles in Jordan since 2007 – Survey, link: <https://www.ilo.org/resource/news/child-labour-doubles-jordan-2007-%E2%80%9393-survey>

وتشمل التأثيرات النفسية الاجتماعية فقدان الطفولة ميكراً، والتعرض لبيئة وسلوكيات مقدمي الرعاية، والضغط النفسي الناتج عن المسؤولية الاقتصادية. ولا يمكن تجاهل بعد الاستغلال، إذ يكون الأطفال العاملون عرضة للإساءة، وعدم دفع الأجر الكامل، والاتجار، مع محدودية إمكانية اللجوء للحصول على حقوقهم.

المسؤولية عن بيانات عمالة الأطفال

تستند إحصاءات عمالة الأطفال المعروضة في هذا القسم بشكل رئيسي إلى المسح الوطني لعمالة الأطفال لعام 2016 الذي أجرته منظمة العمل الدولية، والذي يظل المصدر الأكثر شمولاً ودقة من الناحية المنهجية لفهم عمالة الأطفال في الأردن. وقد نفذ هذا المسح دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بين عامي 2015 و2016 بمساندة فنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال (IPEC)، مع استخدام منهجيات دولية موحدة لمسوح عمالة الأطفال. كما اعتمد المسح على تصميم عينة ممثل وطنياً يشمل جميع المحافظات والمناطق الحضرية والريفية، مع تفصيل البيانات حسب العمر والجنس والجنسية والموقع الجغرافي والقطاع الاقتصادي.

أما التقديرات المحدثة لعامي 2023-2024 (75,000 طفل في أنشطة اقتصادية، و45,000 طفل في أشكال عمل خطرة) فقد استُقيت من تقارير برنامج حماية الأطفال لدى اليونيسف الأردن المتاحة عبر بوابة الشفافية الخاصة باليونيسف، ومن تقرير وزارة العمل الأمريكية لعام 2023 بعنوان "Findings on the Worst Forms of Child Labor: Jordan". ويجب فهم هذه التقديرات على أنها تقديرات برنامجية تقريبية وليست نتائج مسح وطني شامل، إذ لم يُجرَ أي مسح وطني شامل لعمالة الأطفال منذ عام 2016.

وتأتي المعلومات النوعية المتعلقة بالأطفال الصغار جداً (أعمارهم 4-5 سنوات) من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 حول ممارسات حقوق الإنسان في الأردن، والذي يستند إلى ملاحظات ميدانية من منظمة Terre des hommes ومنظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في الأردن.

ويجدر بالقراء ملاحظة أن بيانات عمالة الأطفال، خاصة تلك المستقاة من مسوح الأسر، غالباً ما تقلل من تقدير بعض أشكال العمل مثل العمل المنزلي (الذي يؤثر بشكل أكبر على الفتيات)، والعمل في مشاريع العائلة (الذي قد لا تعتبره العائلات "عملاً")، والعمل في القطاع غير الرسمي. كما قد تواجه منهجيات المسح صعوبات في الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً بما في ذلك اللاجئين غير المسجلين والمجموعات الرُحَّل، ما يعني أن الانتشار الفعلي لعمالة الأطفال قد يكون أعلى من الأرقام المعلنة.

وعلى الرغم من هذه القيود المتأصلة، يظل مسح منظمة العمل الدولية لعام 2016 المصدر الأكثر موثوقية لفهم أنماط واتجاهات عمالة الأطفال في الأردن، ويوفر الأساس الأكثر موثوقية للتحليل. وتبرز الحاجة الملحة لإجراء مسح وطني محدث لعمالة الأطفال، نظراً لأن أحدث بيانات شاملة أصبحت تقريباً منذ تسع سنوات.

2.2 زواج الأطفال: سلب الطفولة من خلال ممارسات ضارة

يُعدّ زواج الأطفال، أي زواج الفتيات والفتيان قبل إتمامهم الثامنة عشرة من العمر، انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل وممارسة ضارة تخلّف آثاراً مدمرة على صحة الفتيات وتعليمهن ونموهن.⁵ وفي الأردن، تَمَسَّ هذه الظاهرة كلاً من الأردنيين واللاجئين، إلا أنها أكثر انتشاراً بشكل ملحوظ بين المجتمعات السورية اللاجئة. وتشير البيانات الوطنية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، المسؤولية عن تسجيل عقود الزواج المبرمة في المحاكم الشرعية، إلى أنّ 10% من الفتيات في الأردن يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة، فيما تتزوج 1% منهن قبل سن الخامسة عشرة. وتترجم هذه النسب إلى آلاف الحالات سنوياً؛ ففي عام 2020، سجّل 7,964 عقد زواج لفتيات دون الثامنة عشرة، ما شكّل ما يقارب 12% من إجمالي عقود الزواج المسجلة في ذلك العام، إضافة إلى 194 حالة زواج لفتيان دون الثامنة عشرة.

ويكشف التوزيع الجغرافي لزواج الأطفال عن تركّز مقلق في المراكز الحضرية الكبرى والمناطق المستضيفة للاجئين. فقد سجّلت محافظة عمّان أعلى الأعداد المطلقة، حيث تزوّج 3,075 فتاة و84 فتى دون الثامنة عشرة في عام 2017، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات جغرافية مفصلة.⁶ كما سجّلت محافظة إربد، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، 2,041 فتاة و41 فتى

⁵ UNICEF, Child marriage, link: <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>

⁶ HPC, Jordan in Marriage Child On Study A, 2017, link: <https://www.hpc.org.jo/sites/default/files/HPC%20Child%20Marriage%20Eng.pdf>

في زيجات مبكرة،⁷ في حين وثقت محافظة الزرقاء 2,197 فتاة و53 فتى، وسجلت محافظة البلقاء 471 فتاة و21 فتى. وتعكس هذه الأنماط من جهة كثافة السكان في هذه المحافظات، ومن جهة أخرى الهشاشة المتزايدة الناتجة عن الفقر والنزوح.

ويبرز بُعد اللجوء في زواج الأطفال تفاوتًا صارخًا تقاوم منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. فوفقًا لتقييمات شاملة للهشاشة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها، فإن 13% من الفتيات السوريات اللاجئات في الأردن ممن تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عامًا متزوجات بالفعل، مقارنة بنسبة 2% فقط بين الفتيات الأردنيات في الفئة العمرية ذاتها، أي بفارق يزيد على ستة أضعاف. وتشير دراسات أجريت قبل النزاع السوري إلى أن نحو 13% من الفتيات في سوريا كنّ يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة، ما يدل على أن النزوح لم يُخفّض هذه الظاهرة بل حافظ عليها أو ربما زاد من حدتها. وفي سياق المخيمات، قد تكون النسب أكثر حدة خلال فترات معينة؛ ففي مخيم الزعتري، أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن، شكّلت زيجات الأطفال 57% من إجمالي الزيجات المسجلة في تموز/يوليو 2020، حيث كان 37 عقدًا من أصل 65 يخص أطفالًا، وهو مؤشر صادم على كيفية دفع ظروف النزوح والمخيمات نحو آليات تكيف ضارة⁸.

وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في تفاقم هشاشة زواج الأطفال في الأردن. إذ أظهرت البيانات الإحصائية الوطنية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ارتفاع نسبة زيجات الأطفال خلال عام 2020 من 11% من إجمالي الزيجات في عام 2019 إلى ما يقارب 12% في عام 2020، مدفوعة بالآثار الاقتصادية للجائحة التي دفعت العديد من الأسر إلى اعتبار الزواج المبكر ضرورة اقتصادية. وكان هذا الارتفاع أكثر وضوحًا داخل مخيمات اللاجئين، حيث تجاوزت زيجات الأطفال في بعض الأشهر نصف إجمالي الزيجات المسجلة.

ويطلب فهم أسباب انتشار زواج الأطفال تحليل الدوافع المعقدة التي تدفع الأسر إلى هذه الممارسة الضارة. ويبرز العوز الاقتصادي بوصفه محركًا رئيسيًا، إذ ارتفعت معدلات الفقر في الأردن بنسبة 38% منذ بداية الجائحة، وبنسبة 18% بين اللاجئين السوريين تحديدًا، وفقًا لتقييمات الهشاشة الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي ظل هذه الظروف، ترى الأسر التي تواجه ضغوطًا مالية خانقة، ولا سيما تلك التي لديها عدد كبير من البنات، أن تزويج البنات يخفف العبء الاقتصادي المترتب على إعالتهم، مع احتمال الحصول على مهر أو مساعدات مالية فورية. كما تلعب الأعراف والمعتقدات الثقافية دورًا محوريًا، لا سيما مفهوم “السترة”، الذي يُفسّر على نطاق واسع في الأردن بوصفه توفير الأمان والحماية وضمان مستقبل الفتاة من خلال الزواج، حيث تعتقد كثير من الأسر أن الزواج المبكر يحمي الفتيات من المشقة ويوفر لهن الاستقرار المالي والاجتماعي.

وتدفع الحاجة المتصورة إلى حماية الفتيات من العنف الجنسي والتحرّش، ولا سيما في بيئات المخيمات التي تعاني من ضعف الأمن، العديد من الأسر إلى اعتبار الزواج المبكر إجراءً وقائيًا، رغم كونه تصورًا خاطئًا. ففي هذا المنطق، يُقدّم الحفاظ على “الشرف” والحماية المزعومة على حساب تعليم الفتيات ونموهن وفرصهن المستقبلية. وبالنسبة لبعض الأسر اللاجئة، قد يخدم زواج الأطفال أهدافًا استراتيجية تتعلق بالوضع القانوني أو حرية الحركة، حيث تُزوَّج الفتيات أحيانًا من أردنيين على أمل مغادرة المخيمات أو تحسين فرص الاستقرار القانوني للبناء في المستقبل، وهو ما يعكس محدودية الخيارات واليأس الذي تفرضه ظروف النزوح⁹.

كما تُسهم التفسيرات الدينية ودور قضاة المحاكم الشرعية في تهيئة بيئة تسمح باستمرار زواج الأطفال رغم الإصلاحات القانونية. فعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الأردني يحدّد سن الزواج بثمانية عشر عامًا، إلا أن الاستثناءات الواسعة تتيح للقضاة منح إذن بزواج من هم دون ذلك، إذ كان يُسمح سابقًا بزواج من هم في سن الخامسة عشرة، وأصبح الحد الأدنى ستة عشر عامًا بعد تعديلات عام 2018. وقد عبّر بعض القضاة عن قبولهم بزواج الأطفال في ظروف معينة، معتبرين إياه وسيلة لحماية الفتيات من الفقر أو الإساءة أو جرائم “الشرف”. ويؤدي هذا الهامش الواسع من السلطة التقديرية إلى تباين في تطبيق القانون، حيث يمنح بعض القضاة الاستثناءات بسهولة، فيما يفرض آخرون رقابة أكثر صرامة. وقد حدّدت الجهات العاملة في مجال حماية الطفل، إلى جانب الحكومة نفسها، تدريب قضاة المحاكم الشرعية على الآثار الضارة لزواج الأطفال وآليات التدقيق في طلبات الاستثناء كحاجة ملحة.

⁷ HPC, Jordan in Marriage Child On Study A, 2017, link: <https://www.hpc.org.jo/sites/default/files/HPC%20Child%20Marriage%20Eng.pdf>

⁸ Unhcr, Syrian refugee women break the chain of child marriage, 2023, link: <https://www.unhcr.org/jo/news/syrian-refugee-women-break-chain-child-marriage>

⁹ HPC, Jordan in Marriage Child On Study A, 2017, link: <https://www.hpc.org.jo/sites/default/files/HPC%20Child%20Marriage%20Eng.pdf>

وتتسم آثار زواج الأطفال على الفتيات بالشدة وطول الأمد. فعلى الصعيد الصحي، يؤدي الحمل المبكر قبل اكتمال النمو الجسدي إلى زيادة مخاطر وفيات الأمهات، والإصابة بالناسور الولادي، وحوادث مضاعفات خطيرة أثناء الولادة. وعلى الصعيد التعليمي، تخرج الفتيات المتزوجات مبكرًا من التعليم في الغالب خروجًا دائمًا، ما يحرمهن من فرص التعلم والنمو والمشاركة الاقتصادية مستقبلًا.¹⁰ أما الآثار النفسية والاجتماعية فتشمل الصدمات الناتجة عن تحمل أدوار ومسؤوليات مبكرة، وفقدان الطفولة والمرافقة، والعزلة عن شبكات الأقران، وارتفاع معدلات العنف الأسري، مع محدودية فرص الانفصال عن الزوجات المسيئة بسبب العمر والاعتماد الاقتصادي والوصم الاجتماعي. ويستمر هذا الأثر عبر الأجيال، إذ تميل الفتيات اللواتي تزوجن مبكرًا إلى إنجاب عدد أكبر من الأطفال، مع مستوى تعليمي أقل، وقدرة أضعف على حماية بناتهن من الوقوع في المصير ذاته.

2.3 العنف ضد الأطفال: تطبيع الأذى

لا يزال العنف ضد الأطفال، بما يشمل من إساءة جسدية ونفسية وجنسية، ظاهرة واسعة الانتشار في الأردن، تطال الأطفال من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، مع تعرّض اللاجئين والفئات المهمشة لمخاطر أعلى بشكل خاص. وتتمثل الإحصائية الأكثر دلالة في بيانات برامج حماية الطفل لدى اليونيسف في الأردن، التي تشير إلى أنّ تسعة من كل عشرة أطفال يتعرّضون لما يُعرف بـ«التأديب العنيف»، أي العدوان النفسي أو العقاب الجسدي، بوصفه ممارسة روتينية في المنازل والمدارس والمجتمعات.¹¹ ويعكس هذا الانتشار شبه الشامل ترسخ أعراف اجتماعية عميقة تقبل، بل وتشجّع أحيانًا، استخدام العقاب الجسدي كوسيلة مشروعة للتأديب والتربية. ويشمل مفهوم التأديب العنيف طيفًا واسعًا من الممارسات، بدءًا من الصراخ والإهانة والتهديد النفسي، وصولًا إلى الضرب باليد أو بالأدوات والصفع وغيرها من أشكال العقاب البدني.

ولا يقتصر تطبيع العنف ضد الأطفال على نطاق الأسرة، بل يمتد إلى البيئات التعليمية، حيث يستمر استخدام العقاب البدني في بعض المدارس على الرغم من حظره رسميًا في النظام التعليمي الأردني، وذلك وفقًا لرصد منظمات المجتمع المدني. فقد يلجأ بعض المعلمين والإدارات المدرسية إلى العقاب الجسدي أو الأساليب النفسية القاسية رغم المنع القانوني، مع محدودية المسائلة عن هذه الانتهاكات. وفي سياقات اللجوء، تتفاقم مخاطر العنف نتيجة تآكل منظومات الحماية، والاحتفاظ في المخيمات والتجمعات غير الرسمية، والضغط الاقتصادي التي تزيد من التوترات الأسرية، فضلًا عن ضعف الإضاءة والبنية التحتية، ما يخلق بيئات تتيح وقوع العنف في المساحات المشتركة.¹²

ويواجه الأطفال السوريون اللاجئون مستويات أعلى من التعرّض للعنف عبر أبعاد متعددة. فداخل الأسرة، تسهم الضغوط الاقتصادية وصدمات النزوح في زيادة العنف الأسري الذي يطال النساء والأطفال على حد سواء. وفي بيئات المخيمات، يؤدي ضعف الأمن إلى مخاطر العنف من الغرباء، بينما تخلق كثافة السكن والمرافق المشتركة أوضاعًا يتعرّض فيها الأطفال للإيذاء أو الإساءة في ظل محدودية الخصوصية والحماية.¹³ وخارج المنزل، يتعرّض الأطفال اللاجئون المنخرطون في عمالة الأطفال للاستغلال والإساءة من أصحاب العمل مع محدودية سبل الانتصاف. أما الفتيات، فيواجهن مخاطر خاصة من العنف والتحرش الجنسي في الأماكن العامة وأثناء الذهاب إلى المدرسة وفي بيئات العمل، وغالبًا ما تُستخدم مخاوف العنف الجنسي ذريعةً لإبقاء الفتيات خارج التعليم أو دفعهن نحو الزواج المبكر بحجة «الحماية».

وتُعدّ آثار التعرّض للعنف على نمو الأطفال ورفاههم عميقة وموثقة على نطاق واسع في أبحاث نمو الطفل. فعلى الصعيد الجسدي، تشمل الآثار الإصابات الفورية الناتجة عن العقاب البدني، واحتمالات العواقب الصحية طويلة الأمد، والأضرار النمائية المرتبطة بالتعرّض المزمن للتوتر والصدمات. نفسيًا، يُظهر الأطفال الذين يتعرّضون للعنف معدلات أعلى من الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وصعوبات السلوك. كما ينعكس العنف سلبيًا على التعلم، إذ يرتبط بانخفاض المواظبة على الدراسة، وصعوبة التركيز، وتدني المخرجات التعليمية. وإضافة إلى ذلك، يُسهم العنف في إدانة دورات العنف بين الأجيال، حيث يميل الأطفال الذين تعرّضوا للعنف إلى اعتباره أمرًا طبيعيًا، وقد يعيدون إنتاج أساليب التأديب العنيفة مع أطفالهم مستقبلًا.

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني لحماية الطفل في الأردن، يشمل قانون حقوق الطفل وعدداً من البروتوكولات والإجراءات ذات الصلة، فإنّ التطبيق لا يزال غير متسق، كما يبقى الوصول إلى خدمات الحماية محدودًا، ولا سيما في المناطق النائية

¹⁰ UNICEF, **Girls' education**

Gender equality in education benefits every child, link: <https://www.unicef.org/education/girls-education>

¹¹ UNICEF/NCFA, 2019/2020, NATIONAL STUDY ON VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN JORDAN, link: <https://www.unicef.org/jordan/media/8921/file/UNICEF%20VAC%20REPORT%20ENG%2015-12-2021.pdf>

¹² UNESCO, 2019, Enforcing the right to education of refugees A policy perspective 08 Working Paper on Education Policy, link: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366839>

¹³ Unicef, 2017, A FAMILIAR FACE Violence in the lives of children and adolescents, link: https://www.unicef.org/media/48671/file/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf

ومخيمات اللاجئين.¹⁴ وقد حققت إدارة حماية الأسرة، وهي الوحدة الشرطية المتخصصة في التعامل مع قضايا العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال، تقدماً ملموساً في السنوات الأخيرة، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بمحدودية الموارد وارتفاع أعباء العمل. وبالنسبة للأطفال اللاجئين، تتعدّد إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية بفعل الخوف من السلطات، وضعف الوعي بالخدمات المتاحة، والحوازر اللغوية لبعض الجنسيات غير الناطقة بالعربية، فضلاً عن القلق من أن يؤثر التواصل مع الجهات الرسمية على وضع التسجيل أو الأهلية للحصول على المساعدات.

3. الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي: معالجة الجراح غير المرئية

أدت أوضاع اللجوء المطوّل، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تؤثر على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء، فضلاً عن التعرّض المزمن للعنف وعدم الاستقرار، إلى نشوء احتياجات حادة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي لدى الأطفال والأسر في الأردن.¹⁵ وغالباً ما تكون هذه الاحتياجات أقل وضوحاً من قضايا الحماية الجسدية مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال، إلا أنها لا تقل أهمية عنها لما لها من أثر مباشر على نمو الأطفال ورفاههم ومسارات حياتهم المستقبلية. ويشمل مفهوم الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي طيفاً واسعاً من التدخلات، يبدأ بالدعم النفسي-الاجتماعي القائم على المجتمع وبرامج الإرشاد الوالدي، ولا ينتهي عند خدمات العلاج النفسي المتخصص للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية سريرية.

شهد قطاع الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي في الأردن تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بتداعيات الأزمة السورية وبالاقرار المتزايد بالآثار النفسية العميقة للنزوح. وقد أحرزت وزارة الصحة الأردنية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، تقدماً مهماً في إدماج خدمات الدعم النفسي-الاجتماعي الأساسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، في تحوّل نوعي من النظر إلى الصحة النفسية بوصفها خدمة تخصصية من المستوى الثالث فقط، إلى اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية الأساسية. ووفقاً لوثائق مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول “الدعم النفسي-الاجتماعي والعمل مع الصدمات في الأردن”، باتت منظمات المجتمع المحلي تقدّم خدمات نوعية في هذا المجال في مناطق رئيسية تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، مثل سحاب والمفرق والزرقاء، ما يعكس تقدماً مهماً في تقريب الخدمات من الفئات المتأثرة.¹⁶

ويرتكز نهج الإدماج الذي تروج له اليونيسف ضمن عملها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي داخل مرافق الرعاية الصحية الأولية، مع تركيز خاص على فئات محددة تشمل الأطفال والبالغين والنساء الحوامل والأمهات الحديّات. وينطلق هذا النهج من إدراك أن العديد من مشكلات الصحة النفسية يمكن التعامل معها بفعالية ضمن مستوى الرعاية الأولية من خلال كوادر صحية عامة مدربة، دون الحاجة دائماً إلى خدمات نفسية متخصصة، الأمر الذي يساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها. وقد كان الأردن من الدول الرائدة التي طبّق فيها هذا النهج تجريبياً، حيث جرى تطوير بروتوكولات خاصة لإدماج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي ضمن خدمات صحة الأم والطفل.

تجري عملية تنسيق الجهات العاملة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي في الأردن من خلال مجموعة عمل، وهي مجموعة فرعية ضمن قطاعي الحماية والصحة في هيكلة التنسيق الإنساني الوطنية. وتدار هذه المجموعة بالشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاء من قطاع الصحة، وتضم وكالات أممية ومنظمات دولية غير حكومية ومنظمات محلية. وتهدف المجموعة إلى تنسيق التدخلات، وتبادل الممارسات الفضلى، وتحديد الفجوات، وتفاذي الازدواجية في الخدمات. كما قامت بتطوير إجراءات تشغيل قياسية، ومسارات إحالة، ومعايير جودة لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي في الأردن، ما يشكّل بنية تنظيمية مهمة لضمان الحد الأدنى من الجودة وإتاحة الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وعلى الرغم من هذا التقدم، ما تزال هناك فجوات كبيرة في تغطية وجودة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي. فالتغطية الجغرافية غير متوازنة، إذ تتركز الخدمات في المدن الكبرى ومخيمات اللجوء المعروفة، بينما تعاني المناطق الريفية وبعض التجمعات شبه الحضرية من ضعف الوصول. كما أن الطاقة الاستيعابية للكوادر المتخصصة في الصحة النفسية في

¹⁴ NRC, 2024, Legal Guide to Child's Right in Jordan, link: <https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/legal-protection-of-children/legal-guide-to-childs-rights-in-jordan-english.pdf>

¹⁵ National Library for Medicine, link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9307067/>

¹⁶ GIZ, Enhancing psychosocial support services for host communities and Syrian refugees in Jordan Psychosocial Support and Trauma Work in Jordan, 2016, link: <https://www.giz.de/en/projects/p>

الأردن ما تزال محدودة، مع نقص في أعداد الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين النفسيين مقارنة بحجم الاحتياج، حتى قبل احتساب احتياجات اللاجئين. ولا تزال الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية تشكل عائقاً أمام طلب الخدمات، حيث تُفسر المشكلات النفسية في كثير من الأحيان ضمن أطر تتعلق بالعار الأسري أو التفسيرات الدينية والروحية، بدلاً من اعتبارها قضايا صحية تستدعي دعماً مهنيًا. أما بالنسبة للاجئين، فتضاف إلى ذلك عوائق أخرى تشمل اللغة لغير الناطقين بالعربية، والخوف من أن يؤثر تلقي الخدمات على المساعدات أو الوضع القانوني، وضعف الوعي بالخدمات المتاحة.

تغطي تدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي في الأردن طيفاً متكاملاً، يبدأ بالتدخلات المجتمعية التي تركز على بناء الصمود وتعزيز مهارات التكيف والتواصل الاجتماعي، وصولاً إلى العلاج النفسي المتخصص للأطفال الذين يعانون من حالات سريرية مثل الاكتئاب واضطرابات القلق واضطراب ما بعد الصدمة.¹⁷ وتشمل التدخلات المجتمعية أنشطة ترفيهية منظمة، والتعبير الإبداعي عبر الفن والموسيقى، وتنمية المهارات الحياتية، وآليات دعم الأقران. كما تستهدف برامج الإرشاد الوالدي الحد من العنف في التربية من خلال تعزيز أساليب التربية الإيجابية ومساعدة مقدمي الرعاية على إدارة الضغوط النفسية. وبالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الأكثر تعقيداً، توفر مسارات الإحالة ربطاً بالخدمات المتخصصة مثل الإرشاد الفردي والعلاج الأسري والتقييم والعلاج النفسي عند الحاجة.

ويُعدّ الاهتمام برعاية الكوادر العاملة في المجال الإنساني والخدمي، ودعم صحتهم النفسية وممارسات العناية الذاتية، عنصراً أساسياً لكنه غالباً ما يُغفل في منظومة الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي في الأردن. وتشير وثائق مشروع GIZ إلى إنشاء مراكز متخصصة لرعاية العاملين، وتطوير سياسات للعناية بالكوادر من قبل وزارة الصحة، وتنفيذ تدريبات تمكّن العاملين من دعم زملائهم في إدارة الضغوط وممارسة العناية الذاتية.¹⁸ ويعكس هذا التوجّه إدراكاً متقدماً بأن مقدمي الخدمات أنفسهم، الذين يعملون في ظروف صعبة ويتعرضون يومياً لروايات وتجارب صادمة، بحاجة إلى دعم نفسي مستمر لضمان استدامة جودة الخدمات.

كما بدأت الجامعات الأردنية بإدماج مفاهيم الدعم النفسي-الاجتماعي ضمن مناهجها الأكاديمية، حيث دعمت GIZ جامعة واحدة على الأقل لتطوير مساقات متخصصة في الدعم النفسي-الاجتماعي في سياقات اللجوء. ويشكل هذا التوجه استثماراً استراتيجياً في بناء قدرات وطنية مستدامة، من خلال إعداد الجيل القادم من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين والعاملين الصحيين على تبني مقاربات واعية بالصدمات النفسية وملائمة للسياق المحلي.¹⁹

4. الأطفال ذوو الإعاقة: إقصاء عميق عن التعليم والحماية

يواجه الأطفال ذوو الإعاقة في الأردن إقصاءً منهجياً عن التعليم وخدمات الحماية والمشاركة الاجتماعية، ما يجعلهم من أكثر الفئات تهميشاً سواء في المجتمعات المستضيفة أو بين اللاجئين. ويتجلى حجم الإقصاء التعليمي بشكل صارخ؛ إذ تشير بيانات جمعتها منظمة الإنسانية والإدماج (Humanity & Inclusion) ودائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن 79% من الأشخاص ذوي الإعاقة في سن الدراسة محرومون من أي شكل من أشكال التعليم في الأردن.²⁰ ويكشف هذا الرقم، الذي يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال ذوي الإعاقة خارج المنظومة التعليمية، عن إخفاقات جوهريّة في تحقيق التعليم الدامج، رغم وجود التزامات سياسية وأطر قانونية تكفل نظرياً حق التعليم لجميع الأطفال.

وتعكس الإحصاءات المتعلقة بانتشار الإعاقة والمشاركة التعليمية صورة مقلقة. فقد أظهر التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 أن 11% من السكان الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات فأكثر يعانون من إعاقات، تُعرّف على أنها صعوبات وظيفية

¹⁷ Unicef, COMMUNITY-BASED MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN HUMANITARIAN SETTINGS: Three-tiered support for children and families, 2020, link: <https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf>

¹⁸ GIZ, handbook on Staff care and Self care for the Ministry of Health: In the context of the health care system, 2020, link: <https://www.giz.de/de/downloads/Handbook%20Self%20Care%20and%20Staff%20Care%20English%202020.pdf>

¹⁹ GIZ, Enhancing psychosocial support services for host communities and Syrian refugees in Jordan Psychosocial Support and Trauma Work in Jordan, 2016, link: <https://www.giz.de/en/projects/psychosocial-support-and-trauma-work-jordan>

²⁰ Handicap International, Disability-Inclusive Education in Jordan, 2020, link: https://www.hi.org/sn_uploads/document/IE_Jordan_Factsheet_April-2022_Final.pdf

تتراوح بين البسيطة والكاملة في أداء وظائف معينة.²¹ وبالاستناد إلى هذا المعدل، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-14 سنة يبلغ نحو 2.4 مليون طفل وفق تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2019، يمكن تقدير عدد الأطفال ذوي الإعاقة في الأردن بنحو 264 ألف طفل. في المقابل، تُظهر إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018-2019 أن 27,694 طفلاً فقط من ذوي الإعاقة كانوا ملتحقين بالتعليم الأساسي، أي ما نسبته 1.9% فقط من إجمالي 1.4 مليون طالب مسجل. ويكشف هذا التفاوت الكبير بين نسبة انتشار الإعاقة في المجتمع ونسبتها بين الطلبة الملحقين بالمدارس عن عمق الإقصاء التعليمي الذي يواجهه الأطفال ذوو الإعاقة.

وتتفاقم التحديات بالنسبة للأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة. فقد أظهرت دراسات تقييم أجزائها Humanity & Inclusion وIMMAP بين اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان أن 22.9% من الأطفال اللاجئين السوريين بعمر سنتين فأكثر يعانون من إعاقات، أي أكثر من ضعف المعدل العام البالغ 11%. ويعكس هذا الارتفاع مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها الإصابات الناتجة عن النزاع، بما في ذلك إصابات الانفجارات والصدمات النفسية، وضعف خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وخلالها أثناء النزوح، وسوء التغذية وتأثيره على النمو، وغياب خدمات التدخل المبكر لحالات التأخر النمائي، إضافة إلى أن الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة غالباً ما تواجه عوائق إضافية تمنعها من العودة إلى بلدها، ما يؤدي إلى إطالة أمد النزوح. ويؤدي تداخل وضع اللجوء مع الإعاقة إلى مضاعفة الهشاشة، حيث تقل فرص التحاق الأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة بالمدارس مقارنة بأقرانهم غير ذوي الإعاقة، كما تقل فرصهم مقارنة بالأطفال ذوي الإعاقة من جنسيات أخرى.

كما يتقاطع النوع الاجتماعي مع الإعاقة لِيُنتِج أنماطاً إضافية من الإقصاء. فقد بيّنت أبحاث Humanity & Inclusion أن الأولاد ذوي الإعاقة أكثر عرضة من الفتيات ذوات الإعاقة لعدم الالتحاق بالمدرسة مطلقاً، وأقل انتظاماً في الحضور المدرسي.²² ويعكس هذا الاستنتاج، الذي قد يبدو غير متوقع، ديناميكيات اجتماعية معقدة؛ إذ تواجه الأسر وصمة اجتماعية أشد تجاه الذكور ذوي الإعاقة مقارنة بالإناث، حيث يُنظر إلى الإعاقة لدى الابن على أنها مصدر أكبر للعار. كما تسود توقعات اجتماعية بأن يسهم الذكور اقتصادياً في إعالة الأسرة، وعندما يعجز الذكور ذوو الإعاقة عن تلبية هذه التوقعات، قد تُهمش أولوية تعليمهم. ويُضاف إلى ذلك تعرّض الأولاد ذوي الإعاقة لمستويات أعلى من التمييز، ما يرفع معدلات التسرب المدرسي بينهم.

وتتعدد العوائق التي تحول دون وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم في الأردن، وهي عوائق مترابطة على المستويات كافة. فعلى المستوى النظامي، يؤدي ضعف البيانات والأدلة المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة إلى جعلهم غير مرئيين في التخطيط التعليمي وتخصيص الموازنات، في ظل غياب جمع منتظم للبيانات حول الأطفال ذوي الإعاقة خارج المدرسة. كما يفتقر النظام التعليمي إلى القدرات اللازمة لتطبيق التعليم الدامج، حيث لا يتلقى المعلمون تدريباً كافياً على استراتيجيات التعليم الشامل، وتظل المناهج الدراسية جامدة وغير ميسرة لمتعلمين متنوعين، في حين تكون البيانات التعليمية المادية والافتراضية غير مهيأة للأطفال ذوي الإعاقات الحركية أو البصرية أو السمعية أو غيرها. وعلى مستوى الأسرة والمجتمع، تسهم الاتجاهات السلبية السائدة تجاه الإعاقة في التقليل من أهمية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، إذ تعتقد كثير من الأسر أن هؤلاء الأطفال غير قادرين على التعلم أو الاستفادة من التعليم. وتتفاقم هذه العوائق مع الفقر الأسري، ولا سيما بين الأسر اللاجئين، ما يجعل كلفة التعليم عبئاً يصعب تحمّله. كما تؤدي الوصمة والتمييز إلى انتشار العنف والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وعزلهم في مؤسسات تعليمية منفصلة بدلاً من دمجهم في المدارس النظامية، وتدني التوقعات بشأن إمكاناتهم وقدراتهم المستقبلية.

وعلى المستوى النظري، يدعم الإطار السياسي في الأردن التعليم الدامج. فالأردن دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2008، ويلتزم بموجب المادة (24) منها بتعزيز التعليم الشامل والداعم للإدماج. كما يؤكد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 مسؤولية الحكومة عن توفير فرص تعليمية مناسبة، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتطرح الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم عام 2020 رؤية طموحة تهدف إلى رفع نسبة الأطفال ذوي الإعاقة في سن الدراسة الملحقين بالمدارس النظامية إلى 10% بحلول عام 2031، وهو تحسن ملحوظ

²¹ Dos, The Reality of Disability "Functional Difficulties" in Jordan, based on the data of The General Population and Housing Census 2015, link: https://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Analytical_Reports/Disability_2021.pdf

²² Handicap International, Disability-Inclusive Education in Jordan, 2020, link: https://www.hi.org/sn_uploads/document/IE_Jordan_Factsheet_April-2022_Final.pdf

مقارنة بالوضع الحالي، لكنه لا يزال يعني أن تسعة من كل عشرة أطفال ذوي إعاقة سيقفون خارج التعليم. كما دعا البرنامج الاستراتيجي للتعليم 2018-2022 إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم اللاجئين²³.

إلا أن تنفيذ هذه السياسات لا يزال ضعيفاً، نتيجة محدودية المخصصات المالية، ونقص تدريب المعلمين، وعدم كفاية تكييف البنية التحتية المدرسية من حيث الإتاحة وسهولة الوصول، وضعف آليات المساءلة عن تحقيق الإدماج. ويؤدي هذا الانفصال بين الالتزامات السياسية والواقع التنفيذي إلى استمرار حرمان الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة في الأردن من حقهم الأساسي في التعليم.

5.مراجعة الأدبيات: الأسس النظرية وقاعدة الأدلة

يتطلب فهم تحديات حماية الطفل في الأردن الارتكاز إلى أطر نظرية راسخة تفسّر كيفية نشوء قضايا الحماية، واستمرارها، وسبل معالجتها. وقد طوّرت هذه الأطر عبر عقود من البحث والممارسة على المستوى العالمي، وهي توفر عدسات تحليلية لفهم التفاعل المعقد بين العوامل الفردية والأسرية والمجتمعية والمجتمعية-الكلية (المجتمع الأوسع) التي تشكل حماية الأطفال ورعايتهم. إضافة إلى ذلك، فإن مراجعة الدراسات والتقييمات الرئيسية المنفذة في الأردن توفر سياقاً أساسياً وبيانات مرجعية يمكن من خلالها مقارنة نتائج هذا التقييم القائم على الاحتياجات.

نهج قائم على حقوق الطفل: الأسس القانونية والأخلاقية

يشكل النهج القائم على حقوق الطفل، المستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الأساس الأخلاقي والقانوني لبرامج حماية الطفل على مستوى العالم. وتمثل مصادقة الأردن على الاتفاقية عام 1991 التزاماً قانونياً ملزماً بضمان حقوق كل طفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة. وتؤكد الاتفاقية أن الأطفال هم أصحاب حقوق وليسوا متلقين إحسان، وأن على الدول واجباً أساسياً في إعمال هذه الحقوق، وأن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون اعتباراً أساسياً في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال. كما أن مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1992 ترتب التزامات إضافية تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات.

وفي عام 2023، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، المسؤولة عن متابعة تنفيذ الدول للاتفاقية، ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السادس للأردن، وأعربت فيها عن قلقها حيال قضايا محددة تشمل زواج الأطفال، والعنف ضد الأطفال، والإقصاء التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، وهي ذات القضايا التي وثقتها هذه المراجعة المكتبية. وتحمل هذه الملاحظات الختامية وزناً معيارياً مهماً في الحوارات السياسية، كما تمثل تفسيراً موثقاً للالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي. ويقتضي النهج القائم على حقوق الطفل أن تعالج البرامج كلاً من الاحتياجات الفورية للحماية والقضايا البنيوية الكامنة التي تسمح باستمرار انتهاكات الحقوق، بما في ذلك الأطر القانونية، والقدرات المؤسسية، وتخصيص الموارد، والأعراف الاجتماعية، وآليات المساءلة.

النموذج الاجتماعي-البيئي: تفاعل المستويات المتعددة للحماية والمخاطر

لا يمكن فهم حماية الطفل من خلال التحليل على مستوى الفرد فقط، بل يتطلب ذلك فحص كيفية تفاعل العوامل على مستويات متعددة لخلق المخاطر أو توفير الحماية. ويُعدّ النموذج الاجتماعي-البيئي، المستخدم على نطاق واسع من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مجالات الوقاية من العنف وحماية الطفل، إطاراً مفاهيمياً يحدّد التأثيرات ضمن أربعة مستويات متداخلة.

على المستوى الفردي، تؤثر عوامل مثل عمر الطفل وجنسه ووضع الإعاقة وتاريخ النزوح والتعرّض السابق للصدمات في درجة الهشاشة. فالفتاة السورية اللاجئة البالغة من العمر خمسة عشر عاماً والتي تعاني من إعاقة جسدية تواجه مخاطر حماية مختلفة تماماً عن تلك التي يواجهها طفل أردني في العاشرة من عمره دون إعاقة، ما يعكس تقاطع الخصائص الفردية في تشكيل أنماط فريدة من الهشاشة. وتستجيب منظمة أرواح الإنسان (Tdh) لهذه الاحتياجات من خلال تدخلات مصممة خصيصاً، تشمل

²³ MoE/HCD, The 10-Year Strategy for Inclusive Education, link: https://moe.gov.jo/sites/default/files/the_10-year_strategy_for_inclusive_education_0_0.pdf

الدعم النفسي-الاجتماعي، والأنشطة الترفيهية، وإدارة الحالات، بما يتلاءم مع الظروف الخاصة بكل طفل، إدراكاً بأن الحماية الفاعلة تستلزم فهماً دقيقاً لمزيج العوامل التي تشكل المخاطر والقدرة على الصمود.

وعلى المستوى الأسري، تؤثر عوامل مثل الوضع الاقتصادي للأسرة، ومستوى تعليم الوالدين واتجاهاتهما، وتكوين الأسرة، وضغوط المعيشة في حماية الأطفال. فالأسرة التي تعيلها امرأة وتعيش في فقر مدقع قد تلجأ إلى استراتيجيات تكيف مختلفة عن أسرة مكونة من والدين بدخل مستقر، وقد تشمل هذه الاستراتيجيات ممارسات سلبية مثل عمالة الأطفال أو زواج القاصرات. وتعمل أرض البشر على تعزيز عوامل الحماية على هذا المستوى من خلال الإرشاد الأسري وخدمات إدارة الحالات التي تعزز قدرات الأسر. وتستهدف التدخلات الأسر التي تعاني من الفقر أو الإعاقة الأحادية أو مستويات عالية من الضغط، بهدف الحد من آليات التكيف الضارة وتحسين ممارسات الرعاية والمرونة الأسرية، انطلاقاً من أن تقوية البيئة الأسرية شرط أساسي لتحقيق حماية مستدامة للأطفال.

أما على المستوى المجتمعي، فتؤثر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالتأديب وأدوار النوع الاجتماعي، وتوفر الخدمات وإمكانية الوصول إليها، ومستوى التماسك أو التوتر المجتمعي، والعوامل البيئية مثل السلامة والبنية التحتية، في تشكيل بيئة محفوفة بالمخاطر أو داعمة للحماية. فالمجتمع الذي يرفض زواج الأطفال ويملك لجاناً فاعلة لحماية الطفل يوفر ديناميكيات حماية مختلفة تماماً عن مجتمع تُعد فيه هذه الممارسات مقبولة وتغيب فيه الخدمات. وتعمل أرض البشر على تغيير الأعراف الضارة وتعزيز البيانات المحلية الحامية من خلال الحشد المجتمعي، وجلسات التوعية، وإنشاء لجان حماية الطفل، وتوفير المساحات الآمنة. وتسهم هذه التدخلات في تعزيز التماسك المجتمعي، ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يرسخ بيانات أكثر أماناً ودعماً للأطفال.

وعلى المستوى المجتمعي-الكلّي (الوطني)، تشكل الأطر القانونية والسياسات الوطنية والظروف الاقتصادية والقيم الثقافية السياق العام الذي يؤثر في جميع المستويات الأخرى. وتشارك أرض البشر في جهود المناصرة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأثير في السياسات، وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز حقوق الأطفال الأكثر هشاشة. ومن خلال هذه الجهود، تسعى المنظمة إلى الإسهام في تهيئة سياق وطني أكثر أماناً للأطفال والأسر، إدراكاً بأن الحماية المستدامة تتطلب تغييراً بنوياً إلى جانب تقديم الخدمات المباشرة.

ويُعدّ هذا الإطار متعدد المستويات ضرورياً لتصميم تقييمات الاحتياجات، إذ يضمن أن تتناول عملية جمع البيانات ليس فقط مواطن الضعف الفردية، بل أيضاً ظروف الأسرة، وديناميكيات المجتمع، والعوامل النظامية التي تولّد المخاطر أو تحدّ منها. ومن خلال تطبيق النموذج الاجتماعي-البيئي، تضمن أرض البشر شمولية تدخلاتها، بحيث تعالج الاحتياجات الفورية لحماية الطفل، وفي الوقت ذاته تعزز قدرات الأسر، وتحول المجتمعات، وتؤثر في الأنظمة الأوسع للحد من المخاطر وتعزيز رفاه الأطفال. ويتطلب ذلك تنفيذ تدخلات متزامنة على مستويات متعددة: خدمات مباشرة للأطفال، ودعم اقتصادي وأسري لتعزيز الأسر، وحشد مجتمعي لتغيير الأعراف وتحسين الحماية المحلية، ومناصرة للتأثير في السياسات وتخصيص الموارد. ويعكس هذا النهج المتكامل فهماً بأن هشاشة الأطفال وقدرتهم على الصمود تتشكل بعوامل تتجاوز الفرد، ما يستلزم عملاً منسقاً عبر جميع المستويات البيئية لتحقيق حماية دائمة.

الرعاية المستنيرة بالصدمة: إدراك أثر الخبرات السلبية

أدّى النزوح المطول الذي تعرّضت له مجتمعات اللاجئين، وانتشار العنف الذي طال تسعة من كل عشرة أطفال، والضغط الاقتصادي التي تنقل كاهل مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، إلى انتشار واسع للصدمة النفسية بين الأطفال في الأردن. وتستند مبادئ الرعاية المستنيرة بالصدمة، التي تطوّرت عبر أبحاث موسّعة حول الخبرات السلبية في الطفولة وتأثيراتها النمائية، إلى ضرورة أن تعترف جميع خدمات حماية الطفل والدعم النفسي-الاجتماعي بانتشار الصدمات وأثرها، وأن تفهم كيفية تأثيرها في السلوك والنمو، وأن تدمج هذا الفهم في السياسات والممارسات، وأن تتجنّب بشكل فعال إعادة إحياء الصدمة. ويؤكد إطار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) للدعم النفسي-الاجتماعي في الأردن على أهمية اعتماد مقاربات مستنيرة بالصدمة، إدراكاً لأن مقدمي الخدمات غير المدربين على هذا النهج قد يتسببون دون قصد في إلحاق ضرر إضافي عبر ممارسات تستثير استجابات صدمية أو تفشل في توفير الشعور بالأمان والاستقرار الذي يحتاجه الأطفال المتأثرون بالصدمة.

كما تتطلب الرعاية المستنيرة بالصدمة مراعاة الحساسية الجندرية، حيث تختلف تجارب الصدمة وتأثيراتها باختلاف الجنس؛ إذ تواجه الفتيات صدمات مرتبطة بالعنف الجنسي أو الزواج المبكر، بينما يواجه الأولاد صدمات ناتجة عن توقعات الإعاقة

الاقتصادية أو التجنيد العسكري في بلدانهم الأصلية. ويؤكد هذا الإطار أيضاً أن آثار الصدمة لا تقتصر على من تعرّضوا للعنف بشكل مباشر، بل تشمل كذلك من شهدوا العنف، أو فقدوا أحبائهم، أو عاشوا ضغوطاً مزمنة وعدم استقرار مرتبطين بالنزوح والفقر.

9. البيانات الأولية

يعرض هذا القسم نتائج التحليل النوعي والكمي اللذين أجريا في المحافظات الست المستهدفة (عمّان، إربد، مادبا، الكرك، الزرقاء، والبلقاء). وقد تم تنظيم النتائج وفق منهجية تحليلية موضوعية تتمحور حول خمسة محاور تحليلية أساسية في كل منطقة جغرافية، وهي: مخاطر حماية الطفل الرئيسية (1.1)، الرفاه النفسي-الاجتماعي وآليات التكيف (1.2)، الاستجابة المؤسسية والعوائق أمام الإبلاغ (1.3)، مشاركة الأطفال والشباب (1.4)، وأنماط الهشاشة والمخاطر المرتبطة بالنوع الاجتماعي (1.5).

تقدّم الفقرات الفرعية اللاحقة عرضاً معمقاً لما يُعرف بـ«الملف التعريفي للمحافظة» لكل موقع جغرافي، حيث يتبع كل ملف بنية تحليلية موحدة تتماشى مع المحاور الخمسة المذكورة. وضمن كل محور، يتم دعم الرؤى النوعية—التي غالباً ما تُبرز من خلال أصوات المشاركين المباشرة—بالأنماط والاتجاهات الكمية المستخلصة من بيانات الاستبيان. ويتيح هذا النهج التكاملي تحقيق قابلية المقارنة بين المحافظات المختلفة، وفي الوقت ذاته الاعتراف بالخصوصيات والسياقات المحلية المميزة التي تشكّل واقع حماية الأطفال ورفاههم في كل منطقة. كما خُصص قسم تحليلي مستقل للنتائج المشتركة على مستوى المحافظات المتعلقة بالأطفال والنظام القضائي (القسم 7)، نظراً لتشابه القضايا التي تم رصدها عبر المناطق المستهدفة كافة.

1. عمان

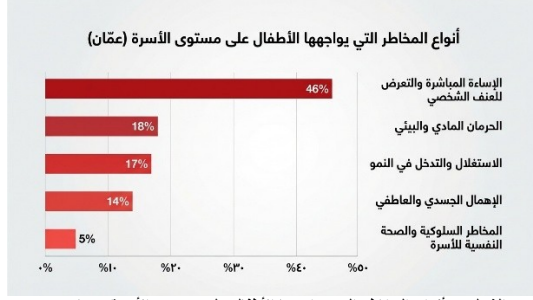
1.1 مخاطر حماية الطفل الرئيسية

1.1.1 المخاطر الأسرية

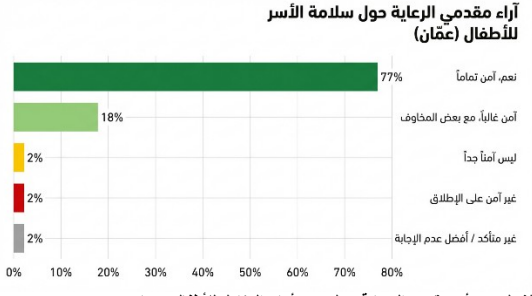
عرّف خبراء المجتمع المدني المنزل بوصفه «الأساس» لحماية الطفل؛ فإذا كان بيئة داعمة وآمنة، يكون الأطفال أكثر قدرة على طلب المساعدة عند تعرضهم لمخاطر خارجية. إلا أن قادة مجتمعيين، وعلى نحوٍ مثير للجدل، أشاروا إلى أن المنزل قد يُعدّ أخطر بيئة على الأطفال في كثير من الحالات، نتيجة الانتشار الواسع لتفكك الأسرة. ويتجلى ذلك في أشكال متعددة من العنف والإيذاء، سواء العاطفية منها، مثل التمييز بين الإخوة، والصراعات بين مقدمي الرعاية، والإهمال، والاعتراّب العاطفي الذي يُمارَس أحياناً كوسيلة تأديبية، أو الجسدية. ولاحظ المشاركون أن قابلية الأطفال للتعرض للإساءة المنزلية تزداد بشكل ملحوظ عندما يعاني مقدم الرعاية من مشكلات نفسية أو من تعاطي المواد. كما جرى تحديد أطفال الأمهات العاملات مراراً بوصفهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، في ربط واضح بين الضرورة الاقتصادية البنيوية واتساع فجوات الرعاية.

وتدعم النتائج الكمية هذه المخاوف بقوة؛ إذ تُظهر أن أكثر المخاطر انتشاراً التي يواجهها الأطفال على مستوى الأسرة في عمّان هي الإساءة المباشرة والتعرض للعنف بين الأفراد، حيث تطلّ هذه المخاطر 46% من الأطفال (كما هو موضح في الشكل 2). وعلى الرغم من خطورة هذا النمط من المخاطر، فإن الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية المشاركين في المسح عبّروا عن تصورات إيجابية حول سلامة المنزل، إذ رأى 95% منهم أن البيئة المنزلية آمنة (كما يبيّنه الشكل 1). ويعكس هذا التباين فجوة إدراكية لافتة بين واقع المخاطر التي يختبرها الأطفال وتصورات البالغين حول السلامة داخل المنزل.

يشير هذا التباين إلى أن مقدّمي الرعاية قد يكونون، بوعي أو دون وعي، يميلون إلى التقليل من الإبلاغ عن مخاوف السلامة داخل المنزل تجنباً للأحكام الاجتماعية أو الوصم. كما قد يعكس ذلك تصورات مُطبّعة ومقبولة اجتماعياً لمفاهيم التأديب والسلامة، لا تُدرك خطورة ممارسات مثل العزل العقابي، أو العقاب الجسدي، أو الإهمال، ولا تُصنّفها بوصفها أشكالاً من الإساءة، رغم ما تحمله من آثار جسيمة على سلامة الطفل ورفاهيته.



الشكل 2: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على مستوى الأسرة (عمان)



الشكل 1: رأي مقدمي الرعاية حول مدى أمان المنازل للأطفال (عمان)

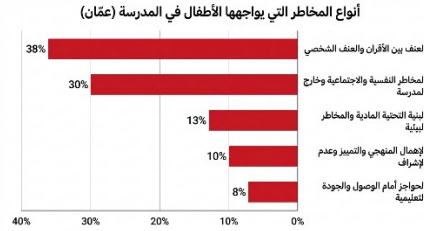
1.1.2 المخاطر على مستوى المجتمع والمدرسة والأماكن العامة

أبرز المشاركون أن شعور الأطفال بالأمان في المدرسة يعتمد غالباً على الروابط الاجتماعية الموجودة مسبقاً وليس على الحماية المؤسسية. أفاد الأطفال والشباب أنهم يشعرون بعدم الأمان الشديد، واصفين المدرسة بأنها مليئة بـ "القتال والسب"، حيث روى أحد الطلاب مشهداً لقتال عنيف استخدم فيه زملاء أدوات حادة وأصابوا بعضهم البعض في اليدين. هذا الشعور بالأمان، بالنسبة للأطفال الضعفاء والمعتمدين على العلاقات، يعتمد على وجود زملاء من الجيران أو أشقاء أكبر سناً أو أقارب لحمايتهم. كما يغذي هذا انعدام الأمان وجود هرمية للسلطة، حيث يأخذ الطلاب الأكبر سناً والأقوى جسدياً أموال الغداء أو الأكسسوارات من الطلاب الأصغر سناً والأضعف، ما يخلق "هرمية الخوف". وأضاف المشاركون أن المعلمين يساهمون أيضاً في زيادة القلق من خلال التحيز وإعطاء معاملة خاصة لأطفالهم، مما يجعل الآخرين يشعرون بعدم العدالة.

وقد أكدت البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أبلغ مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أن العنف بين الأقران والعنف الشخصي كان الخطر السائد في مدارس عمان، حيث أثر على 36% من الأطفال. ومن اللافت أن ثاني أعلى فئة من المخاطر كانت المخاطر النفسية والاجتماعية ومخاطر التنقل الخارجي بنسبة 30%، كما هو موضح في الشكل 4.

علاوة على ذلك، تتناقض الشهادات القاسية للطلاب مع تصور معظم مقدمي الرعاية للأمان، حيث يعتقد 90% منهم أن بيئة المدرسة إما "آمنة تماماً" (44%) أو "آمنة إلى حد كبير مع بعض المخاوف" (46%)، كما هو مبين في الشكل 3.

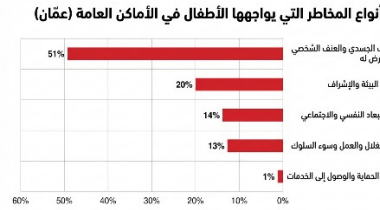
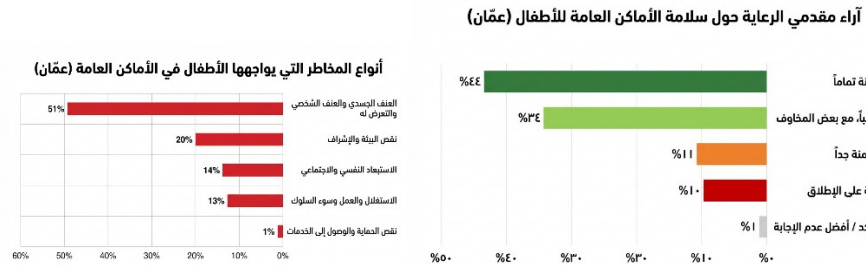
يمكن أن يشير هذا التباين إلى أن شعور الأطفال بالثقة المحدودة للتعبير عن مخاوفهم من عدم الأمان قد يمتد من المنزل إلى المدارس، مما يترك مقدمي الرعاية غير مدركين لشدة الوضع، إلى جانب احتمالية وجود نقص في المتابعة والمراقبة من قبل مقدمي الرعاية لحالة أطفالهم في البيئة المدرسية.



الشكل 3: رأي مقدمي الرعاية حول أمان المدارس للأطفال (عمان) الشكل 4: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في المدارس (عمان)

في الأماكن العامة، وصف مقدمو الرعاية تعرض الأطفال للتحرش والتمييز بشكل متكرر، وخصوصاً الأطفال الأكثر ضعفاً مثل اللاجئين، ذوي البشرة الداكنة، والأطفال ذوي الإعاقات الجسدية. على سبيل المثال، شاركت إحدى الأمهات أن ابنتها المصابة بمتلازمة داون "تتعرض للإهانات والشتائم" في كل مرة تخرج فيها إلى الحي.

ترتبط هذه الملاحظات بشكل مباشر بالنتائج الكمية، حيث أبلغ مقدمو الرعاية أن التعرض للعنف الجسدي والشخصي يُعد الخطر الأبرز، ويؤثر على 51% من الأطفال، كما هو موضح في الشكل 6. ومع ذلك، احتفظت غالبية مقدمي الرعاية بتصور إيجابي نسبياً حول سلامة الأماكن العامة، بنسبة 44%، كما هو مبين في الشكل 5.



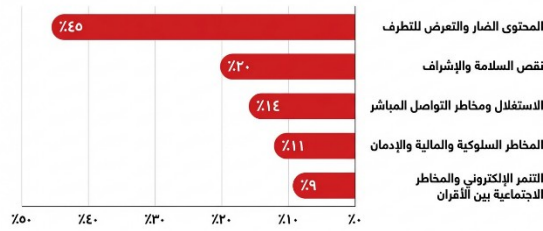
الشكل 5: رأي مقدمي الرعاية حول مدى أمان الأماكن العامة للأطفال (عمان) الشكل 6: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في الأماكن العامة (عمان)

1.1.3 المخاطر على الأطفال عبر الإنترنت والفضاء الرقمي

تم الإشارة إلى أن الإنترنت يُدخل أنواعاً جديدة من المخاطر على الأطفال، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، والابتزاز باستخدام الصور الشخصية، وسرقة الحسابات، وقد تم تحديده كخطر رئيسي إذا تُرك دون إشراف. كما أبرز القادة المجتمعيون أضرار التعرض الرقمي، حيث يتعرض الشباب لـ "إعلانات مسيئة وغير مناسبة" ومقاطع فيديو خطيرة "تؤثر على سلوكهم"، مؤكدين أن الإنترنت يمكن أن يكون "أكثر خطورة" من الشارع أو المدرسة. وبالمثل، أقر الأطفال والشباب أنفسهم بأنهم معرضون لسلوكيات ضارة ومفترسة على الإنترنت تشجع على المخاطر والسلوك العدواني وتؤثر على طريقة تفكيرهم.

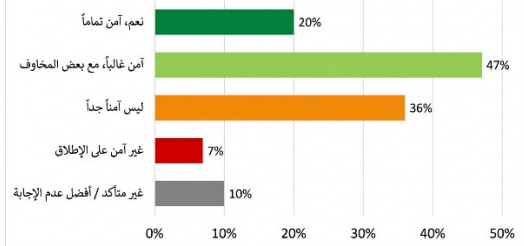
وثبتت البيانات الكمية ذلك بشكل قوي، حيث أبلغ 36% من أولياء الأمور المستطلعين أن البيئة "ليست آمنة جداً" (وهي النسبة الأعلى بين جميع المحافظات)، وأفاد 47% أنها "آمنة إلى حد كبير، مع بعض المخاوف"، مما يعكس المخاطر المعترف بها سابقاً، كما هو موضح في الشكل 7. كما حدّدوا أن التعرض للمحتوى الضار والعنف هو الخطر السائد للأطفال على الإنترنت بنسبة 41%، مما يؤكد جدية النتائج السابقة حول نوع المحتوى الرقمي الذي يتعرض له الأطفال، بالإضافة إلى مخاطر أخرى، كما هو موضح في الشكل 8.

أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت (عمّان)



الشكل 8: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت (عمّان)

آراء مقدمي الرعاية حول سلامة الإنترنت للأطفال (عمّان)



الشكل 7: آراء أولياء الأمور حول سلامة الإنترنت للأطفال (عمّان)

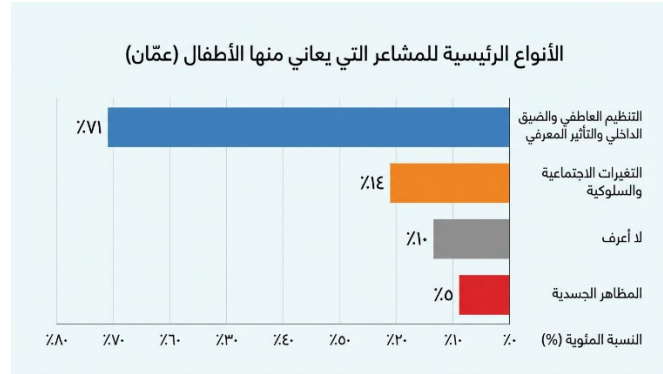
1.2 الرفاه النفسي وآليات التكيف

1.2.1 الضغوط النفسية والاجتماعية

أفاد المشاركون في عمّان بأن الضغوط النفسية الأساسية التي يواجهها الأطفال واليافعون تتبع بالدرجة الأولى من الضغوط الاقتصادية وعدم الاستقرار الأسري. وقد عبّر كلٌّ من مقدمي الرعاية والشباب عن مشاعر ضيق عاطفي ناتجة عن العجز المالي عن تلبية طلبات بسيطة أو توفير أنشطة ترفيهية أساسية، وهو ما يتفاقم بفعل وسائل التواصل الاجتماعي التي أشير إليها كمصدر لإثارة مشاعر الغيرة أو عدم الكفاية، حيث يقارن الأطفال أوضاعهم بأقرانهم الذين تظهر عائلاتهم بمستوى معيشي أفضل. ومع مرور الوقت، لا يقتصر الأثر السلبي على مقدمي الرعاية فحسب، بل ينتقل إلى الأطفال واليافعين الذين أفادوا بشعور متزايد بالإرهاق الوجودي المرتبط بتحمل المسؤوليات والعمل ومتطلبات الأسرة، ويتعزز ذلك بإحساس بالعجز أو انعدام القيمة عند عدم القدرة على إيجاد فرص عمل، خاصة عند مقارنة أنفسهم بأقران نجحوا في ذلك.

على الصعيد التعليمي، أشار المشاركون أيضاً إلى ارتفاع مستويات الضغط الأكاديمي، بما في ذلك التوتر المرتبط بالامتحانات النهائية والقلق الناتج عن ممارسات بعض المعلمين التي تتسم بالإساءة مثل الصراخ أو التوبيخ القاسي. كما تلعب حالة عدم الاستقرار الإقليمي دوراً إضافياً في زيادة الضغوط النفسية، حيث ذكرت أحداث العنف في غزة خلال بعض النقاشات كمصدر لمشاعر الحزن والقلق لدى الأطفال.

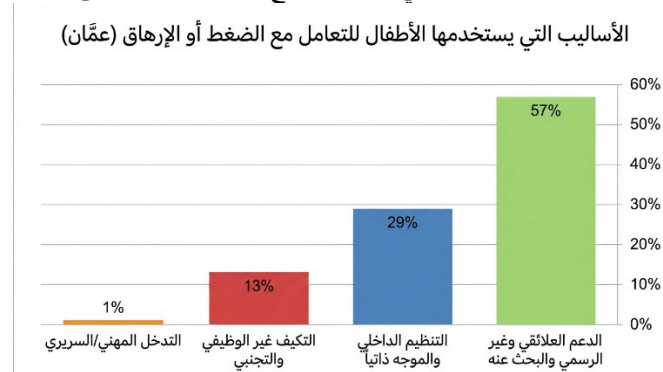
وتتوافق هذه النتائج مع المعطيات الكمية، إذ أوضح مقدّمو الرعاية الذين شملهم الاستبيان أن الأطفال يواجهون تحديات كبيرة في مجالات تنظيم المشاعر، والضيق النفسي الداخلي، والتأثيرات المعرفية، ولا سيما ما يتعلق بالشعور بالقلق أو الخوف أو التوتر، والشعور المستمر بالحزن أو التعاسة، وتدني تقدير الذات أو الإحساس بعدم القيمة، بنسبة بلغت 71%، كما هو موضح في الشكل (9-ب).



الشكل 9: الأنواع الرئيسية للمشاعر التي يختبرها الأطفال (عمّان)

1.2.2 آليات التكيف واستجابة مقدّمي الرعاية

عند مواجهة الضيق العاطفي، أفاد اليافعون والأطفال بسعيهم لتحقيق توازن بين التواصل الاجتماعي وتشتيت الذات. كما أُبلغ عن مزيج من أساليب التكيف الفردية الإيجابية والسلبية، مثل قراءة القرآن، والكتابة في دفتر يوميات، والمشي، والصمت، والعزلة الذاتية، ولعب كرة القدم، وقراءة الروايات، والإفراط أو التقليل في تناول الطعام، والتدخين، وذلك لتوفير راحة قصيرة الأمد. ومن اللافت أن 86% من مقدّمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بملاحظتهم استخدام أطفالهم في الغالب لأساليب تكيف إيجابية (السعي إلى الدعم العلائقي وغير الرسمي، والتنظيم الداخلي والتوجيه الذاتي)، كما هو موضح في الشكل 10، وإن كانت هذه الأساليب غير رسمية في معظمها، مع لجوء 1% فقط إلى تدخلات رسمية.

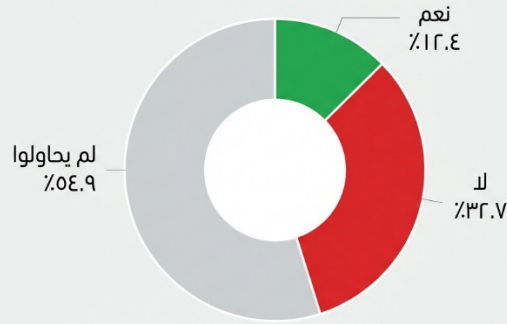


الشكل 10: الأساليب التي يستخدمها الأطفال للتكيف مع الضغط أو الإرهاق (عمّان)

أشار مقدّمو الرعاية إلى وجود توجه عام يتسم بالتعاطف وحلّ المشكلات في تعاملهم مع تعبير أطفالهم عن الضيق النفسي، مثل التحدث معهم ومحاولة فهم وجهات نظرهم، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي العام وخلق مساحات للمرح والتعلم خارج إطار المدرسة. ومع ذلك، وكما ذكر سابقاً، لوحظت خلال مجموعات النقاش المركّزة ممارسات تأديبية شائعة، حيث ذكر مقدّمو الرعاية اعتمادهم على العزل العقابي والحرمان، مثل منع الطفل جسدياً من الخروج، أو حجب المصروف إلى حين أداء واجبات محددة (مثل الصلاة أو الدراسة). ومن اللافت أن الآثار العاطفية لمثل هذه الأساليب كانت واضحة، إذ اعترفت إحدى الأمهات بخطئها في منع طفلها من الاختلاط الاجتماعي، وما تسبّب به ذلك من فقدانه لأصدقائه.

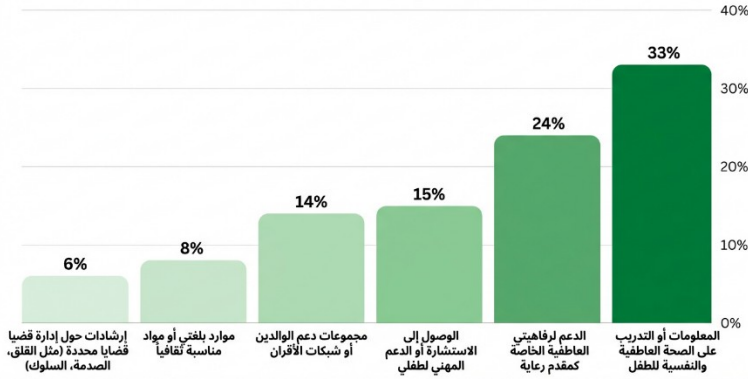
وتقدّم البيانات الكمية رؤى إضافية تدعم هذه النتائج، حيث أظهر أكثر من نصف مقدّمي الرعاية الذين شملهم الاستبيان (55%) أنهم لم يحاولوا مطلقاً طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأطفالهم، بينما واجه 12% ممن حاولوا الحصول على هذه الخدمات تحديات في الوصول إليها (كما هو موضح في الشكل 11)، شملت نقصاً عاماً في المعلومات حول الخدمات المتاحة، أو كونها بعيدة جغرافياً أو مرتفعة التكلفة في حال توفرها. كما أكدت النتائج أن الغالبية أشاروا إلى حاجتهم للمعلومات أو التدريب المتعلق بالصحة النفسية والعاطفية للأطفال (33%)، إضافة إلى الدعم لرفاههم النفسي هم أنفسهم (24%)، أكثر من حاجتهم إلى التدخلات المهنية المتخصصة، كما هو مبين في الشكل 12.

هل واجه مقدمو الرعاية تحديات عند محاولة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأطفالهم؟ (عمّان)



الشكل 11: تجربة مقدمي الرعاية في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال (عمّان)

أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتوفير الدعم النفسي لأطفالهم (عمّان)



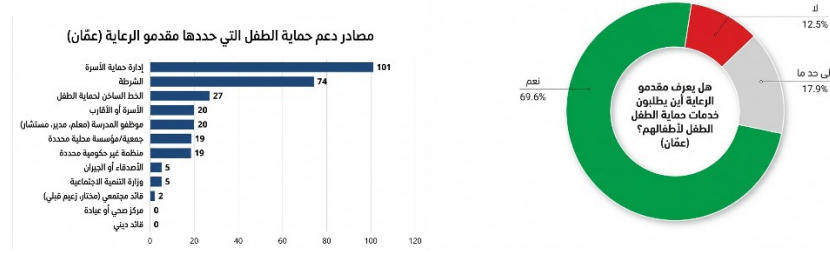
الشكل 12: أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم دعم الصحة النفسية لأطفالهم (عمّان)

1.3 الاستجابة المؤسسية ومعوّقات الإبلاغ

1.3.1 قنوات الإبلاغ القائمة

أظهرت البيانات أن شبكة الحماية في عمّان واسعة ومتعددة المستويات، وتشمل قنوات رسمية وغير رسمية على حدّ سواء. فقد أشار قادة المجتمع والخبراء إلى وجود قنوات إبلاغ رسمية، من بينها الشرطة، وإدارة حماية الأسرة، التي تم التعرف عليها أيضاً من قبل الأطفال واليافعين — ووزارة التنمية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، تتكامل أدوار هذه الجهات عبر تنسيق البلاغات وتحويل الحالات إلى وحدة إدارة الحالات في وزارة التنمية الاجتماعية لإجراء تقييم المخاطر، فيما تُحال الحالات الشديدة إلى مراكز الحماية المختصة. كما أفاد الأطفال واليافعون بأنهم تلقّوا معلومات حول خط حماية الطفل 110، إضافة إلى منظمات مثل مؤسسة نهر الأردن، باعتبارها جهات يمكن اللجوء إليها في حال التعرّض لخطر أو الحاجة إلى الدعم.

أما بالنسبة لمقدمي الرعاية المشاركين في الاستبيان، وبما يتسق مع إفادات الفئات الأخرى، فقد أكد غالبية المشاركين (70%) معرفتهم بالموارد المتاحة للحصول على خدمات حماية الطفل. كما أفادوا بأن نقاط الاتصال الثلاث الأولى التي يلجؤون إليها عند الحاجة تندرج جميعها ضمن القنوات الرسمية، كما هو موضح في الشكلين (13) و(14) أدناه.



الشكل 13: وعي مقمّي الرعاية بخدمات حماية الطفل المتاحة (عمان) الشكل 14: مصادر دعم حماية الطفل (عمان)

بصورة غير رسمية، تُعدّ الأسرة المباشرة (الأب، الأم، الإخوة) والأشخاص الموثوقون خارج نطاق الأسرة القنوات الأساسية التي يلجأ إليها الأطفال للحصول على الدعم العاطفي أو النفسي. وأشار الفاعلون المجتمعيون إلى اعتمادهم نهجًا متدرجًا في التعامل مع مخاطر حماية الطفل، يبدأ بتحديد سبب الضرر ومحاولة معالجته بطرق غير رسمية داخل الأسرة أو المجتمع، قبل تصعيد الحالة إلى الجهات الرسمية المختصة مثل إدارة حماية الأسرة. وقد أوضح أحد قادة المجتمع أن إدارة حماية الأسرة غالبًا ما تركز في البداية على الوساطة والحوار الودية غير الرسمية قبل الشروع في الإجراءات القانونية الرسمية. كما أشار المشاركون إلى عدد من منظمات المجتمع المدني بوصفها موارد غير رسمية مهمة في مجال حماية الطفل، من بينها جمعية يعزّب، ومركز نايا المجتمعي، ومؤسسة أمل، ومؤسسة سيناريو.

1.3.2 الفجوات في القدرات المؤسسية والتنسيق والاستجابة

أشار خبراء من منظمات المجتمع المدني إلى أنه، وعلى الرغم من وجود هيكل رسمي للإبلاغ عن حالات حماية الطفل، إلا أن الفاعلية التشغيلية لهذا النظام تتأثر بشكل مستمر بضعف التنسيق بين الجهات المعنية. وقد أكدت المجتمعات المحلية إدراكها لعقد اجتماعات دورية بين الفاعلين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ومديرية الأمن العام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، إلا أن هذا التنسيق لا ينعكس دائمًا على استجابات فعّالة ومتكاملة على أرض الواقع.

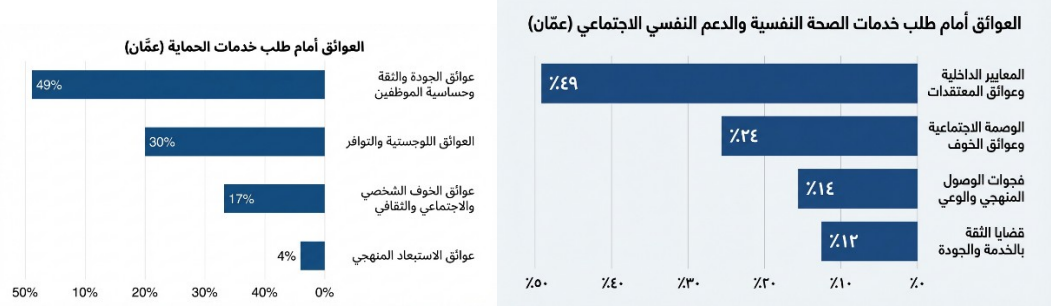
وأضاف المشاركون أن صعوبات التنسيق تتفاقم بشكل خاص في نهاية السنة المالية، حيث تؤدي فجوات التمويل إلى إغلاق العديد من المشاريع أو إلى توقف جهات الإحالة مؤقتًا عن استقبال الحالات. وقد تم تسليط الضوء على أن ضعف الاستدامة المالية يؤثر بشكل مباشر على القدرة المؤسسية، من حيث عدد الكوادر العاملة، واستمرارية البرامج، والقدرة على الاستجابة للحالات.

إلى جانب ذلك، أشار الخبراء إلى وجود فجوة هيكلية تتمثل في تمركز الخدمات في المناطق ذات الدخل المنخفض، مقابل محدودية أو غياب هذه الخدمات في المناطق ذات الدخل الأعلى، رغم وجود احتياجات فعلية لحماية الأطفال فيها أيضًا. ويتعزز هذا التحدي بسبب قيام بعض المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بتنفيذ مبادرات قصيرة الأمد أو مؤقتة، وُصفت من قبل المشاركين بأنها تأتي في إطار «الترند»، ما يترك انطباعًا لدى المجتمع بغياب الالتزام الحقيقي والمستدام بجعل حماية الطفل أولوية أساسية.

1.3.3 العوائق الاجتماعية-الثقافية أمام طلب الدعم

أبرز القادة المجتمعيون أن العائق الرئيسي أمام طلب الدعم يتمثل في الخوف العميق من الوصم الاجتماعي وهيمنة ما يُعرف بـ«ثقافة العيب»، التي تثني الأفراد عن مناقشة قضايا الإساءة أو العنف بشكل علني. وقد عبّر أحد مقدمي الرعاية عن ذلك بقوله: «ليس من المقبول كثيرًا في مجتمعنا الذهاب وتقديم شكوى؛ يُنظر إلى الأمر على أنه عيب.»

وتتوافق هذه المعطيات مع نتائج الاستبيانات، حيث أفاد مقدمو الرعاية بأن الأعراف والمعتقدات المتجذرة داخليًا لديهم تشكل عائقًا رئيسيًا أمام طلب خدمات حماية الطفل (49%)، إلى جانب العوائق المرتبطة بجودة الخدمات ومستوى الثقة بها وحساسية الكوادر العاملة (49%). وتُعدّ هذه العوامل من أبرز المحددات التي تحول دون اللجوء إلى خدمات حماية الطفل، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي، كما هو موضح في الشكلين 15 و16.



الشكل 15: العوائق أمام طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي (عمّان) الشكل 16: العوائق أمام طلب خدمات الحماية (عمّان)

أوضح خبراء المجتمع أن أفراد المجتمع يميلون بشكل مستمر إلى إعطاء الأولوية للسرية وتجنب الإبلاغ، خوفاً من الوصم الاجتماعي، أو الطلاق، أو النزاعات على الحضانة، أو التعرّض للانتقام من الجناة. وتؤكد البيانات الكمية هذا التوجّه؛ فعلى الرغم من أن مقدمي الرعاية المشاركين في الاستبيان عبّروا عن مستوى مرتفع من الثقة في نظام الحماية الرسمي (67%)، كما هو موضح في الشكل (18)، إلا أنهم أقرّوا بأنهم نادراً ما يلجؤون فعلياً إلى طلب خدمات الحماية الرسمية للأطفال (95%)، كما يظهر في الشكل (17). وقد لوحظ أن هذا الواقع ينعكس ضغطاً إضافياً على الأطفال واليافعين لعدم الإبلاغ، حيث أشاروا بدورهم إلى أنهم غالباً ما يخشون ردّة فعل مقدمي الرعاية في حال الإفصاح عن الانتهاكات أو طلب المساعدة.



الشكل 17: محاولات مقدمي الرعاية لطلب خدمات حماية الطفل (عمّان) الشكل 18: مستوى ثقة مقدمي الرعاية بالنظام الرسمي لحماية الطفل (عمّان)

1.4 مشاركة الأطفال والشباب

1.4.1 قنوات وبيانات التعبير والتأثير

أفاد الأطفال والشباب في عمّان أنهم يعبرون عن آرائهم من خلال وسائل رسمية وغير رسمية، مع التأكيد على أهمية الثقة والصدق. على الصعيد غير الرسمي، ذكر أحد الأطفال أنه يتعامل مع المناقشات الحساسة باستخدام أساليب غير مباشرة، مثل تقديم سيناريو افتراضي أو السؤال عن صحة مثال ما، لقياس رد فعل والده المحتمل قبل التعبير عن رأيه الشخصي.

أما القنوات الرسمية فشملت وسائل التواصل الاجتماعي، والتحدث مع صانعي القرار، وبرلمان المدرسة، والمجالس البلدية المدرسية، والمشاركة عبر الإنترنت. نجح الشباب في التأثير على قرارات صغيرة على المستوى المنزلي والمدرسي، مثل إقناع أفراد الأسرة بتغيير مسار رحلة عائلية أو نوع الطعام، أو التعبير عن آرائهم في المجلس البلدي، والتي تم قبولها. ومع ذلك، عند سؤالهم عما إذا كان هناك أي تغيير فعلي نتيجة للتعبير عن آرائهم، كانت الإجابة الجماعية الغالبة: "لا".

فيما يتعلق بالمساحات/الأنشطة المخصصة للأطفال في المحافظات، أظهر مقدمو الرعاية المستطلعون أن المساحات الخارجية والترفيهية (55%) (وتشمل الحدائق العامة، والمساحات الخضراء، وملاعب الأطفال، وميادين كرة القدم) وكذلك المراكز المجتمعية والمراكز القائمة على الانتماء (29%) (وتشمل مراكز المجتمع التي توفر مساحات صديقة للأطفال، والمؤسسات الدينية مثل المساجد والكنائس، ومنظمات المجتمع المحلي والمؤسسات العامة) هي أكثر المساحات استخداماً مجاًناً. أما

المساحات/الأنشطة المدفوعة فكانت قليلة (40%)، بينما كان النشاط البدني والرياضة ثاني أكثر الأنشطة استخداماً (20%)، كما هو موضح في الشكلين 19 و 20 أدناه.



الشكل 19: أكثر المساحات المجانية استخداماً للأطفال (عمان)

الشكل 20: أكثر المساحات المدفوعة استخداماً للأطفال (عمان)

1.4.2 الحواجز أمام قدرة الأطفال على المشاركة

تشمل الحواجز الرئيسية التي تمنع الأطفال والشباب من التعبير عن آرائهم في الأماكن الخاصة والعامة نقص الثقة بالنفس، والتوتر، والشعور بالوحدة، وعدم موافقة الوالدين أو الخوف من رد فعلهم، والقلق الاجتماعي (مثل الشعور بالإقصاء عند عدم دعوتهم للنشاط الجماعي). كما لوحظ أن موقف بعض الوالدين المتجاهل يشكل عائقاً كبيراً، حيث أشار المشاركون إلى أن بعض الأهل لا يستمعون للأطفال، ويعتقدون أن الأطفال غير قادرين أو صغار جداً، أو يخشون فقدان السيطرة عند منحهم وسائل للتعبير.

يمتد هذا التردد إلى البيئات المدرسية، حيث يمتنع بعض الطلاب عن التوجه إلى المعلمين أو المرشدين إذا توقعوا التجاهل أو عدم التصديق.

ويؤكد ذلك أيضاً البيانات الكمية، إذ أشار أولياء الأمور المستطلعة آراؤهم إلى أن أكبر الحواجز أمام مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات في المدرسة والمجتمع هي موقف الوالدين المتجاهل، يليه الوقت المحدود بسبب المدرسة والعمل والمسؤوليات الأسرية، كما هو موضح في الشكل 22.

بالإضافة لذلك، يعتقد نصف هؤلاء الوالدين (53%) أن الأطفال لديهم فرص واهتمام بالمشاركة في اتخاذ القرارات في المدرسة والمجتمع، بينما 16% يرون أنهم لا يملكون الفرصة لكنهم يرغبون في المشاركة، كما يظهر في الشكل 21.

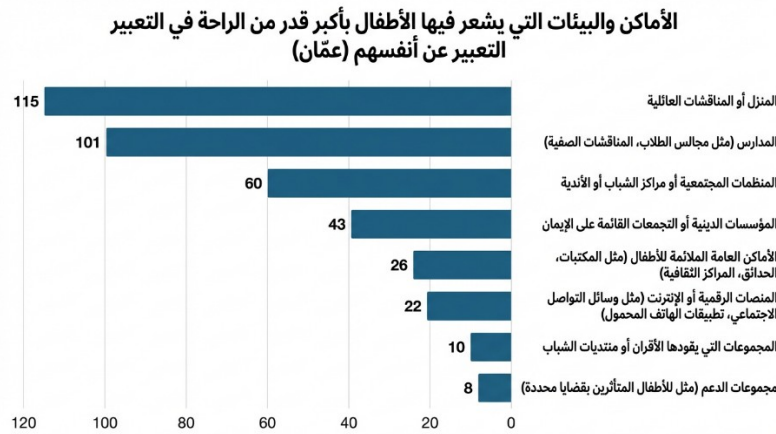


الشكل 21 (يسار): فرص الأطفال واهتمامهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات في المدارس والمجتمع (عمّان)
الشكل 22 (يمين): الحواجز أمام مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات في المدارس والمجتمع (عمّان)

1.4.3 الدعم المؤسسي والمشاركة المرغوبة

أبرز المشاركون أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، مثل جمعية يارب للتنمية الخيرية وغيرها، تقدم أنشطة متنوعة تشمل: الجوقة، الحرف اليدوية، الأداء الصوتي، المسرح، والإعلام. تعمل هذه المنظمات على ضمان سماع أصوات الأطفال والشباب من خلال تضمين اقتباسات مباشرة وقصص نجاح في تقاريرهم، وتوثيق الفعاليات، وإجراء تقييمات قبل بدء أي مشروع جديد لجمع البيانات من الأطفال ومقدمي الرعاية على حد سواء. أوضح خبراء المجتمع المدني أن الهدف هو الشمولية، لتغطية جميع الجنسيات والأعراق، وضمان أن تكون المرافق متاحة ومجهزة للجميع.

ومن المثير للاهتمام أن مقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أوضحوا أن المنظمات الأهلية تأتي في المرتبة الثالثة ضمن الأماكن والإعدادات التي يعتقدون أن الأطفال يشعرون فيها بالراحة للتعبير عن أنفسهم، بعد المدارس والمنازل، كما هو موضح في الشكل 23.



الشكل 23: الأماكن والإعدادات التي يشعر فيها الأطفال بأكثر قدر من الراحة للتعبير عن أنفسهم (عمّان)

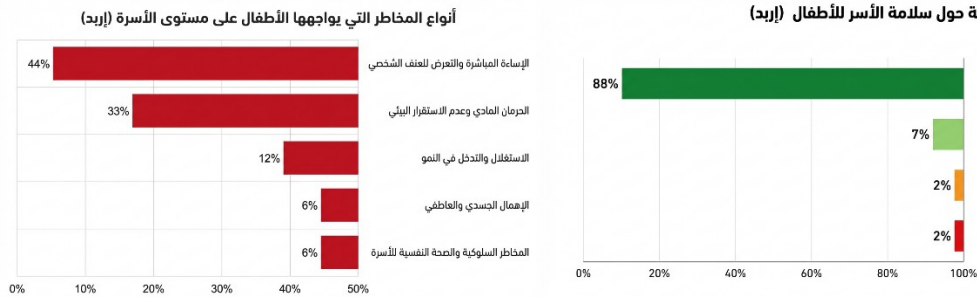
2. إربد

2.1 المخاطر الرئيسية لحماية الطفل

2.1.1 المخاطر في الأسرة

أكد قادة المجتمع المحلي أن وحدة الأسرة في إربد، كما في عمان، تواجه تحديات مرتبطة بالديناميات الأسرية المجزأة إلى جانب الضغوط النفسية على الوالدين، مشيرين إلى أن هذه العوامل غالباً ما تجعل الطفل ضحية. وروى أحد المشاركين أن طفلاً في مجتمعهم كان خائفاً جداً من رد فعل والده على درجات منخفضة في الامتحان لدرجة أنه بكى، وظهرت على جسده "علامات واضحة على ضرب شديد من قبل الوالد". كما أشار المشاركون في مجموعات التركيز إلى أن الديناميات الهرمية بين الأشقاء شائعة، حيث يتحكم الأشقاء الأكبر سناً أحياناً في الأصغر ويؤدي ذلك أحياناً إلى الضرب الجسدي.

وتدعم هذه الملاحظات البيانات الكمية، حيث أشار أولياء الأمور المستطلعين إلى أن الإساءة المباشرة والتعرض للعنف بين الأشخاص هو الخطر الأكثر انتشاراً الذي يواجه الأطفال على مستوى الأسرة في إربد، ويؤثر على 44% من الأطفال. ورغم هذه المخاطر الجسيمة، ترى الغالبية العظمى من الأسر (95%) أن المنزل آمن، حيث قال 88% منهم إنه "نعم، آمن تماماً"، وأشار 7% إضافيون إلى أنه "آمن إلى حد ما مع بعض المخاوف" (انظر الشكل 24). ومن المثير للاهتمام أن الخطر الثاني الأعلى الملاحظ هو الحرمان المادي وعدم الاستقرار البيئي بنسبة 32%، بالإضافة إلى مخاطر أخرى كما هو موضح في الشكل 25.



الشكل 25: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على مستوى المنزل (إربد)

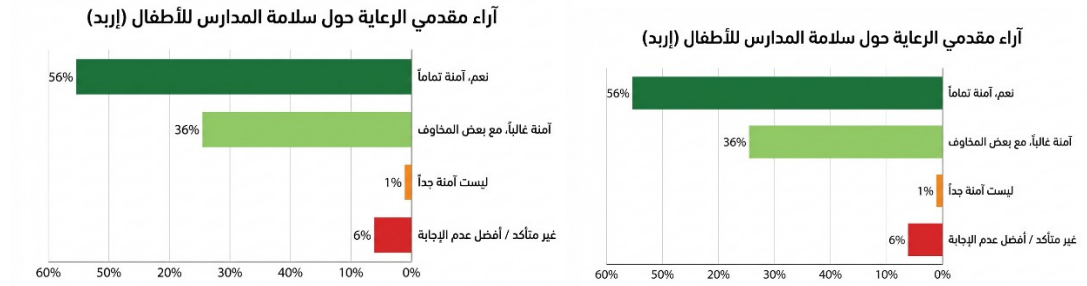
الشكل 24: رأي أولياء الأمور حول مدى أمان المنازل للأطفال (إربد)

2.1.2 المخاطر على مستوى المجتمع والمدرسة والأماكن العامة

أبدى المشاركون في إربد آراءً متباينة حول أمان المدارس. أعرب العديد من الأطفال والشباب عن شعورهم بـ"الأمان التام" ومستوى عالٍ من الأمان داخل المدرسة، خاصةً عند وجود المعلمين والأصدقاء معهم. ومع ذلك، ذكر آخرون التعرض للتنمر، والمقارنات، والتحيز في المعاملة. على سبيل المثال، تم ذكر المقارنة العلنية مع طلاب آخرين (أكاديمياً أو سلوكياً) كمصدر للتنمر، وعند حدوث التنمر، وصف الأطفال شعورهم بالحزن والانزعاج نتيجة السخرية من أصدقائهم. وأشار بعض الأطفال إلى أنه حتى عند التقدم بشكوى إلى المدير، لا يحدث شيء، مما يضطرهم غالباً إلى الصمت.

تؤكد البيانات الكمية هذه الجوانب السلبية، حيث تبين أن عامل الخطر الأكثر انتشاراً هو العنف بين الأقران والعنف الشخصي، الذي يؤثر على 43% من الأطفال (كما هو موضح في الشكل 27). كما يؤكد الشعور بالتوتر الذي أبلغ عنه الأطفال، حيث جاء ضمن ثاني أعلى فئة خطورة وهي المخاطر النفسية والاجتماعية ومخاطر السفر الخارجي، التي تؤثر على 40% من الأطفال.

أما فيما يتعلق بالجانب الإيجابي من الآراء، فهو ينعكس أيضاً في النتائج الكمية، إذ على الرغم من مستويات العنف المرتفعة، ترى الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية المشاركين في المسح (92%) أن بيئة المدرسة إيجابية، حيث ذكر 56% أنها "آمنة تماماً"، و36% أشاروا إلى أنها "آمنة إلى حد كبير"، مع بعض المخاوف (كما هو موضح في الشكل 26).

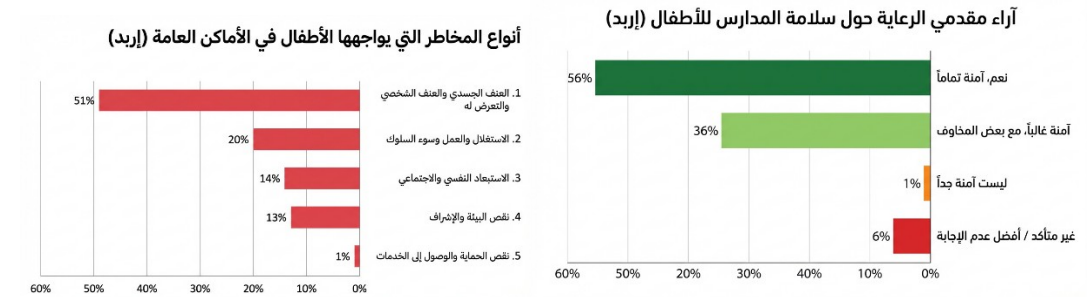


الشكل 26: رأى مقدمى الرعاية حول أمان المدارس للأطفال (إربد)

الشكل 27: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في المدارس (إربد)

فيما يخص الأماكن العامة، أفاد الأطفال بالشعور العام بعدم الأمان، لا سيما في المناطق التي توجد فيها مجموعات من الحيوانات الضالة، وخصوصاً الكلاب، أو بشكل عام عند مرور غرباء بالقرب منهم. وذكرت فتاة صغيرة أن شعور عدم الأمان يزداد لدى الإناث عندما يكون الشخص المار قريباً منهم من الجنس الآخر، وأفادت مشاركة أخرى بأنها تشعر بالقلق والخوف كلما تأخرت عن الوصول إلى المدرسة، نظراً لقرب مدرستها من مدارس الذكور. وفي النهاية، يبدو أن الخوف مرتبط بالحدود المؤسسية، حيث أشار الأطفال إلى شعورهم بالأمان الأكبر في المنزل، بالقرب من أفراد الأسرة المباشرين، أو الأشخاص المألوفين لديهم.

ويؤكد ذلك البيانات الكمية، حيث أشار أولياء الأمور المشاركون في الاستطلاع إلى أن التعرض للعنف الجسدي والشخصي يمثل الخطر السائد بنسبة 51%، كما هو موضح في الشكل 29. ومع ذلك، حافظوا على تصور إيجابي للأمان في الأماكن العامة، إذ بلغت نسبة الذين يعتبرونها "آمنة تماماً" 56%، و"آمنة إلى حد ما مع بعض المخاوف" 39%، كما هو موضح في الشكل 28.



الشكل 28: رأى أولياء الأمور حول مدى أمان الأماكن العامة للأطفال (إربد)

الشكل 29: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في الأماكن العامة (إربد)

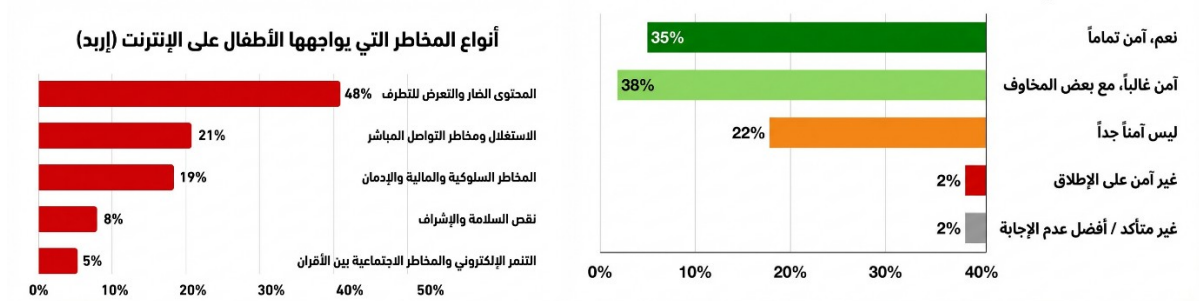
2.1.3 المخاطر المرتبطة بالإنترنت والحماية الرقمية

اعتبر قادة المجتمع التكنولوجيا التهديد الأكثر تدميراً لعقلية الأطفال والشباب، ووصفوها بأنها "أخطر سلاح". خلال المقابلات المعمقة، صوروها على أنها غزو ثقافي، مشيرين إلى أنها تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب من قبل مقدمي الرعاية، ما يؤدي إلى نضوج مبكر، بالإضافة إلى استبدال الوقت الذي يقضونه مع عائلاتهم، مما يسبب العزلة نتيجة انشغالهم طوال اليوم. كما ذكرت مخاطر إضافية تشمل انتحال الهوية لخداع الأطفال والقرصنة الإلكترونية.

وتم تصور هذا الخطر على أنه متعمد، حيث تُعتبر شركات الإنترنت فاعلين يهدفون إلى التأثير عمداً على طريقة تفكير الأطفال. كما أكد الأطفال تعرضهم لمحتوى صادم وشديد، بما في ذلك فيديوهات تتضمن القتل والتعذيب. وقد أشارت مقدمو الرعاية أيضاً إلى أن وجود أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل ChatGPT يشكل خطراً جديداً عليهم.

وتؤكد البيانات الكمية هذا التقييم بشكل قوي، حيث أشار 38% من مقدمي الرعاية المستطلعين إلى أن البيئة على الإنترنت "آمنة إلى حد ما مع بعض المخاوف"، وأوضح 22% أنها "غير آمنة جداً"، مما يعكس الخطر المعترف به، كما هو موضح في الشكل 30. كما حددوا أن المحتوى الضار والتعرض للعنف يمثلان الخطر الرئيسي للأطفال على الإنترنت بنسبة 48%، داعمين بذلك ما ذكره الأطفال سابقاً. بالإضافة إلى ذلك، يظهر دور الإنترنت في التأثير على عقلية الأطفال في الخطر العالي الذي أقره مقدمو الرعاية بنسبة 21%، والمتعلق بالمخاطر المرتبطة بالاستغلال والتواصل المباشر، كما هو موضح في الشكل 31.

آراء مقدمي الرعاية حول سلامة الإنترنت للأطفال (إربد)



الشكل 31: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت (إربد)

الشكل 30: رأي مقدمي الرعاية حول أمان الإنترنت للأطفال (إربد)

2.2 الصحة النفسية والاجتماعية وآليات التكيف

2.2.1 الضغوط النفسية والاجتماعية

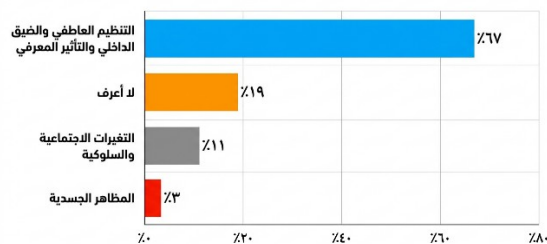
تشير النتائج إلى أن الأطفال والشباب في المناطق المستهدفة يواجهون مجموعة من الضغوط النفسية والاجتماعية الأساسية التي تؤثر على رفاهيتهم. هذه الضغوط تنبع من عدة مصادر: الصراعات الخارجية، الضغوط الأكاديمية، الأعمال المنزلية اليومية، والمحتوى الرقمي المزيج على الإنترنت.

أعرب الأطفال والشباب عن شعورهم بالحزن والغضب نتيجة التعرض للتمييز والتنمر، إضافة إلى مشاهدة مقاطع فيديو صادمة تتضمن وفاة أطفال في مناطق النزاع مثل غزة. كما أظهرت الفتيات الأكبر سناً شعوراً بالضغط المزدوج نتيجة مسؤوليات الدراسة والأعمال المنزلية، ما يزيد من شعورهن بالإرهاق النفسي.

وأكد مقدمو الرعاية أن الضغوط المالية، لا سيما في العائلات الكبيرة، تزيد من التوتر والغيظ لدى الوالدين، ما ينعكس على الأطفال ويزيد من تعرضهم للضغط النفسي. تدعم البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أشار 67% من مقدمي الرعاية إلى أن أطفالهم يواجهون صعوبات في تنظيم المشاعر، التعامل مع الضيق النفسي، والتأثيرات الإدراكية، بما في ذلك: الانفعال أو الغضب بسهولة، الشعور بالحزن لفترات طويلة، والخوف أو القلق بسبب التجارب الصعبة التي مروا بها.

ومن الملاحظ أيضاً أن 19% من مقدمي الرعاية أشاروا إلى عدم معرفتهم بالنوع الرئيسي من المشاعر التي يعبر عنها أطفالهم، ما يسلط الضوء على وجود فجوة في وعي الأسرة بالحالة النفسية للأطفال.

الأنواع الرئيسية للمشاعر التي يعاني منها الأطفال (إربد)

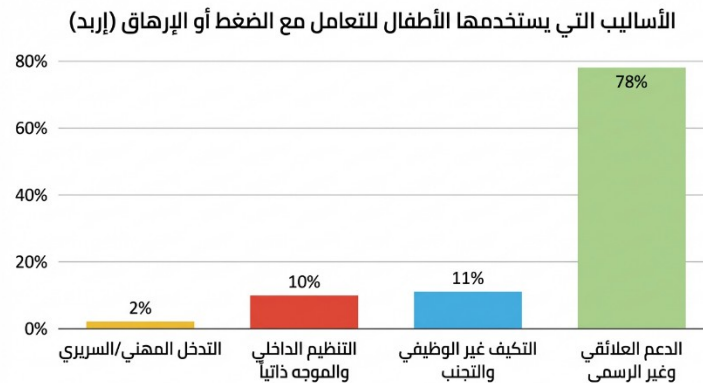


الشكل 32: الأنواع الرئيسية للمشاعر التي يختبرها الأطفال (إربد)

2.2.2 آليات التكيف

أفاد الأطفال والشباب عند مواجهة الضغوط العاطفية باستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، مثل الدراسة، وقراءة

القرآن، والاستماع إلى الموسيقى، والكتابة، واللعب، والتنفيس عن المشاعر، والنوم. ومع ذلك، غالبًا ما يُعيق هذا الشعور بعدم الثقة بالآخرين والخوف من الحديث أو التعرض، مما يدفع بعض الأطفال إلى عدم التحدث مع أي شخص، والانخراط بدلاً من ذلك في آليات تكيف ضارة مثل التدخين والاستخدام المفرط للهاتف. ومن المثير للاهتمام، أن 89% من أولياء الأمور المستطلعين أشاروا إلى أنهم يلاحظون أطفالهم يستخدمون غالبًا استراتيجيات تكيف إيجابية (مثل طلب الدعم العاطفي والاجتماعي غير الرسمي وتنظيم الذات الداخلي والتوجيه الذاتي)، كما هو موضح في الشكل 33، رغم أنها غير رسمية، مع نسبة 2% فقط تلجأ إلى التدخلات الرسمية.



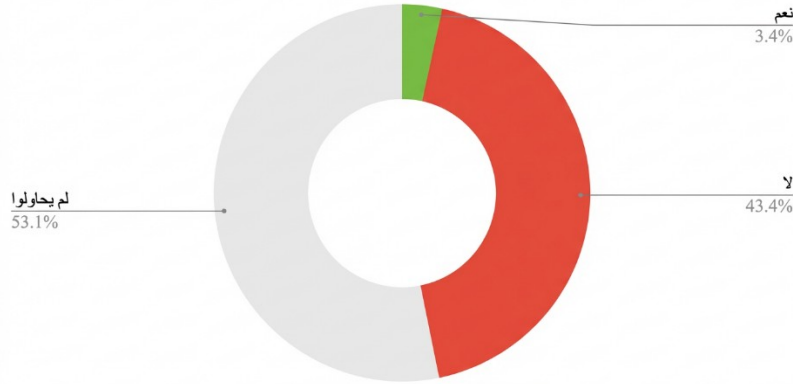
الشكل 33: طرق الأطفال في التكيف مع الضغوط أو الإرهاق (إربد)

لاحظ مقدمو الرعاية استخدامهم للدعم العاطفي والحوار مع أطفالهم عند التعبير عن الضيق النفسي، سواء بشكل لفظي من خلال الحديث معهم وفهم وجهات نظرهم، أو بشكل جسدي من خلال الأحضان والقبلات. ومع ذلك، أقرّوا أيضًا بتأثير الضغوط النفسية على الأبوة والأمومة، بما في ذلك الضغوط المالية التي تتجسد في ضغوط نفسية وتؤدي إلى تفاعلات أكثر صرامة مع الأطفال. واعترف المشاركون أنه عندما لا يستطيعون توفير الاحتياجات الأساسية، فإن ذلك أحيانًا يؤدي إلى الانفعال أو حتى العدوانية تجاه الأطفال. وتم رصد بعض طرق التكيف المتطرفة لدى بعض العائلات، مثل: “عدم قدرة مقدم الرعاية على توفير الضروريات اليومية أحيانًا يجبر العائلات على دفع البنات نحو الزواج المبكر.”

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما لوحظ استخدام الانضباط كأداة من قبل مقدمي الرعاية، والذي يشمل مزيجًا من الممارسات الإيجابية والسلبية، مثل الحديث، وتقديم النصائح، وشرح الأخطاء، والتحكم في المصروف (إما بالزيادة أو النقصان)، وتعليم الرضا من خلال مقارنة أطفالهم بمن يواجهون ظروفًا صعبة جدًا، مثل الناس في غزة.

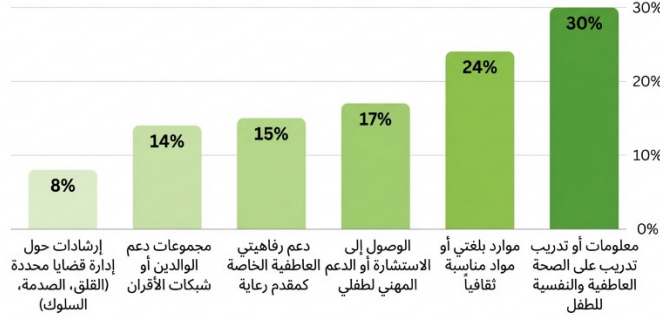
وتقدم البيانات الكمية رؤى مثيرة تكمّل هذه النتائج، حيث أظهرت أن أكثر من نصف مقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع (53%) لم يحاولوا أبدًا طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال. ومع ذلك، فإن غالبية الذين طلبوا هذه الخدمات لم يواجهوا تحديات (43%)، كما هو موضح في الشكل 34. أما بالنسبة لأولئك الذين واجهوا تحديات، فشملت نقص المعلومات العامة حول الخدمات المتاحة، أو في حال وجودها، بُعد المسافة. وقد أكد ذلك أيضًا غالبية المشاركين الذين أبرزوا الحاجة إلى معلومات أو تدريب حول الصحة النفسية والعاطفية للأطفال (30%)، بالإضافة إلى دعم رفاهيتهم العاطفية الخاصة (24%)، بدلاً من الوصول إلى تدخلات مهنية، كما هو مبين في الشكل 35.

هل واجه مقدمو الرعاية تحديات عند محاولة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأطفالهم؟ (إربد)



الشكل 34: تجربة مقدمي الرعاية في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال (إربد)

أنواع الموارد المطلوبة لدى مقدمي الرعاية لتوفير الدعم للصحة النفسية لأطفالهم (إربد)



الشكل 35: أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم الدعم النفسي للأطفال (إربد)

2.3 الاستجابة المؤسسية والعوائق أمام الإبلاغ

2.3.1 قنوات الإبلاغ القائمة

كشفت البيانات أن شبكة الحماية في إربد تتضمن قنوات رسمية وغير رسمية على حد سواء. تحدث قادة المجتمع المحلي عن القنوات الرسمية للإبلاغ مثل دائرة حماية الأسرة والبرامج التي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية. كما أشاروا إلى الفاعلين في المجتمع المدني مثل جمعية إنقاذ الطفل، منظمة أرض البشر، جمعية إدون، مركز الأميرة بسمه، جمعية تحفيز لريادة الأعمال والتنمية، وACTED، والتي تقدم ورش عمل تدريبية وأنشطة تعليمية، بالإضافة إلى المبادرات المحلية مثل شبابنا وفرسان التغيير التي تنظم أنشطة دعم نفسي واجتماعي.

وبالنسبة للشباب والأطفال، لوحظ أن نقطة الاتصال الأولية لمشكلات الحماية غالباً ما تكون الأسرة (الإخوة والأخوات، الأم، الأب)، ثم الأصدقاء، وفي بعض الحالات المعلمين والمستشارين المدرسيين، وإذا لم تُحل المشكلة، يلجأ أفراد المجتمع إلى دائرة حماية الأسرة والجهات الأخرى المذكورة.

أما بالنسبة لمقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع، فقد أكد معظمهم (84%)، مثل باقي المشاركين، معرفتهم بالموارد التي يمكنهم من خلالها طلب خدمات حماية الطفل، وأشاروا، مثل باقي المستجيبين، إلى أن أهم ثلاث نقاط اتصال أولية لديهم جميعها قنوات رسمية، كما هو موضح في الشكلين 36 و 37 أدناه.



الشكل 37: مصادر دعم حماية الطفل (إربد)

الشكل 36: مدى وعي مقدمي الرعاية بخدمات حماية الطفل المتاحة (إربد)

2.3.2 الفجوات في القدرة المؤسسية والتنسيق والاستجابة

أشار قادة المجتمع المحلي إلى أنه، وعلى الرغم من وضوح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بحماية الطفل على المستوى النظري والرسمي، إلا أن التنسيق العملي بين الجهات المعنية ما يزال ضعيفاً. وغالباً ما تعمل هذه الجهات بشكل منفصل، حتى في حال عقد الاجتماعات فيما بينها، مما يؤدي إلى آليات استجابة غير متناسقة أو غير ملائمة من حيث التوقيت، إضافة إلى وجود فجوات وتداخلات في الأدوار، وهو ما يضعف شبكة الحماية بشكل عام. وأضافوا أن هذا الواقع يسهم في محدودية الوعي أو الفهم لكيفية عمل آليات الإحالة الرسمية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مستوى الثقة لدى أفراد المجتمع. وأشار أحد المشاركين إلى ذلك بقوله:

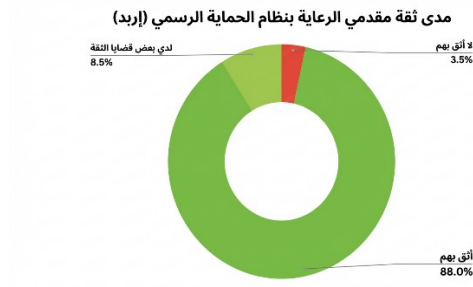
“الجميع يقول: إذا كنت مجنوناً تذهب إلى الطبيب النفسي. حتى الطبيب نفسه قد يكون مريضاً ويحتاج إلى علاج”.

كما شدد المشاركون على أن المؤسسات ذاتها تواجه تحديات تتعلق بالقدرة، من بينها النقص الواسع في الكوادر المؤهلة والأدوات التقنية المناسبة، فضلاً عن القيود المالية، مما يحد من قدرتها على توسيع أنشطة الحماية واستدامتها بشكل فعال. وفي المدارس على وجه الخصوص، أشير إلى أن المرشدين والمرشدات التربويين غالباً ما يكونون مثقلين بالأعباء، حيث يتولى المرشد الواحد متابعة مدرسة كاملة، مما يحد من قدرتهم على التعامل بفعالية مع المشكلات المعقدة والمزمنة لدى الطلبة.

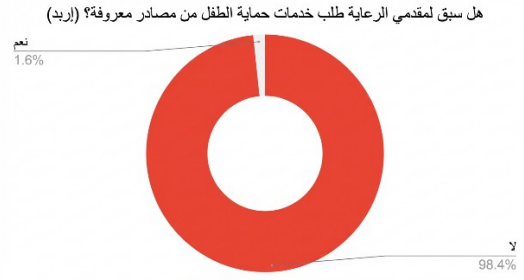
2.3.3 العوائق الاجتماعية والثقافية أمام طلب الدعم

أوضح قادة المجتمع أن العائق الأبرز أمام الإبلاغ أو حتى طلب المساعدة يتمثل في الخوف من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأعراف العشائرية وأحكام المجتمع. وأشار مقدمو الرعاية إلى أن تقديم الشكاوى يُعد في الغالب أمراً غير مقبول اجتماعياً، ويتفاقم هذا الأمر بشكل خاص بالنسبة للفتيات، خوفاً من “تعريض فرص الزواج المستقبلية للخطر والمساس بسمعة الأسرة وشرفها”.

أما فيما يتعلق بالأولاد، فقد أفاد المشاركون بأنهم يُثثون عن الإبلاغ عن مشكلات مثل التتمر أو الضغوط والمشكلات العاطفية، خشية الظهور بمظهر الضعف. وذكر أحد مقدمي الرعاية أن الأولاد غالباً ما يقلدون آباءهم من خلال مغادرة المنزل لتفريغ الضغوط النفسية بدلاً من التعبير عنها. وقد أكدت نتائج الاستبيانات هذه المعطيات، إذ على الرغم من أن نسبة كبيرة من مقدمي الرعاية (88%) عثروا على ثقة عالية بالنظام الرسمي لحماية الطفل، إلا أن الغالبية العظمى منهم (98%) لم يسبق لهم اللجوء إلى خدمات حماية الطفل عبر القنوات الرسمية، كما هو موضح في الشكلين 38 و 39.



الشكل 39: مستوى ثقة مقدمي الرعاية في نظام الحماية الرسمي (إربد)

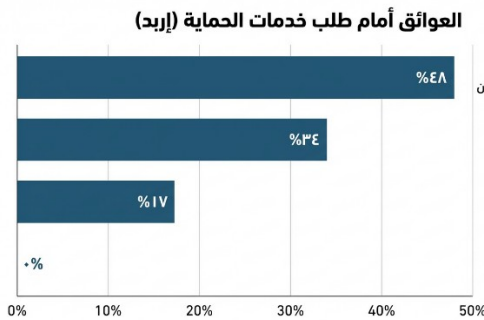


الشكل 38: محاولات مقدمي الرعاية لطلب خدمات حماية الطفل (إربد)

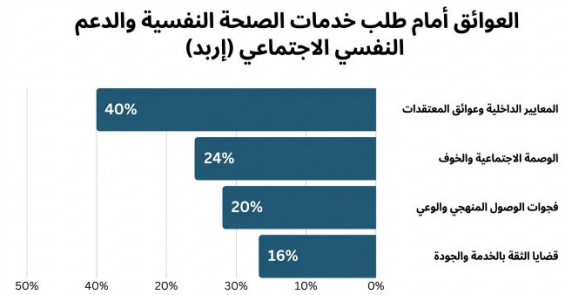
وأضاف المشاركون أن الأطفال قد يلجؤون إلى الكذب أو إخفاء تعرضهم للمشكلات لتجنب ردود فعل مقدمي الرعاية، وهو ما يتعارض مع ما أفاد به الأطفال سابقاً حول لجوئهم إلى أفراد الأسرة للبحث بمشكلاتهم. كما أشار إلى أن احتمالية الإبلاغ تنخفض بشكل ملحوظ عندما يكون الجاني أحد أفراد العائلة.

من جانبهم، أوضح خبراء المجتمع المدني أن هناك محدودية في الوعي أو الإلمام بنظام حماية الطفل الرسمي أو بالجهات التي تقدم هذا النوع من الدعم، الأمر الذي يحول دون بناء الثقة لدى الأسر أو وصولها إلى الخدمات (وهو ما يتوافق أيضاً مع ما هو موضح في الشكلين رقم (#) و (#) أدناه).

وقد أكدت نتائج الاستبيانات هذه المعطيات، حيث أشار مقدمو الرعاية الذين شملهم المسح إلى أن أبرز العوائق أمام طلب خدمات حماية الطفل عبر القنوات الرسمية تتمثل في الأعراف والقناعات الداخلية المتجذرة (40%)، والعوائق المرتبطة بجودة الخدمات ومستوى الثقة وحساسية الكوادر العاملة (48%)، إضافة إلى العوائق اللوجستية وتوفر الخدمات (34%)، كما هو موضح في الشكلين 40 و 41.



الشكل 41: العوائق أمام طلب خدمات الحماية (إربد)



الشكل 40: العوائق أمام طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (إربد)

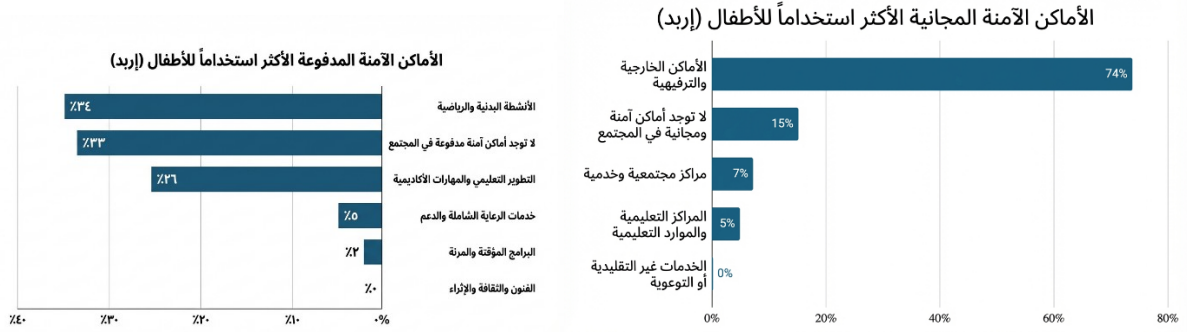
2.4 مشاركة الأطفال والشباب

2.4.1 قنوات وسياقات التعبير والتأثير

أفاد الأطفال والشباب في إربد باستخدامهم أساليب الإقناع والتواصل غير المباشر، مثل مراقبة ردود فعل مقدم الرعاية أولاً، والتقرب من الشخص قبل مشاركة الرأي. ومع ذلك، يشعرون عمومًا بالأمان عند التعبير عن أنفسهم داخل إطار الأسرة، طالما توفرت الثقة، حيث أشار أحد الأطفال إلى شعوره بالحماية والاستماع إليه «عندما أكون في البيت، ومع أمي... وعندما نكون جميعًا معًا في الصباح».

وفي البيئة المدرسية، يشارك الأطفال والشباب في أنشطة تعبيرية وتنظيمية مثل الودقات واللقاءات، إلى جانب مشاركتهم في أنشطة متنوعة تشمل المختبرات العلمية، والمسابقات المدرسية، ومسابقات الغناء والموسيقى، والأنشطة المهنية، ولعب الشطرنج، وبطولات كرة القدم.

أما فيما يتعلق بالمساحات والأنشطة المخصصة للأطفال في المحافظات، فقد أظهرت بيانات الاستبيانات أن المساحات الخارجية والترفيهية المجانية الاستخدام (74%)—والتي تشمل الحدائق العامة أو المساحات الخضراء، وملاعب الأطفال العامة، وملاعب كرة القدم، كانت الأكثر استخدامًا. في المقابل، شملت المساحات أو الأنشطة المدفوعة بشكل أساسي الأنشطة البدنية والرياضية (34%)، إلا أنها وُصفت عمومًا بأنها محدودة من حيث التوفر، بنسبة 34% فقط، كما هو موضح في الشكلين 42 و 43 أدناه.



الشكل 43: أكثر المساحات المدفوعة استخدامًا من قبل الأطفال (إربد)

الشكل 42: أكثر المساحات المجانية استخدامًا من قبل الأطفال (إربد)

2.4.2 العوائق أمام ممارسة الأطفال والشباب لوكالتهم

تم الإشارة إلى أن أبرز العوائق التي تمنع الأطفال والشباب من التعبير عن آرائهم في الفضاءات الخاصة والعامة تتمثل في تجاهل مقدمي الرعاية، والسخرية، ونقص الثقة بالنفس، والقيود الجسدية أو الإعاقات. وأفاد الشباب بأنهم غالبًا ما يتعرضون للتأنيب ويُطلب منهم عدم الانضمام إلى مناقشات مقدمي الرعاية، ويُوجهون للجلوس مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية.

وقد أكدت البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أشار مقدمو الرعاية المشاركون في الاستبيان إلى أن أكبر العوائق أمام مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار في المدرسة والمجتمع هي موقف مقدمي الرعاية المتجاهل، يليه نقص الثقة بالنفس أو الوعي بحقوقهم في المشاركة، كما هو موضح في الشكل 45.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 17% فقط من هؤلاء مقدمي الرعاية أن الأطفال في محافظتهم لديهم فرص واهتمام بالمشاركة في اتخاذ القرار في المدرسة والمجتمع، بينما عبّر نصفهم عن أن الأطفال سيكونون مهتمين لكن بشكل متقطع، كما هو موضح في الشكل 44.



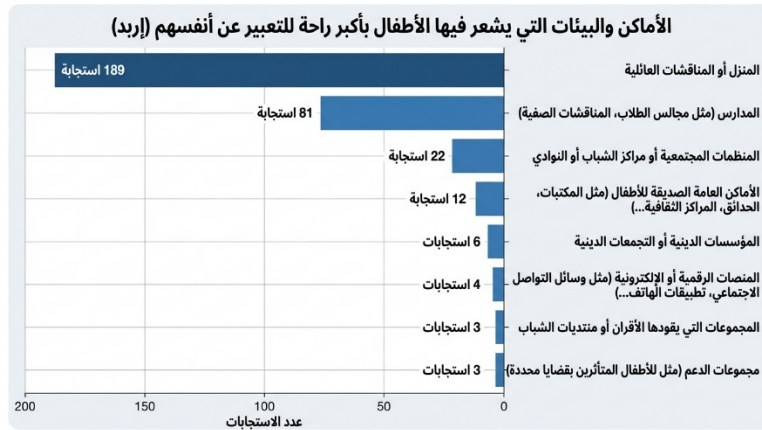
الشكل 44 (يسار): فرص الأطفال واهتمامهم بالمشاركة في اتخاذ القرار في المدارس والمجتمع (إربد)
الشكل 45 (يمين): العوائق أمام مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار في المدارس والمجتمع (إربد)

2.4.3 الدعم المؤسسي والمشاركة المرغوبة

أشار خبراء المجتمع المدني إلى أن جهودهم لضمان سماع أصوات الأطفال تركز على التحسين المستمر بناءً على الملاحظة العملية أثناء تنفيذ الأنشطة. وأوضح أحد الخبراء أنه من خلال التطبيق الميداني المستمر، تمكنوا من فهم احتياجات الأطفال بشكل أفضل، ما أسفر عن نتائج فعلية وتحسن ملحوظ في الأنشطة. كما ذكر خبير آخر استخدام أدوات جمع التغذية الراجعة مثل "مقياس المشاعر" و"صندوق الشكاوى"، ويشارك الأطفال في تصميم الأنشطة، والتخطيط لها، وتسجيل الملاحظات أثناء التنفيذ.

وأعرب الأطفال والشباب عن حاجتهم إلى أنشطة تُركّز على التنمية البدنية، بما في ذلك المساح للبينين والبنات، والجري، وكرة القدم للفتيات، والبياردو، وحلاقة الشعر. وأكدوا أن تسهيل التعبير عن الذات يتطلب بناء الثقة بالنفس وتفعيل دور مقدمي الرعاية في صقل شخصياتهم.

ومن المثير للاهتمام أن مقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أوضحوا أن المؤسسات الأهلية (CBOs) تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الأماكن والإعدادات التي يرون أن الأطفال يشعرون فيها براحة أكبر للتعبير عن أنفسهم، بعد المدارس والمنزل، كما هو موضح في الشكل 46.



الشكل 46: الأماكن والإعدادات التي يشعر فيها الأطفال براحة أكبر للتعبير عن أنفسهم (إربد)

3. مادبا

3.1 المخاطر الرئيسية لحماية الطفل

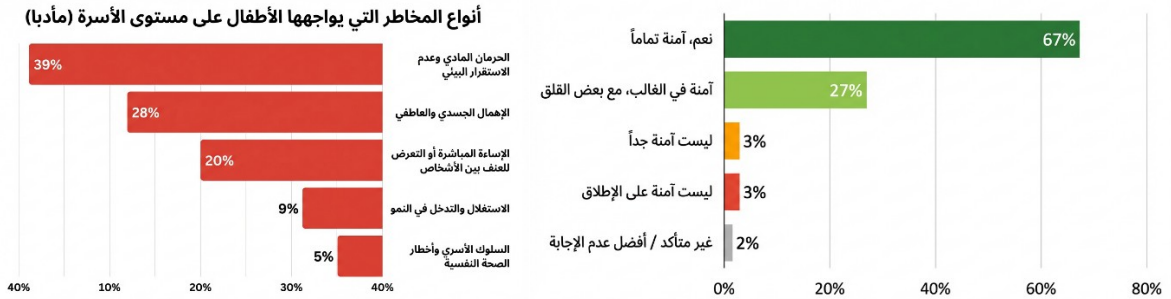
3.1.1 مخاطر الأسرة

مثلما هو الحال في إربد وعمان، أبرز الأطفال والشباب في مادبا أن المخاطر داخل البيئة المنزلية معقدة، وغالبًا ما تكون متجذرة في الضغوط النفسية للأهل والديناميات الأسرية المفككة. وأشار مقدمو الرعاية إلى أن نقص الموارد المالية يؤدي في كثير من الأحيان إلى ردود فعل غاضبة وعقاب جسدي تجاه الأطفال، حتى على أخطاء بسيطة. كما أشاروا إلى أن وجود زوجة أب مسيئة يمثل مصدرًا آخر لانعدام الأمان، إضافة إلى المحسوبة بين الأشقاء.

وتؤكد البيانات الكمية هذا الواقع، حيث أظهرت نتائج الاستبيانات أن الحرمان المادي وعدم الاستقرار البيئي يمثلان أكثر عوامل الخطر انتشارًا، ويؤثران على 39% من الأطفال. ومع ذلك، تقدم البيانات الكمية رؤية مثيرة، إذ أبدى 94% من مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع أن المنزل آمن بشكل عام (”نعم، آمن تمامًا“)، بينما أفاد 27% أنه “آمن إلى حد كبير، مع بعض المخاوف”، كما هو موضح في الشكل 47، وهو ما يتناقض جزئيًا مع النتائج السابقة.

ومن اللافت أن ثاني أكثر المخاطر الملاحظة كان الإهمال الجسدي والعاطفي بنسبة 28%، وهو ما قد يكون نتيجة الضغوط الأسرية والديناميات العائلية التي ذكرت سابقًا، إلى جانب مخاطر أخرى، كما هو موضح في الشكل 48.

آراء مقدمي الرعاية حول سلامة الأسرة للأطفال (مادبا)



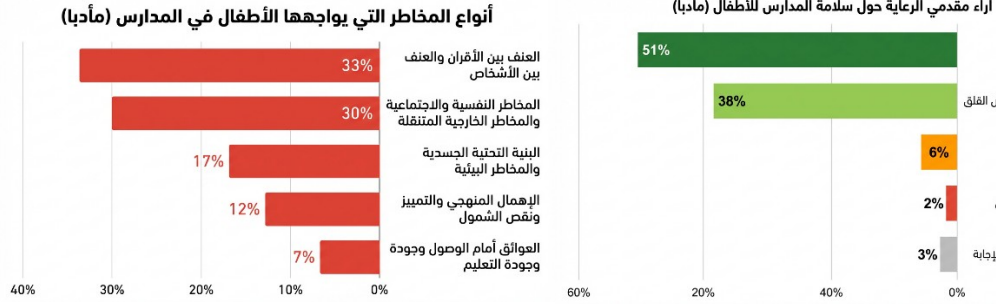
الشكل 48: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على مستوى الأسرة (مادبا)

الشكل 47: رأي مقدمي الرعاية حول مدى أمان الأسرة للأطفال (مادبا)

3.1.2 مخاطر المجتمع والمدرسة والفضاءات العامة

أشار الأطفال والشباب إلى أن المدارس تمثل مكانًا ذو أمان نسبي وفي الوقت نفسه تحمل مخاطر كبيرة، وذلك حسب ظروف كل طفل، حيث أشار نصف المشاركين إلى وجود “أمان عالي”، بينما أبلغ النصف الآخر عن “عدم وجود أمان” أو “لا أشعر بالأمان بسبب وجود مشاكل”.

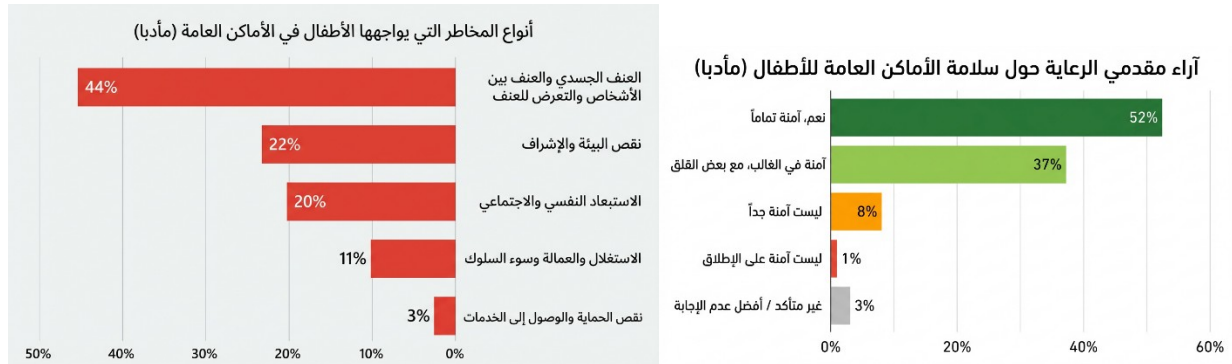
وبالمثل، يرى غالبية مقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع (89%) أن المدارس آمنة، حيث ذكر 51% منهم أنها “نعم، آمنة تمامًا”، وأفاد 38% أنها “آمنة إلى حد كبير، مع بعض المخاوف”، كما هو موضح في الشكل 49. كما أشار المشاركون إلى سلوكيات التنمر من قبل المعلمين، مثل إظهار المحسوبية، وخصوصًا تجاه أطفالهم، وأحيانًا الانتهاكات الجسدية. وتدعم البيانات الكمية هذا الأمر، حيث أظهر الاستطلاع أن العنف بين الأقران والعنف الشخصي هو أكثر مخاطر السلامة المدرسية انتشارًا، ويؤثر على 33% من الأطفال، يليه عن كثب المخاطر النفسية والاجتماعية ومخاطر التنقل الخارجي، التي تؤثر على 30% من الأطفال، كما هو موضح في الشكل 50.



الشكل 50: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في المدارس (مادبا)

الشكل 49: رأي مقدمي الرعاية حول مدى أمان المدارس للأطفال (مادبا)

ومع ذلك، اتفق الأطفال والشباب جميعاً على عدم وجود أمان في الفضاءات العامة. فالمخاطر متنوعة وغالباً خارجة عن السيطرة، وتتراوح بين الاعتداء البشري (بما في ذلك المشاجرات في الشوارع، الإهانات، استخدام الأسلحة، وتهور قيادة السيارات) إلى المخاطر الطبيعية (مثل الحيوانات الضالة، الثعابين، والعقارب). وقد كرر قادة المجتمع ومقدمو الرعاية هذا الرأي، مشيرين إلى أن الفضاءات العامة غير آمنة بشكل عام. وتدعم البيانات الكمية هذا الواقع بقوة، إذ أظهر الاستطلاع أن أكثر المخاطر انتشاراً التي يواجهها الأطفال في الفضاءات العامة هي التعرض للعنف الجسدي والشخصي، حيث تؤثر على 44% من الأطفال، كما هو موضح في الشكل 52. ومع ذلك، وبشكل مشابه لما لوحظ في إربد، فإن غالبية مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع (89%) لديهم تصور إيجابي حول أمان المدارس، حيث ذكر 52% أنها "نعم، آمنة تماماً"، وأفاد 37% أنها "آمنة إلى حد كبير، مع بعض المخاوف"، كما هو موضح في الشكل 51.



الشكل 52: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاءات العامة (مادبا)

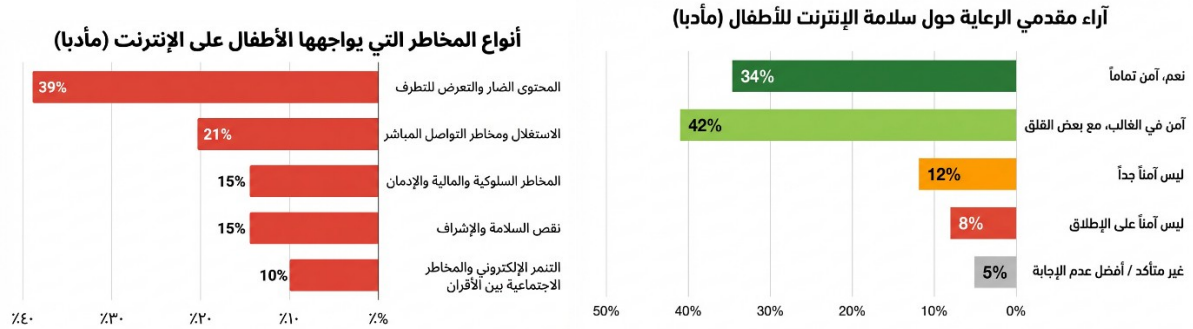
الشكل 51: رأي مقدمي الرعاية حول مدى أمان الفضاءات العامة للأطفال (مادبا)

3.1.3 مخاطر الحماية على الإنترنت والوسائط الرقمية

أشار الأطفال والشباب إلى أن المخاطر الرقمية تتركز حول المخاطر العلانية وانتهاكات الأمان، بما في ذلك التنمر والتهديدات، والتواصل مع الغرباء والابتزاز، واختراق الحسابات. كما أشاروا إلى تعرضهم بدون إرادة للمحتوى المزجج على الإنترنت، بما في ذلك العنف (مثل القتل، الانتحار، الحروب)، مما يسبب ضغوطاً نفسية وجسدية فورية، مثل الخوف، ألم العينين، التحفيز الحسي المفرط، وربما فقدان الرؤية نتيجة الاستخدام الطويل للشاشات.

كما لوحظ أن الأطفال والشباب أنفسهم على دراية بالآثار الشخصية الخطيرة لاستخدام الإنترنت، حيث أوصوا شخصياً بإشراف الأهل، وتقليل وقت الشاشة، وحتى قطع الوصول إلى الإنترنت تماماً، مع التوجه بدلاً من ذلك إلى اللعب في الفضاءات العامة مع الأصدقاء. وبالمثل، أشار خبراء المنظمات غير الحكومية إلى أن الإنترنت يمثل خطراً كبيراً نتيجة تعرض الأطفال للمخاطر دون وعي بكيفية التعامل مع المحتوى، وسهولة استغلالهم.

وتدعم البيانات الكمية هذا الواقع بقوة، حيث أفاد 42% من مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع أن البيئة الرقمية “آمنة إلى حد كبير، مع بعض المخاوف”، بينما صرح 12% صراحة أن الإنترنت “ليس آمناً جداً”، مما يعكس المخاطر المعترف بها، كما هو موضح في الشكل 53. كما أشاروا إلى أن المحتوى الضار والتعرض للعنف يشكلان المخاطر السائدة للأطفال على الإنترنت، ويؤثران على 38% منهم، مؤكدين النتائج السابقة، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالابتزاز، وهو ما يتماشى مع المعدل العالي لمخاطر الاستغلال والاتصال المباشر (31%)، كما هو موضح في الشكل 54.



الشكل 54: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت (مادبا)

الشكل 53: رأي مقدمي الرعاية حول مدى أمان الإنترنت للأطفال (مادبا)

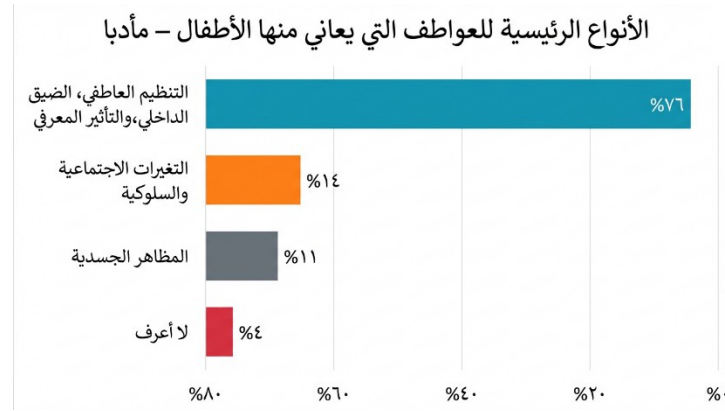
3.2 الرفاه النفسي والاجتماعي وآليات التكيف

3.2.1 الضغوط النفسية والاجتماعية

تم الإشارة إلى أن أبرز الضغوط النفسية التي أبلغ عنها المستجيبون في مادبا تشمل الضغط الأكاديمي، والصراعات الأسرية، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد الأطفال والشباب بتعرضهم لمستويات عالية من التوتر المرتبط بالبيئة الأكاديمية، بما في ذلك الخوف من الامتحانات، والدراسة، وضغط الوالدين على الدراسة، والشعور بالتمييز من المعلمين. كما أكد مقدمو الرعاية أن الصعوبات المالية تفاقم التوتر الأسري، وغالباً ما تؤدي إلى غضب الوالدين أو العقاب الجسدي عندما يطالب الأطفال بحقوقهم أو يطلبون شيئاً.

وتدعم البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أوضح مقدمو الرعاية المشاركون في الاستطلاع أن الأطفال يواجهون صعوبات كبيرة في تنظيم العواطف، والاندماج الداخلي، والتأثيرات المعرفية، وخاصة في الفئات التالية: الغضب أو الانزعاج السريع، الشعور بالقلق أو الخوف أو التوتر، الشعور بالخوف أو الانزعاج نتيجة تجارب صعبة مرّوا بها، بنسبة 67%، كما هو موضح في الشكل 55 أدناه.

ومع ذلك، هناك ملاحظة مثيرة للقلق، إذ أفاد 19% من مقدمي الرعاية بعدم معرفتهم بالنوع الرئيسي للعواطف التي يعبر عنها أطفالهم.



الشكل 55: الأنواع الرئيسية للعواطف التي يختبرها الأطفال (مادبا)

3.2.2 آليات التكيف

عند مواجهة الضيق النفسي، أبرز الأطفال والشباب مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك الدعم الاجتماعي، والروحانية، والانشغال بالنفس لتجنب التفكير السلبي. وقد أشار المشاركون إلى مزيج عام من استراتيجيات التكيف الإيجابية، مثل الممارسات الدينية كالصلاة وقراءة القرآن، والتحدث مع مقدم الرعاية أو الأصدقاء، والتنفس العميق، وكتابة الحلول، وتغيير الروتين اليومي، والانخراط في التأمل، بالإضافة إلى أنشطة مثل الإفراط في تناول الطعام، والنوم، والرسم، والاستماع للموسيقى، أو استخدام الهاتف.

ويعكس الاستطلاع جزءًا من هذا المزيج من استراتيجيات التكيف، حيث أفاد 77% من مقدمي الرعاية بملاحظة أن أطفالهم يستخدمون استراتيجيات تكيف إيجابية (مثل البحث عن الدعم العلائقي وغير الرسمي، وتنظيم الذات الداخلي والتوجيه الذاتي)، كما هو موضح في الشكل 56، وإن كانت غير رسمية. بينما أشار 22% إلى استخدام أطفالهم استراتيجيات تكيف غير فعالة أو تجنبية. ومن اللافت أن نسبة الأطفال الذين يلجأون إلى التدخلات الرسمية لا تزال منخفضة للغاية، حيث بلغت 2% فقط.

الأساليب التي يستخدمها الأطفال للتعامل مع التوتر أو الإرهاق - مادبا



الشكل 56: الأساليب التي يستخدمها الأطفال للتكيف مع التوتر أو الإرهاق (مادبا)

يتأثر استجابة مقدمي الرعاية بشكل كبير بالضغط المالية والأعراف الثقافية عند تعاملهم مع أطفالهم أثناء التعبير عن الضيق النفسي. فبينما يعترف بعضهم بأهمية إظهار الحب والاهتمام، يرى آخرون أن الأطفال لا ينبغي تلبية جميع مطالبهم دائمًا.

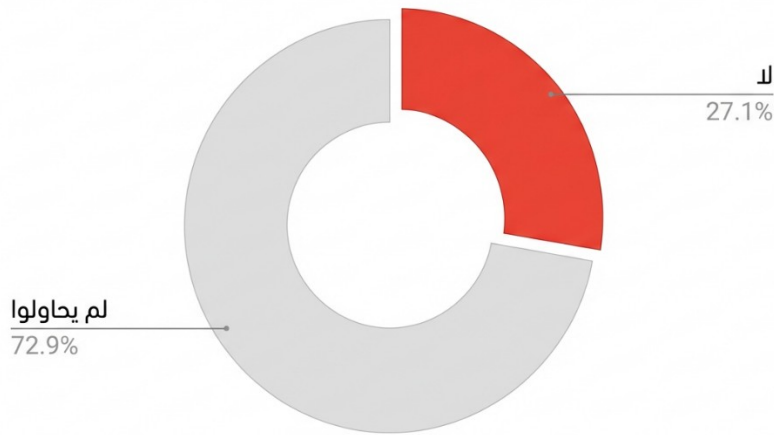
أما ممارسات الانضباط، كما لوحظ في مجموعات النقاش المركزة، فغالبًا ما تكون صارمة وقاسية، تشمل الصراخ، والضرب، والترهيب، وفرض قواعد منزلية صارمة، مع تحديد شدة العقاب وفقًا للأوضاع المالية للأسرة، والتي غالبًا ما تتفاقم مع اقتراب

نهاية الشهر. ومن المثير للاهتمام أنهم أشاروا إلى أن الفتيات يواجهن ضغوطاً اجتماعية وعائلية كبيرة (خصوصاً فيما يتعلق بالأعمال المنزلية)، ومع ذلك يبقين معبرات عاطفياً، على عكس الأولاد الذين يميلون إلى العزلة.

وتقدم البيانات الكمية رؤى مثيرة، إذ أظهرت أن ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة مقدمي رعاية مشاركين في الاستطلاع (73%) لم يحاولوا طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأطفالهم، بينما لم يواجه أولئك الذين لجأوا إلى هذه الخدمات أي صعوبات، كما هو موضح في الشكل 57.

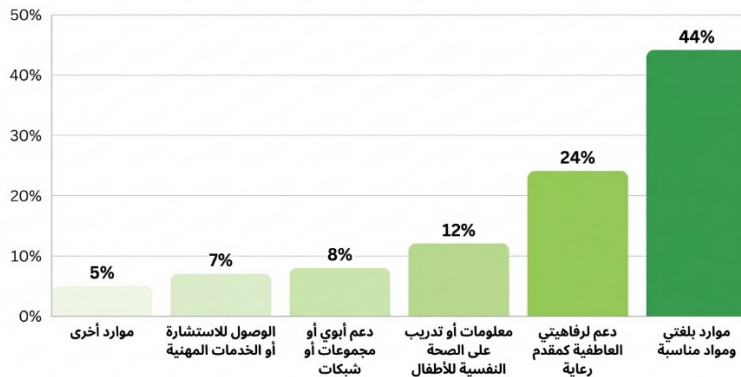
وقد أكدت هذه النتائج أيضاً الحاجة الملاحظة لدى غالبية المشاركين إلى موارد بلغتهم أو مواد ملائمة ثقافياً (ذات صلة بالدعم النفسي والاجتماعي) بنسبة 44%، بالإضافة إلى الدعم لرفاههم العاطفي الخاص بنسبة 24%، بدلاً من الوصول إلى التدخلات المهنية، كما هو موضح في الشكل 58.

هل واجه مقدمو الرعاية تحديات عند محاولة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأطفالهم؟ - إريد



الشكل 57: تجربة مقدمي الرعاية في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال (مادبا)

'نوع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتوفير الدعم النفسي لأطفالهم - مادبا'



الشكل 58: أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم الدعم النفسي للأطفال (مادبا)

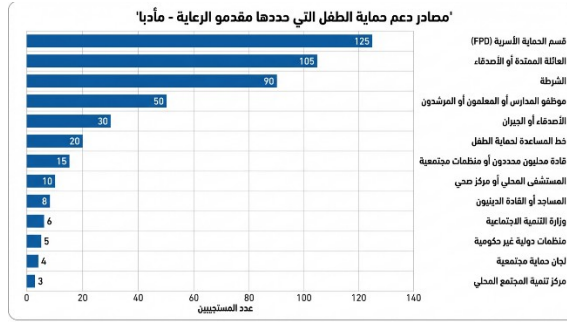
3.3 الاستجابة المؤسسية والعوائق أمام الإبلاغ

3.3.1 القنوات الحالية للإبلاغ

كشفت البيانات أن شبكة الحماية في مادبا تتضمن مزيجاً من القنوات الرسمية وغير الرسمية. وأشار قادة المجتمع إلى أن الإبلاغ الرسمي يتم توجيهه إلى دائرة حماية الأسرة والشرطة، وفي بعض الحالات إلى جهات المجتمع المدني مثل مؤسسة نور الحسين، وأرض البشر، وCOOPI، ومؤسسة نهر الأردن. وفي حالات الخطر الفوري، يتم الاتصال بـ مديرية الأمن العام.

أما على الصعيد غير الرسمي، فقد أشار الأطفال والشباب إلى أن المساعدة عادة ما تُطلب من أفراد الأسرة (الأم، الأب، الأخت، صديق مقرب، عمّة طيبة). كما أبرز مقدمو الرعاية اللجوء إلى الأقارب أو ذوي الخبرة من خلال الوساطة المجتمعية غير الرسمية، وأضافوا أن القادة الدينيين والقبليين يُستشارون غالباً للتوسط أو حل النزاعات تقليدياً. وأفاد الأطفال أيضاً باللجوء إلى أعضاء المدرسة، مثل المدير أو المعلمين.

وبالنسبة لمقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع، وبشكل مشابه للمستجيبين السابقين، فقد أكد نصفهم تقريباً (55%) معرفتهم بالموارد التي يمكنهم من خلالها طلب خدمات حماية الطفل، كما أن أهم ثلاث نقاط اتصال أولية لديهم تمثل مزيجاً من القنوات الرسمية وغير الرسمية، كما هو موضح في الشكلين 59 و60 أدناه.



الشكل 60: مصادر الدعم لحماية الطفل (مادبا)

هل يعرف مقدمو الرعاية أين يطلبون خدمات حماية الطفل لأطفالهم؟ - مادبا



الشكل 59: وعي مقدمي الرعاية بخدمات حماية الطفل المتاحة (مادبا)

3.3.2 الفجوات في القدرة المؤسسية والتنسيق والاستجابة

أبرز خبراء المجتمع المدني أنه على الرغم من أن دائرة حماية الأسرة تُعتبر جهة قوية وفعالة في إدارة الإحالات في الحالات الجادة، إلا أنه لا تزال هناك غياب لإجراءات واضحة أو ضمانات بعدم تعرض الضحايا للعنف مرة أخرى بعد الإبلاغ. كما أشاروا إلى وجود خلل إجرائي شديد في حالات إعادة التوطين من منظور قانوني/سياسي، حيث أنه بالرغم من وجود تقرير “مصلحة الطفل الفضلى” لدعم النقل، فإن رفض أحد الوالدين (سواء كان هو المعتدي أم لا) يمكن قانونياً إيقاف العملية بالكامل، وغالباً ما يؤدي متابعة الإجراءات القانونية إلى عدم تحقيق أي نتائج ملموسة.

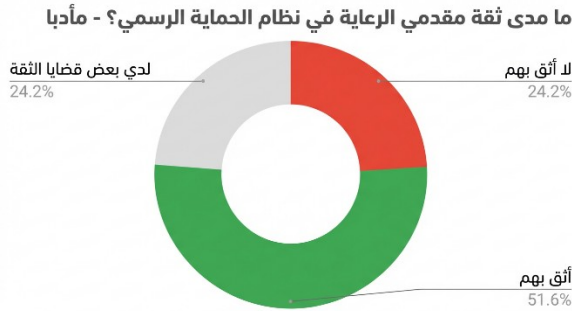
وأضاف الخبراء أن وضعهم التشغيلي يتأثر بنقص التمويل، مما يقيد قدرتهم على الوصول إلى جميع الأطفال ودعمهم، في حين أن بعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تنخرط في حماية الطفل فقط إذا خدم ذلك مصالح مؤسستهم.

ومن اللافت أن هناك تناقضاً بين المستجيبين؛ حيث أوضح قادة المجتمع أن الأدوار واضحة عموماً بين جهات المجتمع المدني المقدمة لخدمات حماية الطفل، بينما أشار خبراء المجتمع المدني إلى أن التنسيق يحتاج إلى تحسين، إذ أن الخدمات أحياناً تتداخل بدل أن تكمل بعضها البعض.

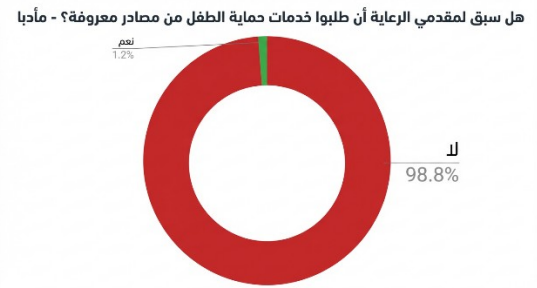
3.3.3 الحواجز الاجتماعية والثقافية أمام طلب الدعم

أشار قادة المجتمع إلى أن الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية يلتزمون الصمت ولا يطلبون المساعدة الرسمية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الوصمة الاجتماعية والخوف من عدم الثقة بسرية المعلومات. وأكد مقدمو الرعاية أن معلومات حول القضايا تم تسريبها رغم إخفاء الأسماء، ولفتوا إلى أنه خصوصًا في المجتمعات الريفية المتماسكة، تزداد احتمالية انتهاك السرية، ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية أو، في حالات متطرفة، للانتقام.

وأكد ذلك أيضًا مقدمو الرعاية المشاركون في الاستطلاع، حيث رغم وجود بعض الثقة (51%) في النظام الرسمي للحماية، فإن ما يقرب من جميعهم (99%) لم يسعوا أبدًا لطلب خدمات حماية الطفل من القنوات الرسمية، كما هو موضح في الشكلين 61 و62 أدناه.



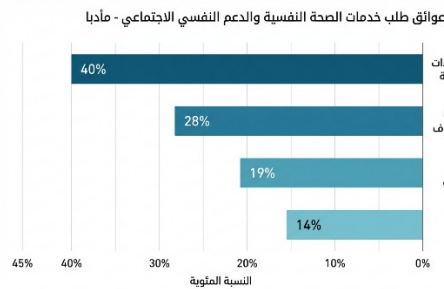
الشكل 62: مستوى ثقة مقدمي الرعاية في نظام الحماية الرسمي (مادبا)



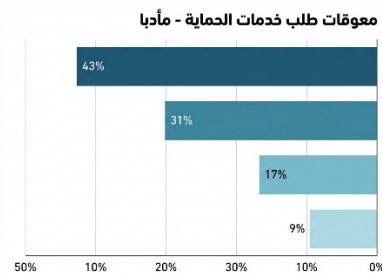
الشكل 61: محاولات مقدمي الرعاية لطلب خدمات حماية الطفل (مادبا)

أما بالنسبة للأطفال والشباب، فرغم ثقتهم بالإبلاغ عن مشاكلهم لأفراد الأسرة، فقد أشار قادة المجتمع إلى أنهم يخافون من ردود فعل مقدمي الرعاية، إذ غالبًا ما يفشل هؤلاء في خلق مساحة مريحة وآمنة للتواصل المفتوح. وأكد المشاركون أنهم يمتنعون عن الإبلاغ خوفًا من الفضائح والشرطة.

وقد أكد ذلك أيضًا مقدمو الرعاية المشاركون في الاستطلاع، حيث أشاروا إلى العوائق الرئيسية المماثلة في طلب خدمات الحماية (بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي)، لا سيما العوائق المرتبطة بالمعايير والمعتقدات الداخلية بنسبة 40%، بالإضافة إلى العوائق المتعلقة بجودة الخدمات، والثقة، وحساسية الموظفين بنسبة 43%، كما هو موضح في الشكلين 63 و64.



الشكل 64: العوائق التي تحول دون طلب خدمات الحماية (مادبا)



الشكل 63: العوائق التي تحول دون طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي -مادبا

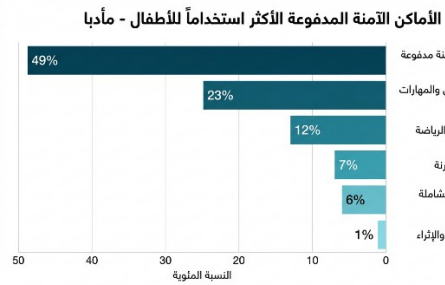
3.4.4 مشاركة الأطفال والشباب

3.4.4.1 قنوات وسياقات التعبير والتأثير

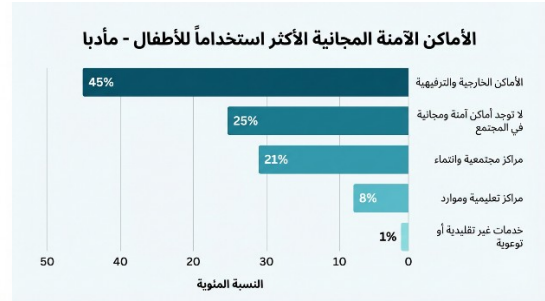
أشار الأطفال والشباب في مادبا إلى استخدام طرق متنوعة للتعبير عن آرائهم، بما في ذلك المشاركة في النقاشات، رفع الصوت، أو المشاركة في أنشطة رسمية مثل المسارح المدرسية، مسابقات الرسم، وأندية التطوع الجامعية. كما يظهر التأثير غير الرسمي داخل الأسرة، حيث تم تطبيق اقتراحاتهم المتعلقة بالأنشطة، وخطط السفر (مثل السفر إلى العقبة)، أو اختيارات الوجبات بنجاح.

أما بالنسبة للفضاءات والأنشطة المخصصة للأطفال في المحافظة، فقد أظهر الاستطلاع أن الفضاءات الخارجية والترفيهية (45%) مثل الحدائق العامة، المساحات الخضراء، الملاعب العامة، وحقول كرة القدم (هي أكثر الأماكن المجانية استخداماً، رغم أن نسبة كبيرة من المشاركين أبلغت بعدم وجود فضاءات مجانية وأمنة للأطفال في المجتمع. (25%)

كما لوحظ أن الفضاءات والأنشطة المدفوعة نادرة أيضاً، بنسبة 49%، بينما يشكل الأنشطة التعليمية وتنمية المهارات الأكاديمية ثاني أكثر الأنشطة استخداماً بنسبة 20%، وتشمل مراكز التعلم أو الدروس الخصوصية، مختبرات الحاسوب أو مراكز التعلم الرقمي، والأندية الفنية أو الثقافية، كما هو موضح في الشكلين 65 و 66 أدناه.



الشكل 66: أكثر المساحات المدفوعة استخداماً من قبل الأطفال (مادبا)



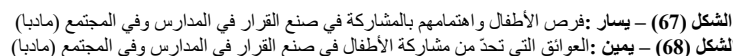
الشكل 65: أكثر المساحات المجانية استخداماً من قبل الأطفال (مادبا)

3.4.4.2 المعوقات أمام فاعلية الأطفال والشباب (القدرة على التعبير والمشاركة)

تتمثل أبرز العوائق التي تحول دون تمكّن الأطفال والشباب من التعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم في الفضاءين الخاص والعام في الضغوط الاقتصادية، وغياب موافقة الوالدين أو الخوف من ردود أفعالهم، إضافة إلى التحديات اللوجستية. وقد أوضح المشاركون أنهم في كثير من الأحيان لا يتمكنون من المشاركة في بعض الأنشطة بسبب عدم قدرة مقدمي الرعاية على تحمّل تكاليفها، أو نتيجة الأعباء الدراسية الثقيلة، إلى جانب ضعف صيانة الملاعب والمساحات المخصصة للأطفال. كما أشاروا إلى شعورهم أحياناً بأن مقدمي الرعاية يتعاملون مع آرائهم بتقليل من الأهمية، بدعوى افتقارهم إلى الخبرة الحياتية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم أخذهم على محمل الجد.

وقد دعمت البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أكد مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستبيان أن العائق الأكبر أمام مشاركة الأطفال في صنع القرار على مستوى المدرسة والمجتمع يتمثل في النظرة التقليدية أو الموقف المتجاهل من قبل مقدمي الرعاية، تلبية مخاوف الأطفال من التعرض للحكم السلبي أو ردود فعل سلبية من مقدمي الرعاية أو الأقران، كما هو موضح في الشكل (68). إضافةً إلى ذلك، أفاد 14% فقط من مقدمي الرعاية بأن الأطفال في محافظتهم يمتلكون الفرص والرغبة للمشاركة في صنع القرار في المدرسة والمجتمع، في حين أشار نحو ثلثهم إلى أن الأطفال قد يكون لديهم اهتمام بالمشاركة ولكن بشكل متقطع أو غير منتظم، كما هو مبين في الشكل (67).

Response	Percentage
نعم، ولكن أحياناً فقط	30.3%
نعم، بشكل منتظم	13.6%
لا، ولكنهم يرغبون بذلك	29.9%
وليس لديهم اهتمام	26.1%



أشار خبراء المجتمع المدني إلى أن المؤسسات التي يعملون معها تُشرك كلاً من الطفل ومقدم الرعاية في إعداد خطط الرعاية في جميع الحالات، مع إعطاء أولوية لرأي الطفل في حال وجود اختلاف في وجهات النظر، وذلك بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى، ويعزز شعوره بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار.

وفي السياق نفسه، أوضحت بيانات الاستبيانات أن مقدمي الرعاية صَنَّفوا منظمات المجتمع المحلي (CBOs) في المرتبة الثالثة من حيث الأماكن أو البيئات التي يشعر فيها الأطفال بالراحة عند التعبير عن آرائهم ومشاعرهم، بعد كل من المدارس والمنازل، كما هو موضح في الشكل.(69)



53

4. الكرك

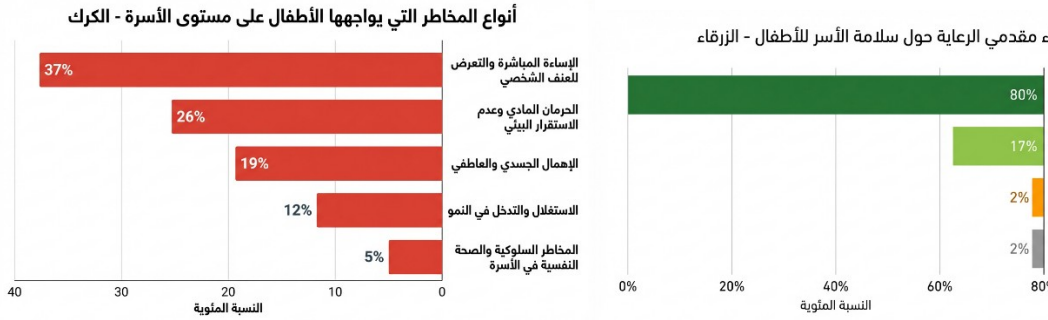
4.1 المخاطر الرئيسية لحماية الطفل

4.1.1 المخاطر داخل الأسرة

أشار مقدمو الرعاية في الكرك إلى أن مخاطر الحماية غالباً ما تنشأ داخل بيئة المنزل، نتيجة الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح الأطفال أن مقدمي الرعاية يستخدمون مزيجاً من أساليب الإساءة الجسدية والعاطفية، بما في ذلك الضرب، الحرمان، وفي بعض الحالات المعاملة الصامتة، والتي أفاد الأطفال بأنها قد تكون أشد قسوة من الإساءة الجسدية. وقد أضاف بعض مقدمي الرعاية توضيحاً لهذه المشاعر التي عرّ عنها الأطفال، مشيرين إلى أن شعور الأطفال بالأمان في المنزل غالباً ما يكون نتيجة الخوف، حيث يلتزم الأطفال بسلوكيات أكثر انضباطاً داخل المنزل خوفاً من مقدمي الرعاية (خصوصاً الآباء)، وهو ما يظهر في سلوكهم المعاكس خارج المنزل.

وتدعم البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أظهرت الاستبيانات أن الإساءة المباشرة والتعرض للعنف بين الأفراد يمثل أهم المخاطر التي يواجهها الأطفال في الكرك، بنسبة 37%. ومن الملاحظ أن مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع أبدوا ثقة عالية في سلامة المنزل، حيث أفاد 80% بأن المنزل "آمن تماماً"، و17% بأنه "آمن إلى حد كبير مع بعض المخاوف"، وهو ما يتناقض مع النتائج النوعية السابقة، كما هو موضح في الشكل (70).

بعد الإساءة المباشرة، جاءت الحرمان المادي وعدم الاستقرار البيئي كثاني أعلى المخاطر، حيث تؤثر على 26% من الأطفال، وهو ما يدعم الاستنتاج النوعي حول استخدام مقدمي الرعاية للحرمان كأداة إساءة، إلى جانب المخاطر الأخرى، كما هو مبين في الشكل (71).



الشكل 71: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على مستوى الأسرة (الكرك)

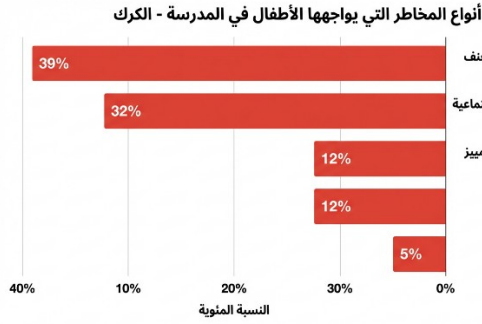
الشكل 70: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة المنازل للأطفال (الكرك)

4.1.2 مخاطر المجتمع والمدارس والفضاءات العامة

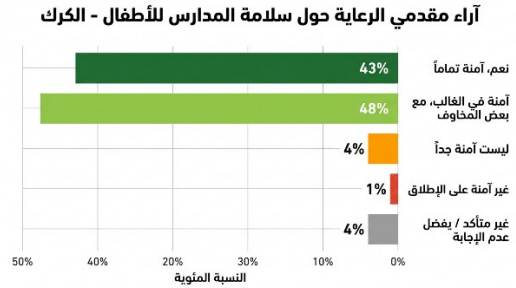
لوحظ أن شعور الأطفال والشباب بالأمان في المدرسة لا يعتمد على الحماية المؤسسية بقدر اعتماده على الروابط الاجتماعية، حيث أن العديد من المعلمين والموظفين هم من الأقارب أو المعارف. وتشمل المخاطر التي يواجهها الأطفال في المدرسة مخاطر اجتماعية وجسدية، مثل التنمر الجسدي، والمحابة من قبل المعلمين، والنميمة، والإضرار بالسمعة، وهو أمر ذو صلة خاصة بالطبيعة المحافظة للمحافظة، وقد يؤدي إلى إجبار الأطفال، خصوصاً الفتيات، على ترك المدرسة خوفاً من الحكم المجتمعي. كما أضاف مقدمو الرعاية أن العنف داخل الأسرة يمكن أن يكون دورياً، إذ قد يُعيد الطفل الذي يتعرض للتنمر أو الضرب خارج المنزل تكرار نفس السلوك العدواني تجاه الإخوة.

وقد دعمت البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أظهر الاستطلاع أن أهم المخاطر التي يواجهها الأطفال في المدرسة هي العنف بين الأقران والعلاقات الشخصية، ويؤثر ذلك على 39% من الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة المخاطر المرتبطة بالنميمة والإضرار بالسمعة تظهر بوضوح في ثاني أكبر فئة من المخاطر، وهي المخاطر النفسية والاجتماعية ومخاطر السفر الخارجي، التي تؤثر على 32% من الأطفال، كما هو موضح في الشكل (73).

ومن اللافت، وعلى عكس المحافظات السابقة، أن الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع أبدوا ثقة في سلامة المدارس، لكن مع بعض المخاوف بنسبة 46%، بينما أشار 43% إلى أن المدرسة آمنة تماماً، كما هو مبين في الشكل (72).



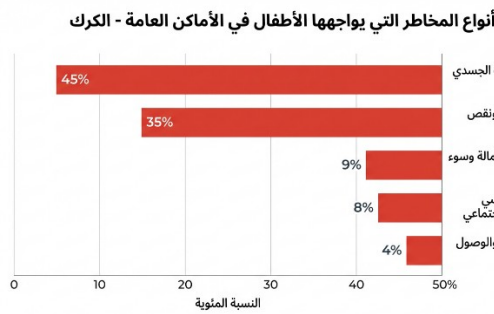
الشكل 73: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في المدارس (الكرك)



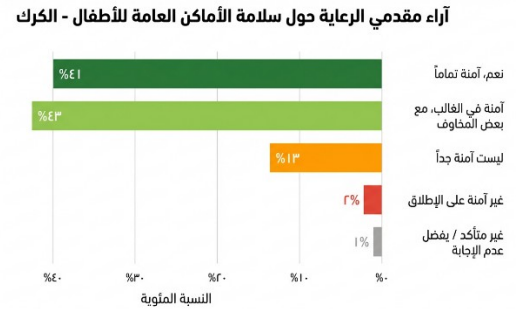
الشكل 72: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة المدارس للأطفال (الكرك)

أما بالنسبة للفضاءات العامة، فقد أكد الأطفال والشباب بوضوح عدم وجود أي فضاءات آمنة، كما لوحظ انتشار المخاطر الجسدية في المجتمع، بما في ذلك الاختطاف، وهجمات الكلاب الضالة، وتناول الأطعمة والحلوى الملوثة بالمخدرات المنتشرة في الشارع.

وتدعم البيانات الكمية هذه الملاحظات بشكل قوي، حيث أشار مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع إلى أن التعرض للعنف الجسدي والعلاقات الشخصية يمثل أبرز المخاطر التي يواجهها الأطفال، ويؤثر على 45% منهم، تليه نقص الرقابة والبيئة غير الآمنة كثنائي أعلى المخاطر، ويؤثر على 35% من الأطفال، كما هو موضح في الشكل (75). وبشكل مشابه للبيئة المدرسية، أفاد غالبية مقدمي الرعاية بأن الفضاءات العامة "آمنة إلى حد كبير مع بعض المخاوف" بنسبة 43%، كما هو مبين في الشكل (74).



الشكل 75: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاءات العامة (الكرك)



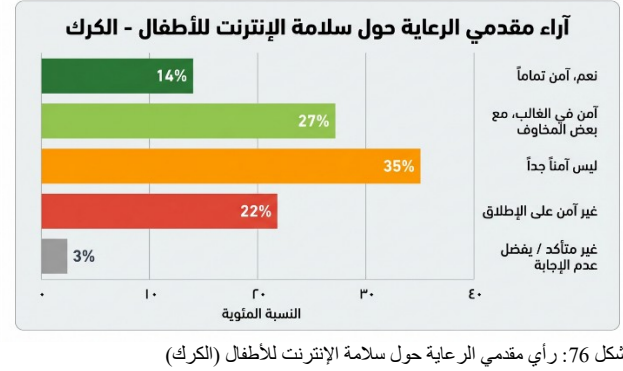
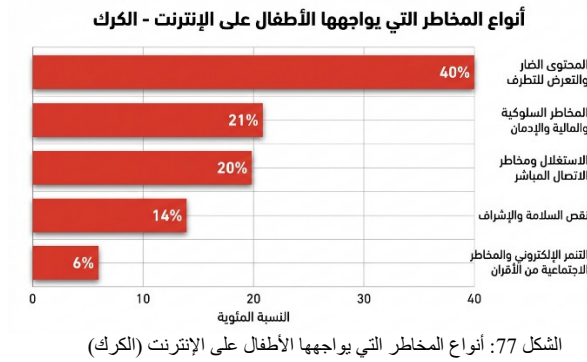
الشكل 74: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة الفضاءات العامة للأطفال (الكرك)

4.1.3 المخاطر الرقمية وحماية الأطفال على الإنترنت

أبرز قادة المجتمع المدني وخبراء المجتمع المدني على حد سواء الطبيعة المعقدة والخفية للتعرض الرقمي للأطفال، مشيرين إلى أن الإنترنت يمثل المكان الأكثر خطورة على الأطفال، حيث تكون عناصره، مثل الإعلانات، منتشرة ومستهدفة بشكل كبير، وقادرة على تحليل نوعية الشخص الذي يشاهدها وتكييف محتواها وفقاً لذلك. وأوضح القادة أن هذا التلاعب الموجه لا يقتصر على الأطفال فقط، بل يشمل أي شخص ليس على وعي كامل بذاته، حيث أن البشر بشكل عام عُرضة للتأثير والإغراء بسهولة. أما المخاطر الرقمية التي أشار إليها المشاركون، فتتراوح من المشاكل الشائعة مثل الابتزاز والهجمات الإلكترونية إلى التهديدات الجسدية والنفسية الخطيرة. فقد أفاد مقدمو الرعاية بوجود ألعاب تجذب الأطفال إلى الويب المظلم، أو التورط في الاتجار بالأعضاء، أو الإساءة الجنسية، وبرامج تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس، وحتى الترويج الخفي للفرق الدينية الخطيرة أو الرموز الشيطانية داخل الألعاب. وأكد الأطفال والشباب أنهم مدركون بدرجة عالية لهذه التهديدات.

وتدعم البيانات الكمية هذه الملاحظات بشكل قوي، حيث أفاد 35% من مقدمي الرعاية أن البيئة "غير آمنة إلى حد كبير"، بينما صرح 27% بأنها "آمنة إلى حد كبير مع بعض المخاوف"، مما يعكس مستوى الخطر المعترف به، كما هو مبين في الشكل (76). كما تم تحديد المحتوى الضار والتعرض للعنف كأبرز المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، ويؤثر ذلك على

40% منهم، مؤكّداً النتائج السابقة حول نوعية المحتوى الذي يتعرض له الأطفال. أما المخاطر الثانية من حيث الشدة، فتتمثل في المخاطر السلوكية والمالية والإدمان، وتؤثر على 21% من الأطفال، كما هو موضح في الشكل (77).



4.2 الرفاه النفسي الاجتماعي وآليات التكيف

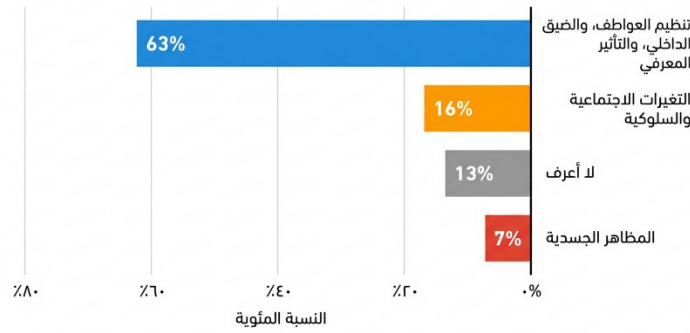
4.2.1 الضغوط النفسية والاجتماعية

على غرار محافظة مادبا، أشارت النتائج في الكرك إلى أن الضغوط النفسية الرئيسية التي يواجهها الأطفال والشباب تشمل الضغط الأكاديمي، والصراعات الأسرية، والضغوط الاقتصادية. وقد شدد الأطفال والشباب على أن عدم قدرة مقدمي الرعاية على تلبية متطلباتهم المالية يسبب التهيج وأحياناً العدوانية، مما يولد ضغوطاً نفسية عميقة لدى الأطفال الذين يبدأون بالتساؤل عن الاستقرار المالي لعائلاتهم، متسائلين: "لماذا أنجبتمونا إذا لم يكن لديكم المال؟"، خاصة عند مقارنة أقرانهم الذين غالباً ما تكون ظروفهم المالية أفضل، وتأثير ذلك على أمن مستقبلهم، خصوصاً عندما يكون الأشقاء الأكبر سناً المؤهلون للعمل عاطلين عن العمل، مما يجعلهم يشعرون باليأس تجاه فرصهم المستقبلية.

كما أشار الأطفال والشباب إلى أن الواجبات الدراسية المكثفة والدراسة الزائدة تسهم بشكل كبير في التوتر اليومي داخل الأسرة. وتشمل هذه التوترات الصراعات العائلية، والعنف المنزلي، والصراخ العلني، والمعاملة غير العادلة بين الأشقاء، وقد أشار المشاركون إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والاعتداد بالذات، وفي بعض الحالات إلى العزلة الشديدة. ومن اللافت أن أحد المشاركين أشار إلى أنه عندما يتعرض الأطفال للتنمر، فإنهم غالباً "يكررون نفس السلوك تجاه الإخوة أو أقران آخرين".

وتدعم البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أوضح مقدمو الرعاية المشاركون في الاستطلاع أن الأطفال يواجهون صعوبات كبيرة في ضبط العواطف، والتعرض للضغط النفسي، والتأثيرات المعرفية، خصوصاً في الفئات التالية: الغضب أو الانزعاج بسهولة، الشعور بالحزن لفترة طويلة، انخفاض تقدير الذات أو الشعور بعدم القيمة، والشعور بالخوف أو الانزعاج بسبب تجارب صعبة مروا بها، ويبلغ معدل التأثير 63%، كما هو موضح في الشكل (78).

الأنواع الرئيسية للعواطف التي يعاني منها الأطفال - الكرك



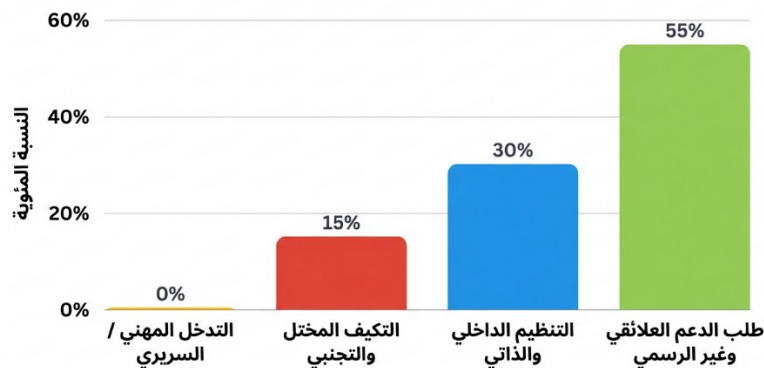
الشكل 78: الأنواع الرئيسية للعواطف التي يختبرها الأطفال (الكرك)

4.2.2 آليات التكيف

عند مواجهة الضيق العاطفي، أشار الأطفال والشباب إلى مجموعة من استراتيجيات التكيف، التي تشمل الدعم الاجتماعي والتشتيت الذاتي. وقد تم الإبلاغ عن مزيج من أساليب التكيف الإيجابية والسلبية في الخصوصية، مثل العزلة في أماكن هادئة (على سبيل المثال، الجلوس بمفردهم على سطح المنزل، النوم، التدخين، أو اللعب على الهاتف).

ومن الملاحظ أن 85% من مقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى ملاحظة استخدام أطفالهم لأساليب تكيف إيجابية في الغالب، مثل البحث عن الدعم العاطفي غير الرسمي وتنظيم الذات الداخلي، كما هو موضح في الشكل (79)، رغم أن هذه الأساليب غير رسمية. وفي نتيجة مقلقة، لم يذكر أي من المستجيبين أن طفلهم لجأ يوماً إلى تدخل مهني متخصص.

الطرق التي يستخدمها الأطفال للتعامل مع الضغط أو الإرهاق - إربد



الشكل 79: أساليب التكيف التي يستخدمها الأطفال للتعامل مع الضغط أو الإرهاق (الكرك)

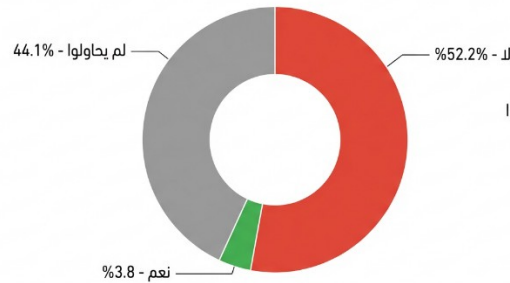
أشار مقدمو الرعاية إلى أنهم يتعاملون مع الضيق العاطفي لأطفالهم من خلال الاستماع النشط والتعاطف، ساعين لتحديد الجذر الأساسي للسلوك قبل التدخل، مع قيام بعضهم باللجوء أحياناً إلى استشارات نفسية للتحديات التربوية. كما أوضحوا أن نهجهم التأديبي يتراوح بين المودة واللفظ إلى التهديد وإثارة الخوف، وغالباً ما يُستخدم الأخير عندما يكون مقدم الرعاية تحت ضغط مالي، مما يزيد من سلوكيات التهيج لديهم.

ومثل محافظة مادبا، لوحظ أن التوقعات المرتبطة بالنوع الاجتماعي تؤثر على التعبير العاطفي، حيث تميل الفتيات إلى استخدام البكاء والتواصل، بينما يُضغَط على الأولاد لكبت مشاعرهم. كما لوحظ، مثلما في إربد، أن الضغوط الاقتصادية المزمنة قد تدفع بعض الأسر إلى استراتيجيات تكيف ضارة، مثل دفع الفتيات إلى الزواج المبكر.

وتكشف البيانات الكمية عن رؤية مثيرة، حيث بينت أن نصف تقريباً من مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع (44%) لم يحاولوا أبداً طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (MPHSS) لأطفالهم، ومع ذلك، فإن غالبية من حاولوا الاستفادة من هذه الخدمات لم يواجهوا أي تحديات (52%)، كما هو موضح في الشكل (80). أما بالنسبة لأولئك الذين واجهوا تحديات، فتشمل نقص المعلومات عن الخدمات المتاحة، وبعد المسافة أو ارتفاع التكلفة في حال توفرها.

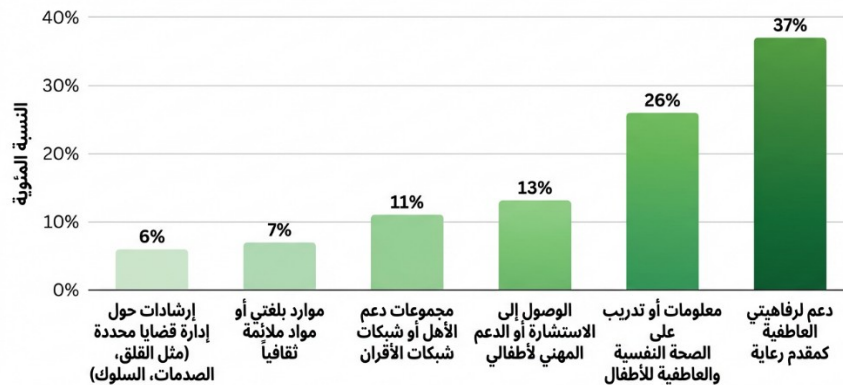
وقد أكد معظم المشاركين على الحاجة إلى دعم رفاههم العاطفي الشخصي بنسبة 37%، وكذلك الحاجة إلى موارد بلغتهم أو مواد مناسبة ثقافياً ذات صلة بالدعم النفسي بنسبة 26%، بدلاً من الوصول إلى التدخلات المهنية المباشرة، كما هو موضح في الشكل (81).

هل واجه مقدمو الرعاية تحديات عند محاولة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأطفالهم؟ - الكرك



الشكل 80: تجربة مقدمي الرعاية في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال (الكرك)

أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم الدعم للصحة النفسية لأطفالهم - الكرك



الشكل 81: أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم الدعم النفسي والصحي للأطفال (الكرك)

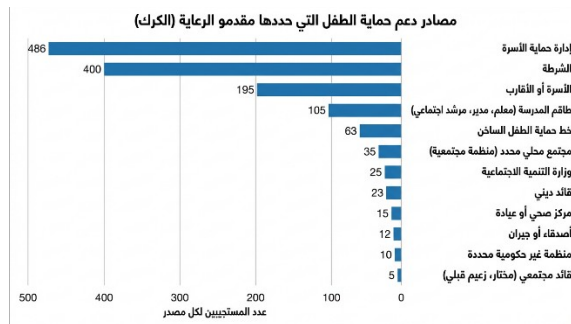
4.3 الاستجابة المؤسسية والحواجز أمام الإبلاغ

4.3.1 القنوات القائمة للإبلاغ

مثل المحافظات السابقة، تتميز الكرك أيضاً بوجود مزيج من القنوات الرسمية وغير الرسمية التي يلجأ إليها الأفراد في أوقات الحاجة. ذكر قادة المجتمع أن دائرة حماية الأسرة، ومراكز الشرطة، ومديرية الأمن العام تُعد من القنوات الرسمية، وأضافوا أن كل قسم أسري لديه مستشارون اجتماعيون وباحثون، وحتى مكاتب الأمن تحتوي على باحثين اجتماعيين مدربين. كما أشاروا إلى أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تقدم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي، مثل مؤسسة ولي العهد التي توفر جلسات تمكين للشباب العاطلين عن العمل.

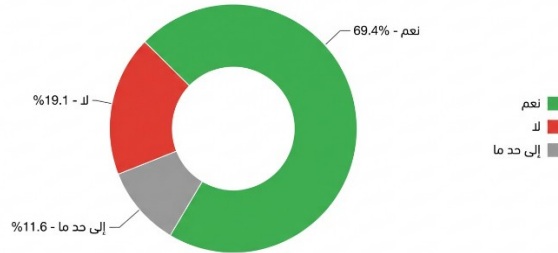
على الصعيد غير الرسمي، أشار الأطفال والشباب إلى أن الأسرة تمثل النظام الأساسي للدعم، حيث يلجأ الأطفال أولاً إلى مقدم الرعاية (على الرغم من ندرة ذلك)، ثم الإخوة، الأصدقاء، وأيضاً المعلمين والمديرين، حسب وجود علاقة إيجابية وأمنة بشكل ملحوظ معهم. كما أشار مقدمو الرعاية إلى الاعتماد على أنظمة غير رسمية متجذرة في تقاليد المجتمع، مثل اللجوء إلى القادة أو الشيوخ القبليين لحل النزاعات بشكل خاص، بالإضافة إلى الشبكات الشخصية مثل الجيران أو الأقارب.

وفي البيانات الكمية، أشار مقدمو الرعاية المشاركون في الاستطلاع إلى أن حوالي ثلثهم تقريباً (69%) لديهم معرفة بالموارد التي يمكنهم من خلالها طلب خدمات حماية الطفل، وعكس ذلك ما أظهرته النتائج النوعية السابقة، حيث كانت أهم ثلاث نقاط اتصال أولية لديهم مزيجاً من القنوات الرسمية وغير الرسمية، كما هو موضح في الشكلين (82 و 83) أدناه.



الشكل 83: مصادر دعم حماية الطفل (الكرك)

هل يعرف مقدمو الرعاية أين يمكنهم طلب خدمات حماية الطفل لأطفالهم؟ - الكرك



الشكل 82: وعي مقدمي الرعاية بالخدمات المتاحة لحماية الأطفال (الكرك)

4.3.2 الفجوات في القدرة المؤسسية والتنسيق والاستجابة

أوضح قادة المجتمع المحلي أن عملية الإبلاغ واضحة ومنظمة بشكل عام، وتتبع عدة خطوات، مع التركيز على السرية (خصوصاً فيما يتعلق بأفراد العائلة الممتدة) وراحة الطفل (مع السماح باختيار الضباط، بما في ذلك توفر ضباط إناث). وأضافوا أن هناك في المدارس نظاماً لمحاضرات توعية ينفذها الشرطة وقطاع الصحة، وهي متاحة عند طلب إدارة المدرسة. وأشار أحد خبراء المجتمع المدني إلى أن استخدام أدوات موحدة مستندة إلى الإطار الوطني الأردني للحماية، بما في ذلك تقييم مستويات المخاطر، وخطط التدخل، وخطط السلامة، بالإضافة إلى بروتوكولات إدارة الأزمات والإسعافات النفسية الأولية، يُطبق في الحالات المعقدة (مثل حالات الانتحار المحتملة).

ومع ذلك، أشار خبراء آخرون إلى أن استجابات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني يمكن أن تكون متفاوتة وغير متسقة لعدة أسباب، منها: نقص الكوادر المتخصصة المدربة على التعامل مع القضايا النفسية (مثل اضطراب ما بعد الصدمة) والمعضلات

الأخلاقية (مثل التعامل مع حالات الإيذاء الذاتي أو عندما يطور الضحية علاقة أقوى مع المعالج من مقدم الرعاية)، ونقص أدوات تقييم المخاطر المتقدمة وخطط السلامة، ونقص الموارد المالية مما يحد من الوصول إلى الخدمات في المناطق النائية ويعيق توفير البدائل المناسبة، وانخفاض الوعي العام بخدماتهم بسبب غياب الحملات التوعوية، وأخيرًا متطلبات السرية القانونية الطويلة (رغم الاعتراف بأهميتها) وإجراءات التنسيق مع السلطات الرسمية.

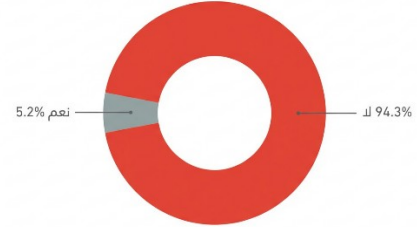
4.3.3 الحواجز الاجتماعية والثقافية أمام طلب الدعم

أشار قادة المجتمع إلى أن أفراد المجتمع ينظرون إلى قنوات الإبلاغ الرسمية (مثل المديرية العامة للأمن العام) على أنها "عقابية أكثر من كونها داعمة"، وأن هناك نقصًا عامًا في الثقة ببروتوكولات السرية، ويُعزى ذلك إلى الخوف من السلطات وقلة التواصل بين هذه الجهات والمجتمعات المحلية. وقد خالف ذلك جزئيًا البيانات الكمية، حيث أعرب 56% من مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم بالنظام الرسمي للحماية، بينما انقسم الباقيون بين لديهم بعض القضايا المتعلقة بالثقة (28%) وعدم الثقة على الإطلاق (16%)، كما هو موضح في الشكل 85. كما أظهرت البيانات أن معظم مقدمي الرعاية في الكرك لم يسعوا تقريبًا للحصول على خدمات حماية الأطفال من القنوات الرسمية (94%)، وهو ما يؤكد النتائج النوعية، كما هو موضح في الشكل 84

ما مدى ثقة مقدمي الرعاية بنظام الحماية الرسمي؟ (الكرك)



هل سبق لمقدمي الرعاية طلب خدمات حماية الطفل من مصادر معروفة؟ (الكرك)

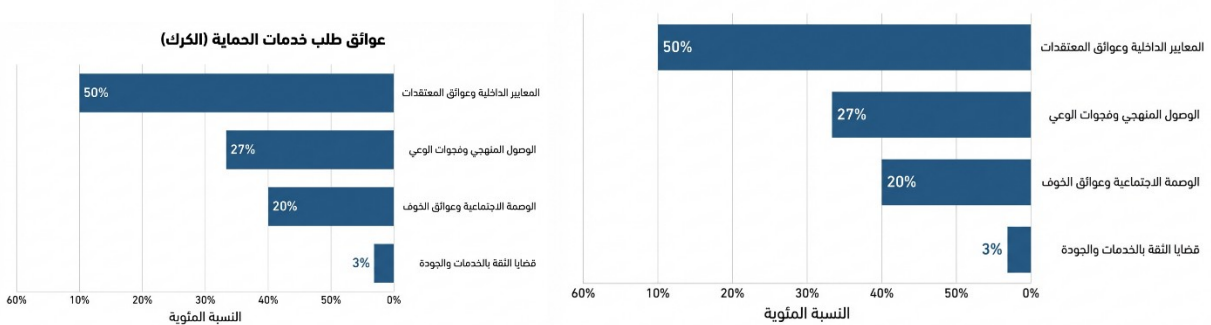


الشكل 85: مستوى ثقة مقدمي الرعاية بنظام الحماية الرسمي (الكرك)

الشكل 84: محاولات مقدمي الرعاية لطلب خدمات حماية الطفل (الكرك)

بالإضافة إلى ذلك، في حالات الاعتداء الجنسي وطلب الدعم النفسي، أفاد قادة المجتمع أن الأسر غالبًا ما تخفي الحوادث وتنشط عن الإفصاح عنها، خوفًا من تشويه سمعة العائلة والتقييد بالأعراف التقليدية. وبينما عبّر الأطفال والشباب بشكل عام عن شعورهم بالارتياح عند الإبلاغ عن مشكلاتهم لمقدمي الرعاية، أشاروا إلى أن غياب الأمان، ونقص الوعي، وقلة الدعم من مقدمي الرعاية في بعض الحالات قد تثبطهم عن ذلك. وقد أكدت البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أشار مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع إلى العوائق المرتبطة بالأعراف والمعتقدات المستبطنة، بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية، كأسباب رئيسية لعدم طلب خدمات حماية الأطفال (بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي) من القنوات الرسمية، كما هو موضح في الشكلين 86 و87.

عوائق طلب خدمات الحماية (الكرك)



الشكل 87: العوائق التي تحول دون طلب خدمات الحماية (الكرك)

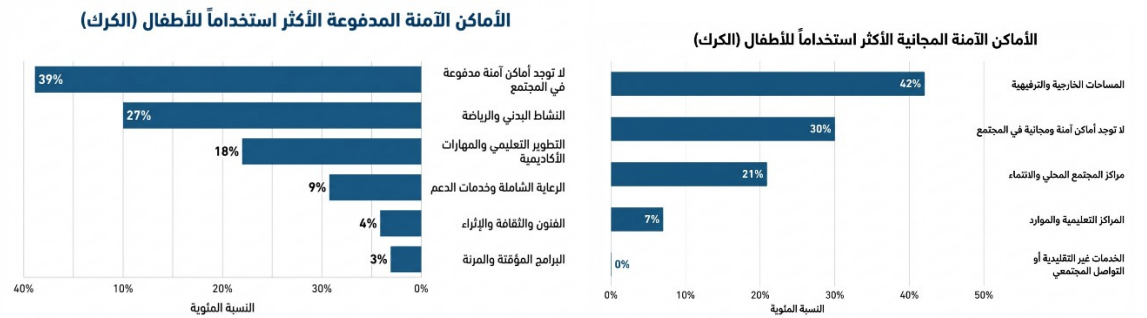
الشكل 86: العوائق التي تحول دون طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي (الكرك)

4.4 مشاركة الأطفال والشباب

4.4.1 قنوات وسياقات التعبير والتأثير

أفاد الأطفال والشباب أن مشاركتهم تندمج بشكل كبير ضمن أطر التوعية المدرسية والمجتمعية. وتشمل القنوات الأنشطة المدرسية مثل حملات السلامة المرورية، المسرحيات، والجداريات، كما يشاركون في الجلسات التي تقدمها مؤسسة ولي العهد والمبادرات التطوعية غير الرسمية. ضمن الأسرة، يشارك الأطفال آرائهم حول القضايا اليومية أو المشاكل المالية مع الأقارب الموثوقين، مثل مناقشة المشاكل المالية مع العم أو الأمور الشخصية مع الأم. ومن الملاحظ أن الشباب الذين يعملون بعد المدرسة أشاروا إلى أن عملهم يوفر لهم "راحة مالية" ويؤثر إيجابيًا على حالتهم النفسية.

أما بالنسبة للمساحات والأنشطة المخصصة للأطفال في المحافظات، أظهر المسح أن المساحات الخارجية والترفيهية (47%) (وتشمل الحدائق العامة أو المساحات الخضراء، الملاعب العامة، وميادين كرة القدم) هي الأكثر استخدامًا كمساحات مجانية، رغم أن نسبة معتبرة من المشاركين أفادت بعدم وجود مساحات مجانية آمنة للأطفال في المجتمع (30%). وذكرت المساحات/الأنشطة المدفوعة أيضًا بأنها نادرة، حيث بلغت 30%، مع أن النشاط البدني والرياضة شكل ثاني أكثر الأنشطة استخدامًا بنسبة 27%، كما هو موضح في الشكلين 88 و 89 أدناه.



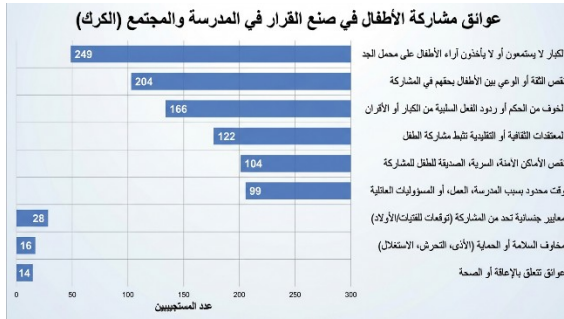
الشكل 89: أكثر المساحات المدفوعة استخداماً من قبل الأطفال (الكرك)

الشكل 88: أكثر المساحات المجانية استخداماً من قبل الأطفال (الكرك)

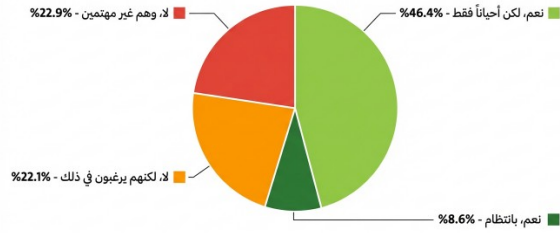
4.4.2 المعوقات أمام المشاركة الفاعلة

أشار الأطفال والشباب إلى أن أهم عائق أمام مشاركتهم وإبداء آرائهم في الأماكن الخاصة والعامة هو نقص هذه المساحات الفعالية في الكرك. وأوضحوا غياب النوادي، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والاستخدام غير المنتج للهاتف، مؤكدين أنهم سيكونون أكثر تشجيعاً على التعبير عن أنفسهم إذا توفرت مساحات آمنة تشجع على التعلم والمشاركة.

وقد أكدت البيانات الكمية ذلك، حيث أشار أولياء الأمور المشاركون في المسح إلى أن أكبر العوائق أمام مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار في المدرسة والمجتمع تتمثل في الموقف المتجاهل من قبل الوالدين، يليه نقص الثقة بالنفس أو الوعي بحقوقهم في المشاركة، كما هو موضح في الشكل 91. بالإضافة إلى ذلك، أفاد 9% فقط من أولياء الأمور أن الأطفال في محافظتهم يمتلكون فرصاً واهتماماً بالمشاركة في اتخاذ القرار في المدرسة والمجتمع، بينما أعرب نحو نصفهم تقريباً عن أن الأطفال سيكونون مهتمين بالمشاركة، لكن بشكل متقطع، كما هو موضح في الشكل 90.



هل لدى الأطفال فرص أو اهتمام بالمشاركة في صنع القرار في المدرسة والمجتمع؟ (الكرك)



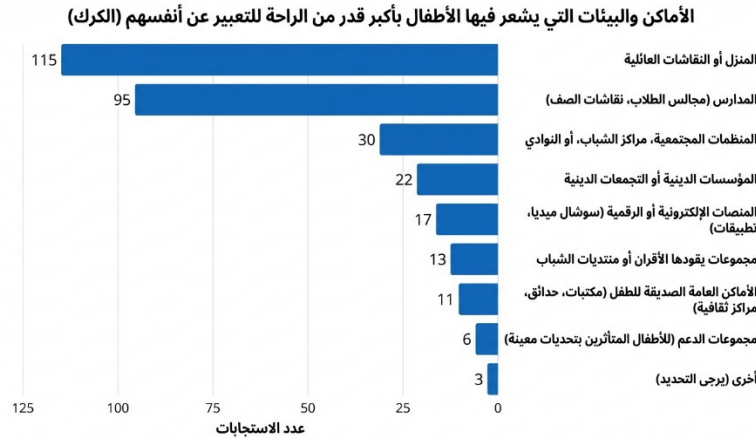
الشكل 90 (اليمين): فرص الأطفال واهتمامهم بالمشاركة في اتخاذ القرار في المدارس وفي المجتمع (الكرك)
 الشكل 91 (اليسار): العوائق التي تحد من مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار في المدارس وفي المجتمع (الكرك)

4.4.3 الدعم المؤسسي والمشاركة المرجوة

أوضح خبراء المجتمع المدني أن الجهات المحلية تضمن مشاركة الأطفال من خلال جلسات التوعية والأنشطة الميدانية. وأضاف أحد الخبراء أن من الآليات المستخدمة تحديد متطوعين من فئات عمرية قريبة من الأطفال لتسهيل التواصل ومساعدتهم على التعبير عن احتياجاتهم بشكل واضح ومريح. كما أشاروا إلى أن أفراد المجتمع يستجيبون لهذه الأنشطة ويشاركون فيها عبر جلسات توعية وتعليمية تركز على الاستجابة للعنف أو التغيرات النفسية لدى الأطفال.

وعبر الشباب عن رغبتهم في أنشطة تتعلق بتعلم اللغات، وثقافة العمل التطوعي، والمعرفة المالية، ومهارات الطباعة والرقمية، والنوادي الرياضية، والمراكز التعليمية.

ومن الملاحظ أن أولياء الأمور المشاركين في المسح أوضحوا أن المنظمات المجتمعية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأماكن والبيئات التي يشعر فيها الأطفال براحة أكبر للتعبير عن أنفسهم، بعد المدارس والمنازل، كما هو موضح في الشكل 92.



الشكل 92: الأماكن والبيئات التي يشعر فيها الأطفال بالراحة الأكبر للتعبير عن أنفسهم (الكرك)

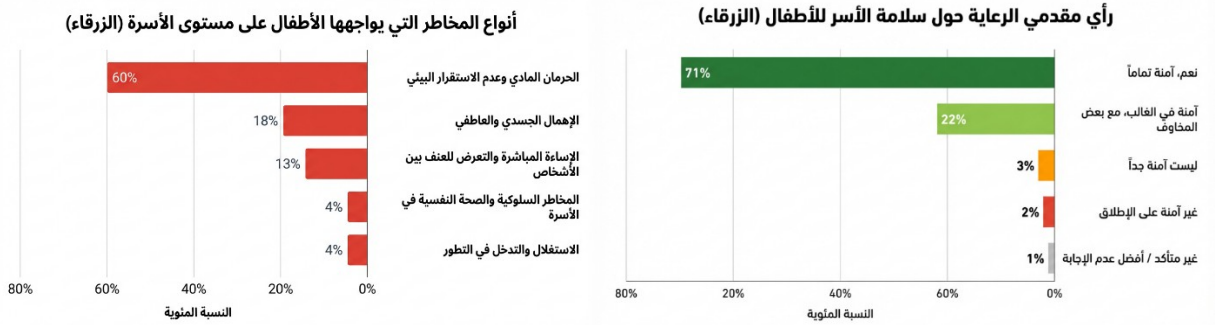
5. الكرك

5.1 المخاطر الرئيسية لحماية الأطفال

5.1.1 المخاطر داخل الأسرة

رغم أن معظم الأطفال أفادوا بأنهم يشعرون بالأمان داخل منازلهم، إلا أن الأمان يبقى متأثراً بالصراعات العائلية، بما في ذلك المشاجرات بين مقدمي الرعاية والمضايقات والتهمز بين الأشقاء. ومن جهة أخرى، أشار قادة المجتمع إلى أن المنزل يظل بيئة عالية المخاطر لبعض الأطفال، مع الاعتراف بأن بعض الأطفال يتعرضون لضغوط نفسية وإساءة داخل الأسرة. كما أبرز أحد خبراء المجتمع المدني أن الضغوط الاقتصادية تعرض العديد من الأطفال للعمل بعد المدرسة أو للاستغلال، أو تدفعهم أحياناً إلى الانقطاع عن التعليم تماماً.

وتؤكد البيانات الكمية هذه الملاحظات، حيث أشار أولياء الأمور المشاركون في الاستبيان إلى أن الحرمان المادي وعدم استقرار البيئة هما أعلى المخاطر التي يواجهها الأطفال، إذ تؤثر على 60% منهم، كما هو موضح في الشكل 94. وفي الوقت نفسه، تُظهر البيانات تناقضاً مع النتائج النوعية، حيث أن غالبية أولياء الأمور المشاركين في الاستبيان لديهم تقييم إيجابي لسلامة المنازل، مع 71% أفادوا بأنها "آمنة تماماً" و 22% بأن "آمنة إلى حد كبير مع بعض المخاوف"، ليصل إجمالي الآراء الإيجابية إلى 93%، كما هو موضح في الشكل 93



الشكل 94: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على مستوى الأسرة (الزرقاء)

الشكل 93: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة المنازل للأطفال (الزرقاء)

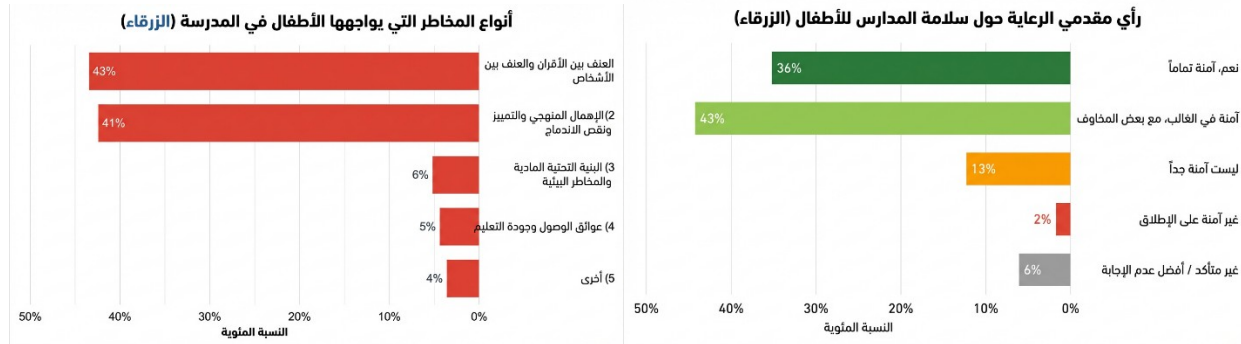
أشار أولياء الأمور أنفسهم إلى وجود مخاطر داخل المنزل، بما في ذلك التعرض لمخاطر الإنترنت والمخاطر العامة في المنزل مثل الكهرباء والغاز وأدوات المطبخ، كما أشاروا إلى أن الضغوط اليومية وظروف المعيشة الصعبة قد تحد من تفاعلهم ومشاركتهم مع أطفالهم.

5.1.2 المخاطر في المجتمع والمدارس والأماكن العامة

فيما يخص المجتمع والمدارس، رغم تقدير التعليم وارتفاع انتشاره في الزرقاء، إلا أن المخاطر مثل التنمر اللفظي والجسدي، بالإضافة إلى المعاملة القاسية والتهمز من قبل المعلمين كما أبلغ الأطفال والشباب، تخلق بيئة غير مريحة وتجعل الكثير منهم يفضل البقاء في المنزل أو الانقطاع عن الدراسة وفقدان الثقة بالنفس، وفقاً لتقارير خبراء المجتمع المدني. وبشكل خاص للفتيات الصغيرات، لوحظ أن الأمان يتأثر بمجاورة مدارس ساهمت في العنف بين الأولاد، حيث يتعرضن للمضايقات المستمرة والتحرش اللفظي. وتؤكد البيانات الكمية هذه الملاحظات، حيث أظهر استبيان أولياء الأمور أن العنف بين الأقران والعنف بين الأشخاص هو الخطر الأكثر شيوعاً الذي يواجه الأطفال في المدرسة، ويؤثر على 43% منهم، يليه مباشرة الإهمال النظامي والتمييز ونقص الشمولية 24 بنسبة 41%، كما هو موضح في الشكل 96

²⁴ تشمل هذه الفئة من المخاطر ما يلي: نقص الإشراف من البالغين أثناء فترات الاستراحة أو في المناطق المشتركة، التمييز أو الإقصاء من قبل المعلمين أو الطلاب (مثل التمييز على أساس الجنس، الإعاقة، الجنسية، وضع اللاجئين، أو الطبقة الاجتماعية)، وعدم تجهيز المدرسة بشكل جيد أو عدم كونها شاملة للأطفال ذوي الإعاقة أو الاحتياجات التعليمية الخاصة.

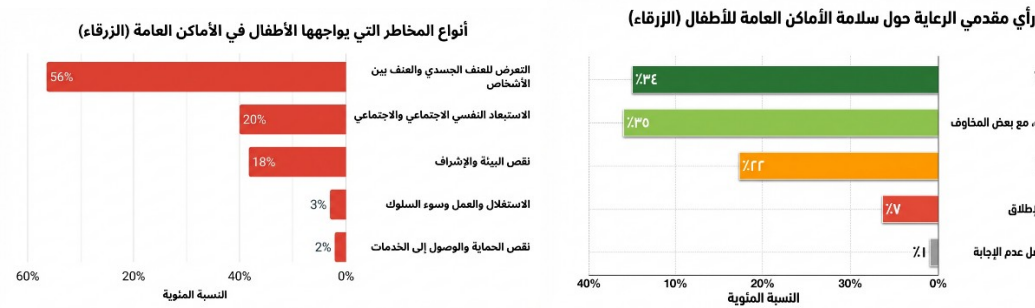
ومماثل لمحافظة الكرك، أعربت الغالبية العظمى من أولياء الأمور المشاركين عن ثقتهم في أمان المدارس، لكن مع بعض القلق (43%)، بينما أفاد 36% فقط بأنها "آمنة تماماً"، كما هو موضح في الشكل 95 أدناه.



الشكل 96: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في المدارس (الزرقاء)

الشكل 95: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة المدارس للأطفال (الزرقاء)

فيما يتعلق بالأماكن العامة، تشمل مصادر خوف الأطفال والشباب ومخاوفهم المتعلقة بالأمان مجموعة واسعة من القضايا، مثل وجود مجموعات من الشباب الذين غالباً ما يتسببون في اشتباكات في الشوارع، والمشاكل الإنشائية المتعلقة بالطرق العامة، والتي تتفاقم بسبب القيادة المتهورّة وعدم الالتزام بقواعد المرور (مما يعرض المشاة، وخاصة الأطفال، للخطر)، بالإضافة إلى انتشار المخدرات، والسرقة، والتحرش، والتنمر، ومخاطر وسائل النقل العام، وخطر الاختطاف. وتؤكد البيانات الكمية ذلك بشكل واضح، حيث أظهر استبيان أولياء الأمور أن التعرض للعنف الجسدي والعنف بين الأشخاص يمثل الخطر الأعلى والأكثر تأثيراً بنسبة 56% (كما هو موضح في الشكل 98). ومع أن 69% من أولياء الأمور ما زالوا يحتفظون برؤية إيجابية بشأن الأمان (34% "آمن تماماً" و35% "آمن إلى حد ما، مع بعض المخاوف"، كما هو موضح في الشكل 97)، إلا أن حجم المخاطر الكامنة يظهر جلياً في نسبة 22% من أولياء الأمور الذين أشاروا صراحةً إلى أن الأماكن العامة



الشكل 97: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة الأماكن العامة للأطفال (الزرقاء)

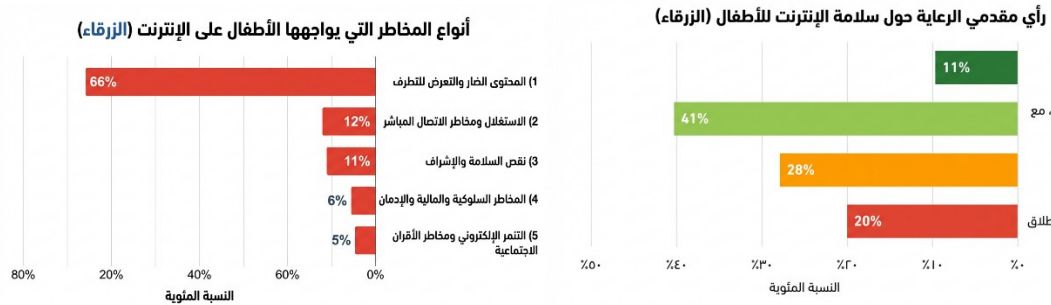
الشكل 98: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في الأماكن العامة (الزرقاء)

5.1.3 مخاطر الحماية على الإنترنت والرقمية

خلال مقابلات أصحاب المصلحة الرئيسيين، أشار قادة المجتمع صراحةً إلى أن الإنترنت هو المنصة الأكثر خطراً التي يستخدمها الأطفال والشباب، وذلك بسبب الإهمال الأبوي وارتفاع وقت استخدام الشاشات. وتشمل المخاطر الرقمية التي تم ذكرها: التحرش، الابتزاز، محتوى يشجع على إيذاء النفس، وتأثيرات انتحارية. كما أشار الأطفال والشباب بأن المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له يكون متلاعباً وشائعاً، مثل الألعاب الإدمانية كـ Roblox، وألعاب القتال العنيفة، والإعلانات غير الملائمة في شكل نوافذ منبثقة. وأوضحوا أن المحتوى لا يُستهلك بشكل سلبي فقط، بل يُعلم سلوكيات ضارة وأفكاراً سلبية مثل العنف، السرقة، أو استخدام لغة غير لائقة.

يتم تأكيد ذلك بشكل قوي من خلال البيانات الكمية، حيث أفاد 28% من أولياء الأمور المشاركين في الاستطلاع بأن البيئة "ليست آمنة جداً"، وأفاد 41% بأنها "آمنة إلى حد كبير، مع بعض المخاوف"، مما يعكس الخطر المعترف به سابقاً، كما هو موضح في الشكل 99. كما حدّدوا أن التعرض للمحتوى الضار والعنف يمثل الخطر الرئيسي للأطفال على الإنترنت، ويؤثر على نسبة كبيرة

تصل إلى 66%، متجاوزاً جميع المخاطر الأخرى بفارق كبير، مما يعيد التأكيد على النتائج السابقة التي أشار إليها الأطفال بشأن نوع المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له، إلى جانب المخاطر الأخرى، كما هو موضح في الشكل 100.



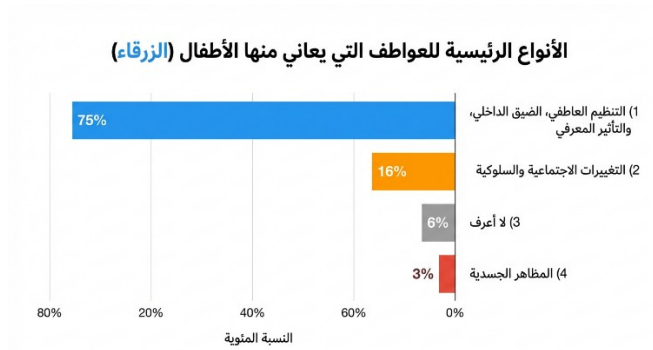
الشكل 100: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت (الزرقاء)

الشكل 99: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة الإنترنت للأطفال (الزرقاء)

5.2.1 الضغوط النفسية والاجتماعية

أفاد المشاركون في الزرقاء أن أبرز الضغوط النفسية والاجتماعية تشمل البيئات المدرسية السلبية، والصراعات الأسرية، والصعوبات المالية. وأوضح الأطفال والشباب أن التنمر من قبل أقرانهم وسوء المعاملة من قبل المعلمين يشكلان مصادر رئيسية للحزن، وأن المشكلات المالية، بما في ذلك البطالة لدى الوالدين، تسبب لديهم شعوراً بالخوف والإحباط، بالإضافة إلى القلق بشأن مستقبلهم الشخصي. وتتفاقم هذه الضغوط لدى بعض الأطفال، حيث يُتوقع من الفتيات القيام بالأعمال المنزلية ومن الأولاد العمل خارج المنزل. وأضاف مقدمو الرعاية أن هذه المشاكل المالية قد تدفعهم أحياناً لتفريغ إحباطهم على الأطفال، وغالباً ما يزداد الأمر سوءاً عند المقارنة بين الأشقاء أو أبناء العمومة.

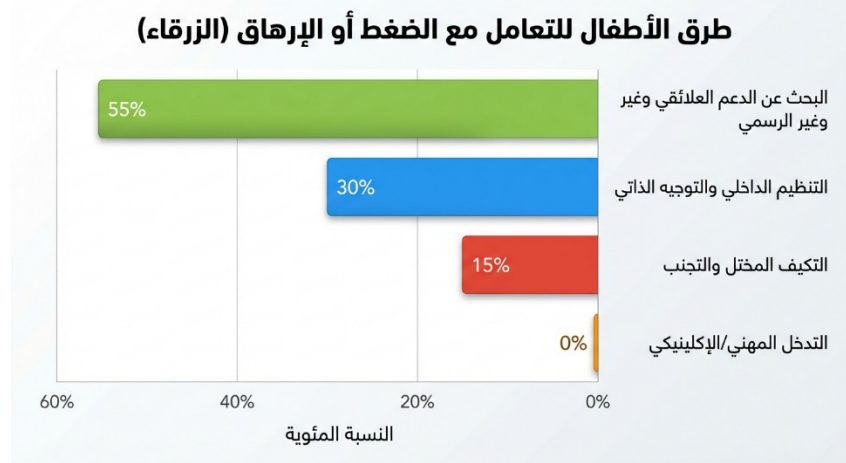
ويعزز البيانات الكمية هذا الأمر، حيث أشار مقدمو الرعاية المشاركون في الاستطلاع إلى أن الأطفال يواجهون صعوبات كبيرة في تنظيم المشاعر، والضيق النفسي الداخلي، والتأثير المعرفي (وخاصة الفئات التالية تحت هذا البند: الشعور بالقلق أو الخوف أو التوتر، الشعور بالحزن أو التعاسة لفترة طويلة، الشعور بالخوف أو الانزعاج نتيجة تجارب صعبة مروا بها)، بنسبة 75%، كما هو موضح في الشكل 101 أدناه.



الشكل 101: الأنواع الرئيسية من المشاعر التي يختبرها الأطفال (الزرقاء)

5.2.2 آليات التكيف

مماثلًا لما لوحظ في عمّان، أظهر الأطفال والشباب في الزرقاء توازنًا بين التواصل الاجتماعي وإلهاء النفس عند مواجهة الضيق النفسي. كما تم الإبلاغ عن مزيج من آليات التكيف الخاصة الإيجابية والسلبية، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو القرآن، الصلاة، اللعب على الهاتف أو ألعاب الفيديو، ممارسة كرة القدم، أو المشي، بالإضافة إلى العزلة (البقاء وحيدًا في الغرفة لساعات)، وفترات قصيرة من العمل (حيث توفر إحساسًا بالفائدة مقارنة بالبقاء في المنزل). ومن المثير للاهتمام، أن 85% من مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أنهم يلاحظون استخدام أطفالهم بشكل أساسي آليات التكيف الإيجابية (مثل البحث عن الدعم العلاجي والعلاقات غير الرسمية، والتنظيم الداخلي وتوجيه الذات)، كما هو موضح في الشكل 102، بالرغم من كونها غير رسمية. ومماثلًا للوكر، لم يبلغ أي مشارك عن سعي طفله للحصول على تدخل مهني أو احترافي.



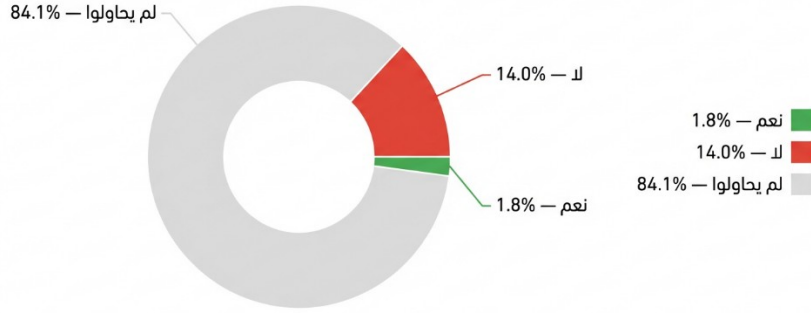
الشكل 102: أساليب الأطفال في التكيف مع الضغط أو الإرهاق (الزرقاء)

مماثلًا لما لوحظ في مادبا والكر، أشار مقدمو الرعاية إلى أن استجاباتهم لضيق أطفالهم النفسي تتأثر بشكل كبير بالتوقعات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وخصوصًا بالنسبة للولاد؛ حيث غالبًا ما تواجه محاولات الأمهات لتشجيع التعبير عن المشاعر ضغطًا من الآخرين للـ "دعوه يكون رجلاً"، وأوضحت إحدى الأمهات أنه إذا لم ير الولد والده يُظهر مشاعره أبدًا، "ينشأ بنفس الطريقة". وتعتمد أساليب الانضباط، كما أفاد المشاركون، على التدابير العقابية، بما في ذلك الصراخ، ومصادرة الهواتف، وفرض عقوبات مثل حجب المصروف أو الحرمان من الخروج.

تقدم البيانات الكمية رؤى مثيرة للاهتمام تدعم هذا السياق، حيث أظهرت أن غالبية كبيرة مقلقة 84% من مقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع (44%) لم يحاولوا أبدًا طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (MPHSS) لأطفالهم، وللأقلية الصغيرة التي فعلت، لم تواجههم أي تحديات (14%)، كما هو موضح في الشكل 103. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين واجهوا خدمات، كان التحدي الوحيد المذكور هو بعد المسافة عن مكان سكنهم.

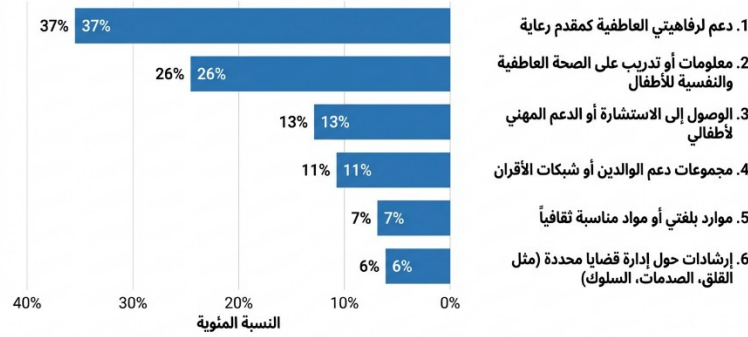
وقد أكد ذلك أيضًا أن الغالبية أشاروا إلى حاجتهم إلى الدعم لصحتهم النفسية والعاطفية الخاصة بنسبة 37%، وكذلك الحاجة إلى موارد بلغتهم أو مواد ملائمة ثقافيًا (ذات صلة بدعم الصحة النفسية) بنسبة 26%، بدلاً من الوصول إلى التدخلات المهنية، كما هو مبين في الشكل 104.

هل واجه مقدمو الرعاية تحديات عند محاولة الوصول لخدمات الصحة النفسية لأطفالهم (الزرقاء)



الشكل 103: تجربة مقدمي الرعاية في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال (الزرقاء)

أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم الدعم النفسي لأطفالهم (الزرقاء)



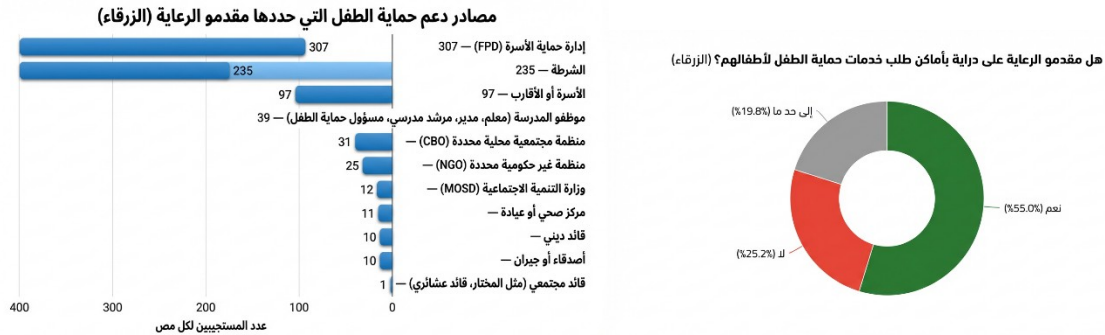
الشكل 104: أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم الدعم النفسي للأطفال (الزرقاء)

5.3 الاستجابة المؤسسية والعوائق أمام الإبلاغ

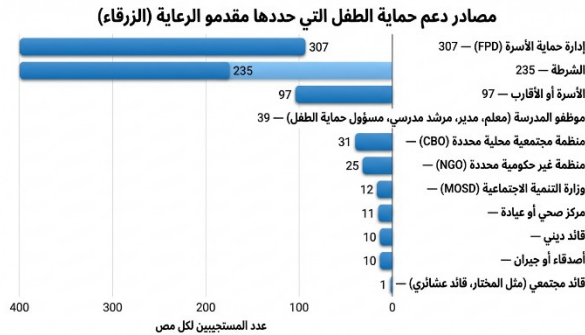
5.3.1 قنوات الإبلاغ القائمة

أظهر المشاركون في الزرقاء مستوى عاليًا من المعرفة بالجهات التي يمكن الإبلاغ إليها في حال حدوث أي مشاكل للأطفال. وتحدث القادة المجتمعيون عن القنوات الرسمية، مثل دائرة حماية الأسرة، الشرطة، وحدة حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة. وأضافوا أيضاً أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل قري SOS ، ومبادرة اليونيسف، مركز زهاء، شابات الرصيفة، وجمعية أثر، بالإضافة إلى المتطوعين الأفراد، تقدم أحياناً الدعم، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والتدريب لمقدمي الرعاية على الأبوة الإيجابية، والإحالات للحالات الحرجة (باستخدام أدوات تقييم المخاطر وخطط السلامة).

أما بالنسبة لمقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع، وبالمماثلة لبقية المشاركين، فقد أكد نصفهم تقريباً (55%) معرفتهم بالموارد التي يمكنهم من خلالها طلب خدمات حماية الطفل. أما بالنسبة لقنوات الإبلاغ، فقد كانت أول ثلاث نقاط اتصال لهم مزيجاً من القنوات الرسمية وغير الرسمية، كما هو موضح في الشكلين 105 و 106 أدناه.



الشكل 105: وعي مقدمي الرعاية بالخدمات المتاحة لحماية الطفل (الزرقاء)



الشكل 106: مصادر دعم حماية الطفل (الزرقاء)

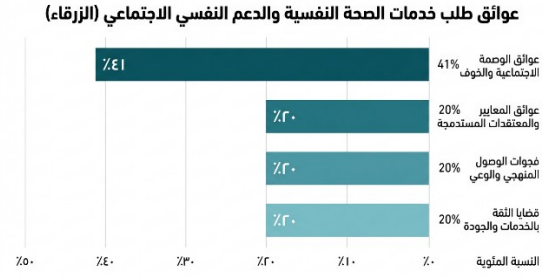
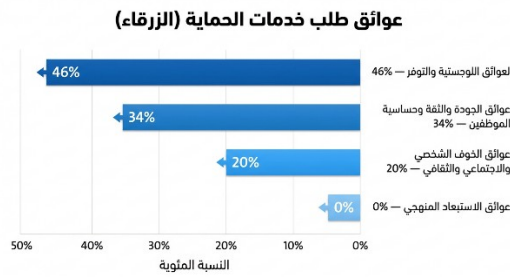
بشكل غير رسمي، عادةً ما يلجأ الأطفال إلى أمهاتهم أو أفراد الأسرة، بينما يسعى الشباب للحصول على المساعدة من الشخص الأقرب والأكثر ثقة لديهم، وبالمثل في المدرسة، حيث قد يتحدثون إلى معلم أو صديق مقرب. أما مقدمو الرعاية، فيعتمدون غالباً على خبرة الأقارب، نصائح الجيران، أو شيوخ المجتمع وزعماء القبائل لحل النزاعات.

5.3.2 الثغرات في القدرة المؤسسية والتنسيق والاستجابة

مماثلاً للبيانات السابقة، أوضح القادة المجتمعيون أن هناك غالباً تداخلاً بدل التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في الزرقاء فيما يتعلق بالاستجابة لمشكلات حماية الطفل، مما يؤدي إلى نزاعات قضائية وإهمال حالات الأطفال بسبب تأخر الاستجابة (خصوصاً في القضايا القانونية المعقدة التي تتجاوز ولاية وقدرة الجهات المحلية). وتشمل التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التمويل المحدود والكوادر المدربة بشكل مستمر (خصوصاً في الحالات المعقدة التي تتضمن معضلات أخلاقية)، نقص الثقة المجتمعية، ضعف الالتزام والمتابعة، والتحديات اللوجستية مثل بعد مراكز الخدمة، تكاليف النقل، وضيق الوقت.

5.3.3 الحواجز الاجتماعية والثقافية في طلب الدعم

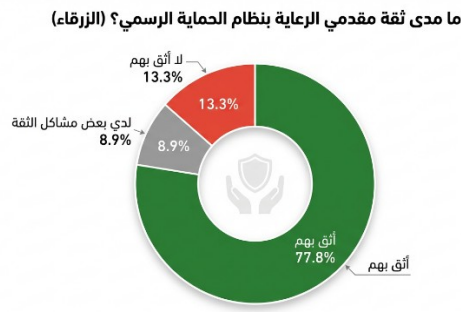
اتفق كل من مقدمي الرعاية والقادة المجتمعيين على أن الخوف من الوصمة الاجتماعية والعار والحكم المجتمعي يشكل أكبر عائق للإبلاغ عن المشكلات التي يواجهها الأطفال، حيث أشار أحد المشاركين إلى أن الشرطة قد تصل علناً إلى المنازل، مما يعرض الأسر ويخلق إحراجاً اجتماعياً. وأكد الأطفال والشباب بالإجماع أن الخوف من مقدمي الرعاية، والخوف من اكتشاف المجتمع، والخوف من أن يتحدث الناس عنهم هو السبب الرئيسي للصمت. وقد أكدت البيانات الكمية ذلك، حيث أشار مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الوصمة الاجتماعية تشكل 41%، وأضافوا أن عوائق توفر الخدمات تشكل أحد أهم العوائق لطلب خدمات حماية الطفل بنسبة 46%، كما هو موضح في الشكلين 107 و 108.



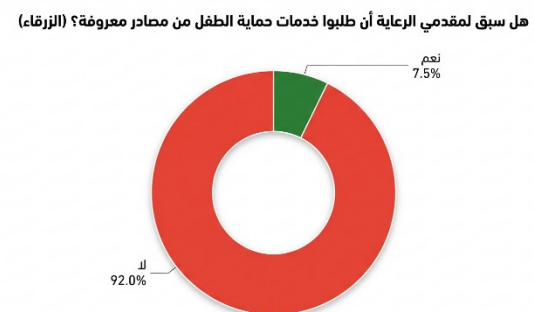
الشكل 107: العوائق أمام طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (الزرقاء) الشكل 108: العوائق أمام طلب خدمات الحماية (الزرقاء)

بالإضافة إلى ذلك، وبالمماثلة للكرك، تشعر العائلات في الزرقاء بالقلق من أن يؤدي الإبلاغ عن الحوادث، وخصوصاً تلك التي تحدث لبناتهم، إلى تشويه سمعتهم والإضرار بفرص الزواج. ويمتد هذا القلق أيضاً إلى طلب الدعم النفسي، حيث أبلغ عن وجود وصمة اجتماعية مماثلة تجعل الكثيرين يفضلون الحديث مع الأقارب أو الأصدقاء بدلاً من المتخصصين.

وقد أكد مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع هذا الأمر أيضاً، حيث لم يسع معظمهم (92%) أبداً لطلب خدمات حماية الطفل من القنوات الرسمية، على الرغم من ثقتهم العالية بها (77%)، كما هو موضح في الشكلين 109 و 110.



الشكل 110: مستوى ثقة مقدمي الرعاية بالنظام الرسمي للحماية (الزرقاء)



الشكل 109: محاولات مقدمي الرعاية لطلب خدمات حماية الطفل (الزرقاء)

5.4 مشاركة الأطفال والشباب

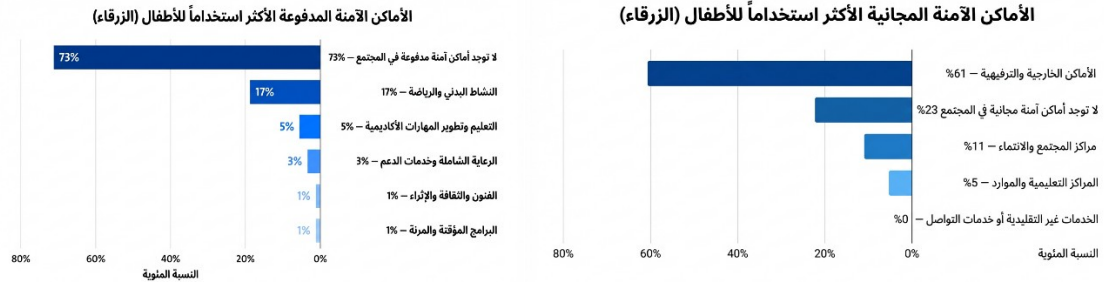
5.4.1 قنوات وسياقات التعبير والتأثير

مماثلًا للكرك، أشار الأطفال والشباب في الزرقاء إلى حرية عامة في التعبير عن آرائهم، حيث قال أحد المشاركين: "أعبر عن رأيي كما هو"، وأكدوا على أهمية الحوار المفتوح في المنزل والمدرسة لبناء الثقة. وتشمل طرق التعبير الاستطلاعات، والندوات، ومجموعات النقاش، ومجالس الطلبة، والجمعيات، ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما لاحظوا حدوث تغييرات صغيرة عند التعبير عن آرائهم، مثل شاب اقترح إصلاح سقف المنزل وقدرت أسرته مساهمته، وآخر شعر بالتقدير بعد تطبيق ملاحظاته في مسابقة مناظرة مدرسية. وأضافوا أن الأماكن والسياقات التي يشعرون فيها براحة أكبر للتعبير عن آرائهم تشمل المسجد، و فرق كرة القدم، ونوادي اللياقة البدنية، والأندية المدرسية مثل نادي المناظرات وكشافة المدرسة.

أما بالنسبة للمساحات والأنشطة المخصصة للأطفال في المحافظات، فقد أظهر مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أن المساحات الخارجية والترفيهية (61%) (وتشمل الحدائق العامة أو المساحات الخضراء، الملاعب العامة، وحقول كرة القدم)

هي الأكثر استخدامًا مجانًا، على الرغم من أن بعضهم أشار إلى عدم وجود مساحات آمنة مجانية للأطفال في المجتمع (23%) وأفاد المشاركون أيضًا أن المساحات أو الأنشطة المدفوعة نادرة بشكل ملحوظ بنسبة 73%، وكانت ثاني أكثر الفئات استخدامًا هي النشاط البدني والرياضة (17%)، كما هو موضح في الشكلين 111 و 112 أدناه.



الشكل 112: أكثر المساحات المدفوعة استخدامًا من قبل الأطفال (الزرقاء)

الشكل 111: أكثر المساحات المجانية استخدامًا من قبل الأطفال (الزرقاء)

5.4.2 المعوقات أمام الفاعلية (القدرة على التأثير)

في الزرقاء، تشمل أبرز العوائق التي تمنع الأطفال والشباب من التعبير عن آرائهم وأصواتهم في المساحات الخاصة والعامّة نقص الثقة بالنفس، والضغط النفسي، والسخرية، وعدم اهتمام مقدمي الرعاية، والإعاقات الجسدية، والخوف من قول شيء غير صحيح. وأضافوا أن مقدمي الرعاية غالبًا ما يتعاملون مع آرائهم بتجاهل ولا يأخذونها على محمل الجد. وأكدوا أن الاستماع باحترام وتقبل الأفكار يُعدّان عاملين أساسيين لتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع المشاركة الفاعلة.

وقد دعمت البيانات الكمية هذه النتائج، حيث أكد مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أن أكبر العوائق أمام مشاركة الأطفال في صنع القرار في المدرسة والمجتمع تتمثل في ضعف الثقة بالنفس أو نقص الوعي بحقوقهم في المشاركة، يلي ذلك تعامل مقدمي الرعاية الرفض أو المتجاهل، كما هو موضح في الشكل 114.

وبالإضافة إلى ذلك، أفاد 21% من مقدمي الرعاية بأن الأطفال في محافظتهم يمتلكون فرصًا واهتمامًا بالمشاركة في صنع القرار في المدرسة والمجتمع، في حين أعرب 38% منهم عن أن الأطفال قد يكون لديهم اهتمام بالمشاركة ولكن بشكل متقطع، كما هو موضح في الشكل 113.



الشكل 113 (يسار): فرص الأطفال واهتمامهم بالمشاركة في صنع القرار في المدارس وفي المجتمع (الزرقاء)

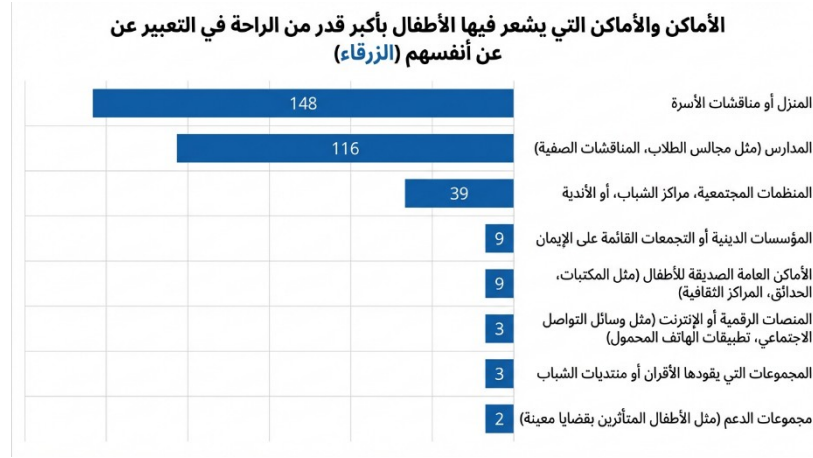
الشكل 114 (يمين): العوائق أمام مشاركة الأطفال في صنع القرار في المدارس وفي المجتمع (الزرقاء)

5.4.3 الدعم المؤسسي والمشاركة المنشودة

أكد خبراء المجتمع المدني أن الجهات المحلية تضمن إيصال أصوات الأطفال من خلال الإيمان بأن الأطفال شركاء أساسيون وليسوا مجرد مستفيدين. فعلى سبيل المثال، يتم إشراك الأطفال في تصميم أنشطة التوعية (مثل الحملات والمسرحيات) لضمان أن تعكس الرسائل واقعهم. كما تحرص هذه الجهات على الحفاظ على حلقات تغذية راجعة مستمرة، من خلال توضيح كيفية استخدام آرائهم (أو أسباب عدم إمكانية تنفيذ بعض المقترحات)، بما يساهم في بناء الثقة. وتستخدم آليات مثل جلسات الاستماع، ومجموعات النقاش البورية المنتظمة في المدارس والمراكز، والاستبيانات المبسطة لإدماج مدخلاتهم.

وأعرب الأطفال والشباب عن رغبتهم في مراكز تدريب تصمم أنشطة تركز على اكتساب المهارات، والتدريب في مجالات التجميل للعمل مستقبلاً، بالإضافة إلى المراكز الرياضية.

ومن المثير للاهتمام، أوضح مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أن منظمات المجتمع المحلي (CBOs) جاءت في المرتبة الثالثة ضمن الأماكن والسيارات التي يعتقدون أن الأطفال يشعرون فيها بالراحة الأكبر للتعبير عن أنفسهم، بعد المدارس والمنزل، كما هو موضح في الشكل 115.



الشكل 115: الأماكن والسيارات التي يشعر فيها الأطفال براحة أكبر للتعبير عن أنفسهم (الزرقاء)

6. البلقاء

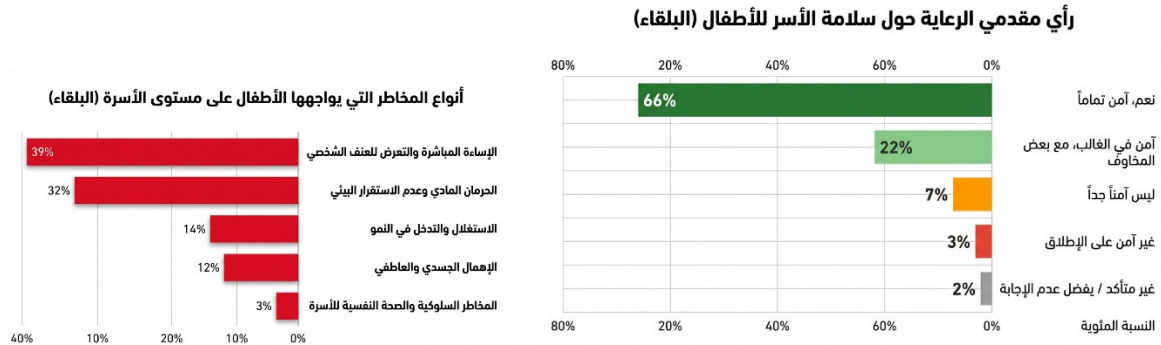
6.1 مخاطر حماية الطفل الرئيسية

6.1.1 المخاطر على مستوى الأسرة

اتسمت البيئة الأسرية بحالة من **التقلب العاطفي الشديد والمخاوف المعلنّة**. وأشار الأطفال والشباب إلى أنهم يتأثرون بشكل كبير **بالخلافات الأسرية** (لا سيما في الأسر متعددة الزوجات، حيث يُظهر الآباء غالباً تفضيلاً بين زوجاتهم)، الأمر الذي يثنيهم عن اللجوء إليهم بحثاً عن الدعم أو الراحة. كما أضافوا أن مقدمي الرعاية يمارسون **أساليب انضباط** قد تتصاعد أحياناً إلى **ممارسات قاسية ومسيئة**، مثل التوبيخ، والضرب، والإهمال، والحرمان (مثل مصادرة الهواتف أو حجب المصروف)، وأساليب العزل كمنعهم من الخروج مع الأصدقاء، بل وحتى **تقييدهم**.

ويؤكد ذلك أيضاً ما ورد في البيانات الكمية، حيث أفاد مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع بأن **الإيذاء المباشر والتعرض للعنف بين الأشخاص** يُعدّ عامل الخطر الأكثر انتشاراً، إذ يؤثر على **39%** من الأطفال. ومن اللافت أن مقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع يرون عموماً أن **المنزل بيئة آمنة بنسبة 88%**، كما هو موضح في الشكل 116.

وبعيداً عن الإيذاء المباشر، تمثل الحرمان المادي وعدم الاستقرار البيئي ثاني أعلى المخاطر المُبلغ عنها بنسبة 32%، وهو ما يدعم النتائج النوعية المتعلقة باستخدام مقدمي الرعاية لأساليب الحرمان، إلى جانب المخاطر الأخرى، كما هو موضح في الشكل 117.



الشكل 116: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة المنازل للأطفال (البقاء)

الشكل 117: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على مستوى الأسرة (البقاء)

6.1.2 المخاطر على مستوى المجتمع والمدرسة والأماكن العامة

أفاد الأطفال والشباب بشعورهم بعدم الأمان الشديد في المدارس، حيث يتعرضون للإيذاء اللفظي والجسدي من قبل المعلمين، مشيرين إلى أن بعض المعلمين يعتقدون أن الطلبة «يستحقون الضرب»، حتى عندما يكونون أبرياء، مما يجعلهم يشعرون بالتهميش وعدم الاحترام. كما أشاروا إلى أن بعض المعلمين يفرضون هزيمة غير عادلة من خلال المحاباة القائمة على التفوق الأكاديمي، حيث يتم التركيز على الطلبة المتفوقين وتجاهل أولئك الذين يعانون من ضعف التحصيل الدراسي. وتدعم البيانات الكمية هذه الروايات المتعلقة بالعنف بشكل واضح، حيث أشار مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع إلى أن العنف بين الأقران والعنف بين الأشخاص يُعد عامل الخطر الأكثر انتشاراً، إذ يؤثر على 46% من الأطفال، فيما يشكل ضعف البنية التحتية والمخاطر البيئية ثاني أعلى عامل خطر، مؤثراً على 34% من الأطفال، كما هو موضح في الشكل 119. ومماثلًا لما ورد في الكرك والزرقاء، أعربت الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بسلامة المدارس مع وجود بعض القلق بنسبة 46%، في حين أفاد 44% منهم بأن المدارس آمنة تماماً، كما هو موضح في الشكل 118 أدناه.



الشكل 118: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة المدارس للأطفال (البقاء)

الشكل 119: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في المدارس (البقاء)

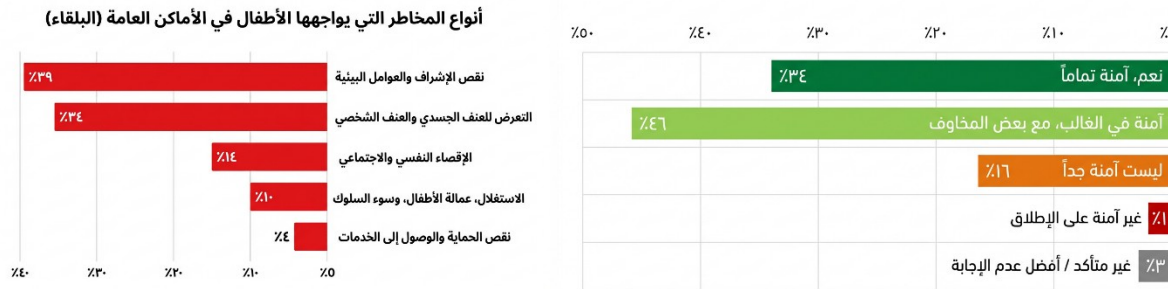
أشار القادة المجتمعيون ومقدمو الرعاية إلى أن الأماكن العامة تفتقر إلى معايير السلامة اللازمة للأطفال والشباب، بما في ذلك الملاعب والحدائق، وأن السلوكيات المنحرفة (مثل التدخين وتعاطي المخدرات) أصبحت أكثر انتشاراً في الأماكن التي يتجمعون فيها، لا سيما بين الأطفال والشباب المنخرطين في العمل القسري. وبناءً على ذلك، أوضح الأطفال والشباب أن الطرق العامة تشكل خطراً جسيماً، حيث يقود العديد من السائقين بهتور، وذكر أحد المشاركين قلقاً كبيراً مفاده أن «سائقي الحافلات أنفسهم يتعاطون المخدرات».

وإلى جانب المخاطر في الأماكن العامة، أشار القادة المجتمعيون إلى أنه في المنازل غير المحمية في البلقاء، يواجه الأطفال مخاطر ناتجة عن هندسة معمارية غير آمنة، ونقاط خطورة، ومخاطر بيئية.

وتؤكد البيانات الكمية هذه النتائج بشكل قوي، حيث حدد مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أن نقص الإشراف والمخاطر البيئية يشكلان عامل الخطر الأبرز، مؤثرين على 39% من الأطفال، يليهما عن كثب التعرض للعنف الجسدي والعنف بين الأشخاص بنسبة 34%، كما هو موضح في الشكل 121.

ومماثلًا لما ورد في الكرك، أعربت الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم بسلامة المدارس مع وجود بعض القلق بنسبة 46%، يليهم 43% ممن أفادوا بأن المدارس آمنة تمامًا، كما هو موضح في الشكل 120 أدناه.

رأي مقدمي الرعاية حول سلامة الأماكن العامة للأطفال (البلقاء)



الشكل 120: آراء أولياء الأمور حول سلامة الأماكن العامة للأطفال (البلقاء)

الشكل 121: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في الأماكن العامة (البلقاء)

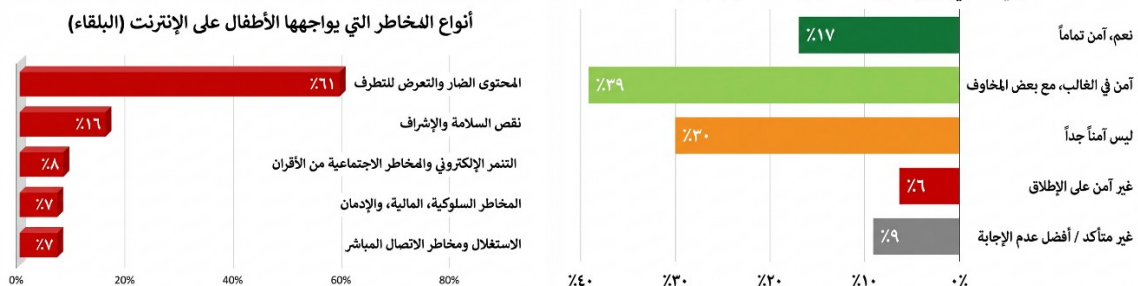
6.1.3 مخاطر الحماية على الإنترنت والأجهزة الرقمية

تم تصنيف الإنترنت والأجهزة الرقمية، إلى جانب الشوارع العامة، على أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والشباب، خاصة في غياب الإشراف الأسري. وربط كل من الشباب ومقدمي الرعاية المحتوى الضار على الإنترنت بتدهور السلوكيات، مع خوفهم من أن الألعاب العنيفة مثل PUBG، Squid Game، Blue Whale، وMariam قد تعيد برمجة عقل الأطفال وتتسبب بأضرار لا رجعة فيها، وتدفع الأطفال إلى «تقليد الأفعال التي يرونها بنفس الطريقة مع إخوتهم، دون معرفة الصواب من الخطأ». كما أشار القادة المجتمعيون إلى أن التعرض للمواقع الإباحية والفيديوهات القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا على السلوكيات والعقلية العامة.

وأضاف مقدمو الرعاية أن الأطفال والشباب يواجهون مخاطر رقمية أخرى مثل القرصنة والابتزاز (بما في ذلك تهديد الفتيات الصغيرات وابتزازهن باستخدام صورهن ورسائلهن). وكشفت إحدى المشاركات قصة مأساوية عن خداع على الإنترنت، حيث تم خداع صديقة ابنتها على إنستغرام، ما أدى إلى القتل.

وتدعم البيانات الكمية هذه النتائج بشكل قوي، حيث أفاد 30% من مقدمي الرعاية أن البيئة «ليست آمنة جدًا»، بينما صرح 39% بأنها «آمنة في الغالب، مع بعض المخاوف»، مما يعكس الخطر المعترف به سابقًا، كما هو موضح في الشكل 122. كما حدد المشاركون أن المحتوى الضار والتعرض للعنف هو عامل الخطر المهيمن على الأطفال على الإنترنت، إذ يؤثر على نسبة كبيرة تصل إلى 66%، متفوقًا بشكل كبير على جميع المخاطر الأخرى، وهو ما يعيد تأكيد النتائج السابقة التي أبلغ عنها الأطفال حول نوعية المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له، كما هو مبين في الشكل 123.

رأي مقدمي الرعاية حول سلامة الإنترنت للأطفال (البلقاء)



الشكل 122: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة الإنترنت للأطفال (البلقاء)

الشكل 123: أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت (البلقاء)

6.2 الصحة النفسية والاجتماعية وآليات التكيف

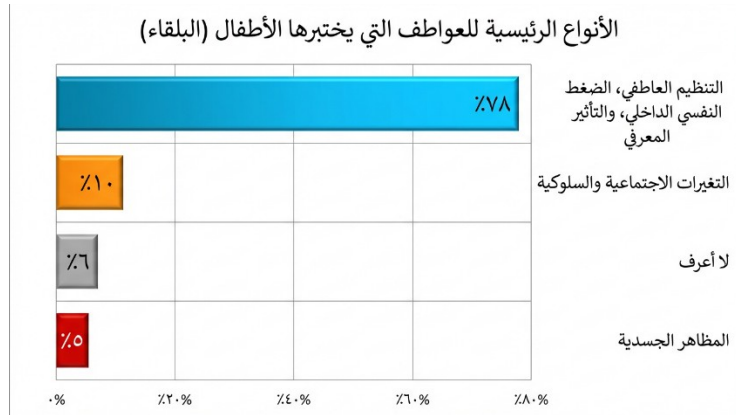
6.2.1 الضغوط النفسية والاجتماعية

ممثلاً لما لوحظ في مادبا والكرك، تم الإبلاغ عن أن الضغوط النفسية الأساسية التي أشار إليها المشاركون في اللقاء تشمل الضغط الأكاديمي، والصراعات الأسرية، والصعوبات المالية. وأفاد الشباب بأنهم يشعرون بالضغط والخوف، لا سيما بسبب امتحان التوجيهي. كما أشاروا إلى أن المشكلات المالية تؤدي إلى توتر الوالدين، وانخفاض التواصل العاطفي بين أفراد الأسرة، خصوصاً عندما يعمل كلا الوالدين ويقضيان ساعات طويلة خارج المنزل.

وتتضاعف الضغوط الوالدية عندما لا يستطيع مقدمو الرعاية تلبية مطالب أطفالهم، بما في ذلك الكماليات البسيطة مثل هدايا أعياد الميلاد. ومن اللافت أن جميع المشاركين من الشباب في اللقاء كانوا منخرطين في نوع من العمل، غالباً في المجال الزراعي، بالإضافة إلى المدرسة أو حتى بدلاً منها.

ولدى الشباب، تتفاقم هذه المشاعر بسبب توتر وجودي كبير يتعلق بمستقبلهم، إضافة إلى الإرهاق والضغط الناتج عن زيادة المسؤوليات المنزلية ورعاية الأسرة (لا سيما بالنسبة للفتيات). كما ذكر الأطفال أن مشاهدة العنف المنزلي ضد الأمهات، وخلافات الأسرة، والتعرض للتهجير والإبادة في غزة تعد جميعها مصادر للحزن والضييق النفسي.

ويؤكد ذلك أيضاً ما ورد في البيانات الكمية، حيث أوضح مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع أن الأطفال يواجهون صعوبة كبيرة في تنظيم المشاعر، والانزعاج النفسي، والتأثيرات المعرفية (وخاصة في الفئات التالية: الشعور بالقلق أو الخوف أو التوتر، الشعور بالحزن أو التعاسة لفترة طويلة، انخفاض تقدير الذات أو الشعور بعدم القيمة، والشعور بالخوف أو الانزعاج بسبب تجارب صعبة مرّوا بها)، بنسبة 78%، كما هو موضح في الشكل 124 أدناه.



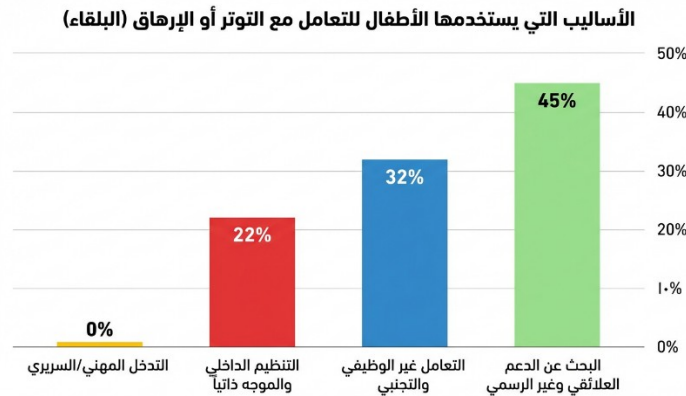
الشكل 124: الأنواع الرئيسية من المشاعر التي يختبرها الأطفال (اللقاء)

6.2.2 آليات التكيف

ممثلاً لما لوحظ في عمان والزرقاء، أظهر الأطفال والشباب في اللقاء عند مواجهة الضيق العاطفي توازناً بين الاتصال الاجتماعي والانشغال بالذات. كما تم الإبلاغ عن مزيج من أساليب التكيف الإيجابية والسلبية، مثل الذهاب في نزهة، ممارسة الرياضة، الرقص، اللعب مع الحيوانات الأليفة، القراءة، استخدام الهاتف، العزلة الذاتية، النوم، الإفراط أو الامتناع عن الطعام، أو تجنب الآخرين عند الانزعاج.

ومماثلًا لمادبا، يدعم مقدمو الرعاية الذين شملهم الاستطلاع جزئياً هذا المزيج من استراتيجيات التكيف، حيث أفاد 77% منهم بملاحظة أن أطفالهم يستخدمون أساليب تكيف إيجابية (طلب الدعم العائلي وغير الرسمي، والتنظيم الذاتي الداخلي)، كما هو موضح في الشكل 125، وإن كانت هذه الأساليب غير رسمية. بينما أشار 22% إلى استخدام أطفالهم أساليب تكيف مختلفة أو تجنبية.

ومماثلًا لما لوحظ في الزرقاء والكرك، لم يبلغ أي من المشاركين أن أطفالهم سعوا يومًا للحصول على تدخل مهني متخصص.



الشكل 125: الأساليب التي يستخدمها الأطفال للتعامل مع التوتر أو الإرهاق (البقاء)

لاحظ مقدمو الرعاية أنهم يتعاملون مع الضيق العاطفي لأطفالهم بمزيج من الاستجابات التعاطفية والعقابية. وتشمل الأساليب الإيجابية الاستماع الفعال، تحديد السبب الجذري للضيق، تقديم الدفء العاطفي، ومحاولة تلبية مطالب الأطفال لجعلهم يشعرون بالتقدير. كما أشار مقدمو الرعاية إلى أنهم يؤمنون أيضًا بالتواصل الصادق، بما في ذلك شرح القيود المالية لمساعدة الأطفال على قبول واقع الأسرة. ومن اللافت أن الأطفال والشباب أشاروا إلى أن ثقتهم بمقدمي الرعاية غالبًا ما تكون مشروطة، خوفًا من أن يؤدي مشاركة بعض المشاكل معهم إلى تفاقمها.

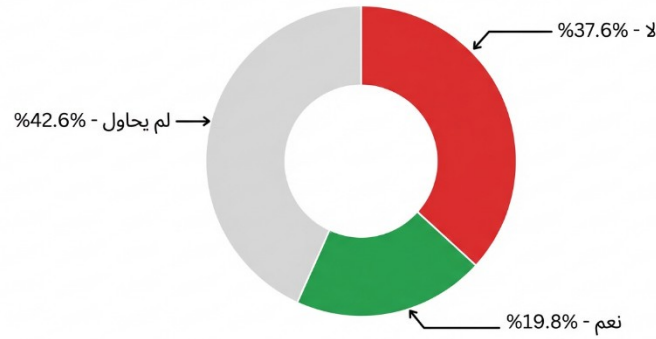
تركزت الأساليب العقابية بشكل أساسي على الانضباط، كما لوحظ في مجموعات النقاش المركزة، حيث أشار بعض مقدمي الرعاية إلى معارضتهم الشديدة للإيذاء الجسدي وأولوية النقاش والحوار، بينما اعترف آخرون بالجوء أحيانًا إلى العقاب الجسدي. كما ذكر المشاركون استخدام المكافآت والحوافز، مثل إعداد الأطعمة المفضلة للأطفال، لتحفيزهم أو السيطرة عليهم.

ومماثلًا لمادبا والكرك والزرقاء، أدرك مقدمو الرعاية أن الأدوار الجندرية تؤثر على التعبير العاطفي. ومع ذلك، أضافوا تفصيلًا بأن الفتيات أكثر هشاشة عاطفيًا بسبب القيود على الحركة، بينما قد يلجأ الأولاد إلى "الصحبة السيئة" كوسيلة لتفريغ الإحباط.

وتوفر البيانات الكمية رؤى مثيرة للاهتمام تدعم ذلك، حيث أظهر أن نحو نصف مقدمي الرعاية المستطلعين (42%)، مماثلًا للكرّك، لم يسع أبدًا لطلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأطفالهم، ومن بين الذين سعوا لذلك، واجه عدد ملحوظ صعوبات في الوصول إلى هذه الخدمات (20%)، كما هو موضح في الشكل 126. وتشمل هذه الصعوبات نقص المعلومات حول الخدمات المتاحة، وبعد المواقع أو تكلفتها، أو عدم ملائمتها للأطفال ذوي الإعاقات.

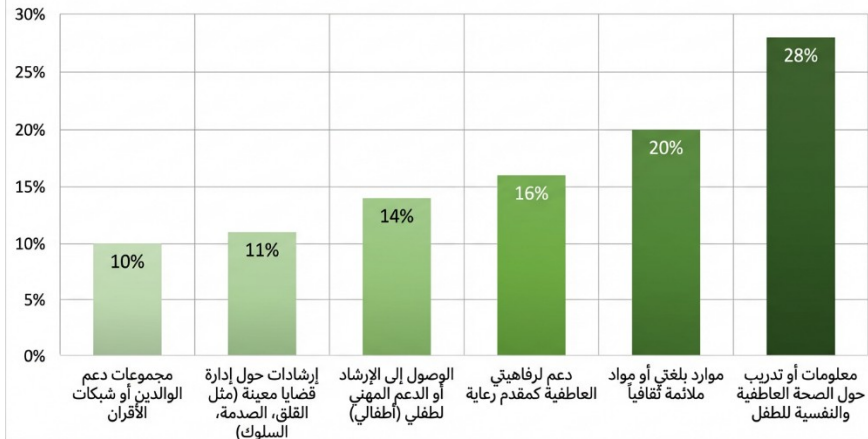
كما أكد غالبية مقدمي الرعاية الحاجة إلى معلومات أو تدريب حول الصحة العاطفية والنفسية للأطفال بنسبة 27%، بالإضافة إلى الموارد بلغتهم أو مواد مناسبة ثقافيًا لدعم الصحة النفسية بنسبة 20%، بدلاً من مجرد الوصول إلى التدخلات المهنية، كما هو موضح في الشكل 127.

هل واجه مقدمو الرعاية تحديات عند محاولة الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأطفالهم؟ (البقاء)



الشكل 126: تجربة مقدمي الرعاية في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال (البقاء)

نوع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم الدعم النفسي لأطفالهم (البقاء)



الشكل 127: أنواع الموارد التي يحتاجها مقدمو الرعاية لتقديم الدعم النفسي للأطفال (البقاء)

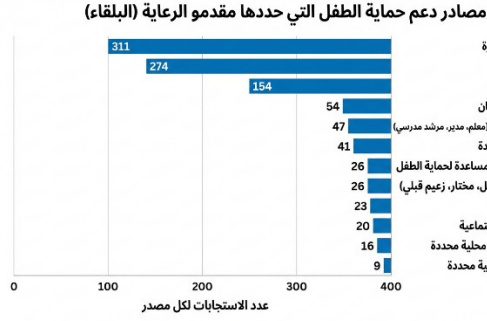
6.3 الاستجابة المؤسسية والعوائق أمام الإبلاغ

6.3.1 القنوات القائمة للإبلاغ

أظهرت البيانات أن شبكة الحماية في البلقاء تعتمد بشكل كبير على الشخصيات المجتمعية التقليدية وغير الرسمية نظراً لغياب نظام منظم. وذكر القادة المجتمعيون القنوات الرسمية مثل دائرة حماية الأسرة، الشرطة، والمديرية العامة للأمن العام، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل منظمة Terre des Hommes وجمعية شباب الوادي، التي تقدم أنشطة توعوية وترفيهية.

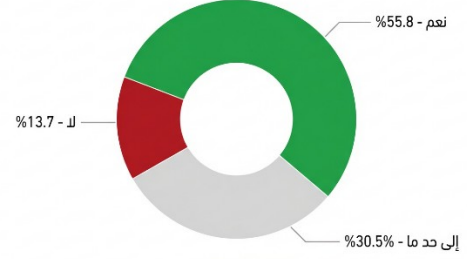
وعلى الصعيد غير الرسمي، أشار الأطفال والشباب إلى أن العائلة المباشرة، بما في ذلك الأم، الأب، العم، العمة، والجدة، تعتبر مصدراً رئيسياً للثقة واللجوء عند الحاجة. كما أشار المشاركون إلى الدور المهم للوساطة المجتمعية، حيث يلجأ الأفراد إلى الأقارب، الشيوخ، مدير المدرسة، أو القائد المجتمعي للتوسط وإحقاق السلام، لا سيما في القضايا المدرسية، وعند الخطر يعتمدون على الشرطة أو طلب الدعم من الجيران. وأفاد الأطفال والشباب بأنهم يجدون الراحة في الحقائق، وأماكن التسلية، والجمعيات للحديث والتفريغ النفسي والطاقة.

أما بالنسبة لمقدمي الرعاية الذين شملهم الاستطلاع، فقد أكد نصفهم تقريباً (56%) معرفتهم بالموارد التي يمكنهم من خلالها طلب خدمات حماية الطفل. وبخصوص قنوات الإبلاغ، فإن أعلى ثلاث نقاط اتصال أولية لديهم تمثل مزيجاً من القنوات الرسمية وغير الرسمية، كما هو موضح في الشكلين 128 و 129 أدناه.



الشكل 128: مصادر دعم حماية الأطفال (البقاء)

هل مقدمو الرعاية على دراية بأين يبحثون عن خدمات حماية الطفل لأطفالهم؟ (البقاء)



الشكل 128: وعي مقدمي الرعاية بالخدمات المتاحة لحماية الأطفال (البقاء)

6.3.2 الفجوات في القدرات المؤسسية والتنسيق والاستجابة

أشار القادة المجتمعيون إلى أن الإطار المؤسسي في البقاء يعاني من نقص كبير، حيث لا يوجد نظام حماية منظم وحقوقي للأطفال بسبب غياب الجهود المتسقة والمنظمة من الجهات الرسمية أو المجتمعية. وأوضحوا أن الدعم المباشر للأطفال من الجهات الرسمية نادر إلا إذا تدخل مقدمو الرعاية، وأن قضايا الحماية تُعالج تقريباً حصرياً عبر دائرة حماية الأسرة، وعند الإبلاغ عن أي حالة، يكون الاستجابة بطيئة، وأحياناً تستغرق وقتاً قبل تقديم شكوى رسمية.

وفي ملاحظة مثيرة للقلق، أشار المشاركون إلى أن الأفراد الضعفاء الذين يلجأون إلى دائرة حماية الأسرة يُعتقد أنهم نادراً ما يحصلون على مساعدة فعالة، وأن الإبلاغ عن القضايا الخطيرة قد يزيد الوضع سوءاً في بعض الأحيان. كما أشاروا إلى الحاجة إلى متخصصين مخصصين لتقديم التدريب والتوعية، نظراً لوجود مستويات منخفضة من الفهم لدى الأطفال حول مخاطر الحماية.

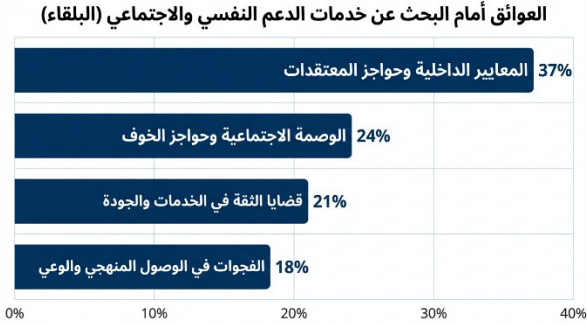
6.3.3 العوائق الاجتماعية والثقافية أمام طلب الدعم

مماثلًا لما لوحظ في مادبا، أوضح القادة المجتمعيون أن الوصمة الاجتماعية ونقص الثقة في السرية تمثلان العوائق الرئيسية للإبلاغ عن القضايا التي تواجه الأطفال والشباب. وأفاد مقدمو الرعاية بأن العائلات، خصوصاً المحافظة منها، تقلل من شأن المشكلات وتبقى صامتة لتجنب النزاع أو النميمة أو الفضيحة أو الإضرار بسمعة الأسرة والمجتمع، كما ذكر أن الأمهات غالباً ما يلتزم الصمت إذا تعرض طفلهم للتحرش أو الإساءة.

وأضافوا أن هناك خوفاً من الانتقام أو التهديدات (مثل الضرر بالملكات أو المضايقات) من الأفراد العنيفين أو الجناة، الذين قد يستخدمون المال لإسكات الضحايا، مشيرين إلى أن المبلغين لا يحصلون على حماية. كما أضافوا أن أعضاء المجتمع يخشون الحكم عليهم أو وسهمهم بـ"الجنون" عند زيارة طبيب نفسي.

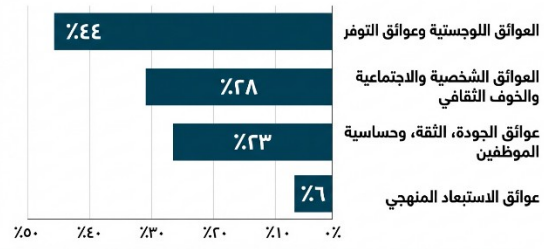
وقد أكدت هذه النتائج أيضاً استطلاعات مقدمي الرعاية، حيث أشاروا إلى أن المعايير الداخلية والمعتقدات تمثل أحد أهم العوائق أمام طلب الخدمات الرسمية بنسبة 37%. ومع ذلك، أضافوا أن المشكلات اللوجستية وتوافر الخدمات (44%) تُعد أيضاً من العوائق الرئيسية لطلب هذه الخدمات، كما هو موضح في الشكلين 130 و 131.

الشكل 131: العوائق أمام طلب خدمات الحماية (البقاء)



الشكل 130: العوائق أمام طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال (البقاء)

العوائق أمام البحث عن خدمات الحماية (البقاء)

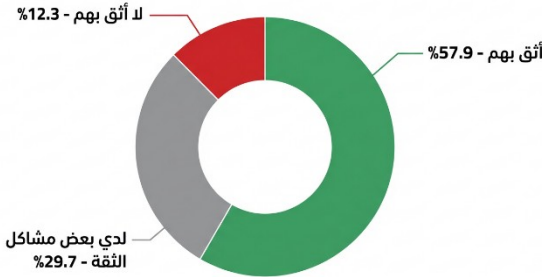


الشكل 131: العوائق أمام طلب خدمات الحماية (البقاء)

أما بالنسبة للإبلاغ الرسمي، فأشار المشاركون إلى أن الإبلاغ يُنظر إليه على أنه مرهق، حيث يتضمن استجابات طويلة، مما يدفع الناس إلى تجنبه بسبب مشاعر الخجل ونقص الثقة في الجهات التي يطلبون المساعدة منها.

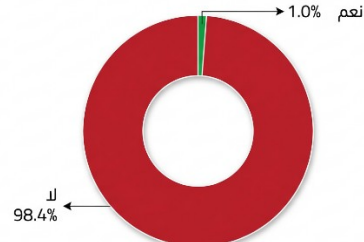
ومن المثير للاهتمام أن البيانات الكمية أكدت ذلك، حيث أكد ما يقرب من جميع مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع (99%) أنهم لم يطلبوا خدمات حماية الطفل من القنوات الرسمية أبدًا. ومع ذلك، أظهرت البيانات أيضًا تناقضًا جزئيًا، حيث عبّر نصف مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم في نظام الحماية الرسمي (58%)، بينما انقسم الباقون بين وجود بعض المشكلات في الثقة (30%) وعدم الثقة مطلقًا (12%)، كما هو موضح في الشكلين 132 و 133.

ما مدى ثقة مقدمي الرعاية في نظام الحماية الرسمي؟ (البقاء)



الشكل 133: مستوى ثقة مقدمي الرعاية في نظام الحماية الرسمي (البقاء)

هل سبق لمقدمي الرعاية البحث عن خدمات حماية الطفل من مصادر معروفة؟ (البقاء)



الشكل 132: محاولات مقدمي الرعاية للحصول على خدمات حماية الطفل (البقاء)

6.4 مشاركة الأطفال والشباب

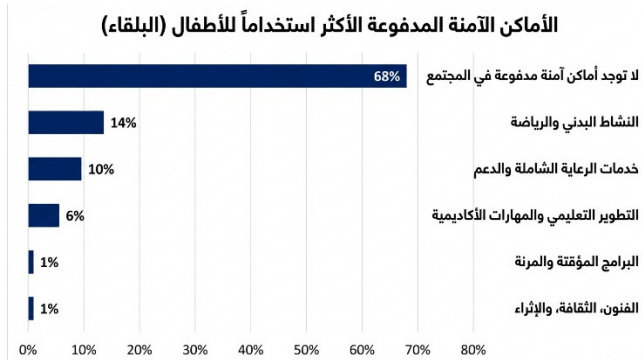
6.4.1 قنوات وسياقات التعبير والتأثير

أشار الأطفال والشباب في البقاء إلى أن التعبير عن آرائهم يعتمد بشكل كبير على مدى قرب العلاقة مع الشخص المعني، مع ذكر مثال العلاقة القريبة بين الأم وابنتها. ومع ذلك، أشار بعض المشاركين إلى أنهم لا يتحدثون مع مقدم الرعاية أو يعبرون عن مشاعرهم.

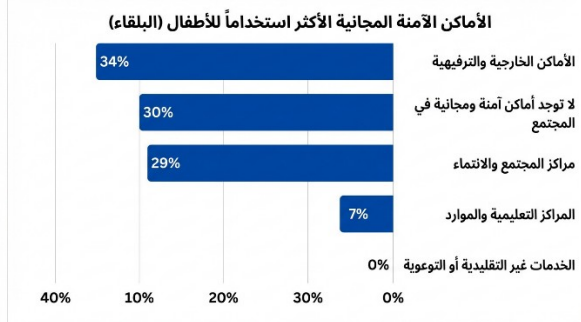
وفي السياقات الجماعية، يشاركون في أنشطة الصف، توزيع الأدوار، أو اقتراح أفكار لمشاريع مدرسية، مثل طلب بناء حديقة، ملعب، أو تركيب مراوح لفصل الصيف، والتي تم تنفيذ بعضها أحيانًا.

أما بالنسبة للأماكن والأنشطة المخصصة للأطفال في المحافظات، أظهر الاستطلاع أن المساحات الخارجية والترفيهية (34%) ، والتي تشمل الحدائق العامة أو المساحات الخضراء، الملاعب العامة، وميادين كرة القدم، هي الأكثر استخدامًا مجانيًا، على الرغم من أن نسبة معتبرة أفادت بعدم وجود مساحات آمنة مجانية للأطفال في المجتمع. (30%)

وبالنسبة للمساحات والأنشطة المدفوعة، أفاد المشاركون بأنها شحيحة إلى حد كبير بنسبة 63%، بينما كانت الأنشطة البدنية والرياضة هي ثاني أكثر الأنشطة استخدامًا بنسبة منخفضة جدًا تصل إلى 14%، كما هو موضح في الشكلين 134 و 135 أدناه.



الشكل 135: أكثر الأماكن المدفوعة استخداماً للأطفال (البقاء)



الشكل 134: أكثر الأماكن المفتوحة استخداماً للأطفال (البقاء)

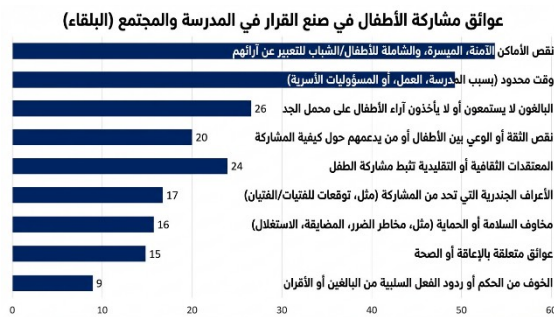
6.4.2 العوائق أمام المشاركة الفاعلة

تشمل العوائق الرئيسية التي تمنع الأطفال والشباب من التعبير عن آرائهم في الأماكن الخاصة والعامة نقص موافقة الوالدين/الخوف من رد فعلهم، بالإضافة إلى غياب المساحات والأنشطة المناسبة أو عدم دعوتهم إليها.

أفاد الأطفال والشباب بأن مقدمي الرعاية أحيانًا ينزعجون عندما يتدخل الأطفال بسبب اعتقادهم بنقص الخبرة الحياتية لديهم، وفي بعض الأمور يُوبَّخون إذا تحدثوا، مما حد من ثقّتهم. وبالنظر إلى غياب المساحات والأنشطة، أشار المشاركون إلى أنهم يظلون نشطين للغاية وينتقدون مبادراتهم الخاصة، مثل إنتاج فيلم قصير بعنوان "دير علا"، حيث تعلموا فيه مهارات صناعة الأفلام والتوعية.

وقد أكدت البيانات الكمية ذلك أيضًا، حيث أوضح مقدمو الرعاية المشاركون في الاستطلاع أن أكبر العوائق أمام مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار في المدرسة والمجتمع هي غياب المساحات الآمنة والميسرة للتعبير عن آرائهم، يليها قلة الوقت بسبب المدرسة أو العمل أو المسؤوليات الأسرية، كما هو موضح في الشكل 137.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 33% من مقدمي الرعاية أن الأطفال في محافظتهم لديهم فرص واهتمام بالمشاركة في اتخاذ القرار في المدرسة والمجتمع، بينما أعرب نصفهم تقريبًا عن أن الأطفال قد يكون لديهم اهتمام بالمشاركة أحيانًا فقط، كما هو موضح في الشكل 136.



هل لدى الأطفال فرص أو اهتمام بالمشاركة في صنع القرار في المدرسة والمجتمع؟ (البقاء)



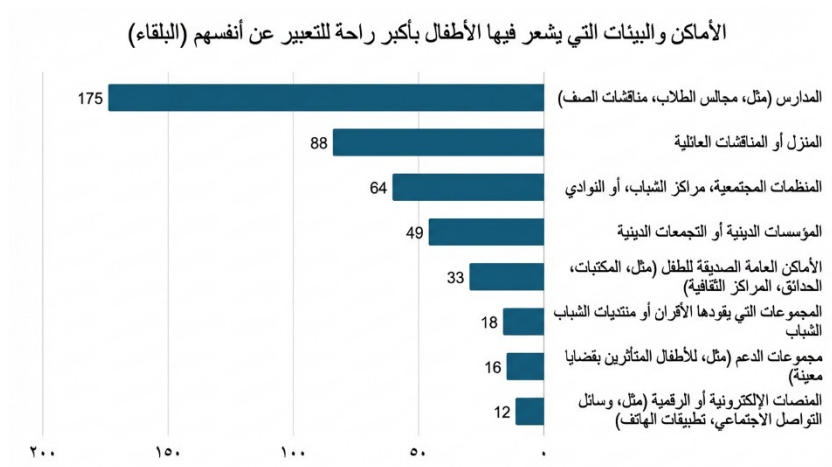
الشكل 136 (يسار): فرص الأطفال واهتمامهم بالمشاركة في اتخاذ القرار في المدارس والمجتمع (البقاء)
 الشكل 137 (يمين): العوائق أمام مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار في المدارس والمجتمع (البقاء)

6.4.3 الدعم المؤسسي والمشاركة المرغوبة

على الرغم من محدوديتها، أشار المشاركون إلى أن بعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تنظم أنشطة مثل الحياكة، جلسات المهارات الحياتية، والأنشطة التوعوية، وأحياناً تتيج للأطفال المشاركة في تنظيم الفعاليات، مما يجعلهم يشعرون وكأنهم "قادة المجتمع".

أعرب الشباب عن رغبتهم في مجموعة أوسع من الأنشطة، بما في ذلك فن الراتنج، الاستقلال المالي وإنشاء المشاريع، ورش عمل تعليمية ولغوية (الإنجليزية)، الدفاع عن النفس، تدريب على التواصل باحترام، كمال الأجسام، برامج اللياقة البدنية، وبرامج المهارات الرقمية (الذكاء الاصطناعي أو البرمجة). كما طالبوا بوجود حدائق عامة وملاعب أحياء، مشيرين إلى أن ميادين المدارس محدودة الاستخدام.

ومن المثير للاهتمام أن مقدمي الرعاية المشاركين في الاستطلاع أوضحوا أن الجمعيات والمنظمات المجتمعية تحتل المرتبة الثالثة بين الأماكن والبيئات التي يعتقدون أن الأطفال يشعرون فيها بالراحة عند التعبير عن أنفسهم، بعد المدارس والمنزل، كما هو موضح في الشكل 138.



الشكل 138: الأماكن والبيئات التي يشعر فيها الأطفال بالراحة الأكبر للتعبير عن أنفسهم (البقاء)

7. الأطفال ونظام العدالة

تم تنظيم التحليل أدناه بشكل منفصل نظراً لتجانس معظم النتائج عبر المحافظات المستهدفة، ومقسّم إلى ثلاثة محاور رئيسية : مسارات التعامل، التفاعل مع النظام الرسمي، التأهيل/إعادة الإدماج، كما هو موضح أدناه. وفي الحالات التي كانت فيها نتائج فريدة مرتبطة بمحافظة معينة، فقد تم الإشارة إليها بشكل خاص في النص.

أما بالنسبة للنتائج النوعية، فقد كان هناك 20 مشاركاً فقط (الكرك: 4، إربد: 1، الزرقاء: 5، مادبا: 3، البلقاء: 2، عمان: 5) أكدوا أن طفلاً واحداً على الأقل كان سابقاً في نزاع مع القانون أو مرتبطاً بنظام العدالة (مثل الشرطة، المحاكم، أو الاحتجاز)، وتم دمج رؤى إجاباتهم في النص.

7.1 عوامل المخاطر والوساطة قبل المحاكمة

يكشف تحليل عوامل المخاطر أن المشاكل القانونية للأطفال نادراً ما تكون محدودة على أفعال فردية، بل تتجذر بعمق في الهشاشة الهيكلية وعدم استقرار الأسرة عبر جميع المحافظات.

- الفقر عامل جوهري، حيث يدفع الأطفال إلى مواقف خطيرة مثل التسول، السرقة، الشجارات في الشوارع، وعمل الأطفال، مما يعرضهم للاستغلال أو خرق القانون.
- عوامل أخرى تشمل تفكك الأسرة أو المشكلات المنزلية التي تؤدي إلى عدم استقرار نفسي وعاطفي، غياب الوثائق الرسمية مثل عدم وجود بطاقة هوية، مما يزيد من تعرضهم للاحتجاز أو الاستغلال، وانعدام السكن/اللاجئين بلا جنسية، الذي يزيد من احتمالية التعامل مع الشرطة.
- أشار قادة المجتمع في الكرك ومادبا إلى أن بعض المخالفات قد تكون صغيرة جداً، مثل الشجار في المدرسة أو رمي حجر.

عبر جميع المحافظات، أشار الأطفال إلى أن أسرهم ومجتمعهم يلجأ دائماً إلى الوساطة المجتمعية غير الرسمية قبل التوجه إلى النظام القضائي الرسمي للحصول على حل سريع وسري. وتتم هذه الممارسة عبر تسلسل هرمي من الشخصيات غير الرسمية: رئيس الأسرة، مقدم الرعاية، الإخوة أو الأعمام، شيوخ الأسرة، قادة القبائل/الوسطاء المعروفون، وأعضاء البرلمان. وفي الزرقاء، كانت المناقشات بين العائلتين تعتبر الخطوة الأولى نحو الحل.

فعالية هذه الممارسات المجتمعية وُصفت بأنها "متفاوتة للغاية"، فهي فعالة جداً في الحالات المناسبة، مثل تلك التي تتطلب الحماية والرعاية، لأنها تضمن سلامة الطفل وقبوله داخل الأسرة. ومع ذلك، فإن فعاليتها محدودة في الجرائم الجسيمة التي تتطلب مقاضاة رسمية. في عمان، أحياناً قد تؤدي الوساطة المجتمعية إلى ممارسات سلبية مثل التنازل عن الحقوق القانونية، الابتزاز المالي، أو اللجوء إلى "البلطجية". وأوضح قادة المجتمع في الزرقاء أن هذه الأساليب لا تلبي التوقعات بالكامل.

7.2 التفاعل مع النظام الرسمي

يتميز تفاعل الأطفال مع النظام القضائي الرسمي بـ أعباء إدارية كبيرة وعدم اتساق في الإجراءات، على الرغم من وجود تشريعات تبدو حماية.

- بعض قادة المجتمع أشادوا بـ قانون الأحداث ووصفوه بأنه "ممتاز"، لكن التحديات الإدارية مثل البيروقراطية شائعة.
- تشمل التحديات القانونية ضعف إنفاذ القانون والتلاعب النظامي، مثل ممارسة الأطفال لأدوار محاكمة بدلاً من الجناة الكبار لتخفيف العقوبة.

أشار القادة أيضاً إلى نقص الخدمات الواضحة للأطفال (مثل الدعم النفسي، الاستشارات القانونية المتخصصة)، وأفادت بعض الأسر في الزرقاء بخوفها من التعامل مع الجهات الرسمية، إضافة إلى القدرات المحدودة لمراكز الرعاية. كما أشاروا إلى أن

القيود الأمنية ونقص التخطيط التاريخي سببت مشاكل، على سبيل المثال، توقف الرحلات وتصاريح التعليم للأطفال في مراكز الأحداث بعد عام 2012، مما دفع بعضهم لترك المركز وعدم العودة، معرضين أنفسهم للخطر.

أما تجارب الأطفال خلال الإجراءات الرسمية، فقد وصفوها بالخوف وعدم الوضوح. وأوضحوا أن التحقيق كان أصعب وأشد جزء مربك، مما سبب خوفًا شديدًا من السجن.

- في عمان وإربد، أفاد الأطفال والشباب أن حقوقهم لم تُشرح لهم في العملية القانونية الأولية.
- أما في الزرقاء، فقد أوضح ضابط المراقبة كل شيء قبل الانضمام للبرنامج، بما في ذلك المكان والسبب.
- وأخيرًا، آراء المشاركين حول عدالة النظام القضائي كانت متباينة؛ بعضهم شعروا بأنهم عوملوا بإنصاف، بينما أشار آخرون إلى أن النظام يحتاج إلى تحسين.

7.3 التأييد

أفاد الأطفال والشباب في جميع المحافظات بفوائد كبيرة من برامج A2D:

- تحسين السلوك: التوقف عن الشجارات (بتعلم ضبط النفس مثل العد حتى عشرة)، إدارة الوقت للدراسة، وتنظيم الحركة (طلب إذن قبل الخروج).
- أحد الشباب في عمان شعر بتحسن، وبدأ قراءة القرآن والصلاة.
- لاحظ أن فقط 2 من أصل 20 مشاركًا أبلغوا عن حصول أطفالهم على دعم بعد التعامل مع النظام القضائي، أحدهم يشمل دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للطفل، والآخر لعائلة الطفل.
- عاطفيًا، أشاروا إلى أن البرامج زرعت شعورًا بالمستقبل والأمل، مما منع شعورهم الوجودي بأن حياتهم انتهت.
- كما أشاروا إلى الالتقاء بأشخاص جدد، تطوير أفكار جديدة، وشعور باللطف والاحترام والدعم من المعلمين والموظفين.
- الدوافع الرئيسية للمشاركة: البرنامج كان "أفضل من السجن"، سهل، ممتع، والمعلم أو القاضي كان يعلم أنهم يستحقون الانضمام.

7.4 إعادة الإدماج وانطباع المجتمع

- رد فعل المجتمع كان أبرز عائق أمام إعادة الإدماج الناجحة.
- أضاف قادة المجتمع أن الأسر تصاب بالصدمة أو الخجل عند احتجاز الطفل أو اتهامه، والمجتمع يتأرجح بين التعاطف والوصمة القاسية.
- أمثلة: الجرائم مثل السرقة تحمل وصمة كبيرة؛ الناس يحذرون الآخرين من الاقتراب من الطفل.
- في الزرقاء، قد ينكر الآباء أطفالهم، وأشار الشباب إلى أن الأم تلومهم، ما يسبب شعورًا بالذنب.

- في إربد، لاحظ الشباب أن مقدمي الرعاية لا يزالون يحملون أفكارًا تقليدية وأن المجتمع متأثر سلبًا بوسائل التواصل الاجتماعي.
- عمومًا، معظم المستجيبين النوعيين أشاروا إلى تعرض أطفالهم لمعاملة غير عادلة في المجتمع.
- إعادة الإدماج في المدرسة غالبًا ما تكون صعبة، وتتطلب نقل المدارس أو تدخل مدير التعليم إذا رفضت المدرسة القديمة إعادة التسجيل، ويُعتبر دعم الوالدين ضروريًا لضمان سلامة الطفل.
- أضاف المشاركون الكميون (مقدمو الرعاية) أنهم واجهوا تحديات متعددة بعد التعامل مع النظام القضائي، أبرزها: الوصمة والتمييز في المجتمع والمدارس، ونقص الوصول إلى خدمات الدعم المناسبة.
- كما عانوا من ضغوط نفسية وصعوبات في الاستمرار في التعليم أو العمل، بينما أبلغ البعض عن ظروف احتجاز غير آمنة أو غير مناسبة.
- فرص إعادة الإدماج المحدودة، إلى جانب غياب الدعم المخصص للأطفال ذوي الإعاقة، زادت من ضعفهم الاجتماعي والعاطفي.
- تحديات إضافية: تفاعلات سلبية مع السلطات، أعباء مالية مرتبطة بالإجراءات القانونية، ونزاعات أو انفصال عن مقدمي الرعاية.

8. ملفات الهشاشة والمخاطر المرتبطة بالنوع الاجتماعي

تم تنظيم التحليل أدناه أيضًا بشكل منفصل بسبب تجانس النتائج عبر المحافظات، ومقسّم إلى ثلاث مجموعات رئيسية من الأطفال الأكثر هشاشة:

1. الأطفال ذوي الإعاقة
2. الفتيات الصغيرات
3. الأطفال اللاجئين والفقراء

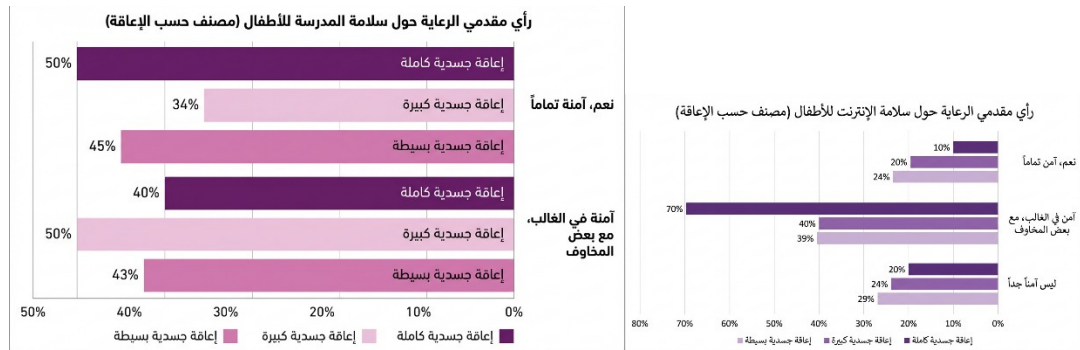
8.1 الأطفال ذوو الإعاقة

- عبر جميع المحافظات، تم تحديد الأطفال ذوي الإعاقة كأكثر الفئات عرضة للهشاشة.
- في عمان، أشار مقدمو الرعاية إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة غالبًا ما يكونون "هدفًا للسخرية".
- في الكرك، ذكرت أم أن ابنتها المصابة بحالة طبية تعرضت للتنمر المستمر من أقرانها.
- بشكل عام، لاحظ مقدمو الرعاية أن بعض الأطفال يعانون من الإحراج بسبب وصمة المجتمع، وصعوبات مالية لتلبية احتياجاتهم.

التحديات التي تواجههم تشمل:

- التعرض الأكبر للإهمال وعدم تلبية احتياجاتهم.
- صعوبة أكبر في الوصول إلى خدمات الحماية.

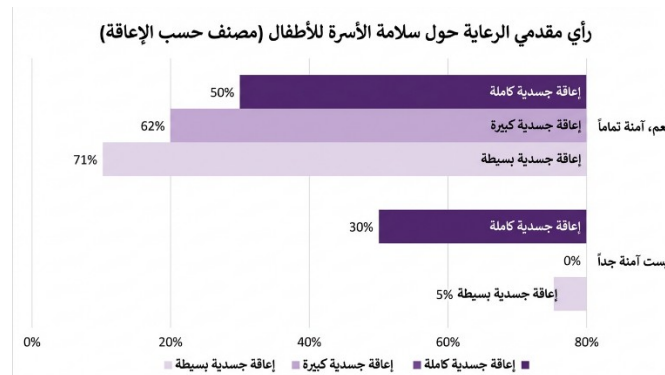
- نقص التدريب لدى المعلمين لدعمهم، وعدم جاهزية المدارس لتلبية احتياجاتهم.
- أظهرت النتائج النوعية أن الأطفال ذوي الإعاقة الجسدية يواجهون مخاطر في بيئات مختلفة:
 - في المدارس: هناك انقسام متقارب بين من يرون البيئة آمنة ومن يرون وجود بعض المخاوف، مع ارتفاع المخاوف حتى 40% بين من يعانون من إعاقة جسدية شديدة -الشكل (140)
 - على مستوى الأسرة: أشار 30% من مقدمي الرعاية إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة يشعرون بعدم الأمان -الشكل 141
 - على الإنترنت: وُجد أنه أكثر الأماكن خطورة، حيث أشار 70% من مقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة إلى القلق، بينما أشار 19% إلى أنه غير آمن تماماً -الشكل 139.



الشكل 140: رأي مقدمي الرعاية حول أمان المدارس للأطفال

الشكل 139: رأي مقدمي الرعاية حول أمان الإنترنت للأطفال

(مفصل حسب الإعاقة)

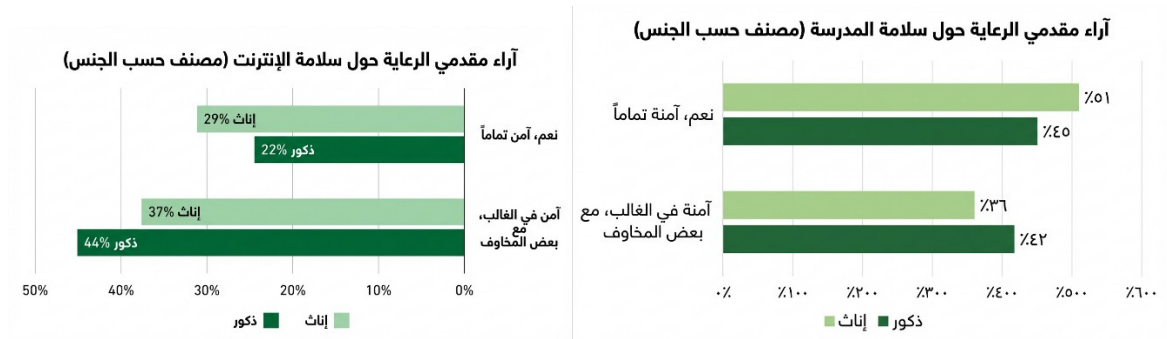


الشكل 141: رأي مقدمي الرعاية حول أمان المنزل للأطفال (مفصل حسب الإعاقة)

8.2 الفتيات الصغيرات

برزت ظاهرة الزواج المبكر في عدة محافظات كقضية واسعة الانتشار، تؤثر بشكل خاص على الفتيات الصغيرات.

- في عمان، أفاد الأطفال والشباب أن أقرانهم يتزوجون أو يخطبون في سن صغيرة جدًا؛ فقد تزوجت فتاة في سن 13 عامًا، وخطبت أخرى في سن 14 عامًا عندما خاف ولي أمرها من تمردها.
 - في إربد، أشار المشاركون إلى وجود أقارب تزوجوا في سن المراهقة (أخت في 16 عامًا، وعمة وابنة عم في 17 عامًا).
 - في مادبا، عرف العديد من الشباب أصدقاء أو أقارب تزوجوا في سن 13، بينما تزوج آخرون بين 14 و17 عامًا.
 - في الزرقاء، أكد المشاركون وجود الظاهرة أيضًا، مشيرين إلى أصدقاء تزوجوا في سن 14-15 عامًا.
- بالإضافة لذلك، تم وصف التحرش بالأطفال والشباب، وخاصة الفتيات، بأنه منتشر في جميع المحافظات.
- في عمان، أشار الأطفال والشباب إلى أن التحرش يحدث بشكل متكرر، "عادة في الشارع"، مع ذكر أمثلة مثل تعرض صديقة للمضايقة من قبل أشخاص في الشوارع.
 - في إربد، ذكرت الفتيات الصغيرات تعرضهن للتحرش المستمر في الشوارع والأسواق، غالبًا مع لوم الضحية (مثل التعليقات حول ملابس الفتيات).
 - في مادبا، شدد المشاركون على انتشار التحرش بشكل كبير، مع أمثلة مثيرة للقلق (محاولة خطف، متابعة الفتيات بالسيارة، التصوير/الابتزاز). وأوضحوا أن التحرش يحدث في الشوارع، بعد المدرسة، وحتى عبر الإنترنت، وأن العديد من الضحايا يظن صامتين بشأنه.
 - في الزرقاء، أفيد أن التحرش يحدث في مناطق معزولة وفي طريق المدرسة، حيث روت مشاركة أن نفس الشاب تابعها لمدة أسبوعين أثناء عودتها للمنزل حتى بدأت والدتها مرافقتها.
 - في البلقاء، أكد الشباب أن التحرش موجه بشكل روتيني للفتيات، وشرحوا أن معظم الفتيات يستجبن بالخوف أو الصمت، مما يؤدي إلى تقييد حركتهن وزيادة هشاشتهن العاطفية.
- ومن المثير للاهتمام، أظهرت البيانات الكمية أن مقدمي الرعاية من الذكور لديهم مستوى أعلى من الإدراك للمخاوف حول سلامة البيئة مثل المدارس أو الإنترنت مقارنة بالإناث (42% و44% على التوالي)، كما هو موضح في الشكلين 142 و143 أدناه.



الشكل 143: رأي مقدمي الرعاية حول أمان الإنترنت للأطفال

الشكل 142: رأي مقدمي الرعاية حول أمان المدارس للأطفال

(مفصل حسب الجنس)

8.3 الأطفال من ذوي وضع اللاجئين والمكافحة للفقر

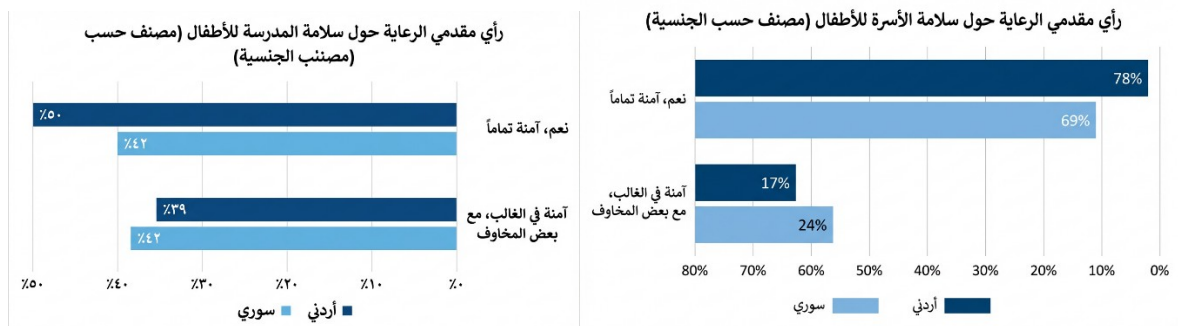
حدّد المشاركون بشكل متكرر الأطفال الذين يحملون وضع اللاجئين، وكذلك أولئك الذين تواجه أسرهم صعوبات مالية، باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر.

• في عمان، لاحظ مقدمو الرعاية أن الطفل "الذي لا يمتلك أوراقاً قانونية لا يُعامل بنفس الطريقة" مقارنة بأقرانه الذين يمتلكون المستندات.

• في إربد، أشار الخبراء إلى أن الأطفال اللاجئين وذوي وضع عديم الجنسية هم عرضة للخطر بشكل كبير، مؤكدين أن البرامج المتاحة لا تلبي احتياجاتهم بالكامل. وأوضحوا أن الأطفال من ذوي الإعاقة ضمن هذه المجموعات يواجهون مشكلات متفاقمة، حيث يكونون أكثر تعرضاً للفقر والمخاطر المرتبطة به.

• في الزرقاء، ذكر الخبراء أن الأطفال من أسر تعاني من الفقر، وأطفال الأوصياء المطلقين يفتقرون إلى الدعم ويواجهون صعوبات طويلة الأمد إذا لم تتمكن أسرهم من توفير احتياجاتهم.

وأكدت هذه النتائج أيضاً البيانات الكمية، حيث أظهر مقدمو الرعاية من السوريين قلقاً طفيفاً بشأن سلامة البيئات المنزلية والمدرسية، بنسبة 24% و 42% على التوالي، كما هو موضح في الأشكال 144 و 145.



الشكل 145: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة الأطفال في المدارس

الشكل 144: رأي مقدمي الرعاية حول سلامة الأطفال في المنزل

(مفصل حسب الجنسية)

9. الاستنتاجات

يوفر هذا القسم صورة شاملة تجمع جميع النتائج السابقة عبر مختلف المحاور، موضحًا الاتجاهات الأساسية والعابرة للمواضيع التي تحدد حالة حماية الطفل في المحافظات المستهدفة.

1. البيئة المنزلية

عبر جميع المحافظات الست، ظهر المنزل كمساحة مزدوجة الطابع: مليئة بالمخاطر وفي الوقت نفسه تُعد أمانة بحسب تصور مقدمي الرعاية. تظهر البيانات الكمية باستمرار أن الإيذاء المباشر والتعرض للعنف بين أفراد الأسرة من أكثر المخاطر انتشارًا في المنزل (مثل 46% من الأطفال في عمان و 44% في إربد)، بينما يهيمن الحرمان المادي وعدم الاستقرار البيئي في الزرقاء (60%) ومادبا (39%) مع ذلك، تصف الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية (غالبًا أكثر من 90%) المنزل بأنه بيئة آمنة. يشير هذا التناقض إلى أن مقدمي الرعاية قد يقللون من أهمية المخاطر عمدًا أو بدون وعي لتجنب الحكم الاجتماعي، أو لديهم تصور طبيعي للانضباط والسلامة لا يدرك خطورة العقاب الجسدي أو الإهمال. تدعم النتائج النوعية أن تفكك الأسرة، وضغط الوالدين، وسلوكيات الأشقاء تسهم في مخاطر المنزل، لكنها غالبًا مخفية تحت ثقافة “خصوصية الأسرة”.

2. البيئة المدرسية

أفاد الأطفال والشباب في كل المحافظات بعدم شعورهم بالأمان في المدرسة بسبب العنف بين الأقران والتنمر وسوء سلوك المعلمين (مثل التمييز والمحابة). تكرر ذكر المعارك، الشتائم، والهيكليات القائمة على القوة كسمات شائعة. تظهر البيانات الكمية أن العنف بين الطلاب يمثل أعلى المخاطر في المدارس (36% في عمان، 43% في إربد). مع ذلك، يحتفظ معظم مقدمي الرعاية بتصور متفائل جدًا عن أمان المدارس: 51% في إربد و 56% في مادبا يرون المدارس آمنة تمامًا، بينما شهدت محافظات مثل الكرك والزرقاء وعمان والبلقاء نسبة أكبر لمن يصفونها بأنها “آمنة إلى حد ما مع بعض المخاوف” (حوالي 43%-46%). يشير هذا إلى أن الوعي المجتمعي أو ضعف الاستجابة المؤسسية قد يجعل مقدمي الرعاية أكثر اعترافاً بالمخاطر. وأكد الأطفال أن التبليغ عن التنمر أو العنف غالبًا لا يؤدي إلى أي استجابة، مما يتركهم محبطين وصامتين. إن ضعف دور المدارس الوقائي يرجع إلى نقص الأنظمة المستجيبة، وإهمال المعلمين، والضغط على المرشدين، وثقافة الصمت حول الاعتداء.

3. الفضاءات العامة

أشار جميع المشاركين النوعيين إلى أن المساحات العامة تشكل مصدر تهديد جسدي وتمييز للأطفال، خاصة الضعفاء مثل اللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة. تعكس البيانات الكمية ذلك، حيث صنف نصف الأطفال تقريبًا في المجتمع (مثل 51% في عمان) التعرض للعنف الجسدي والشخصي كأعلى خطر. لكن مقدمي الرعاية غالبًا ما يخفون هذه المخاطر جزئيًا، حيث يصف غالبية منهم المجتمع بأنه آمن أو “آمن إلى حد ما مع بعض المخاوف”. يظهر هنا وعي نسبي أكبر مقارنة بالمنزل أو المدرسة، لكن هناك ميل لتفسير العنف على أنه نتيجة أفعال فردية أو إخفاقات أخلاقية، مما يقلل من إدراك خطر البيئة العامة.

4. المخاطر الرقمية/الإنترنت

تم التعرف على التهديدات على الإنترنت باعتبارها أحد أهم أبعاد حماية الطفل الحديثة، حتى أكثر من المدارس أو الأماكن العامة. تضمنت المخاطر الرقمية: التنمر الإلكتروني، الابتزاز، المحتوى العنيف أو الجنسي، الانتحال والقرصنة، والتواصل الاستغلالي. أشار الأطفال إلى تعرضهم لمحتوى صادم ولقاءات تنطوي على استغلال. وأظهرت البيانات الكمية وعيًا نسبيًا أكبر لدى مقدمي الرعاية تجاه الإنترنت مقارنة بالمجالات الأخرى: أكثر من ثلث مقدمي الرعاية يرون الإنترنت “غير آمن جدًا”، وما يقارب ثلث آخر لديهم بعض المخاوف، مع 40-50% يعتبرون

المحتوى الضار والعنف أهم مخاطر الإنترنت. مع ذلك، استجابة المجتمع لهذه المخاطر جديدة وضعيفة بسبب نقص الإشراف الأبوي والثقافة الرقمية المحدودة، إلى جانب تأثير خوارزميات الشركات التقنية.

5. الضغوط النفسية المشتركة وأنماط التكيف

عبر جميع المحافظات، يعاني الأطفال من ضغوط متشابهة تشمل:

- الضغط الأكاديمي (32% من مقدمي الرعاية أشاروا إلى صعوبة أطفالهم في التعامل معه)
- الصراعات الأسرية والعنف المنزلي
- الصعوبات الاقتصادية والفقر

تظهر البيانات أن الأطفال يعتمدون بشكل كبير على استراتيجيات الدعم العاطفي وغير الرسمية، مثل اللجوء إلى أفراد الأسرة أو الأصدقاء، والمشاركة في أنشطة إيجابية (اللعبة، الرياضة)، أو التسلية بالهوايات والإنترنت. أحياناً تظهر سلوكيات سلبية (العزلة، الإفراط أو الامتناع عن الأكل، التدخين). أما مقدمو الرعاية، فيحاولون التعامل مع الضغوط عبر الاستماع وحل المشكلات، لكن استخدام الخدمات المهنية للصحة النفسية والدعم الاجتماعي قليل جداً (1%-2%).

6. الوصول إلى الخدمات والفجوات

على الرغم من الوعي النسبي بالقنوات الرسمية (مثل دائرة حماية الأسرة أو الرقم 110)، فإن الأسر نادراً ما تلجأ إليها. حوالي 90% من مقدمي الرعاية لم يحاولوا التبليغ رسمياً. أسباب التردد تشمل: وصمة العار، نقص الثقة بالسرية، إجراءات معقدة، ضعف جودة الخدمات، وبعد المسافات وتكاليفها. في المناطق النائية، مثل البلقاء، تفتقر الخدمات الفعلية للهيكلة الرسمية، وتستند الأسر بشكل كبير إلى الشخصيات المجتمعية غير الرسمية.

7. القضايا المشتركة في التنسيق والسياسات والثقة المجتمعية

تواجه جميع المحافظات ضعف التنسيق بين الجهات وفجوات تنفيذ السياسات. غالباً تعمل الوكالات في عزلة أو بأهداف متضاربة، مع قيود على القدرات والتمويل.

أطر السياسات والقوانين لا تحمي الأطفال بالشكل الكافي: عدم وجود بروتوكولات واضحة بعد التبليغ، المخاوف من الانتقام أو النميمة، والافتقار لحماية طويلة الأمد، كل ذلك يضعف الثقة بالنظام الرسمي ويعزز الاعتماد على الآليات غير الرسمية.

10-التوصيات

يوضح هذا القسم مجموعة من التوصيات ذات الأولوية، المستمدة من بيانات المشاركين الرئيسيين واستنتاجات الدراسة عبر المحافظات. تم تنظيم التوصيات ضمن خمسة محاور مترابطة تعكس التحولات المطلوبة على المستوى النظامي، المؤسسي، الأسري، والمجتمعي لتعزيز حماية الطفل.

تحت كل محور من التوصيات، يُقدّم ملخص يوضح ارتباطه بإطار عمل برنامج حماية الطفل التابع لمنظمة أرض البشر، لبيان مدى توافقه مع البرنامج وتقديم توجيه حول ما يجب تعديله أو تعزيزه لدعم البرمجة والمناصرة بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

1. الحوكمة، المساءلة، وتعزيز النظام

- إنشاء/تعزيز أنظمة إشراف حكومية وأقسام للرقابة على جودة خدمات حماية الطفل، خصوصاً ضمن وزارة التنمية الاجتماعية:

يجب أن تقوم هذه الأنظمة (مثل وحدات التفتيش، التدقيق الخارجي، آليات تقديم الشكاوى) بالمراقبة المنهجية لجودة واستجابة خدمات الحماية، خاصة تلك المقدمة من المدارس، المجتمع المدني، والجهات الأمنية (مثل دائرة حماية الأسرة، الأمن العام).

كما ينبغي التأكد من الالتزام بإجراءات صديقة للطفل، آمنة وغير تمييزية، مع التعامل مع البلاغات بشكل عاجل وسري، بما يتوافق مع القوانين الوطنية مثل قانون حقوق الطفل 2022 وقانون حماية الأسرة، وكذلك مع المعايير الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل ومعايير الحد الأدنى لحماية الطفل.

يجب على منظمة أرض البشر تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية لضمان تقديم خدمات حماية الطفل بشكل متسق وصديق للطفل، من خلال دعم تطوير آليات الرقابة والمراجعة الخارجية. ويشمل ذلك توفير أدوات مراقبة معيارية، وإجراءات تشغيل واضحة، وأنظمة مساهمة لتعزيز جودة الخدمات عبر جميع مؤسسات حماية الطفل.

• تقييم الاستراتيجية الوطنية الحالية للعدالة الجنائية للفترة (2024-2028) والدفاع عن نشر تقارير تقدم شفافة: يجب أن يكون هذا التقييم مستقلاً ويفحص ما تم تنفيذه فعلياً حتى الآن، لا سيما فيما يتعلق بممارسات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. بالتوازي، ينبغي العمل على إنشاء نظام رصد وتقييم مع نشر تقارير تقدم عامة ومؤشرات واضحة حول برامج التحويل (مثل: عدد الحالات المحولة، متوسط الوقت لاتخاذ قرار التحويل، نسبة رضا الأطفال والأسر، توفر واستخدام الاستشارة القانونية أو الدعم النفسي الاجتماعي)، وذلك لتحديد الفجوات في النظام وسبل معالجتها.

دعم التغيير المستدام في معايير وممارسات عدالة الأطفال: يجب على تير ديه تخصيص الموارد لتقييم فعالية جهودها في المناصرة بشكل منهجي. سيمكن إنشاء آلية للرصد والتعلم من إجراء تعديلات مستندة إلى الأدلة، وتعزيز التعلم المؤسسي، وإظهار التقدم في تحسين ممارسات عدالة الأطفال.

• المشاركة وتعزيز فرق تنسيق الحماية متعددة القطاعات: أظهرت البيانات وجود فريقين معنيين بحماية الطفل والأسرة، وهما: الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الذي ينظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل، التي ترأسها اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

• معالجة النقص الحاد في الكوادر المؤهلة: تقديم الدعم المالي وبناء القدرات لمقدمي خدمات إدارة الحالات (الحكومة، المجتمع المدني، المدارس)، لا سيما في المناطق غير المخدومة حيث تكون القدرات الحالية محدودة.

• تبسيط الإجراءات لتسهيل وتسريع عملية الإبلاغ: يجب تبسيط عملية الإبلاغ والتحويل، وتقليل الخطوات والروتين غير الضروري الذي يعيق الحماية. يشمل ذلك وجود تصنيف واضح (ما يتم التعامل معه على مستوى المدرسة/المجتمع مقابل دائرة الحماية العائلية والخدمات الاجتماعية)، وتحديد معايير استجابة زمنية لكل نوع من الحالات، وتقديم تغذية راجعة للعائلات حول ما تم فعله.

يجب على أرض البشر الاستمرار في تعزيز التنسيق متعدد القطاعات والتخطيط المشترك بين الجهات الفاعلة في حماية الطفل، مع معالجة قيود الموارد التي تحد من أداء المؤسسات. يجب أن تصاحب جهود بناء القدرات دعم مالي وتشغيلي عند الحاجة، إلى جانب الاستمرار في تبسيط مسارات التحويل وإجراءات الإبلاغ لضمان استجابة سريعة وفعالة.

• إدخال عقوبات صارمة على خرق السرية: بالنظر إلى الحالات الموثقة لتسريب معلومات القضايا، يجب على الجهات الحكومية المعنية بحماية الطفل (مثل وزارة التنمية الاجتماعية، مديرية الأمن العام، وإدارة حماية الأسرة) فرض عقوبات واضحة وقوية على أي موظف أو مقدم خدمة يفشي تفاصيل القضايا السرية.

• توضيح مسارات الإبلاغ الآمنة: تعزيز وتوسيع الجهود الحالية من قبل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوعية

الأطفال ومقدمي الرعاية بكيفية الإبلاغ بأمان (مثل الخطوط الساخنة، نقاط الاتصال في المدارس، المراكز المجتمعية) وتوضيح الجوانب القانونية المرتبطة بالعملية.

نظرًا للامتناع الواسع لمقدمي الرعاية عن طلب الدعم الرسمي على الرغم من وعيهم بقنوات الإبلاغ، ينبغي على أرض البشر التركيز على معالجة الحواجز المرتبطة بالوصمة الاجتماعية، والخوف من كشف الأسرار، وانعدام الثقة في سرية المعلومات. ويستلزم ذلك تعزيز ممارسات الحماية، وتحسين حساسية واستجابة المؤسسات، والاستثمار في جهود التوعية المجتمعية التي تساهم في جعل طلب المساعدة أمرًا مقبولاً وطبيعياً.

2. تعزيز استجابة الأنظمة التعليمية والمجتمعية وضمان السلامة

● **دمج التعليم حول حماية الطفل والقيم الإنسانية في المناهج المدرسية:** ينبغي أن تُدرّس المناهج بشكل منهجي مفاهيم حقوق الإنسان، وسلامة الجسد، وعدم العنف، والاحترام، والتعاطف، لمساعدة الأطفال على التمييز بين السلوكيات المقبولة والصارفة في المنزل والمدرسة والمجتمع وعبر الإنترنت، مع وحدات عملية حول حل النزاعات، والوقاية من التهم، وطرق طلب المساعدة بأمان.

● **إدخال برامج تعليمية حول الأسرة وحماية الطفل على مستوى الجامعات:** يجب أن تتضمن الجامعات مقررات إلزامية تتعلق بدinاميكيات الأسرة، والانضباط الإيجابي، ونمو الطفل، ومبادئ الحماية.

يجب على أرض البشر الانخراط مع السلطات التعليمية والمؤسسات الأكاديمية لدمج موضوعات حماية الطفل، والتربية الإيجابية، والتعليم الأسري في المناهج المدرسية والجامعية الرسمية. ويشمل ذلك تقديم الدعم الفني والتدريب للمعلمين لضمان استدامة هذه المواضيع وتثبيتها ضمن البرامج التعليمية الرسمية، وليس الاكتفاء بالبرامج غير الرسمية.

● **إنشاء والحفاظ على مساحات عامة آمنة:** يجب إنشاء وصيانة الحدائق العامة، ملاعب الأحياء، والمساحات الصديقة للأطفال، مع الحرص على إضاءة كافية وإشراف عند الإمكان، وجعلها متاحة لجميع الأطفال. واستجابة للمخاوف المرتبطة بالنوع الاجتماعي، يمكن تخصيص مساحات ترفيهية أو أنشطة مخصصة للفتيات لضمان وجود أماكن آمنة للعب والتفاعل الاجتماعي.

● **تحسين البنية التحتية للسلامة اليومية:** ينبغي أن تتناول البرامج المخاطر البيئية المحددة التي أشار إليها المجتمع، مثل إزالة الكلاب الضالة، تحسين إنارة الشوارع، وتوفير حافلات مدرسية لتقليل مخاطر الطرق غير الآمنة إلى المدرسة.

● **تقديم أنشطة ترفيهية ومنهجية:** يجب إنشاء أندية رياضية (سباحة، كرة القدم، فنون قتالية، كمال أجسام)، مراكز ثقافية وترفيهية، مراكز لتعليم القرآن والتلاوة، وبرامج أخرى تصب طاقة الأطفال في أنشطة إيجابية. كما يمكن إدخال فترات تفاعلية حرة في المدارس، وتنظيم فعاليات مجتمعية، وتقديم فرص تعليمية مجانية (مثل دورات الروبوتات) لتعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي، خصوصاً للأطفال الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال المتورطين في القانون، أو ذوي الإعاقات الجسدية، والفتيات الصغيرات.

بعيداً عن المساحات الصديقة للأطفال داخل المؤسسات، يجب على أرض البشر الانخراط مع السلطات البلدية والمجتمعات المحلية لمعالجة مخاطر السلامة البيئية الأوسع التي تؤثر على الأطفال. ويشمل ذلك فتح حوارات وتخطيط مشترك حول البنية التحتية العامة، مثل الإنارة، الحدائق، وسائل النقل، والعوامل الأخرى التي تشكل سلامة الأطفال في الأماكن العامة.

3. السلامة الرقمية، الثقافة الرقمية، والاستخدام المسؤول

- **تعزيز الحوكمة الرقمية الوطنية لحماية الأطفال:** استناداً إلى مخاوف المجتمع من أن الإنترنت "أخطر من الشارع"، يجب توجيه جهود المناصرة وبناء التحالفات نحو الجهات الحكومية (مثل المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم) للنظر في تصميم تدابير تنظيمية تقلل من تعرض الأطفال للمحتوى الضار وغير القانوني (مثل تعزيز الرقابة على المحتوى، آليات الإبلاغ عن المنصات الضارة، ودمج وحدات الثقافة الرقمية الإلزامية في المدارس)، مع الموازنة بين الحق في الوصول إلى المعلومات وحقوق الأطفال.
- **تعزيز الاستخدام المسؤول للأجهزة على مستوى الأسرة:** على صعيد الأسر، يجب رفع الوعي بمفاهيم الخصوصية على الإنترنت، والتثمن الإلكتروني، واستدراج الأطفال عبر الإنترنت، والتفكير النقدي في المحتوى الرقمي. كما ينبغي تشجيع العائلات على وضع حدود واضحة ومناسبة لعمر الأطفال لاستخدام الأجهزة والإنترنت، خاصة في الليل وللأطفال الأصغر سناً، مع التركيز على بناء الثقة وليس مجرد التحكم.

يجب على أرض البشر تعزيز جهودها في مجال الحماية الرقمية من خلال المناصرة لسياسات وطنية وتدابير تنظيمية تعزز سلامة الأطفال على الإنترنت، بما في ذلك الرقابة على المحتوى وتطبيق حماية مناسبة لأعمار الأطفال. وينبغي أن يُكمل ذلك بمبادرات مستمرة للتثقيف الرقمي وزيادة الوعي للأطفال والأسر والمجتمعات

4. دعم الأسرة، مهارات الأبوة والأمومة، واستقرار المنزل

8. تقديم دعم مالي ومادي مستهدف للأسر الضعيفة: تنشأ العديد من مخاطر حماية الأطفال من الضغوط الاقتصادية، لذا يجب الاستثمار في تقديم مساعدات نقدية أو عينية (مثل الغذاء، الملابس، مستلزمات المدرسة، بدلات النقل، أو مصروف للأطفال عند الاقتضاء) للأسر الكبيرة والأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية، بهدف تقليل الضغوط التي قد تدفع الأطفال إلى العمل أو الانقطاع عن التعليم. يجب أن يركز الاستهداف على الأسر التي تم تحديدها بأنها تواجه هشاشة خاصة بالأطفال، مثل الأسر التي يشارك أطفالها في العمل (خصوصاً الأعمال الخطرة)، الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، الأسر ذات مقدم رعاية واحد، الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، وكذلك الأسر ذات الخلفيات اللاحقة.

ينبغي على منظمة أرض البشر أن تعترف صراحةً بالضغوط الاقتصادية باعتبارها عاملاً رئيسياً يهدد حماية الأطفال ضمن نهجها في إدارة الحالات. ويشمل ذلك تحديد الأسر التي تواجه هشاشة اقتصادية حادة وتمكين تقديم المساعدات النقدية أو العينية المباشرة كاستجابة وقائية عند الضرورة.

9. توسيع برامج التعليم والتدريب العملي للأباء والأمهات: بالنظر إلى أن البيانات أظهرت أن الوصول إلى الخدمات المهنية واستخدامها شبه معدوم (1-2% فقط يلجأون للتدخل المهني)، يجب تصميم وتنفيذ برامج تعليمية مستمرة تساعد الأوصياء على فهم نمو الطفل، وأساليب التأديب غير العنيف، والدعم العاطفي، والمخاطر الواقية التي يواجهها أطفالهم اليوم (مع التركيز على المخاطر الرقمية، وأيضاً زيادة وعيهم بخطورة المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الأطفال في المنازل والمدارس والمجتمع، نظراً للفجوة الواضحة في إدراك السلامة). يجب أن تتضمن البرامج أيضاً طرقاً لإدارة صحتهم النفسية والعاطفية. ينبغي أن تكون الجلسات مصممة لمراحل الأبوة المختلفة وتشمل أدوات عملية مثل كيفية التواصل مع الأطفال وكيفية ملاحظة علامات الضيق لديهم.

• دمج استجابات الصحة النفسية وتعاطي المواد: نظراً للروابط بين الصحة النفسية للأوصياء وتعاطي المواد والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال، فإن الاستثمار في الكشف المبكر ومعالجة الأمراض النفسية والإدمان بين الأوصياء والشباب، إلى جانب توسيع مبادرات الدعم النفسي الموجهة للأطفال والمجموعات المجتمعية، يُعد أمراً عاجلاً ضمن الخدمات الصحية المستهدفة.

ينبغي على أرض البشر الاستمرار في تعزيز قدرة الأوصياء على دعم الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال من خلال برامج تنمية مهارات الأبوة والأمومة ومهارات الحياة، مع ضمان وجود مسارات واضحة للوصول إلى خدمات الصحة النفسية المتخصصة وعلاج الإدمان لكل من الأطفال والأوصياء عند الحاجة.

10. ينبغي إدخال برامج تعليمية قبل الزواج وللوقاية من الزواج المبكر، من خلال الشراكة مع المحاكم الشرعية لتقديم دورات أو برامج اعتماد تهدف إلى تزويد الأزواج بمهارات أساسية في التواصل، الأبوة الإيجابية، حل النزاعات، والتخطيط المالي، مع مراعاة دور الضغوط الأسرية والانهيئات العلائقية في زيادة مخاطر حماية الطفل.

ينبغي على أرض البشر التعاون مع المحاكم الشرعية والمؤسسات ذات الصلة لإدخال برامج تعليمية قبل الزواج وللوقاية من الزواج المبكر، تتضمن مبادئ الأبوة الإيجابية، وحل النزاعات، وحماية الطفل. وقد يشمل ذلك جهود المناصرة، والدعم الفني، والتدريب المخصص لموظفي المحاكم والأطراف المرتبطة بها.

5. الحماية على مستوى المجتمع وتغيير الأعراف الاجتماعية

- تطوير شبكات حماية مجتمعية وتعزيز قدرات المجتمع المدني: تدريب ودعم القيادات الدينية، والشخصيات القبلية، والمعلمين، وأعضاء المجتمع المرموقين، وموظفي المجتمع المدني المحلي على مفاهيم حماية الطفل، والدعم النفسي والاجتماعي (خصوصاً للأطفال الأكثر ضعفاً)، وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الدمج للأطفال المخالفين للقانون (مثل توفير أنشطة بناء المهارات، والدعم النفسي والاجتماعي المخصص، وجلسات التوعية حول مسؤولية المجتمع تجاههم)، مما يمكنهم من أن يكونوا جسوراً بين الأسر والخدمات الرسمية.
- الاستفادة الإيجابية من القيم الثقافية: ينبغي أن تُبنى رسائل التوعية على القيم الأخلاقية والعادات المحلية التي تدعم الرعاية، والكرامة، واللاعنف. ويشمل ذلك استخدام الاجتماعات المجتمعية والفعاليات التقليدية لتعزيز الرسائل المتعلقة بحقوق وسلامة الأطفال، وإزالة الوصمة عن الأطفال المخالفين للقانون، وأهمية طلب خدمات الدعم النفسي والاجتماعي الرسمية وغير الرسمية للأطفال وأولياء أمورهم.
- تطبيع طلب الدعم وتقليل الوصمة: يجب أن تعرض الحملات العامة والمبادرات المحلية قصص نجاح مجهولة الهوية (عبر الأفلام، الرسوم المتحركة، وسائل التواصل الاجتماعي، أو المسرح المجتمعي) تُظهر الأسر وهي تطلب الدعم وتستفيد منه دون شعور بالخجل أو الفضيحة، وأطفال يتم دمجهم مجدداً في المجتمع بعد تعرضهم للنزاع مع القانون.

ينبغي على منظمة أرض البشر توسيع جهود الحماية على مستوى المجتمع من خلال التعاون مع الجهات غير الرسمية الموثوقة، وتعزيز مسارات الإحالة إلى الخدمات الرسمية، واستخدام استراتيجيات تواصل تراعي الحساسية الثقافية. وتهدف هذه الجهود إلى تغيير الأعراف الضارة، وتقليل الوصمة المجتمعية، وتشجيع الأسر على طلب الدعم المناسب لقضايا حماية الأطفال والصحة النفسية والاجتماعية.

11. المصادر المرجعية

- Department of Statistics, Jordan. (2015). *General Population and Housing Census 2015*. Amman: Department of Statistics. Retrieved from <https://dosweb.dos.gov.jo>
- Department of Statistics, Jordan. (2019). *Statistical Yearbook of Jordan 2019*. Amman: Department of Statistics. Retrieved from <https://dosweb.dos.gov.jo>
- GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). (2024). *Psychosocial Support and Trauma Work in Jordan*. Retrieved from <https://www.giz.de/en/projects/psychosocial-support-and-trauma-work-jordan>
- Girls Not Brides. (2024). *Jordan Country Profile: Child Marriage Atlas*. Retrieved from <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/jordan/>
- Humanity & Inclusion. (2022). *Disability Inclusive Education in Jordan Factsheet*. Retrieved from https://www.hi.org/sn_uploads/document/IE_Jordan_Factsheet_April-2022_Final.pdf
- Humanity & Inclusion and iMMAP. (2018). *Removing Barriers: The Path towards Inclusive Access: Disability Assessment among Syrian Refugees in Jordan and Lebanon*. Humanitarian Data Exchange. Retrieved from <https://data.humdata.org>
- International Catholic Migration Commission. (2021). *Child Marriage in Jordan: Report on Project Findings and Recommendations*. Retrieved from https://www.icmc.net/wp-content/uploads/2021/07/Child-Marriage-in-Jordan_FINAL.pdf
- International Labour Organization. (2016). *National Child Labour Survey 2016: Jordan*. Beirut: ILO Regional Office for Arab States.
- Terre des hommes. (2024). *Middle East and North Africa: Our Impact*. Retrieved from <https://www.tdh.org/en/our-impact/middle-east-north-africa>
- UN Committee on the Rights of the Child. (2023). *Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Jordan* (CRC/C/JOR/CO/6). Geneva: United Nations. Retrieved from <https://docstore.ohchr.org>
- UNHCR. (2024). *Annual Results Report 2024: Jordan*. Amman: United Nations High Commissioner for Refugees. Retrieved from https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-06/Jordan_ARR_2024.pdf
- UNHCR. (2024). *Irbid Field Office Fact Sheet, December 2024*. Retrieved from <https://data.unhcr.org/en/documents/download/114823>
- UNHCR. (2024). *MHPSS Working Group: Mental Health and Psychosocial Support*. Retrieved from <https://data.unhcr.org/en/working-group/65>

UNHCR. (2022). *Vulnerability Assessment Framework: 2022 Population Report for Refugees in Host Communities*. Amman: UNHCR Jordan. Retrieved from <https://data.unhcr.org/en/documents/details/93754>

UNICEF. (2014). *A Study on Early Marriage in Jordan*. Amman: UNICEF Jordan. Retrieved from https://www.unicef.org/media/files/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014-email.pdf

UNICEF. (2019). *A Qualitative Study on the Underlying Social Norms and Economic Causes that Lead to Child Marriage in Jordan*. Amman: UNICEF Jordan, University of Edinburgh, and Higher Population Council. Retrieved from <https://www.unicef.org/jordan/media/1796/file/Jordan-Reports.pdf>

UNICEF and Ministry of Education, Jordan. (2020). *Jordan Country Report on Out-of-School Children*. Amman: UNICEF Jordan. Retrieved from <https://www.unicef.org/jordan>

UNICEF Jordan. (2024). *Child Protection Programme Overview*. Retrieved from <https://www.unicef.org/jordan/child-protection>

UNICEF Middle East and North Africa. (2024). *Integration of Mental Health and Psychosocial Support in Primary Health Care for Children, Adolescents, Pregnant Women and New Mothers in the Middle East and North Africa Region*. Retrieved from <https://www.unicef.org/mena/topics/psychosocial-support>

UN Women. (2013). *Gender-based Violence and Child Protection among Syrian Refugees in Jordan, with a Focus on Early Marriage*. Amman: UN Women Jordan. Retrieved from <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/7/report-web.pdf.pdf>

U.S. Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs. (2023). *2023 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Jordan*. Washington, DC: U.S. Department of Labor. Retrieved from <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/jordan>

U.S. Department of State. (2024). *2024 Country Reports on Human Rights Practices: Jordan*. Washington, DC: U.S. Department of State. Retrieved from <https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/jordan>

12. الملاحق

الملحق الأول – مصفوفة أسئلة البحث

سؤال التقييم / الهدف	أسئلة البحث عالية المستوى (أمثلة مختارة)	طريقة جمع البيانات	مجموعات المستجيبين المستهدفة	مصادر البيانات
ما هي أبرز التحديات النفسية أو الصحية العقلية التي يواجهها الأطفال والشباب؟	- ما هي الاحتياجات المحددة للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب في مختلف الفئات العمرية؟ - ما هي آليات التكيف والدعم غير الرسمي المستخدمة حالياً لمعالجة التوتر أو القلق أو الصدمات؟ - كيف تؤثر الأعراف الجندرية وتوقعات الأسرة والمعتقدات الثقافية على الرغبة في طلب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي؟ - ما هي أبرز العوائق أمام الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي؟ - ما التحسينات المطلوبة لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي؟	المسح الأسري (HHS) (استطلاع D12 - مجموعات النقاش المركزة (الشباب، الأطفال، أولياء الأمور) (المقابلات المتعمقة (رؤساء المنظمات المجتمعية/المنظمات غير الحكومية، موظفو أرض البشر)	أعضاء المجتمع الشباب (12-24) الأطفال (12-17) أولياء الأمور مزودو خدمات الدعم النفسي الاجتماعي	بيانات الاستطلاعات الكمية نسخ/ملاحظات نوعية تقارير المراقبة والتقييم الحالية
هل توجد خدمات لحماية الطفل، وهل يثق المجتمع بها؟	- إلى أي مدى تتوفر خدمات حماية الطفل وتمكين الشباب ويمكن الوصول إليها؟ - كيف يرى الأطفال والشباب وأولياء الأمور جودة وملاءمة برامج حماية الطفل؟ - ما المعتقدات والمواقف والمخاوف المجتمعية التي تمنع الإبلاغ أو الوصول إلى خدمات الحماية؟ - إلى أي مدى يثق الأطفال وأولياء الأمور بجهات الحماية وجهات العدالة؟	HHS (استطلاع 2 - C7, C8, E2, E10) مجموعات النقاش المركزة (الأطفال، الشباب، الرجال، النساء) (المقابلات المتعمقة (قادة المجتمع، موظفو أرض البشر)	أعضاء المجتمع الأطفال (12-17) الشباب (18-24) أولياء السلطات المحلية	بيانات الاستطلاع الكمية نسخ/ملاحظات نوعية قوائم المنظمات المجتمعية بيانات برامج أرض البشر

ما هي العوائق أمام الوصول إلى خدمات MHPSS أو حماية الطفل؟	-ما هي العوائق الرئيسية التي تمنع الوصول إلى خدمات MHPSS أو حماية الطفل؟ -كيف تختلف فجوات الخدمات بحسب وضع اللاجئين، الإعاقة، الفقر، والجنس؟ -ما أشكال الوصم أو التمييز التي يواجهها الأطفال والأسر؟	HHS استطلاع 2, D5 - E9 مجموعات النقاش المركزة (الشباب، النساء، أولياء الأمور) المقابلات المتعمقة (المنظمات المجتمعية، موظفو أرض البشر، قادة المجتمع)	أعضاء مستفيدو موظفو المنظمات المجتمعية	المجتمع الخدمات	بيانات الاستطلاع الكمية نسخ/ملاحظات نوعية ملاحظات ميدانية
ما أكبر المخاطر التي تواجه الأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر؟	-ما أبرز مخاوف حماية الطفل في مختلف البيئات (المنزل، المدرسة، الأماكن العامة، الإنترنت)؟ -ما المخاطر التي تواجه الفئات المهمشة (الفتيات، الأطفال ذوي الإعاقة، اللاجئين)؟ -ما العوامل الأساسية التي تزيد المخاطر؟ -ما مدى شعور الأطفال بالأمان، وما أشكال الدعم المجتمعي المتاحة؟	HHS استطلاع 2, C1 - F7 مجموعات النقاش المركزة (الأطفال، الشباب) المقابلات المتعمقة (المنظمات المجتمعية، الأطفال البديلين للاحتجاز)	الأطفال الأكثر عرضة للخطر أولياء جهات الحماية	الخطر الأمور	بيانات الاستطلاع الكمية نسخ/ملاحظات نوعية تقييمات الضعف القائمة
كيف يمكن تعزيز التدخلات الحالية التي تستهدف الشباب، الأطفال ذوي مخاطر الحماية، وأولياء الأمور؟	-ما الفجوات في التدخلات الحالية لمعالجة التعرضات المتداخلة؟ -ما التوصيات التي يقدمها الأطفال والشباب وأولياء الأمور لجعل الخدمات أكثر شمولية وعدالة؟ -ما الدعم أو البرامج الإضافية التي يمكن أن تساعد على إعادة الإدماج ومنع تكرار المخالفات بين الأطفال المتعاملين مع النظام القضائي؟	مجموعات النقاش المركزة (المستفيدون، غير المستفيدين) المقابلات المتعمقة (مسؤولو النشاط، الضباط، المنظمات المجتمعية)	المقابلات المتعمقة (مسؤولو النشاط، الضباط، المنظمات المجتمعية) المستفيدون من البرامج موظفو تير ديه/المنظمات المجتمعية قادة المجتمع	المقابلات المتعمقة (مسؤولو النشاط، الضباط، المنظمات المجتمعية) المستفيدون من البرامج موظفو تير ديه/المنظمات المجتمعية قادة المجتمع	نسخ/ملاحظات نوعية بيانات المراقبة والتقييم لتيير وثائق البرامج

الملحق الثالث – تدريب المجمعين على جمع البيانات

1.1. أجندة التدريب

ملخص التدريب
العنوان: تدريب بناء قدرات المنظمات المجتمعية –تقييم الاحتياجات بقيادة المجتمع بنهاية هذا التدريب، سيكون لدى المشاركين من المنظمات المجتمعية فهم واضح لـ: 1. التقييمات بقيادة المجتمع • المفهوم والهدف وأهمية تقييم الاحتياجات والضعف بقيادة المجتمع • المنهجيات الأساسية وخطوات التخطيط اللازمة لإجراء هذه التقييمات بفعالية 2. أساسيات جمع البيانات • التعريفات والبروتوكولات والاعتبارات الأخلاقية في جمع البيانات • الأدوات والتقنيات لتنفيذ المقابلات المتعمقة (KIIs) ، مجموعات النقاش المركزة (FGDs) ، والاستطلاعات المجتمعية 3. التخطيط العملي والتحضير الميداني • تطوير خطة تجريبية وخطة عمل • توضيح الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية • فهم وتطبيق المدونة الأخلاقية وإرشادات حماية الطفل أثناء عملية التقييم
جدول التدريب

ملخص التدريب				
العنوان: تدريب بناء قدرات المنظمات المجتمعية -تقييم الاحتياجات بقيادة المجتمع				
الوحدة	المواضيع	المخرجات	التاريخ	الوقت
المقدمة	التسجيل كسر التوقعات القواعد الأساسية	-	-	-
الوحدة الأولى: مفهوم التقييمات بقيادة المجتمع	ما هو تقييم الاحتياجات المجتمعية؟ لماذا تقييم الاحتياجات المجتمعية؟ أهمية ذلك للمنظمات المجتمعية؟	توزيع ومراجعة دليل عملية CLNA باللغة العربية لمراجعة اليوم الثاني	3/8/2025	5 ساعات (9:30 – 3:30)
الوحدة الثانية: جمع البيانات والتنفيذ	ما هو جمع البيانات؟ أخلاقيات جمع البيانات بروتوكولات جمع البيانات التخطيط لجمع البيانات كيف؟ المنهجيات، العينة والأدوات، والتطبيق العمل	- طرق جمع البيانات، تمارين عملية، ولعب الأدوار ملاحظات على المشاركين	4/8/2025	5 ساعات
الوحدة الثالثة: التخطيط العملي والتجريبي	كيفية إعداد خطة عمل؟	خطة عمل مكتملة لجمع البيانات	5/8/2025	5 ساعات

ملخص التدريب			
العنوان: تدريب بناء قدرات المنظمات المجتمعية -تقييم الاحتياجات بقيادة المجتمع			
			الأدوار والمسؤوليات المدونة الأخلاقية إرشادات الحماية خطة CLNA لكل منظمة نموذج خطة العمل ليتم تعبئته من قبل ممثلي المنظمات

1.2 منهجية التدريب

تعتمد منهجية تدريب تقييم الاحتياجات والضعف بقيادة المجتمع على مبادئ تعلم الأوصياء، والتيسير التشاركي، والتعليم التجريبي. الهدف الأساسي هو تمكين ممثلي المنظمات المجتمعية من المهارات العملية، والأدوات، والعقلية الأخلاقية اللازمة لتنفيذ تقييمات شاملة يقودها المجتمع في سياقاتهم المحلية.

تم تصميم التدريب الذي يمتد لثلاثة أيام بحيث ينتقل تدريجيًا من الفهم المفاهيمي إلى الجاهزية الميدانية، مع التركيز القوي على التفاعل، والتفكير، والتطبيق العملي.

1.3 نهج ومبادئ التدريب

يعتمد النهج على دمج طرق تيسير متنوعة لتلبية أنماط التعلم المختلفة وضمان مشاركة نشطة طوال فترة التدريب. تشمل المبادئ الأساسية ما يلي:

الوصف	نهج التدريب
المشاركة	تم تصميم كل جلسة لتكون تفاعلية وقائمة على النقاش، تشجع أعضاء المنظمات المجتمعية على مشاركة تجاربهم، وأمثلة من السياق المحلي، والتحديات التي يواجهونها في عملهم. هذا يربط التعلم بالواقع العملي ويعزز شعورهم بالملكية والمسؤولية.

التعلم التجريبي	بدل الاعتماد على المحاضرات فقط، يركز التدريب على التعلم بالممارسة من خلال تمثيل الأدوار المنظم، والمحاكاة، والعروض العملية، واستعراض الأدوات. يشارك المشاركون مباشرة في التعامل مع استمارات المسح، وأدلة مجموعات النقاش، وبروتوكولات الإحالة لتعزيز قدرتهم على تطبيق الأدوات ميدانيًا.
العمل الجماعي وتعلم الأقران	يُقسّم المشاركون بانتظام إلى مجموعات عمل صغيرة لتصميم خطط تقييم تجريبية، ومراجعة الأدوات، وتحليل بيانات نموذجية. هذه التمارين التعاونية تعزز العمل الجماعي، وتبني المعرفة المشتركة، وتوفر مساحة للمشاركين الأقل ثقة للتعبير عن أنفسهم.
الأخلاقيات كأساس	يتم دمج التأمل الأخلاقي طوال التدريب، مع التركيز المستمر على الموافقة المستنيرة، وحماية الطفل، والسرية، والحساسية الثقافية. تساعد السيناريوهات الواقعية المشاركين على ممارسة تطبيق ميثاق السلوك المهني ومبادئ الحماية في سياقات ميدانية حساسة.

1.2 تفصيل منهجية التدريب حسب اليوم

اليوم	المحور	الوصف
اليوم الأول	فهم مفهوم التقييم القائم على قيادة المجتمع (CLNA)	يركّز هذا اليوم التأسيسي على تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية وآلية التقييمات القائمة على قيادة المجتمع، لا سيما في المجتمعات الهشة والمتأثرة بالنزوح. يستخدم الميسرون العصف الذهني، والحوار المفتوح، والأدوات البصرية (مثل مخططات سير العملية والكتيبات باللغة العربية) لاستعراض: - أهمية البيانات المستمدة من المجتمع - الدور المحدد لمنظمات المجتمع المحلي في قيادة التقييمات المحلية - العملية الكاملة للتقييم القائم على قيادة المجتمع، من التخطيط إلى حلقات التغذية الراجعة - تساعد التمارين التفاعلية مثل رسم التوقعات وتوضيح الأدوار المشاركين على التأمل في أدوارهم المجتمعية والاستعداد للتنفيذ.
اليوم الثاني	أساليب جمع البيانات والتطبيق العملي	يركّز اليوم الثاني على بناء المهارات التقنية في جمع البيانات. يقدم الميسرون:

المصطلحات الأساسية والاعتبارات الأخلاقية •بروتوكولات جمع البيانات (التخطيط، الموافقة المستنيرة، الإحالات) •أساليب تشمل المقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومجموعات النقاش المركزة، والمسوح الأسرية يشارك المشاركون في محاكاة مقابلات ومجموعات نقاش مركزة، مع تبادل الأدوار بين محاور، ومستجيب، ومراقب. تعقب كل محاكاة جلسات تغذية راجعة جماعية، مع التركيز على مهارات الاستقصاء، والحياد، وحماية الطفل، وإدارة المواضيع الحساسة. كما يتدرّب المشاركون على استخدام أدوات ميدانية مثل قوائم التحقق، وأدلة المقابلات، وخطط المعاينة.		
يركّز اليوم الأخير على تحويل المعرفة إلى عمل. يقوم المشاركون بتطوير خطط عمل للتقييم القائم على قيادة المجتمع باستخدام نموذج عربي موحد. ويشمل ذلك: •تحديد الأهداف والجدول الزمنية والمسؤوليات •دمج المعايير الأخلاقية وتدابير الحماية •رسم نقاط الدخول، وحلقات التغذية الراجعة، وآليات التنسيق يدعم الميسرون العمل الجماعي ويقدمون إرشادًا تقنيًا. تتيح العروض التقديمية العامة مراجعة الأقران وتبادل الملاحظات حول الجاهزية العملية. ويُختتم اليوم بمراجعة الدروس المستفادة الرئيسية والالتزامات.	تخطيط العمل والاستعداد الميداني	اليوم الثالث

1.2 الأدوات والمواد

تشمل الحقيبة التدريبية مواد باللغة العربية، من بينها:

- كتيب يشرح عملية التقييم القائم على قيادة المجتمع
- حزم أدوات جمع البيانات (الاستبيانات، مجموعات النقاش المركزة، المقابلات مع اصحاب المصلحة الرئيسيين) (CLNA)
- نموذج خطة العمل
- مدونة السلوك وإرشادات حماية الطفل

- نماذج الإحالة ونصوص الموافقة المستنيرة

يتم استخدام هذه الأدوات بشكل تفاعلي خلال الجلسات التدريبية، كما تُسَلَّم لجميع المشاركين لاستخدامها في العمل الميداني. تضمن هذه المنهجية التشاركية والعملية أن يطور ممثلو منظمات المجتمع المحلي فهماً مفاهيمياً متيناً، إلى جانب الكفاءات التشغيلية اللازمة لقيادة تقييمات عالية الجودة، أخلاقية، وقائمة على المجتمع.

1.1 المنهاج التدريبي / هيكل المنهاج

يمتد التدريب على مدار ثلاثة أيام كاملة، وهو منظم ضمن وحدات تدريبية متدرّجة، تجمع كل منها بين المدخلات النظرية والأنشطة العملية التطبيقية. ويشمل المنهاج التدريبي ما يلي:

الجدول 16: المنهاج التدريبي

اليوم	الوحدة التدريبية	الموضوعات التي تم تناولها	المنهجيات المستخدمة	أدوات التعلم الرئيسية
اليوم الأول	فهم تقييم الاحتياجات المجتمعية بقيادة المجتمع CLNA	-تعريف وقيمة تقييم الاحتياجات المجتمعية بقيادة المجتمع (CLNA)	- دور منظمات المجتمع المحلي (CBOs) في التقييمات المجتمعية - سياق الهاشاشة المجتمعية وحماية الطفل - نقاشات ميسرة - أنشطة كسر الجليد وتحديد التوقعات - عصف ذهني جماعي - نشرة عملية CLNA باللغة العربية	لوحات ورقية (Flipcharts) ووسائل بصرية نماذج العمل الجماعي
اليوم الثاني	أساليب جمع البيانات والبروتوكولات الأخلاقية	ما هو جمع البيانات؟ الاعتبارات الأخلاقية وحماية الطفل	أدوات مجموعات النقاش المركزة ، المقابلات الفردية ، والاستبيانات محاكاة ولعب أدوار	نصوص الموافقة والاعتبارات الأخلاقية قوائم تدقيق تخطيط جمع البيانات

اليوم	الوحدة التدريبية	الموضوعات التي تم تناولها	المنهجيات المستخدمة	أدوات التعلم الرئيسية
		أدوات مجموعات النقاش المركزة ، المقابلات الفردية ، والاستبيانات تخطيط العينات والجوانب اللوجستية	تجربة الأدوات وتقديم التغذية الراجعة تمارين سيناريوهات الحالات	نصوص الموافقة والاعتبارات الأخلاقية قوائم تدقيق تخطيط جمع البيانات
اليوم الثالث	التخطيط العملي والاستعداد الميداني	أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة تقييم المخاطر إعداد خطة عمل تقييم CLNA مدونة السلوك في العمل الميداني	مراجعة الأقران لخطط العمل تخطيط ضمن مجموعات صغيرة جلسات تغذية راجعة	نموذج خطة عمل CLNA مخطط مسار الإحالة ملخص إرشادات الحماية

1.1 المنهجيات

يرتكز المنهاج التدريبي على مبادئ تعلّم مقدّمي الرعاية، ويُعطي أولوية للتعلّم القائم على الخبرة، بما يشمل:

- التيسير التشاركي لتعزيز المشاركة الفاعلة والتفكير التأملي
- لعب الأدوار والمحاكاة الميدانية لتعزيز مهارات جمع البيانات
- العمل الجماعي والتعلّم من الأقران لبناء روح الفريق وحلّ المشكلات بشكل مشترك
- استخدام مواد إرشادية وأدوات بصرية باللغة العربية لضمان سهولة الوصول لجميع المستويات التعليمية

ويُزوّد كل مشارك بحقيبة تدريبية تشمل:

- ملخصات الوحدات التدريبية
- أدوات مطبوعة، مجموعات النقاش المركزة ، المقابلات الفردية ، الاستبيانات
- الإرشادات الأخلاقية
- نموذج خطة العمل
- مسارات الإحالة ونقاط الاتصال

الملحق: جزئية المراجعة المكتبية

الهدف	الأول:	تحديد	الفجوات	الحالية	في	تقديم	خدمات	الحماية	وتغطيتها
يتناول الهدف الأول سؤالاً أساسياً: أين تفشل خدمات حماية الطفل الحالية في الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً، ولماذا؟ تُعد قاعدة الأدلة المرتبطة بهذا الهدف كبيرة ومقلقة؛ إذ يوجد 69,661 طفلاً منخرطين في عمل الأطفال، و7,964 حالة زواج أطفال تحدث سنوياً، وتسعة من كل عشرة أطفال يتعرضون لأساليب تأديب عنيفة. ويُظهر ذلك بوضوح أن خدمات الحماية القائمة غير كافية من حيث النطاق أو الجودة أو سهولة الوصول. غير أن فهم الطبيعة الدقيقة لفجوات الحماية يتطلب رسماً منهجياً يتجاوز الإحصاءات الإجمالية، ليشمل تحليل التفاوتات الجغرافية، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات، والفجوات في أنواع الخدمات المقدمة.									
الهدف الثاني: تقييم توفر جودة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزه الأردن في دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء آليات تنسيق من خلال مجموعة عمل MHPSS، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية حول تغطية هذه الخدمات وجودتها، وما إذا كانت تصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وتُظهر الأدلة التي تمت مراجعتها في هذا البحث المكتبي أن خدمات الدعم النفسي الاجتماعي ما تزال متركزة في المراكز الحضرية الكبرى ومخيمات اللاجئين القائمة، في حين تعاني المناطق الريفية وبعض تجمعات اللاجئين في المناطق شبه الحضرية من محدودية الوصول. كما أن البيانات المتعلقة بالتغطية الفعلية للخدمات—أي نسبة الأطفال الذين يعانون من تحديات في الصحة النفسية ويتلقون دعماً مناسباً، لا يتم تتبعها بشكل منهجي.									
الهدف الثالث: رسم خريطة الفاعلين في مجال حماية الطفل وآليات التنسيق وفرص الشراكة القائمة تتطلب برمجة فعّالة لحماية الطفل فهماً معمقاً للنظام البيئي المعقد للجهات الفاعلة، والولايات المؤسسية، وهياكل التنسيق العاملة في الأردن. وبينما تُعد الجهات الرئيسية مثل اليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووزارة التنمية الاجتماعية معروفة، فإن مشهد المنظمات غير الحكومية المحلية، ومنظمات المجتمع المحلي، والمبادرات القاعدية العاملة في مجال حماية الطفل لا يزال أقل توثيقاً بشكل منهجي. كما توجد آليات تنسيق على مستويات متعددة، مجموعات عمل وطنية، وتنسيق على مستوى المحافظات، ولجان تنسيق على مستوى المخيمات—إلا أن فعاليتها وشموليتها تختلف من سياق إلى آخر.									
الهدف الرابع: تحديد الفئات الأكثر ضعفاً التي تتطلب تدخلات مستهدفة									
رغم أن هذا البحث المكتبي وثّق عدة فئات هشة—منها 675,000 لاجئ، و69,661 طفلاً عاملاً، و79% من الأطفال ذوي الإعاقة المستبعدين من التعليم، فإن فهم الهشاشة يتطلب تجاوز الأرقام الإجمالية إلى تحليل التداخل بين عوامل الضعف والاحتياجات الخاصة بالحماية. فالطفلة السورية اللاجئة ذات الإعاقة التي تعيش في أسرة تعيلها امرأة داخل مخيم تواجه أشكاً مركبة من الهشاشة تختلف نوعياً عن تلك التي يواجهها طفل أردني منخرط في عمل الأطفال في بيئة حضرية.									
الهدف الخامس: تقييم احتياجات بناء القدرات لدى الشركاء المحليين والجهات الحكومية النظيرة تتطلب برمجة حماية طفل مستدامة وجود شركاء محليين أقوياء وأنظمة حكومية فعّالة. وعلى الرغم من أن الأردن أنشأ مؤسسات معنية بحماية الطفل، بما في ذلك وزارة									

التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة و وحدات متخصصة مختلفة، إلا أن قيود القدرات ما تزال تحدّ من فعاليتها. وبالمثل، تمتلك المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المحلي معرفة سياقية قيمة وثقة مجتمعية عالية، لكنها غالباً ما تفتقر إلى القدرات التقنية في مجالات الحماية المتخصصة.

الهدف السادس: دراسة العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات والمشاركة فيها
حتى عندما تتوفر خدمات حماية الطفل، قد تمنع عوائق متعددة الأطفال الأكثر ضعفاً من الوصول إليها. وتعمل هذه العوائق على مستويات مختلفة: عوائق فردية تشمل نقص الوعي، أو الوصم الاجتماعي، أو الخوف؛ وعوائق أسرية تشمل مواقف الوالدين، أو القيود الاقتصادية، أو تضارب الأولويات؛ وعوائق مجتمعية تشمل الأعراف الاجتماعية، أو العزلة الجغرافية، أو انعدام الأمن؛ وعوائق نظامية تشمل معايير الأهلية، أو متطلبات الوثائق، أو تصميم الخدمات بطريقة لا تراعي تنوع الاحتياجات. ويُعد فهم هذه العوائق المتداخلة أمراً أساسياً لتصميم خدمات ليست متوفرة فحسب، بل أيضاً قابلة للوصول ومقبولة لدى الفئات الهشة.

الهدف السابع: تطوير توصيات برمجية قائمة على الأدلة لمنظمة أرض البشر- الأردن (2025-2027)
يتمثل الهدف النهائي من هذا التقييم للاحتياجات في إنتاج توصيات برمجية قابلة للتنفيذ تستند إلى الأدلة بدلاً من الافتراضات. ويقوم هذا الهدف بدمج نتائج جميع الأهداف السابقة لتطوير استراتيجية برمجية متماسكة تعالج الفجوات المحددة، وتبني على نقاط القوة القائمة، وتستجيب لأشكال الهشاشة المحددة، وتعزز القدرات المحلية، وتتغلب على عوائق الوصول. وستكون التوصيات محددة وغير عامة، وقابلة للتنفيذ ضمن القدرات التشغيلية لأرض البشر وقيود الموارد، ومتوافقة مع ولاية المنظمة المؤسسية وأولويات حماية الطفل الوطنية في الأردن. كما سيتم ترتيب التوصيات حسب الأولوية بناءً على درجة الإلحاح، والأثر المحتمل، وإمكانية التنفيذ، إدراكاً لعدم إمكانية معالجة جميع الاحتياجات في الوقت ذاته. والنتيجة المتوقعة هي إطار برمجي استراتيجي لمنظمة أرض البشر - الأردن للفترة 2025-2027 يحدد التدخلات ذات الأولوية، والفئات المستهدفة والمناطق الجغرافية، واستراتيجيات الشراكة، ومتطلبات الموارد، بما يوفر توجيهاً واضحاً لاتخاذ القرارات البرمجية وجهود حشد التمويل.

النطاق الجغرافي: ضمان تغطية تمثيلية عبر سياقات متنوعة

يعكس اختيار المحافظات المستهدفة لهذا التقييم للاحتياجات دراسة متأنية لعدة عوامل، من بينها تركّز أعداد اللاجئين، وانتشار حوادث حماية الطفل، والتنوع الجغرافي، وأنماط توفر الخدمات، والحاجة إلى نتائج تمثيلية على المستوى الوطني يمكن أن تُسهم في توجيه برمجة منظمة أرض البشر (Tdh) وتعزيز الحوار السياساتي الأوسع. سيركّز التقييم على ست محافظات، تم اختيار كل منها لأسباب استراتيجية محددة تضمن النقاط تنوّع السياقات التي تؤثر على الأطفال في الأردن.

تمثّل محافظة عمّان سياق العاصمة بما يحمله من ديناميكيات حضرية معقّدة، وتنوّع في مقدّمي الخدمات، واتجاهات مقلقة في مجال حماية الطفل. وباعتبارها عاصمة الأردن وأكبر مدنه، تستضيف عمّان أعداداً كبيرة من اللاجئين المندمجين في أحياء حضرية مكتظة إلى جانب مجتمعات أردنية هشة. وقد سجّلت المحافظة أعلى الأعداد المطلقة لزواج الأطفال في البيانات المتاحة، حيث تزوّج 3,075 فتاة و84 فتى دون سن الثامنة عشرة في عام 2017، وهو ما يعكس حجم السكان الكبير إلى جانب أوجه هشاشة خاصة ناجمة عن الفقر الحضري والنزوح.

يخلق السياق الحضري في عمّان تحديات حماية مميّزة مقارنة بسياقات المخيمات أو المناطق الريفية؛ إذ يتوزّع الأطفال والأسر على أحياء متعددة بدل تركّزهم في مخيمات، ما يتطلب نماذج مختلفة لتقديم الخدمات. كما أن الطابع المجهول للحياة الحضرية قد يحمي الأسر من الضغوط الاجتماعية، لكنه في الوقت ذاته قد يعزلها عن شبكات الدعم المجتمعي. وتوفّر فرص كسب الرزق في الاقتصاد الحضري غير الرسمي إمكانيات وفرصاً، لكنها تنطوي أيضاً على مخاطر الاستغلال، في حين أن كلفة المعيشة المرتفعة في المدن تزيد الضغوط الاقتصادية التي تدفع نحو استراتيجيات تكيف سلبية.

وتتميّز عمّان كذلك بأكثر مشاهد مقدّمي الخدمات تنوعاً في الأردن، حيث تعمل المنظمات الدولية، والمنظمات المحلية، والخدمات الحكومية، والقطاع الخاص، ما يخلق فرصاً للإحالة والتكامل، إلى جانب تحديات في التنسيق. إن تقييم احتياجات الحماية في عمّان سيوفّر معطيات قابلة للتطبيق على سياقات حضرية أخرى تستضيف لاجئين، كما سيساعد في فحص ما إذا كانت كثافة الخدمات تعني فعلياً سهولة وصول الفئات الأكثر هشاشة إليها.

تمثّل محافظة إربد سياق الشمال ذي التركيز المرتفع جداً للاجئين، وما يرتبط به من ديناميكيات خاصة قرب الحدود. ومع وجود نحو 128,000 لاجئ، تستضيف إربد ثاني أكبر تجمع حضري للاجئين في الأردن بعد عمّان، حيث يتركز اللاجئون في مدينة إربد والبلدات المحيطة بها. وقد أثر قرب المحافظة من الحدود السورية في التركيبة الديمغرافية للاجئين، ولا يزال يؤثر في أنماط الحركة والروابط العابرة للحدود. سجّلت إربد في عام 2017 زواج 2,041 فتاة و 41 فتى دون سن الثامنة عشرة، ما يعكس مخاوف جدية في مجال الحماية. كما كانت المحافظة محوراً لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، حيث أشارت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إلى إربد كمناطق أولوية، ما يتيح فرصة لتقييم كيفية عمل هذه الخدمات الموسّعة ومدى وصولها إلى الفئات الهشة.

ويجمع سياق إربد بين مناطق حضرية وبلدات أصغر وتجمعات شبه حضرية، ما يخلق مشاهد حماية متنوّعة داخل المحافظة الواحدة. وقد فرض تركّز اللاجئين ضغطاً كبيراً على الخدمات والبنية التحتية المحلية، لكنه في الوقت ذاته حفّز تدفق الموارد والبرامج الإنسانية. إن فهم احتياجات الحماية في إربد سيساعد في تسليط الضوء على التحديات في السياقات ذات التركيز العالي للاجئين، وفحص كيف يمكن لتشعب الخدمات في بعض المناطق أن يتزامن مع فجوات في مناطق أخرى.

تمثّل محافظة المفرق سياق المخيم، كونها تحتضن مخيم الزعتري للاجئين، وهو أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن ويضم نحو 80,000 نسمة. وعلى الرغم من تحوّل الزعتري من مخيم طوارئ إلى تجمع أكثر استقراراً مع تحسّن نسبي في البنية التحتية، إلا أن مخاوف الحماية ما تزال كبيرة. ويُعد سياق المخيم، كما ورد في هذا البحث المكتبي، مقلّلاً بشكل خاص فيما يتعلق بزواج الأطفال، حيث إن 57% من الزيجات المسجّلة في تموز 2020 كانت زيجات لأطفال. إن كثافة السكان في المخيمات، ومحدودية فرص كسب الرزق، وقيود الحركة، والعبء النفسي للإقامة الطويلة في المخيم، تخلق ديناميكيات حماية مميّزة. ويواجه الأطفال في الزعتري مخاطر تشمل محدودية الفرص التعليمية بعد التعليم الأساسي، والتعرّض للعنف في ظروف الاكتظاظ، والاستغلال في العمل غير الرسمي داخل المخيم ومحيطه، وضغوط أسرية متزايدة نتيجة الحبس المكاني والضييق الاقتصادي.

في المقابل، توفّر المخيمات بعض المزايا، مثل سهولة الوصول إلى السكان بسبب تركّزهم، وحضور إنساني قوي ومستدام، وإمكانية أن تلعب الشبكات المجتمعية دوراً في الحماية والدعم. كما تضم محافظة المفرق مناطق حضرية ومجمعات مضيقة خارج المخيم، ما يتيح المقارنة بين سياقات المخيم وغير المخيم ضمن منطقة جغرافية واحدة. إن فهم احتياجات الحماية في المفرق ضروري لتصميم برامج فعالة في سياقات المخيمات، مع فحص الخصوصية التي تميّز الزعتري بوصفه أكبر وأكثر مخيمات اللاجئين استقراراً في الأردن.

تمثّل محافظة الزرقاء سياقاً صناعياً وشبه حضري، مع وجود أعداد كبيرة من اللاجئين واتجاهات مقلقة في مجال حماية الطفل. وبصفتها ثالث أكبر مدينة في الأردن، سجّلت الزرقاء في عام 2017 زواج 2,197 فتاة و 53 فتى دون سن الثامنة عشرة، وهو رقم يقارب أرقام إربد رغم أن عدد سكانها أقل. ويخلق الطابع الصناعي للمحافظة مخاطر خاصة تتعلق بعمل الأطفال، حيث قد تستوعب المصانع والورش والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية أطفالاً.

ويقع موقع الزرقاء بجوار عمّان، ما يجعلها تعمل جزئياً كمدينة تابعة، حيث يتنقّل بعض السكان إلى عمّان للعمل أو الحصول على الخدمات، بينما يقيمون في الزرقاء بسبب انخفاض تكاليف السكن. ويخلق هذا الطابع شبه الحضري ديناميكيات مميّزة؛ إذ قد تتمتع الأسر بإمكانية الوصول إلى بعض الخدمات الحضرية دون غيرها، وتتوزع فرص العمل بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وقد تكون الشبكات الاجتماعية أكثر تماسكاً من المدن الكبرى، لكنها أقل تلاحماً من المجتمعات الريفية.

وقد جرى تحديد الزرقاء أيضًا كمنطقة أولوية لبرامج الدعم النفسي الاجتماعي من قبل GIZ ، ما يتيح تقييم هذه الخدمات. إن الطابع الصناعي للمحافظة وتركيز اللاجئين فيها يجعلانها نموذجًا لعدد من المدن الأردنية متوسطة الحجم التي تستضيف نازحين وتواجه في الوقت ذاته تحديات اقتصادية ومخاطر حماية مرتبطة بالسياق الصناعي.

تمثل محافظة البلقاء سياقًا مختلطًا حضريًا-ريفيًا، مع أعداد أقل من اللاجئين وملامح اجتماعية واقتصادية مميزة. فقد سُجِّل في عام 2017 زواج 471 فتاة و21 فتى دون سن الثامنة عشرة، وهي أرقام أقل بكثير من عمان أو إربد أو الزرقاء، ما يجعل البلقاء سياقًا مقارنًا مهمًا لفهم ما إذا كانت تحديات الحماية تختلف في المناطق ذات التركيز الأقل للاجئين.

وتتضمن المحافظة مدينة السلط، إحدى المدن التاريخية في الأردن، إلى جانب مناطق ريفية وشبه ريفية، ما يتيح دراسة احتياجات الحماية عبر هذا الطيف الحضري-الريفي. وقد حظيت البلقاء بتركيز أقل نسبيًا من التدخلات الإنسانية والتنمية مقارنة بالمحافظات ذات الكثافة العالية للاجئين، ما يثير تساؤلات حول توفر الخدمات، وما إذا كانت احتياجات الحماية في المناطق «الأقل أولوية» ما تزال غير ملبّاة. كما أن قرب المحافظة من عمان يتيح لبعض السكان الوصول إلى خدمات العاصمة، في حين يواجه آخرون في المناطق الأبعد فجوات حقيقية في الخدمات. إن فهم احتياجات الحماية في البلقاء سيساعد في تحديد ما إذا كانت تحديات الحماية محصورة في المناطق ذات التركيز العالي للاجئين، أم أنها موجودة على امتداد الأردن لكنها تحظى باهتمام أقل في المناطق ذات أعداد اللاجئين المحدودة، ما يدعم نقاشات العدالة في توزيع الموارد الإنسانية والتنمية.

أما المحافظة السادسة فسيتم اختيارها من جنوب أو شرق الأردن (بالتشاور مع منظمة أرض البشر وشركائها، وقد تكون الكرك أو معان أو العقبة)، وذلك لضمان التمثيل الوطني من خلال إدراج مناطق غالبًا ما يتم تجاهلها في التقييمات الإنسانية التي تتركز في شمال ووسط الأردن. وتواجه المحافظات الجنوبية والشرقية تحديات مختلفة، من بينها العزلة الجغرافية عن مراكز الخدمات الرئيسية، والأعراف الاجتماعية الأكثر محافظة في بعض المناطق، وبنى اقتصادية تعتمد على الزراعة أو السياحة بدل الصناعة، إلى جانب وجود أعداد أقل لكنها ما تزال هشة من اللاجئين. وقد جرى ذكر هذه المحافظات صراحة في الأبحاث الحكومية حول زواج الأطفال، حيث تم تحديد الكرك ومعان كمناطق تركيز في الدراسة الوطنية حول دوافع زواج الأطفال.

إن إدراج محافظة من الجنوب أو الشرق يضمن أن يعكس التقييم احتياجات الحماية عبر كامل التنوع الجغرافي في الأردن، بدل الاقتصار على الممر الشمالي-الوسطى حيث يتركز معظم اللاجئين والخدمات الإنسانية. ويعكس هذا الاختيار التزامًا بإنتاج نتائج على المستوى الوطني يمكن أن تغذي الحوار السياساتي بما يتجاوز المناطق المستضيفة للاجئين فقط.

الدراسات الرئيسية التي تستند إليها هذه التقييمات

تعتمد هذه التقييمات على عدد من الدراسات البحثية الكبرى التي توفر سياقًا أساسيًا وبيانات مرجعية مهمة. مسح العمل الأطفال الوطني لعام 2016 التابع لمنظمة العمل الدولية (ILO) يُعد أكثر المصادر الكمية شمولاً حول عمل الأطفال في الأردن، على الرغم من مرور نحو تسع سنوات على إجرائه. وقد أجرته دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بدعم فني من منظمة العمل الدولية، واعتمد المسح منهجيات معيارية دولية وحقق تمثيلًا وطنيًا من خلال اختيار عينات دقيقة شملت جميع المحافظات والفئات الديمغرافية. وأظهرت نتائج المسح وجود 75,982 طفلًا يعملون، منهم 69,661 في عمل الأطفال، و44,917 في أعمال خطرة، وهو ما يمثل خط الأساس لتقييم الاتجاهات. وأظهرت بيانات المسح عند التفصيل حسب الجنسية أن نسبة عمل الأطفال بين اللاجئين السوريين بلغت 3.22% مقارنة بـ 1.57% بين الأردنيين، مما يوثق تأثير النزوح على هشاشة الأطفال في سوق العمل. أما النتائج المتعلقة بالجنس، حيث يشكل الأولاد 88.3% من الأطفال العاملين، فتثير تساؤلات مهمة حول ما إذا كان عمل الفتيات، خصوصًا الأعمال المنزلية، يتم رصد بدقة في منهجيات المسوحات المنزلية.

دراسات اليونيسيف حول الزواج المبكر في الأردن، بما في ذلك دراسة 2014 بعنوان "دراسة الزواج المبكر في الأردن" ودراسة 2019 النوعية بعنوان "الدراسة النوعية حول الأعراف الاجتماعية الاقتصادية المسببة للزواج المبكر في الأردن" بالتعاون مع جامعة إدنبرة والمجلس الأعلى للسكان، توفر أوسع قاعدة أدلة حول محددات الزواج

المبكر. استخدمت دراسة 2019 منهجيات نوعية صارمة، بما في ذلك مقابلات معمقة ومجموعات تركيز عبر سبع محافظات، واستكشفت كيف تدفع الضغوط الاقتصادية، والأعراف الثقافية المتعلقة بالستر، والمخاوف من العنف الجنسي، وطموحات الجنسية، والعائلات نحو تزويج الأطفال. وتركز الدراسة على الأعراف الاجتماعية الكامنة وليس على العوامل الاقتصادية فقط، ما يعكس فهماً أعمق بأن الزواج المبكر ليس مجرد مشكلة فقر، بل ممارسة معقدة متجذرة في عدم المساواة بين الجنسين والمعتقدات الاجتماعية حول أدوار ومستقبل الفتيات.

قدمت تقييمات منظمة Humanity & Inclusion و IIMAP لعام 2018 بعنوان "إزالة الحواجز: الطريق نحو الوصول الشامل" بيانات رائدة حول الأطفال اللاجئين السوريين ذوي الإعاقة في الأردن ولبنان. وكشفت الدراسة أن 22.9% من الأطفال السوريين اللاجئين بعمر سنتين وما فوق لديهم إعاقة، وهو أكثر من ضعف معدل السكان العام، ما يعكس التداخل العميق بين النزوح والإعاقة. وسجلت الدراسة عدة حواجز محددة، بما في ذلك الحواجز السلوكية من العائلات ومقدمي الخدمات، والصعوبات في الوصول المادي إلى الخدمات والبنية التحتية، والاستبعاد النظامي من التعليم وخدمات الحماية. وقد ساهمت هذه الدراسة في تسليط الضوء على قضية كانت غير مرئية سابقاً، وهي الأطفال اللاجئون ذوو الإعاقة، وتوفير أدلة مهمة لتصميم برامج موجهة وجهود المناصرة.

يوفر إطار تقييم الهشاشة للاجئين التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والذي يُجرى سنوياً بين المجتمعات اللاجئة، مراقبة مستمرة لهشاشة الوضع الاقتصادي ومخاطر الحماية والوصول إلى الخدمات. ويتيح التصميم الطولي للإطار تتبع تطور الهشاشة على مدار الوقت، موثقاً آثار النزوح الطويل، وتأثيرات جائحة COVID-19، والصدمات الاقتصادية على الأسر اللاجئة. وقد سجل الإطار زيادة الفقر بين اللاجئين، وارتفاع مستويات الديون، وتراجع الوصول إلى الرعاية الصحية، واستخدام آليات التأقلم السلبية بما في ذلك عمل الأطفال والزواج المبكر، ما يوضح أن النزوح ليس حالة طارئة مؤقتة بل أزمة ممتدة تتطلب استجابة مستدامة.

الخلاصة: من الأدلة إلى العمل

لقد قام هذا البحث المكتبي الشامل بتحليل كمية كبيرة من الأدلة المستمدة من مصادر رسمية موثوقة، موثقاً التحديات العميقة المتعلقة بحماية الأطفال في الأردن عبر أبعاد متعددة. وتشير الأدلة إلى واقع صارخ ومقلق للغاية: 69,661 طفلاً يعملون في سوق العمل، منهم 44,917 في أعمال خطيرة تهدد صحتهم وسلامتهم ونموهم؛ و7,964 حالة زواج للأطفال تحدث سنوياً، مع معدلات بين الفتيات السوريات اللاجئات أعلى بست مرات من الفتيات الأردنيات؛ وتقريباً جميع الأطفال يتعرضون للعنف الجسدي أو النفسي، حيث يعاني 9 من كل 10 أطفال من العقاب العنيف، ما يطبع العنف كأمر مقبول ومألوف؛ وتبرز احتياجات حادة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي نتيجة النزوح الطويل، والتعرض للصدمات، والضغوط الاقتصادية، بينما تظل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي متفرقة وغير كافية؛ كما يستمر الإقصاء العميق للأطفال ذوي الإعاقة من التعليم، حيث لا يزال 79% منهم خارج النظام المدرسي رغم الالتزامات السياسية بالتعليم الشامل.

ومع ذلك، هذه الإحصاءات ليست مجرد أرقام، بل تمثل أطفالاً حقيقيين تُنتهك حقوقهم، ويُعرض نموهم للخطر، وتتأثر مستقبلهم بسبب إخفاقات الحماية. فخلف كل إحصائية عن زواج الأطفال توجد فتاة تُنهى طفولتها قبل أوانها، ويتوقف تعليمها، وقد تتعرض لصحتها للخطر بسبب الحمل المبكر، وتتغير مسار حياتها جذرياً. وخلف كل إحصائية عن عمل الأطفال يوجد طفل كان ينبغي أن يكون في المدرسة، لكنه يعمل في الحقول أو الورش أو الشوارع، معرضاً للاستغلال ومُحرّماً من التعلم الذي قد يكسر دائرة الفقر. وخلف إحصاءات العنف يوجد أطفال يتعلمون أن العنف أمر طبيعي ومقبول، وقد يحملون هذه الدروس إلى أسلوب تربيتهم المستقبلية لأطفالهم.

ومع ذلك، فإن هذه التحديات، رغم شدتها، ليست مستعصية. فالأردن يمتلك نقاط قوة مهمة: حكومة مستقرة نسبياً مع مؤسسات حماية الطفل القائمة؛ مجتمع مدني نشط ملتزم بحقوق الأطفال؛ شركاء دوليون يقدمون الدعم الفني والمالي؛ أطر قانونية تضمن الحقوق والحماية، رغم تطبيقها غير الكامل؛ وقدرة مثبتة على دمج نهج جديد مثل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن الأنظمة القائمة.

ويمثل تقييم الاحتياجات المقترح في هذا الوثيقة فرصة لترسيخ استراتيجية برامج أرض البشر الأردن للفترة 2025-2027 على أساس أدلة قوية، وضمان أن تركز استثمارات الموارد المالية والوقت البشري والقدرات المؤسسية على أعلى أولويات تؤثر على أكثر الأطفال ضعفًا. كما يمكن التقييم من تحديد الموقع الاستراتيجي لـ Tdh ضمن منظومة حماية الطفل في الأردن، وتوضيح مجالات التميز المقارن في العدالة التصالحية، ومنع زواج الأطفال، والحماية المجتمعية لتحقيق أقصى أثر. وسيعزز الشراكات مع المنظمات المحلية من خلال عمليات تقييم تعاونية تبني العلاقات والتفاهم المتبادل، كما سيولد الأدلة اللازمة للحوار السياسي مع الحكومة، والمانحين، وهيئات التنسيق، مساهمًا في تعزيز القطاع ككل بما يتجاوز برامج أرض البشر الفردية.

ويمر الطريق من هذا البحث المكتبي إلى الأثر البرامجي بعدة مراحل: الانتهاء من منهجية التقييم بالتشاور مع الخبراء الفنيين والشركاء؛ الحصول على الموافقات الأخلاقية اللازمة من لجان المراجعة المؤسسية؛ تدريب فرق جمع البيانات على البحث الأخلاقي والأدوات المتخصصة؛ جمع البيانات بشكل منهجي في ست محافظات باستخدام طرق متعددة للتحقق من النتائج؛ التحليل الدقيق لدراسة الأنماط والفجوات والأسباب الكامنة؛ تطوير توصيات برمجية من خلال عمليات تشاورية مع أصحاب المصلحة؛ وفي النهاية، تصميم وتنفيذ برامج مستندة إلى الأدلة تعالج بشكل فعال احتياجات الحماية التي تم توثيقها. وتتطلب كل مرحلة التزامًا بالجودة، والأخلاقيات، والمشاركة مع الأكثر تأثرًا بتحديات الحماية: الأطفال أنفسهم، وعائلاتهم، ومجتمعاتهم.